



2<sup>ème</sup>

# CONGRÈS BURKINABÉ DE SANTÉ PUBLIQUE

## Thème

Sécurité sanitaire : quels dispositifs pour mieux protéger les populations contre les risques épidémiques et pandémiques ?

## LIVRE DES RÉSUMÉS



Ouagadougou

Du 16 au 18 décembre 2021  
à l'Université Joseph KI-ZEBO  
BURKINA FASO



## SPONSORS DU 2<sup>ème</sup> CONGRES BURKINABE DE SANTE PUBLIQUE







## SOMMAIRE

|                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b><i>SPONSORS DU 2<sup>ème</sup> CONGRES BURKINABE DE SANTE PUBLIQUE .....</i></b>      | <b><i>1</i></b>   |
| <b><i>LISTE DES MEMBRES DU COMITE NATIONAL D'ORGANISATION .....</i></b>                  | <b><i>3</i></b>   |
| <b><i>LISTE DES MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE .....</i></b>                             | <b><i>4</i></b>   |
| <b><i>MOT DU PRESIDENT DE LA SOCIETE BURKINABE DE SANTE PUBLIQUE (SOBUSAP) .....</i></b> | <b><i>5</i></b>   |
| <b><i>MOT DU PRESIDENT DU COMITE SCIENTIFIQUE .....</i></b>                              | <b><i>6</i></b>   |
| <b><i>PROGRAMME DU 2<sup>ème</sup> CONGRES BURKINABE DE SANTE PUBLIQUE .....</i></b>     | <b><i>7</i></b>   |
| <b><i>LISTE ALPHABETIQUE DES COMMUNICANTS .....</i></b>                                  | <b><i>27</i></b>  |
| <b><i>RESUMES DES COMMUNICATIONS ORALES.....</i></b>                                     | <b><i>60</i></b>  |
| <b><i>RESUMES DES COMMUNICATIONS AFFICHEES .....</i></b>                                 | <b><i>209</i></b> |



## **LISTE DES MEMBRES DU COMITE NATIONAL D'ORGANISATION**

### **Président :**

Pr Laurent T. OUEDRAOGO

### **Vice-Président :**

Pr Nicolas MEDA

### **Coordonnateur scientifique :**

Dr Hama A. DIALLO

### **Secrétaire :**

Mme Samira SANON

### **Membres**

- Pr OUEDRAOGO T. Laurent
- Pr OUEDRAOGO Arouna
- Pr MEDA Nicolas
- Dr DRABO Maxine
- Dr DIALLO Hama
- Dr TINTO Halidou
- Dr OUEDRAOGO Smaila
- Dr LOMPO Sandrine
- Dr SOUBEIGA Dieudonné
- Dr RAMDE Norbert
- Dr OUATTARA Seydou
- Dr NIAONE Moumini
- Dr GARE Jocelyne
- Dr DIALLO Ismaël
- Dr KABORE Ahmed
- Dr HIEN Hervé
- Dr YANOOGO Pauline
- Dr KIENDREBEOGO Joel
- Dr OUEDRAOGO Boukary
- Dr KABORE Issa
- Dr NIKIEMA Z. Emmanuelle
- Dr KAFANDO Benoît
- Mme SAKO Nadège
- Mme BOUDA Josiane
- Mme KABORE Salamata
- Mme ZOUNGRANA Olivia
- Mme IDANI Josépha
- Mme SANON Samira
- Mlle BELEMTUGRI Anita
- Mr GNOUMOU Blaise
- Mr TRAORE Abdoulaye
- Mr NANA Issaka
- Mr OUEDRAOGO P. Didier

## **LISTE DES MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE**

### **Président :**

Pr Arouna **OUEDRAOGO**, UFR/SDS

### **Vice-Président :**

Pr Rabiou **CISSE**, Président de l'Université Joseph KI-ZERBO

### **Membres :**

- Pr Laurent T. OUEDRAOGO, UFR/SDS,
- Pr Nicolas MEDA, UFR/SDS
- Pr Joseph Y. DRABO, UFR/SDS
- Pr Adama TRAORE, UFR/SDS
- Pr Patrice ZABSONRE, UFR/SDS
- Pr Diarra OUATTARA YE, UFR/SDS
- Pr Blami DAO, UFR/SDS
- Pr Olga M. LOMPO, UFR/SDS
- Pr Antoine P. NIAMBA, UFR/SDS
- Pr Blandine THIEBA BONANE, UFR/SDS
- Pr Claudine LOUGUE, UFR/SDS
- Pr Lassana SANGARE, UFR/SDS
- Pr Léon G. SAVADOGO, Université Nazi Boni
- Pr Bertin OUEDRAOGO, UFR/SDS
- Pr Mohamed TALL, UFR/SDS
- Pr Abdramane SOURA, ISSP/UJKZ
- Pr Jean TESTA, Université Nice/France
- Dr Estelle YOUL, UFR/SDS
- Dr Maxime DRABO, Directeur de recherche IRSS/CNRST
- Dr Halidou TINTO, Directeur de recherche, IRSS/CNRST
- Dr Hama DIALLO, Maître de Conférences Agrégé, UFR/SDS
- Dr Smaïla OUEDRAOGO, Maître de Conférences Agrégé, UFR/SDS
- Dr Ismael DIALLO, Maître de Conférences Agrégé, UFR/SDS
- Dr Josias YAMEOGO, UFR/SDS
- Dr Serges DIAGBOUGA, IRSS/CNRST
- Dr Ahmed KABORE, UFR/SDS
- Dr Jean KABORE, IRSS/CNRST
- Dr Tamini LAURE, UFR/SDS
- Dr Hervé HIEN, IRSS/CNRST
- Dr Alphonse OUEDRAOGO, GRAS
- Dr Herman SORGHO, IRSS/CNRST
- Dr Elias DAH, Université de Ouahigouya
- Dr Roger ZERBO, CNRST
- Dr Crépin DADJO, OMS/Burkina
- Dr Ado BWAKA, OMS/Burkina
- Dr Moussa SANOGO, UST/Mali
- Dr Dado FARODA, UST/Mali
- Dr Ramatoulaye HAMIDOU, MS/Niger

## MOT DU PRESIDENT DE LA SOCIETE BURKINABE DE SANTE PUBLIQUE (SOBUSAP)

Les 16, 17 et 18 décembre 2021, la Société Burkinabè de Santé Publique (SOBUSAP) tient son deuxième congrès scientifique, le premier ayant eu lieu les 19, 20 et 21 décembre 2019. Ce deuxième congrès se tient dans un contexte marqué au plan national par la crise sécuritaire et la crise sanitaire due à la Covid-19 et au plan international par la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie a profondément bouleversé les modes de vie des populations, déstructuré des économies et fragilisé les systèmes de santé. Elle a rappelé au monde scientifique spécifiquement médical, que les risques pandémiques dus à des microorganismes pathogènes ne font pas partie de l'histoire ou encore le propre des pays en développement. Ils constituent une menace permanente dans un monde ouvert aux échanges de tout genre.



En choisissant comme thème de ce deuxième congrès « **Sécurité sanitaire : quels dispositifs pour mieux protéger les populations contre les risques épidémiques et pandémiques ?** », la SOBUSAP entend susciter la réflexion sur les dispositifs pour mieux protéger les populations contre les menaces sanitaires, spécifiquement contre les risques épidémiques et pandémiques.

Malgré le contexte ci-dessus évoqué, vous êtes nombreux à manifester votre participation par la soumission d'abstracts pour des communications orales ou affichées. Au nom de l'ensemble du comité national d'organisation, j'exprime à l'endroit de chacun et chacune notre gratitude pour cette reconnaissance. Je souhaite à toutes et à tous un fructueux congrès et un bon séjour au Burkina Faso pour ceux qui seront en présentiel.

Je voudrais d'ores et déjà solliciter votre indulgence pour les imperfections que vous remarquerez çà et là dans l'organisation du présent congrès. Nous vous affirmons en tout cas notre ferme volonté de rendre votre participation fructueuse et heureuse.

J'exprime, au nom de l'ensemble des membres du comité national d'organisation, ma gratitude à l'ensemble des partenaires et sponsors sans lesquels ce congrès n'aurait pas lieu. Qu'ils soient remerciés pour ce soutien inestimable.

Je remercie enfin les autorités du Burkina Faso, en particulier le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation pour avoir accepté de patronner le congrès, le Ministre de la Santé et le PDG de Coris Bank International pour le parrainage. Je remercie les autorités académiques de l'Université Joseph Ki-Zerbo, notamment le Président de l'Université et le Directeur de l'UFR sciences de la Santé pour leur soutien.

Agréable congrès à toutes et à tous !

**Professeur Laurent T. OUEDRAOGO**

Professeur Titulaire de Santé Publique

Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques



## MOT DU PRESIDENT DU COMITE SCIENTIFIQUE

Mesdames, messieurs les congressistes,

Au nom du Comité scientifique, je souhaite la cordiale bienvenue à l'ensemble des congressistes.

L'organisation de ce deuxième congrès de la Société burkinabè de Santé publique est un événement scientifique majeur auquel tous les scientifiques sont conviés.

Le thème choisi par le comité scientifique cette année s'intitule : « **Sécurité sanitaire : quels dispositifs pour mieux protéger les populations contre les risques épidémiques et pandémiques** ». Ce choix n'est assurément pas le fait du hasard.

Au cours des travaux qui se dérouleront du 16 au 18 décembre 2021, ce thème fédérateur et d'actualité sera abordé sous différents angles par des enseignants, chercheurs, décideurs et praticiens de terrain venus d'horizons divers.

Le Comité scientifique se réjouit d'ores et déjà de la richesse des contributions scientifiques enregistrées au cours de la présente édition.

Si le contexte sanitaire particulier marqué par la persistance de la pandémie à coronavirus nous amène à adopter un format hybride, nous tenons à rassurer l'ensemble des participants que les dispositions idoines seront prises pour des partages d'expériences et des échanges de connaissances.

Je vous remercie pour vos propositions de communications scientifiques, ainsi que pour votre participation, qu'elle soit en présentiel ou à distance.

En espérant que le contenu scientifique de ce congrès sera à la hauteur de vos attentes, je souhaite à toutes et à tous un fructueux congrès et un bon séjour à Ouagadougou, ville d'hospitalité et de culture.

**Pr Arouna OUEDRAOGO**

Professeur Titulaire de Psychiatrie  
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon  
Officier de l'Ordre des Palmes Académiques



# PROGRAMME DU 2<sup>ème</sup> CONGRES BURKINABE DE SANTE PUBLIQUE

## 2<sup>ème</sup> Congrès Burkinabè de Santé Publique

**Jeudi 16 Décembre 2021**

| Heure<br>Lieu | Bâtiment PSUT<br>Salle des Actes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amphithéâtre<br>UFR/SEA | Bâtiment PSUT<br>Salle de Travaux<br>Dirigés | Bâtiment PSUT<br>Salle de vidéo-<br>conférence |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 08H00 - 09H00 | Inscriptions des participants<br>(en continu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                              |                                                |
| 09H00 - 10H30 | <p><b>Conférence inaugurale</b><br/>Thème :<br/>Sécurité sanitaire : quels dispositifs pour mieux protéger les populations contre les risques épidémiques et pandémiques ?</p> <p>Lieu: Bâtiment PSUT/Salle des Actes</p> <p><b>Conférencier:</b> Pr Laurent OUEDRAOGO</p> <p><b>Modérateurs:</b><br/>Pr Adama SANOU<br/>Pr Arouna OUEDRAOGO</p> <p><b>Rapporteurs:</b><br/>Dr Seydou OUATTARA<br/>Dr Espérance OUÉDRAOGO</p> |                         |                                              |                                                |
| 10H30 - 11H00 | <p><b>Suspension de sessions</b></p> <p><b>Session Posters 1 à 15</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                              |                                                |

|                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Légende           | Sous-Thèmes                                                                                                                                 | Sous-thème 1 :<br>La science de l'analyse et de la gestion des risques et des urgences en santé publique                        | Sous-thème 2 :<br>Les pratiques de surveillance épidémiologique dans le cadre des vigilances sanitaires        | Sous-thème 3 :<br>La communication en période de crise sanitaire                                                                                                                     | Sous-thème 4 :<br>Le règlement sanitaire international et son application par les pays                                                       | Sous-thème 5 :<br>Communications libres                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|                   | Abréviations                                                                                                                                | STH : Sous-thème   S: Session   CO: Communication orale   P : Présentiel   L: En Ligne                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|                   | Code couleur Salle                                                                                                                          | Bâtiment PSUT/Salle des Actes                                                                                                   | Amphithéâtre UFR/SEA                                                                                           | Bâtiment PSUT /Salle de Travaux Dirigés                                                                                                                                              | Bâtiment PSUT /Salle de vidéo-conférence                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|                   | Autre code couleur                                                                                                                          | Conférence inaugurale / Panel/Table ronde                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| Heure<br><br>Lieu | Bâtiment PSUT<br>Salle des Actes                                                                                                            | Amphithéâtre<br>UFR/SEA                                                                                                         | Bâtiment PSUT<br>Salle de Travaux Dirigés                                                                      | Bâtiment PSUT<br>Salle de vidéo-conférence                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| 11H00 – 13H00     | Session 1 Sous-thème 5<br>Modérateurs:<br>Dr Halidou TINTO<br>Dr Smaila OUÉDRAOGO<br>Rapporteurs:<br>Dr Pauline YANOGO<br>Dr Dézémon ZINGUE |                                                                                                                                 | Session 2 Sous-thème 5<br>Modérateurs:<br>Pr Caroline YONABA<br>Dr Angèle ZAN<br>Rapporteur:<br>Dr Jean KABORÉ |                                                                                                                                                                                      | Session 1 Sous-thème 1<br>Modérateurs:<br>Pr Nicolas MEDA<br>Dr Emmanuel SEINI<br>Rapporteurs:<br>Dr Seydou OUATTARA<br>Dr Abdalah OUÉDRAOGO |                                                                                                                                | Session 1 Sous-thème 3<br>Modérateurs :<br>Pr. Abdramane SOURA<br>Dr. Maxime DRABO<br>Rapporteur:<br>Dr Emmanuelle NIKIEMA |                                                                                                                               |
|                   | STH-5-S1-COP-1                                                                                                                              | Variation temporelle de la distribution des allèles eba175 chez des enfants atteint de paludisme simple à Banfora, Burkina Faso | STH-5-S2-COP-13                                                                                                | Évaluation de l’adhésion du personnel de soins à la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance (PCIME) dans le contexte de Gratuité des soins au Burkina Faso : Etude PAASME | STH-1-S1-COL-1                                                                                                                               | Profil épidémiologique et clinique des enfants et adolescents atteints de COVID-19 dans la région centrale, Togo, 2020         | STH-3-S1-COP-1                                                                                                             | Connaissance, Attitude et Perception vis-à-vis de la COVID-19 chez les personnes confinées à l’Hôtel Gaweys de Niamey en 2020 |
|                   | STH-5-S1-COP-2                                                                                                                              | Indice de préparation des services de santé relatifs au paludisme et association avec la létalité palustre infantile.           | STH-5-S2-COP-14                                                                                                | Facteurs associés aux abandons ou aux changements de méthodes contraceptives modernes au Burkina Faso.                                                                               | STH-1-S1-COP-2                                                                                                                               | Etude des facteurs associés à la COVID-19 chez les personnes suspectes dans le district sanitaire I de Niamey                  | STH-3-S1-COP-2                                                                                                             | COVID-19 : Observance des mesures barrières dans les officines de pharmacie privées au Mali                                   |
|                   | STH-5-S1-COP-3                                                                                                                              | Profil épidémiologique du paludisme en Guinée de 2013 à 2020                                                                    | STH-5-S2-COP-15                                                                                                | Etude des déterminants des accouchements dans le service d’obstétrique du Centre Hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO.                                                        | STH-1-S1-COP-3                                                                                                                               | Expérience du LNR-FHV dans la gestion de crise sanitaire : Déploiement du Laboratoire mobile P3 pour le diagnostic du COVID-19 | STH-3-S1-COP-3                                                                                                             | Résultats préliminaires de l’étude sur l’état de stress post-traumatique en population générale au Burkina Faso en 2021       |

|                      |                |                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11H00 – 13H00</b> | STH-5-S1-COP-4 | Analysis of the impact of malaria on the labour productivity of cotton farmers in Burkina Faso                                                                                                        | STH-5-S2-COP-16 | Déterminants de la prise de décision des césariennes en urgence : cas d'étude à l'hôpital de district de Dafra, à Bobo Dioulasso, Burkina Faso                                                                             | STH-1-S1-COP-4 | Investigation d'un cas de COVID-19 dans l'aire de santé de Makandiamougou, District sanitaire de Kita, Septembre 2020                                                           | STH-3-S1-COP-4 | COVID-19 : Observance des mesures barrières dans le commerce de denrées alimentaires dans le district de Bamako                                    |
|                      | STH-5-S1-COP-5 | Perception de la communauté sur la prévention du paludisme après l'introduction de nouvelles moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) dans les districts sanitaires de Banfora, Gaoua et Orodara. | STH-5-S2-COP-17 | Urgences dans le service de maternité du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO : mode d'entrée et qualité de la prise en charge                                                                               | STH-1-S1-COP-5 | Effets du Covid-19 sur le système de santé sénégalais : Cas du centre de gérontologie et gériatrie de Ouakam, Dakar, Sénégal. En 2021                                           | STH-3-S1-COP-5 | Gestion de la maladie à Corona virus dans la ville de Bobo-Dioulasso : pour une analyse des pratiques de l'autorité en période de crise sanitaire. |
|                      | STH-5-S1-COP-6 | Evaluation de l'efficacité thérapeutique de deux combinaisons à base d'artémisinine pour le traitement du paludisme simple chez les enfants au Burkina Faso                                           | STH-5-S2-COP-18 | Fréquence et facteurs liés au décès maternels lors des ruptures utérines au département de gynécologie, d'obstétrique et de médecine de la reproduction du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo Dioulasso. | STH-1-S1-COP-6 | Pratiques de port des équipements de protection individuelle des agents de santé du CHUP-CDG dans le contexte de la COVID-19                                                    | STH-3-S1-COL-6 | WhatsApp et lutte contre la lèpre en milieu rural ivoirien en période de covid-19                                                                  |
|                      | STH-5-S1-COP-7 | Impact des moustiquaires de nouvelle génération sur la prévalence du paludisme, un an après leur introduction au Burkina Faso                                                                         | STH-5-S2-COP-19 | Déclarations et pratiques des mères en matière d'allaitement exclusif en milieu rural au Burkina Faso                                                                                                                      | STH-1-S1-COP-7 | Étude comparative des manifestations cliniques observées chez les patients positifs versus patients négatifs de COVID-19 au CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou (Burkina Faso) | STH-3-S1-COP-7 | Contribution des TIC à la gestion de la Covid-19 au Burkina Faso                                                                                   |
|                      | STH-5-S1-COP-8 | Prévalence du paludisme et couverture des interventions chez les femmes enceintes dans trois districts sanitaires du Burkina Faso : résultats intermédiaires                                          | STH-5-S2-COP-20 | Déterminants de l'utilisation des méthodes contraceptives chez les étudiantes de l'Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso                                                                                                | STH-1-S1-COP-8 | Caractéristiques socio-épidémiologiques et cliniques des patients atteints de la COVID-19 au Niger 2020                                                                         | STH-3-S1-COL-8 | Acceptabilité de la vaccination contre la Covid-19 par les agents de santé de la région sanitaire de Gbèkè, Côte d'Ivoire, 2021                    |

|               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11H00 – 13H00 | STH-5-S1-COP-9                                                                                                                    | Réponses humorales de Plasmodium falciparum chez des enfants et adultes semi-immuns vivant à Saponé au Burkina Faso                                                                                | STH-5-S2-COL-21 | Facteurs explicatifs de la pratique contraceptive moderne des femmes fréquentant les formations sanitaires du district de Youwarou au Mali | STH-1-S1-COL-9  | Investigation d'un cluster de COVID-19 dans une communauté confessionnelle, district sanitaire de l'Ogou, Togo, 2020            | STH-3-S1-COL-9  | Vécu psychosocial des patients de la COVID-19 lors de leur confinement                                         |
|               | STH-5-S1-COP-10                                                                                                                   | Évaluation de l'effet de la CPS sur la prévalence du paludisme et la diversité génétique de Plasmodium falciparum à Saponé.                                                                        | STH-5-S2-COL-22 | Facteurs associés aux décès maternels au Centre de Santé de Référence de Koulikoro de 2009 à 2018                                          | STH-1-S1-COL-10 | Évaluation des pratiques d'hygiène et de prévention de la COVID_19 au CHU Point G du Mali                                       | STH-3-S1-COL-10 | Modèles d'hésitation vaccinale contre la COVID-19 : quelle place pour la littérature en santé ?                |
|               | STH-5-S1-COP-11                                                                                                                   | Hétérogénéité de la prévalence des marqueurs moléculaires associés à la résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques dans les trois faciès épidémiologiques du paludisme au Burkina Faso | STH-5-S2-COL-23 | Facteurs associés aux besoins non satisfaits en contraceptifs modernes chez les jeunes filles au Togo                                      | STH-1-S1-COL-11 | Facteurs associés à la mortalité liée à la COVID-19 au Niger                                                                    | STH-3-S1-COL-11 | Acceptabilité des mesures de distanciation sociale : « comment dire à quelqu'un de ne pas te rendre visite ? » |
| 13H00 - 14H00 | STH-5-S1-COL-12                                                                                                                   | Le paludisme chez les enfants de quatre districts sanitaires du Burkina Faso en contexte de chimio-prévention saisonnière.                                                                         | STH-5-S2-COL-24 | Gender-Based Violence in Mali : A Hidden Disaster in Schools                                                                               | STH-1-S1-COL-12 | Investigation des cas suspects de COVID-19 dans le District Sanitaire de Nongr-Massom, Ouagadougou, Burkina-Faso, Mars-Mai 2020 | STH-3-S1-COL-12 | Perceptions de la COVID-19 des personnels de santé de première ligne de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso  |
|               | <p style="text-align: center;"><b>Suspension de sessions</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Session Posters 1 à 15</b></p> |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                |

|                |                           |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                              |                                               |                    |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Légende</b> | <b>Sous-Thèmes</b>        | <u>Sous-thème 1:</u><br>La science de l'analyse et de la gestion des risques et des urgences en santé publique | <u>Sous-thème 2 :</u><br>Les pratiques de surveillance épidémiologique dans le cadre des vigilances sanitaires | <u>Sous-thème 3:</u><br>La communication en période de crise sanitaire | <u>Sous-thème 4:</u><br>Le règlement sanitaire international et son application par les pays | <u>Sous-thème 5:</u><br>Communications libres |                    |
|                | <b>Abréviations</b>       | <b>STH : Sous-thème</b>                                                                                        | <b>S: Session</b>                                                                                              | <b>CO: Communication orale</b>                                         |                                                                                              | <b>P : Présentiel</b>                         | <b>L: En Ligne</b> |
|                | <b>Code couleur Salle</b> | Bâtiment<br>PSUT/Salle des Actes                                                                               | Amphithéâtre<br>UFR/SEA                                                                                        | Bâtiment PSUT<br>/Salle de Travaux Dirigés                             | Bâtiment PSUT<br>/Salle de vidéo-conférence                                                  |                                               |                    |
|                | <b>Autre code couleur</b> | <b>Conférence inaugurale / Panel/Table ronde</b>                                                               |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                              |                                               |                    |

| Heure<br>Lieu | Bâtiment PSUT<br>Salle des Actes         | Amphithéâtre<br>UFR/SEA                                                                                                                                                                           | Bâtiment PSUT<br>Salle de Travaux Dirigés                                                                                                 | Bâtiment PSUT<br>Salle de vidéo-conférence                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14H00 – 16H00 | <b>PREPARATION CEREMONIE D'OUVERTURE</b> | <b>Session 3 Sous-thème 5</b><br><b>Modérateurs:</b><br>Pr Rasmata OUEÐRAOGO<br>Pr Olga LOMPO<br><b>Rapporteurs:</b><br>Dr Adama ZIDA<br>Dr Absétou BA                                            | <b>Session 1 Sous-thème 2</b><br><b>Modérateurs:</b><br>Dr Hama DIALLO<br>Dr Thérèse KAGONE<br><b>Rapporteur:</b><br>Dr Issaka YAMÉOGO    | <b>Session 2 Sous-thème 3</b><br><b>Modérateur:</b><br>Pr Arouna OUEÐRAOGO<br><b>Rapporteurs:</b><br>Mme Odette KI-ZERBO<br>Dr Moumouni NIAONE                             |
|               |                                          | STH-5-S3-COP-25<br>Pneumococcal Carriage and Antibiotic Resistance in Children Younger than 5 Years in Nouna District, Burkina Faso                                                               |                                                                                                                                           | STH-3-S2-COP-13<br>Perception de la communauté sur le positionnement du Ministère de la santé (MS) en réponse à la COVID-19 au Burkina Faso                                |
|               |                                          | STH-5-S3-COP-26<br>Panorama des pathologies parasitaires dans le service des maladies infectieuses du CHU YO de 2010 à 2019                                                                       | STH-2-S1-COP-2<br>Surveillance sentinelle de la dengue dans la ville de Ouagadougou : la part explicative du temps et de l'environnement. | STH-3-S2-COP-14<br>Conduites suicidaires chez les populations déplacées internes : résultats préliminaires d'une étude réalisée en 2021 dans trois régions au Burkina Faso |
|               |                                          | STH-5-S3-COP-27<br>Activité anti-résistance bactérienne de <i>Securidaca longepedunculata</i> Fresen (Polygalaceae) : Activité anti-quorum sensing et anti-biofilm                                | STH-2-S1-COP-3<br>Investigation d'une épidémie de choléra à Katanga dans la commune du Golfe 1, Grand Lomé, Togo, Novembre 2020           | STH-3-S2-COP-15<br>Résultats préliminaires sur la dépression chez la femme en population générale au Burkina Faso en 2021                                                  |
|               |                                          | STH-5-S3-COP-28<br>Profil de susceptibilité aux antifongiques des souches cliniques de <i>Candida albicans</i> isolées au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso          | STH-2-S1-COP-4<br>Analyse de données de surveillance de la Fièvre Jaune Mali, 2010 à 2019                                                 | STH-3-S2-COP-16<br>Connaissances et attitudes des populations déplacées internes (PDI) sur la covid-19 au Burkina Faso en 2021 : résultats préliminaires                   |
|               |                                          | STH-5-S3-COP-29<br>Caractérisation de la résistance aux antibiotiques, identification des gènes de résistance et des plasmides de souches de <i>Salmonella</i> isolées de poulets au Burkina Faso | STH-2-S1-COP-5<br>Système burkinabè de pharmacovigilance : réglementation, organisation et principaux défis                               | STH-3-S2-COP-17<br>Expérience des adolescents avec la COVID-19 en Afrique sub-Saharienne Résultats d'une enquête téléphonique au Burkina Faso, en Éthiopie et au Nigeria   |

14H00 – 16H00

## PREPARATION CEREMONIE D'OUVERTURE

|                 |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STH-5-S3-COP-30 | Evaluation en milieu naturel de l'efficacité de la pommade MAÏA® contre les moustiques de Goden au Burkina Faso.                                                                                                    | STH-2-S1-COP-6  | Pharmacovigilance des médicaments à base de plantes en pédiatrie                                                                                  | STH-3-S2-COL-18 | Facteurs associés à l'acceptabilité des mesures gouvernementales face à la COVID-19 au Sénégal                                             |
| STH-5-S3-COP-31 | Distribution, comportement et niveau d'infection des membres du complexe <i>Anopheles gambiae</i> en période de transmission du paludisme dans trois districts sanitaires de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso. | STH-2-S1-COP-7  | Dualité du système de surveillance épidémiologique en contexte pandémique, nécessité d'appropriation des soins de santé primaire au Burkina Faso. | STH-3-S2-COL-19 | COVID-19 en Côte d'Ivoire : Impact des rumeurs dans la stratégie gouvernementale de lutte contre la pandémie                               |
| STH-5-S3-COL-32 | Antibiotic Susceptibility of Enterobacterales and Cocci Uropathogens In Patients Attending Regional Hospital in Burkina Faso: Cross-sectional Study.                                                                |                 |                                                                                                                                                   | STH-3-S2-COL-20 | Communication de santé publique et Covid-19 dans l'espace public télévisuel au Burkina                                                     |
| STH-5-S3-COL-33 | Connaissances et Pratiques des Étudiants en Pharmacie à l'Université Cheikh Anta Diop sur l'Utilisation et la Résistance aux Antibiotiques (Sénégal)                                                                | STH-2-S1-COP-9  | Évaluation du système de surveillance épidémiologique de la méningite, Sikasso, Mali 2019                                                         | STH-3-S2-COL-21 | Informations et dynamiques comportementales face à la lutte contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire : de mars 2020 à aujourd'hui               |
| STH-5-S3-COL-34 | Prevalence and antibioresistance of <i>Escherichia coli</i> and <i>Salmonella</i> isolated from lettuce and 13rrigation water in Ouagadougou, Burkina Faso                                                          | STH-2-S1-COP-10 | Évaluation du système de surveillance de la rougeole dans le district sanitaire de Banamba, Mali, 2019.                                           | STH-3-S2-COL-22 | Connaissances, attitudes et pratiques face à la COVID-19 chez les patients souffrant de maladie cardiovasculaire à Parakou (Bénin) en 2021 |

|                 |                                                                                                                     |                |                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STH-5-S3-COL-35 | Prévalence et facteurs associés aux infections transmises par la transfusion chez les donneurs de sang Burkina-Faso | STH5-SS-COP-Y1 | Facteurs associés au faible poids de naissance dans la ville de Ouagadougou : étude cas-témoins               | STH-1-S3-COP-25 | Aspects épidémiologiques et management de la COVID 19 au Burkina Faso : Cas du District sanitaire de Tenkodogo                                 |
|                 | Association entre l'anticoagulant lupique et la pré-éclampsie sévère / éclampsie à Ouagadougou au Burkina Faso      |                | Hypertension artérielle incidente et facteurs associés dans les établissements pénitentiaires au Burkina Faso |                 | Analyse de gestion des crises sanitaires épidémiques et pandémiques face au dilemme de l'approche médicale contre l'approche de santé publique |

16h30-18h30

## CEREMONIE D'OUVERTURE OFFICIELLE

Lieu : Bâtiment PSUT/Salle des Actes

**Patron : Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation**

**Parrain : Monsieur le Ministre de la Santé**

**Co-Parrain : Monsieur le Président du Conseil d'Administration de Coris Bank International**

|         |                    |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                              |                                               |             |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Légende | Sous-Thèmes        | <b>Sous-thème 1:</b><br>La science de l'analyse et de la gestion des risques et des urgences en santé publique | <b>Sous-thème 2 :</b><br>Les pratiques de surveillance épidémiologique dans le cadre des vigilances sanitaires | <b>Sous-thème 3:</b><br>La communication en période de crise sanitaire | <b>Sous-thème 4:</b><br>Le règlement sanitaire international et son application par les pays | <b>Sous-thème 5:</b><br>Communications libres |             |
|         | Abréviations       | STH : Sous-thème                                                                                               | S: Session                                                                                                     | CO: Communication orale                                                |                                                                                              | P : Présentiel                                | L: En Ligne |
|         | Code couleur Salle | Bâtiment PSUT/Salle des Actes                                                                                  | Amphithéâtre UFR/SEA                                                                                           | Bâtiment PSUT /Salle de Travaux Dirigés                                | Bâtiment PSUT /Salle de vidéo-conférence                                                     |                                               |             |
|         | Autre code couleur | Conférence inaugurale / Panel/Table ronde                                                                      |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                              |                                               |             |

## Vendredi 17 Décembre 2021

| Heure         | Bâtiment PSUT<br>Salle des Actes                                                                                                                                                                                                                     | Amphithéâtre<br>UFR/SEA                                                                                        | Bâtiment PSUT<br>Salle de Travaux<br>Dirigés                                                                   | Bâtiment PSUT<br>Salle de vidéo-<br>conférence                         |                                                                                              |                                               |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Lieu          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                              |                                               |  |
| 08H00 – 10H30 | <b>Table ronde 1 :</b><br><b>Analyse des défis associés à la vaccination par la COVID-19 au Burkina Faso par le Ministère de la santé</b>                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                              |                                               |  |
|               | Lieu : Bâtiment PSUT / Salle des Actes<br><b>Conférencier :</b><br>Directeur du CGCV<br>Représentant de l’OMS<br>Représentant du MS<br><b>Modérateur :</b><br>Pr Arouna OUEDRAOGO<br><b>Rapporteurs :</b><br>Dr Roger ZERBO<br>Dr Alphonse OUEDRAOGO |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                              |                                               |  |
| 10H30 – 11H00 | <b>Suspension de sessions</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                              |                                               |  |
|               | <b>Session Posters 1 à 15</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                              |                                               |  |
| Légende       | Sous-Thèmes                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sous-thème 1:</b><br>La science de l'analyse et de la gestion des risques et des urgences en santé publique | <b>Sous-thème 2 :</b><br>Les pratiques de surveillance épidémiologique dans le cadre des vigilances sanitaires | <b>Sous-thème 3:</b><br>La communication en période de crise sanitaire | <b>Sous-thème 4:</b><br>Le règlement sanitaire international et son application par les pays | <b>Sous-thème 5:</b><br>Communications libres |  |
|               | Abréviations                                                                                                                                                                                                                                         | STH : Sous-thème                                                                                               | S: Session                                                                                                     | CO: Communication orale                                                | P : Présentiel                                                                               | L: En Ligne                                   |  |
|               | Code couleur Salle                                                                                                                                                                                                                                   | Bâtiment PSUT/Salle des Actes                                                                                  | Amphithéâtre UFR/SEA                                                                                           | Bâtiment PSUT /Salle de Travaux Dirigés                                | Bâtiment PSUT /Salle de vidéo-conférence                                                     |                                               |  |
|               | Autre code couleur                                                                                                                                                                                                                                   | Conférence inaugurale / Panel/Table ronde                                                                      |                                                                                                                |                                                                        |                                                                                              |                                               |  |

| Heure         | Bâtiment PSUT<br>Salle des Actes                                                                                                         | Amphithéâtre<br>UFR/SEA                                                                                                                                                                     | Bâtiment PSUT<br>Salle de Travaux Dirigés                                                                                                                             | Bâtiment PSUT<br>Salle de vidéo-<br>conférence                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieu          | <b>Session 4 Sous-thème 5</b><br><br><b>Modérateur :</b><br>Pr Patrice ZABSONRÉ<br><br><b>Rapporteur :</b><br>Dr Yéri YOUL               | <b>Session 2 Sous-thème 1</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Pr Blami DAO<br>Dr Smaila OUEÐRAOGO<br><br><b>Rapporteur :</b><br>Dr Jocelyne GARÉ                                             | <b>Session 2 Sous-thème 2</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Pr Elie KABRE<br>Dr Hama Diallo<br><br><b>Rapporteurs :</b><br>Dr Seydou OUATTARA<br>Dr Ourohiré MILLOGO | <b>Session 3 Sous-thème 2</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Pr Nicolas MEDA<br>Dr Seydou OUATTARA/MS<br><br><b>Rapporteur :</b><br>Dr Elias DAH |
| 11H00 – 13H00 | STH-5-S4-COP-37                                                                                                                          | STH-1-S2-COP-13                                                                                                                                                                             | STH-2-S2-COP-13                                                                                                                                                       | STH-2-S3-COP-25                                                                                                                                  |
|               | Facteurs pronostiques de la létalité des Accidents Vasculaires Cérébraux au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou du Burkina Faso | Conséquences imprévisibles des pratiques d'atténuation des risques liés au COVID-19 : Les dispositifs à lavage de mains (DLMs) pourraient augmenter le risque de transmission de la dengue. | Rapport d'analyse des données de surveillance épidémiologique de la rougeole, Mali, 2010-2019.                                                                        | Correction des données du SNIS après les mouvements d'humeur des agents de santé en 2019 : données de vaccination                                |
|               | STH-5-S4-COP-38                                                                                                                          | STH-1-S2-COP-14                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | STH-2-S3-COL-26                                                                                                                                  |
|               | Prévention des maladies non transmissibles et sport selon les fonctionnaires de la ville de Bouake, Côte d'Ivoire                        | Investigation des cas confirmés de covid-19 dans le district sanitaire de Mandiana, Guinée du 11 au 30 aout 2020.                                                                           |                                                                                                                                                                       | Évaluation de la base de données de la tuberculose de 2010 a 2019 en Mauritanie                                                                  |
|               | STH-5-S4-COP-39                                                                                                                          | STH-1-S2-COP-15                                                                                                                                                                             | STH-2-S2-COP-15                                                                                                                                                       | STH-2-S3-COP-27                                                                                                                                  |
|               | Toxidermies graves au Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU de Bobo-Dioulasso (CHUSS)                                             | Analyse de la première année de la pandémie de la COVID-19 dans la région de Ouest Africaine                                                                                                | Profil épidémiologique de la rougeole en Guinée, 2004-2020.                                                                                                           | « Évaluation de la surveillance électronique des paralysies flasques aiguës dans le district sanitaire de Dori, Burkina Faso, 2021. »            |
|               | STH-5-S4-COP-40                                                                                                                          | STH-1-S2-COP-16                                                                                                                                                                             | STH-2-S2-COP-16                                                                                                                                                       | STH-2-S3-COP-28                                                                                                                                  |
|               | Connaissances et pratiques de la prescription des activités physiques et sportives par les médecins                                      | Prévalence et facteurs associés à l'hésitation à la vaccination contre la COVID-19 chez les utilisateurs des réseaux sociaux, Burkina Faso                                                  | Epidemiological profile of bite and rabies cases in the Republic of Guinea, 2011 – 2020                                                                               | Profil épidémiologique des animaux mordeurs mise en observation à l'Ecole Nationale d'Elevage et de Santé Animale, Burkina Faso 2016 – 2020      |
|               | STH-5-                                                                                                                                   | STH-1-                                                                                                                                                                                      | STH-2-                                                                                                                                                                | STH-2-                                                                                                                                           |
|               | Facteurs associés à la non observance thérapeutique chez                                                                                 | Investigation d'une épidémie de la covid-19 dans la ville de                                                                                                                                | Investigation autour des cas de fièvre jaune à Koundara et à                                                                                                          | Mise en place d'une surveillance épidémiologique des                                                                                             |

# 11H00 – 13H00

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                      |                 |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>STH-5-S4-COP-42</div> <div>STH-5-S4-COL-43</div> <div>STH-5-S4-COL-44</div> <div>STH-5-S4-COL-45</div> <div>STH-5-S4-COL-46</div> </div> | les drépanocytaires au Centre national de référence de la drépanocytose (CNRD) Niamey-Niger, 2021.                                                                                                              |                 | Maradi au Niger du 18 mai au 23 mai 2020.                                                                                                                 |                 | Kouroussa en Guinée, Janvier 2021                                                                                    |                 | méningites bactériennes basée sur les aires de santé au Niger                                                                |
|                                                                                                                                                     | Mesures hygiéno-diététiques appliquées par les diabétiques suivis a Bouake, Côte d'Ivoire.                                                                                                                      | STH-1-S2-COP-18 | Investigation d'un foyer de COVID-19, village de Gana, District sanitaire de Kombissiri, Région Centre-sud, Burkina Faso, Juillet 2020.                   | STH-2-S2-COP-18 | Les épidémies de méningites à Neisseria meningitidis au Burkina : revue systématique                                 | STH-2-S3-COP-30 | Evaluation du système de surveillance de la rage au district de la ville de Tahoua ,Niger 2015 à 2019                        |
|                                                                                                                                                     | Connaissance, attitude et pratique du personnel paramédical des districts sanitaires de Diourbel et de Bambey de la Région Médicale de Diourbel vis-à-vis du diabète : période du 10 juillet au 10 octobre 2020 |                 |                                                                                                                                                           | STH-2-S2-COP-19 | Evaluation du Système de Surveillance des morsures et de la Rage, région de Conakry, République de Guinée, 2018-2020 | STH-2-S3-COP-31 | Evaluation du système de surveillance du VIH dans la région de Tillabéri – Niger 2017 – 2019                                 |
|                                                                                                                                                     | Performance d'une communication pour le changement de comportement chez les personnes à risque du diabète de type 2 au Bénin                                                                                    | STH-1-S2-COL-20 | Raisons de la vaccination contre la COVID-19 chez les personnes vaccinées à l'antenne régionale d'hygiène publique de Bouaké, Côte d'Ivoire, juillet 2021 | STH-2-S2-COP-20 | Fréquence de la méningite à Haemophilus influenzae chez l'enfant de 0 à 15 ans au Burkina Faso de 2008 à 2018.       | STH-2-S3-COP-32 | Analyse des données de surveillance épidémiologique de la brucellose animale en Guinée de 2018-2020                          |
|                                                                                                                                                     | Etude de la connaissance et de la prévalence du diabète en milieu rural sénégalais en 2020                                                                                                                      | STH-1-S2-COL-21 | Facteurs associés à l'observance des mesures de prévention primaire de la COVID-19 dans deux marchés populaires à Cotonou en 2021                         | STH-2-S2-COP-21 | Investigation de cas d'ictères fébriles dans le district sanitaire de Barsalogho en 2020                             | STH-2-S3-COP-33 | Épidémiologie du choléra au Togo de 2011 à 2019                                                                              |
|                                                                                                                                                     | Profil épidémiologique des dermatoses professionnelles chez les garagistes automobiles de la ville de Parakou                                                                                                   | STH-1-S2-COL-22 | Facteurs associés au non-port de masques durant la pandémie de COVID-19, district sanitaire de Ratoma, Guinée, avril 2020.                                | STH-2-S2-COP-22 | Analyse des données de surveillance de la méningite bactérienne en Côte d'Ivoire de 2014 à 2019                      | STH-2-S3-COP-34 | Investigation d'un cas confirmé de Poliomyélite dans le district sanitaire de Koumassi, Abidjan, Côte d'Ivoire, Octobre 2020 |

|               |                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            |                 |                                                                                 |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|               | STH-5-S4-COL-47        | Prévalences des facteurs de risque comportementaux de maladies non transmissibles chez les étudiants de l'Université de Parakou (Bénin) en 2021 | STH-1-S2-COL-23                                                                                         | Les contributions à la riposte contre le coronavirus au Burkina Faso, dynamique vers un système résilient : résultats d'un living mapping |                                                                                       |                                                                            | STH-2-S3-COP-35 | Analyse des Données de La Surveillance de La PPCB, En Mauritanie de 2015 à 2020 |
|               |                        |                                                                                                                                                 | STH-1-S2-COL-24                                                                                         | Epidémiologie et Connaissances, attitudes et pratiques de la COVID-19 dans la Région de Tombouctou au Mali                                | STH-2-S2-COL-24                                                                       | Epidémiologie de la tuberculose en milieu communautaire à konobougou, Mali | STH-2-S3-COL-36 | Investigation d'une épidémie de coqueluche à Sikasso, Mali, 2020                |
| 13H00 – 14H00 | Suspension de sessions |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            |                 |                                                                                 |
|               | Session Posters 1 à 15 |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            |                 |                                                                                 |
| Légende       | Sous-Thèmes            | Sous-thème 1:<br>La science de l'analyse et de la gestion des risques et des urgences en santé publique                                         | Sous-thème 2 :<br>Les pratiques de surveillance épidémiologique dans le cadre des vigilances sanitaires | Sous-thème 3:<br>La communication en période de crise sanitaire                                                                           | Sous-thème 4:<br>Le règlement sanitaire international et son application par les pays | Sous-thème 5:<br>Communications libres                                     |                 |                                                                                 |
|               | Abréviations           | STH : Sous-thème    S: Session                                                                                                                  |                                                                                                         | CO: Communication orale                                                                                                                   |                                                                                       | P : Présentiel    L: En Ligne                                              |                 |                                                                                 |
|               | Code couleur Salle     | Bâtiment PSUT/Salle des Actes                                                                                                                   | Amphithéâtre UFR/SEA                                                                                    | Bâtiment PSUT /Salle de Travaux Dirigés                                                                                                   | Bâtiment PSUT /Salle de vidéo-conférence                                              |                                                                            |                 |                                                                                 |
|               | Autre code couleur     | Conférence inaugurale / Panel/Table ronde                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            |                 |                                                                                 |

| Heure<br>Lieu | Bâtiment PSUT<br>Salle des Actes                                                                                                                                                            | Amphithéâtre<br>UFR/SEA                                                                                                                                                                  | Bâtiment PSUT<br>Salle de Travaux<br>Dirigés                                                                                                                       | Bâtiment PSUT<br>Salle de vidéo-<br>conférence                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14H00 – 16H00 | <b>Session 5 Sous-thème 5</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Pr Bertin OUEDRAOGO<br>Pr Mohamed TALL<br><br><b>Rapporteurs</b><br>Dr Seydou OUATTARA                                         | <b>Session 6 Sous-thème 5</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Pr Diarra YÉ<br>Pr Blandine THIEBA<br><br><b>Rapporteur :</b><br>Dr. Laure TAMINI                                           | <b>Session 7 Sous-thème 5</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Pr Léon SAWADOGO<br>Dr Josias YAMEOGO<br><br><b>Rapporteur :</b><br>Dr. Joel KIENDREBÉOGO             | <b>Session 4 Sous-thème 2</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Pr. Jean TESTA<br>Dr. Norbert RAMDE<br><br><b>Rapporteurs :</b><br>Dr. Serges SOMDA<br>Dr. Ahmed KABORÉ |
|               | STH-5-S5-COP-49<br>Santé bucco-dentaire et grossesse : Connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de périnatalité dans les centres hospitaliers universitaires de Ouagadougou | STH-5-S6-COP-61<br>Facteurs associés à l'administration tardive du BCG en milieu rural au Burkina Faso                                                                                   | STH-5-S7-COP-73<br>Etude de l'activité hépatoprotectrice de l'extraire aqueux de <i>Celosia trigyna</i> Linn chez le rat de souches wistar                         | STH-2-S4-COP-37<br>Profil épidémiologique du choléra en Guinée 2010-2020.                                                                                            |
|               | STH-5-S5-COP-50<br>La carie dentaire et ses complications chez l'enfant : étude au Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire de Ouagadougou                                                  | STH-5-S6-COP-62<br>Motifs et délai avant la ré-hospitalisation chez les nourrissons de 2 à 23 mois dans le service de pédiatrie du Centre Hospitalier Régional de Banfora, Burkina Faso. | STH-5-S7-COP-74<br>Audit de gestion et pratiques de prescription en consultation de médecine dans les hôpitaux de district, région des Hauts-Bassins, Burkina-Faso | STH-2-S4-COP-38<br>Système d'information pour la gestion des épidémies au Burkina Faso : Entre théorie et réalité                                                    |
|               | STH-5-S5-COP-51<br>Periodontal Conditions and Pathogens Associated with Pre-Eclampsia: A Scoping Review                                                                                     | STH-5-S6-COP-63<br>Prévalence et facteurs associés à la mise au sein précoce en milieu rural au Burkina Faso                                                                             | STH-5-S7-COP-75<br>Evolution des dépenses de santé des ménages dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso de 2010 à 2019                                    | STH-2-S4-COP-39<br>Délais diagnostiques de la tuberculose pulmonaire et facteurs associés à leur allongement dans la région de Boké, Guinée, 2019-2020               |
|               | STH-5-S5-COP-52<br>Prévalence des affections bucco-dentaires et besoins en soins des personnes handicapées mentales dans les centres spécialisés de Ouagadougou, Burkina Faso               | STH-5-S6-COP-64<br>L'obésité des adolescents : un problème émergent en milieu scolaire au Burkina Faso                                                                                   | STH-5-S7-COP-76<br>Évaluation des déterminants de l'utilisation des mutuelles de santé par la population de la région de Ziguinchor                                | STH-2-S4-COP-40<br>Evaluation du système de surveillance du paludisme dans le district sanitaire de Koundara, Guinée, 2021                                           |

**14H00 – 16H00**

|                 |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STH-5-S5-COP-53 | Epidemiological aspects of cervicofacial cellulitis due to dental origin in the city of Ouagadougou (Burkina Faso)                            | STH-5-S6-COP-65 | Connaissances, attitudes et pratiques du personnel paramédical féminin du district sanitaire de Tivaouane de la Région Médicale de Thiés vis-à-vis du cancer du col de l'utérus en 2020      | STH-5-S7-COL-77 | Impact des normes et protocoles de prise en charge sur la qualité des soins dans les hôpitaux de zone Benin                                            | STH-2-S4-COP-41 | Evaluation du système de surveillance de la méningite en commune V du district de Bamako, Janvier 2015 – Décembre 2019. |
| STH-5-S5-COP-54 | Prévalence de la carie dentaire et les facteurs associés chez les personnes handicapées mentales dans les centres spécialisés de Ouagadougou. | STH-5-S6-COP-66 | Impacts possibles de la COVID-19 sur la santé de la mère et de l'enfant. État des lieux en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso.                                                            | STH-5-S7-COL-78 | Évaluation de la performance d'un service de chirurgie du CNHU-HKM, Bénin, dans le contexte de la COVID-19 en 2021                                     | STH-2-S4-COP-42 | Analyse des données de surveillance de la rougeole, Mali 2016-2020                                                      |
| STH-5-S5-COP-55 | Stratégie intégrée de dépistage et de prise en charge des cas de noma dans la région du sahel au Burkina-Faso                                 | STH-5-S6-COP-67 | Effets de la politique de gratuité des soins sur la fréquentation des services de santé par les enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso : analyse en séries chronologiques interrompues | STH-5-S7-COL-79 | Distance des formations sanitaires primaires et utilisation des services de santé par les enfants d'âge préscolaire                                    | STH-2-S4-COP-43 | Analyse de la base des données de la rage au Niger ,2015 à 2019                                                         |
| STH-5-S5-COL-56 | Inégalités sociales de carie dentaire des enfants sénégalais de Pikine, Sénégal : Faut-il incriminer les déterminants familiaux ?             | STH-5-S6-COL-68 | Évaluation qualitative du projet pilote des Sage-Femmes Itinérantes (SAFI) dans le district de Thilogne au Sénégal                                                                           | STH-5-S7-COL-80 | Management de la qualité du soin : enquête à l'unité d'Odontologie Conservatrice-Endodontie du Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire de Ouagadougou | STH-2-S4-COP-44 | Analyse de la base de données de la grippe aviaire à influenza aviaire du Niger, de 2009 à 2019.                        |
| STH-5-S5-COL-57 | Facteurs limitant la prévention de la carie dentaire chez la femme enceinte dans le district sanitaire de Koupéla, Burkina Faso               | STH-5-S6-COL-69 | Contribution des écoles des maris (EDM) du District Sanitaire (DS) de Matamèye dans la promotion de la santé maternelle au Niger en 2018                                                     | STH-5-S7-COL-81 | Indication de la prescription d'antibiotiques chez les enfants dans les formations sanitaires primaires dans les zones rurales du Burkina Faso         | STH-2-S4-COP-45 | Analyse des Données de surveillance de la Méningite au Mali de 2010 à 2019                                              |

|                      |                 |                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14H00 – 16H00</b> | STH-5-S5-COL-58 | La carie dentaire et ses complications : principaux motifs d'indication d'avulsion au centre municipal de santé bucco-dentaire de Ouagadougou, Burkina Faso | STH-5-S6-COL-70 | Violences basées sur le genre : Evolution et perspectives de lutte contre les mutilations génitales féminines au Bénin     | STH-5-S7-COL-82 | The financial architecture of vector borne diseases in Burkina Faso: Trends and allocations patterns                                          | STH-2-S4-COP-46 | Evaluation du système de surveillance de la rougeole à Conakry, Guinée du 01 janvier au 31 décembre 2020            |
|                      | STH-5-S5-COL-59 | Cancers de la cavité orale et facteurs associés en Afrique subsaharienne : revue systématique de la littérature                                             | STH-5-S6-COL-71 | Épidémiologie de l'insuffisance pondérale chez les nourrissons dans les zones rurales du Burkina Faso                      | STH-5-S7-COL-83 | Facteurs associés à l'utilisation irrationnelle des médicaments dans les ménages de la zone sanitaire Abomey-Calavi/So-Ava, au Bénin, en 2021 | STH-2-S4-COP-47 | Evaluation du système de surveillance sentinelle du choléra en Guinée, 2018.                                        |
|                      | STH-5-S5-COL-60 | Prévalence des malocclusions dentaires et besoin en traitement orthodontique des élèves de la ville de Boromo.                                              | STH-5-S6-COL-72 | Facteurs associés à la mise en œuvre des recommandations des audits de décès maternels dans deux zones sanitaires au Bénin | STH-5-S7-COL-84 | Rôle du pharmacien dans la mise en œuvre de la politique de l'Assurance Maladie Obligatoire au Mali                                           | STH-2-S4-COL-48 | Evaluation du système de surveillance épidémiologique de la rougeole en Communes I et II de Bamako, Mali, 2014-2018 |

|                      |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>17h00 – 19h00</b> | <b>2<sup>ème</sup> Assemblée Générale de la Société Burkinabé de Santé Publique</b><br><b>Participation des membres inscrits</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Lieu : Bâtiment PSUT/Salle des Actes

**Président de séance : Pr. Laurent OUÉDRAOGO**

**Rapporteurs : Pr. Hama DIALLO & Dr. Ahmed KABORÉ**

|                |                           |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                        |                                                                                              |                                               |  |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>Légende</b> | <b>Sous-Thèmes</b>        | <b>Sous-thème 1:</b><br>La science de l'analyse et de la gestion des risques et des urgences en santé publique | <b>Sous-thème 2:</b><br>Les pratiques de surveillance épidémiologique dans le cadre des vigilances sanitaires | <b>Sous-thème 3:</b><br>La communication en période de crise sanitaire | <b>Sous-thème 4:</b><br>Le règlement sanitaire international et son application par les pays | <b>Sous-thème 5:</b><br>Communications libres |  |
|                | <b>Abréviations</b>       | STH : Sous-thème                                                                                               | S: Session                                                                                                    | CO: Communication orale                                                | P : Présentiel                                                                               | L: En Ligne                                   |  |
|                | <b>Code couleur Salle</b> | Bâtiment PSUT/Salle des Actes                                                                                  | Amphithéâtre UFR/SEA                                                                                          | Bâtiment PSUT /Salle de Travaux Dirigés                                | Bâtiment PSUT /Salle de vidéo-conférence                                                     |                                               |  |
|                | <b>Autre code couleur</b> | Conférence inaugurale / Panel/Table ronde                                                                      |                                                                                                               |                                                                        |                                                                                              |                                               |  |

## Samedi 18 Décembre 2021

| Heure<br>Lieu | Bâtiment PSUT<br>Salle des Actes                                                                                                                                             | Amphithéâtre<br>UFR/SEA                                                                                                 | Bâtiment PSUT<br>Salle de Travaux<br>Dirigés                                                                               | Bâtiment PSUT<br>Salle de vidéo-<br>conférence                               |                                                                                                    |                                                  |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 08H00 - 10H30 | Table ronde 2 :<br>Le règlement sanitaire<br>international (RSI) et sa<br>mise en œuvre par les<br>différents pays, organisée<br>par l’OMS                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                    |                                                  |             |
|               | Lieu : Bâtiment PSUT/Salle des<br>Actes<br><br>Conférencier : OMS<br><br>Modérateurs :<br>Pr Rabiou CISSÉ<br>Pr Laurent OUÉDRAOGO<br><br>Rapporteurs:<br>Dr Thomas OUÉDRAOGO |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                    |                                                  |             |
| 10H30 – 11H00 | Suspension de sessions                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                    |                                                  |             |
|               | Session Posters 1 à 15                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                    |                                                  |             |
| Légende       | Sous-Thèmes                                                                                                                                                                  | <u>Sous-thème 1:</u><br>La science de l’analyse<br>et de la gestion des<br>risques et des urgences<br>en santé publique | <u>Sous-thème 2 :</u><br>Les pratiques de<br>surveillance<br>épidémiologique dans le<br>cadre des vigilances<br>sanitaires | <u>Sous-thème 3:</u><br>La communication en<br>période de crise<br>sanitaire | <u>Sous-thème 4:</u><br>Le règlement sanitaire<br>international et son<br>application par les pays | <u>Sous-thème 5:</u><br>Communications<br>libres |             |
|               | Abréviations                                                                                                                                                                 | STH : Sous-thème                                                                                                        | S: Session                                                                                                                 | CO: Communication orale                                                      |                                                                                                    | P : Présentiel                                   | L: En Ligne |
|               | Code couleur Salle                                                                                                                                                           | Bâtiment<br>PSUT/Salle des<br>Actes                                                                                     | Amphithéâtre<br>UFR/SEA                                                                                                    | Bâtiment PSUT<br>/Salle de<br>Travaux Dirigés                                | Bâtiment PSUT<br>/Salle de vidéo-<br>conférence                                                    |                                                  |             |
|               | Autre code couleur                                                                                                                                                           | Conférence inaugurale / Panel/Table ronde                                                                               |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                    |                                                  |             |

| Heure<br>Lieu | Bâtiment PSUT<br>Salle des Actes                                                                                                                                             | Amphithéâtre<br>UFR/SEA                                                                                                                                                                   | Bâtiment PSUT<br>Salle de Travaux Dirigés                                                                                                           | Bâtiment PSUT<br>Salle de vidéo-<br>conférence                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11H00 – 13H00 | <b>Session 8 Sous-thème 5</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Pr. Lassana SANGARÉ<br>Dr. Hama DIALLO<br><br><b>Rapporteurs :</b><br>Dr. Noélie YAMÉOGO<br>Dr. Désiré DAHOUROU | <b>Session 9 Sous-thème 5</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Dr. Estelle YOUL<br>Dr. Sandrine LOMPO<br><br><b>Rapporteurs :</b><br>Dr. Adama SANA<br>Dr. Benoît KAFANDO                   | <b>Session 10 Sous-thème 5</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Pr. Claudine LOUGUÉ<br>Dr. Maxime DRABO<br><br><b>Rapporteurs :</b><br>Dr Issa KABORÉ | <b>Session 11 Sous-thème 5</b><br><br><b>Modérateurs :</b><br>Dr Serges DIAGBOUGA<br>Dr Herman SORGHOU<br><br><b>Rapporteurs :</b><br>Dr. Jocelyne GARE<br>Dr Issouf TRAORÉ                   |
|               | STH-5-S8-COP-85<br>Impact de l'initiation rapide du traitement antiretroviral sur la réponse thérapeutique chez les HSH en Afrique de l'Ouest                                | STH-5-S9-COP-97<br>Conditions de travail des salariés au poste de décorticage d'anacardes à Bobo-Dioulasso                                                                                | STH-5-S10-COP-109<br>Effet du portage céphalique sur les paramètres cinématiques de la marche chez les enfants de 8 à 11 ans                        | STH-5-S11-COL-121<br>Evaluation de l'efficacité du projet « stratégie de réduction de la consommation du sel dans la commune de Porto-Novo »                                                  |
|               | STH-5-S8-COP-86<br>Adhésion au traitement des travailleuses du sexe PVVIH de la ville de Ouagadougou : analyse des déterminants selon les acteurs clés                       | STH-5-S9-COP-98<br>Analyse de la Base de Données du Dénombrement Annuel des Girafes dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W, Partie Nigérienne « Zone Girafe » de 2010 à 2019. | STH-5-S10-COP-110<br>Évaluation de l'âge osseux par l'IRM                                                                                           | STH-5-S11-COL-122<br>Évaluation de la qualité de l'eau de boisson et facteurs associés en milieu professionnel dans la ville de Parakou en 2018                                               |
|               | STH-5-S8-COP-87<br>Profil des travailleuses de sexe utilisant internet pour la recherche de clients au Burkina Faso : Implication pour la prévention du VIH/IST              | STH-5-S9-COP-99<br>Abondance et diversité des moustiques vecteurs de pathogènes en milieu hospitalier : cas de l'hôpital de district de Nouna, Burkina Faso                               | TH-5-S10-COP-111<br>Fracture de la jambe à l'hôpital général de référence de Niamey : aspect épidémiologique et lésionnel                           | STH-5-S11-COP-123<br>Etude de la disponibilité des produits à base de plantes médicinales dans les établissements de vente de produits alimentaires                                           |
|               | STH-5-S8-COP-88<br>Facteurs associés à la mortalité et à la perte de vue après initiation antirétrovirale au district sanitaire de Boromo                                    | STH-5-S9-COP-100<br>Evaluation du Système de Surveillance Ecologique dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W, Partie Nigérienne : Cas de la « Zone Girafe » de 2015 à 2019     | TH-5-S10-COP-112<br>Représentations et pratiques relationnelles en milieu de soins dans le contexte de gratuité au Burkina Faso                     | STH-5-S11-COP-124<br>Activités anti-inflammatoires in vivo et in vitro d'extraits de Pandiaka Angustifolia (Vahl.) Hepper (Amaranthacées) utilisés en médecine traditionnelle au Burkina Faso |

# 11H00 – 13H00

|                 |                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STH-5-S8-COP-89 | Facteurs associés à la couverture par les services de prévention du VIH parmi travailleuses du sexe séronégatives au Burkina Faso        | STH-5-S9-COP-101 | Situation nationale de la résistance aux insecticides chez <i>Aedes aegypti</i> principal vecteur de la transmission des arboviroses au Burkina-Faso | TH-5-S10-COP-113 | Humour et pratiques enseignante : quel enjeu pour l'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires du secondaire                      | STH-5-S11-COP-125 | Santé bucco-dentaire des enfants et jeunes du centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou              |
| STH-5-S8-COP-90 | Suivi préventif trimestriel et incidence du VIH chez des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes en Afrique de l'Ouest | STH-5-S9-COP-102 | Etude de la gestion des déchets biomédicaux dans le district sanitaire de Goudiry au Sénégal                                                         | TH-5-S10-COP-114 | Des enfants handicapés mentaux en famille : problématique de la prise en charge et de l'accompagnement psycho-éducatif des parents            | STH-1-S2-COP-26   | Modèle épidémiologique fractionnaire SEIRS au sens de Caputo : application à la dynamique de propagation de la COVID-19      |
| STH-5-S8-COP-91 | Facteurs de demande d'examen de dépistage de l'hépatite virale B (VHB) chez les femmes enceintes dans la région des Hauts Bassins        | STH-5-S9-COP-103 | Intoxication alimentaire mortelle dans une famille au Burkina Faso : apport des analyses toxicologiques dans la recherche des causes de décès.       | TH-5-S10-COP-115 | Douleurs lombaires chez les joueurs seniors de handball dans la ville de Ouagadougou                                                          | STH-2-S1-COP-1    | Évaluation du système de surveillance de la rougeole, district sanitaire de Tambacounda, Sénégal, 2019                       |
| STH-5-S8-COP-92 | Modélisation mathématique de la transmission du virus de l'hépatite B                                                                    | STH-5-S9-COP-104 | Prévalence et facteurs associés à l'hygiène des mains chez les adolescents scolarisés au Bénin                                                       | TH-5-S10-COL-116 | Risk factors for post-traumatic stress disorder in survivors of a road crash cohort: Results at 12 months of prospective follow-up            | STH-2-S1-COP-8    | Profil épidémiologique de la fièvre jaune au Sénégal de 2013 à 2019                                                          |
| STH-5-S8-COP-93 | Prévalence de l'hépatite virale B chez les travailleurs d'une entreprise agro-alimentaire à Bobo-Dioulasso                               | STH-5-S9-COP-105 | Accès aux ressources d'hygiène des mains dans les ménages béninois : Une analyse de l'Enquête Démographique et Sanitaire de 2018                     | TH-5-S10-COL-117 | Traumatisés graves par accidents de la route au Bénin : conditions de référence, caractéristiques des sujets et mortalité hospitalière        | STH-2-S1-COP-11   | Investigation d'un cas de Rage humaine à Yirimadio dans le district sanitaire de la Commune VI de Bamako, Mali, Juillet 2020 |
| STH-5-S8-COP-94 | Prévalence et facteurs associés à l'intention de consommer du tabac chez les étudiants de première année de l'université Joseph KI-ZERBO | STH-5-S9-COL-106 | Investigation de cas suspect de toxico-infection alimentaire dans le village de Mignoré, District sanitaire de Vavoua, Côte d'Ivoire, 2021           | TH-5-S10-COL-118 | Enquête de satisfaction des utilisateurs de produits sanguins du Centre national de transfusion sanguine selon le modèle tétraclasse de Llosa | STH-2-S2-COP-14   | Analyse des données de surveillance de la Péripleumonnie Contagieuse Bovine au Mali de 2011 à 2020                           |

|                      |                               |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | STH-5-S8-COL-95               | Prévalence et facteurs associés de la consommation du cannabis chez les adolescents scolarisés au Bénin         | STH-5-S9-COL-107                                                                                              | Évaluation des risques professionnels du brulage du plastiques chez les soudeurs à Parakou                           | TH-5-S10-COL-119                                                                             | Dévoilement d'abus sexuels sur mineurs à Cotonou : circonstances, attitudes et vécu des parents d'enfants                                                                                                     | STH-2-S2-COP-23 | Évaluation du Système de Surveillance de la Péripleumonie Contagieuse Bovine dans le District de Bamako au Mali, 2019-2020           |
|                      | STH-5-S8-COP-96               | Evaluation de la qualité des services offerts aux consommateurs d'héroïne par le Centre des Addictions de Dakar | STH-5-S9-COL-108                                                                                              | Prévalence et facteurs associés à la surcharge pondérale chez les adolescents scolarisés, Conakry, Guinée, mars 2020 | TH-5-S10-COL-120                                                                             | Usage des appareils électroniques audiovisuels par les adolescents de 10 à 19 ans dans la commune d'Abomey Calavi en 2021 : connaissances, attitudes et pratiques, et conséquences socio sanitaires associées | STH-1-S2-COP-19 | Profil épidémiologique des patients atteints de Covid-19 dans le district de Ksar, Nouakchott, Mauritanie du 16 mai au 15 août 2020. |
| <b>13H00 – 14H00</b> | <b>Suspension de sessions</b> |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                      |
|                      | <b>Session Posters 1 à 15</b> |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                      |
| <b>Légende</b>       | <b>Sous-Thèmes</b>            | <u>Sous-thème 1:</u><br>La science de l'analyse et de la gestion des risques et des urgences en santé publique  | <u>Sous-thème 2:</u><br>Les pratiques de surveillance épidémiologique dans le cadre des vigilances sanitaires | <u>Sous-thème 3:</u><br>La communication en période de crise sanitaire                                               | <u>Sous-thème 4:</u><br>Le règlement sanitaire international et son application par les pays | <u>Sous-thème 5:</u><br>Communications libres                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                      |
|                      | <b>Abréviations</b>           | STH : Sous-thème                                                                                                | S: Session                                                                                                    | CO: Communication orale                                                                                              |                                                                                              | P : Présentiel                                                                                                                                                                                                | L: En Ligne     |                                                                                                                                      |
|                      | <b>Code couleur Salle</b>     | Bâtiment PSUT/Salle des Actes                                                                                   | Amphithéâtre UFR/SEA                                                                                          | Bâtiment PSUT /Salle de Travaux Dirigés                                                                              | Bâtiment PSUT /Salle de vidéo-conférence                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                      |
|                      | <b>Autre code couleur</b>     | Conférence inaugurale / Panel/Table ronde                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                      |

| Heure<br>Lieu                                                                                             | Bâtiment PSUT<br>Salle des Actes | Amphithéâtre<br>UFR/SEA                                                                 | Bâtiment PSUT<br>Salle de Travaux<br>Dirigés | Bâtiment PSUT<br>Salle de vidéo-<br>conférence |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14H00 16H00                                                                                               | Préparation cérémonie de clôture | Session de formation sur ZOOM<br><br>Formateurs :<br>- Blaise GNOUMOU<br>- Ahmed KABORÉ |                                              |                                                |
| 16h30 – 18h30                                                                                             |                                  | CLOTURE OFFICIELLE                                                                      |                                              |                                                |
| Lieu : Bâtiment PSUT/Salle des Actes<br>Président : Monsieur le Président de l’Université Joseph KI-ZERBO |                                  |                                                                                         |                                              |                                                |

## LISTE ALPHABETIQUE DES COMMUNICANTS

### LISTE ALPHABETIQUE DES COMMUNICANTS

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                            | Titre    | Prénom(s)         | Nom               | Email                                                                      | Pays         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-2-S3-COP-35   | Analyse des Données de La Surveillance de La PPCB, En Mauritanie de 2015 à 2020.                                               | Monsieur | Navaa             | ABD EL WEHAB      | <a href="mailto:ssante.al.mr@gmail.com">ssante.al.mr@gmail.com</a>         | Mauritanie   |
| STH-5-S6-COL-70   | Violences basées sur le genre : Evolution et perspectives de lutte contre les mutilations génitales féminines au Bénin.        | Monsieur | PACOME            | ACOTCHEOU         | <a href="mailto:pacomeacotcheou@yahoo.fr">pacomeacotcheou@yahoo.fr</a>     | Bénin        |
| STH-5-S7-COP-75   | Evolution des dépenses de santé des ménages dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso de 2010 à 2019.                  | Monsieur | Edouard Atoudinne | AKOTIONGA         | <a href="mailto:aedouardako@gmail.com">aedouardako@gmail.com</a>           | Burkina Faso |
| P-11              | Investigation de Cas de COVID 19 au District Riyadh-Nouakchott, Mauritanie, Décembre 2020.                                     | Monsieur | Khavnach          | ALIOUNE           | <a href="mailto:aliourida59@gmail.com">aliourida59@gmail.com</a>           | Mauritanie   |
| STH-3-S1-COP-1    | Connaissance, Attitude et Perception vis-à-vis de la COVID-19 chez les personnes confinées à l'Hôtel Gaweys de Niamey en 2020. | Monsieur | Ibrahim           | ALKASSOUM SALIFOU | <a href="mailto:ibrahim_alkassoum@yahoo.fr">ibrahim_alkassoum@yahoo.fr</a> | Niger        |
| STH-5-S10-COL-119 | Dévoilement d'abus sexuels sur mineurs à Cotonou : circonstances, attitudes et vécu des parents d'enfants.                     | Madame   | Lucrèce           | ANAGONOU          | <a href="mailto:luccea2@gmail.com">luccea2@gmail.com</a>                   | Bénin        |
| STH-5-S11-COP-121 | Evaluation de l'efficacité du projet stratégie de réduction de la consommation du sel dans la commune de Porto-Novo .          | Madame   | Colette Sylvie    | AZANDJEME         | <a href="mailto:colsyaz@yahoo.fr">colsyaz@yahoo.fr</a>                     | Bénin        |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                                                                            | Titre    | Prénom(s)         | Nom       | Email                                                                  | Pays         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S10-COL-120 | Usage des appareils électroniques audiovisuels par les adolescents de 10 à 19 ans dans la commune d'Abomey Calavi en 2021 : connaissances, attitudes et pratiques, et conséquences socio sanitaires associées. | Madame   | Colette Sylvie    | AZANDJEME | <a href="mailto:colsyaz@yahoo.fr">colsyaz@yahoo.fr</a>                 | Bénin        |
| STH-2-S3-COP-26   | Evaluation de la base de données de la tuberculose de 2010 a 2019 en Mauritanie.                                                                                                                               | Monsieur | Hamet Abderahmane | BA        | <a href="mailto:hametba18@gmail.com">hametba18@gmail.com</a>           | Mauritanie   |
| STH-5-S8-COP-87   | Profil des travailleuses de sexe utilisant internet pour la recherche de clients au Burkina Faso : Implication pour la prévention du VIH/IST.                                                                  | Monsieur | Harouna           | BADO      | <a href="mailto:badoharouna537@gmail.com">badoharouna537@gmail.com</a> | Burkina Faso |
| STH-2-S1-COP-10   | Évaluation du système de surveillance de la rougeole dans le district sanitaire de Banamba, Mali, 2019.                                                                                                        | Monsieur | Aliou Badara      | BALLO     | <a href="mailto:alibaba.abb65@gmail.com">alibaba.abb65@gmail.com</a>   | Mali         |
| STH-2-S2-COP-13   | Rapport d'analyse des données de surveillance épidémiologique de la rougeole, Mali, 2010-2019.                                                                                                                 | Monsieur | Aliou Badara      | BALLO     | <a href="mailto:alibaba.abb65@gmail.com">alibaba.abb65@gmail.com</a>   | Mali         |
| STH-5-S10-COP-113 | Humour et pratiques enseignante : quel enjeu pour l'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires du secondaire.                                                                                      | Monsieur | Missa             | BARRO     | <a href="mailto:barromissa@gmail.com">barromissa@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-5-S8-COP-94   | Prévalence et facteurs associés à l'intention de consommer du tabac chez les étudiants de première                                                                                                             | Monsieur | Mahamadou         | BARRO     | <a href="mailto:levieuxbarro@gmail.com">levieuxbarro@gmail.com</a>     | Burkina Faso |

| Code Présentation        | Titre communication                                                                                                                                   | Titre    | Prénom(s)        | Nom              | Email                                                                    | Pays         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                          | année de l'université Joseph KI-ZERBO.                                                                                                                |          |                  |                  |                                                                          |              |
| <b>STH-5-S10-COP-114</b> | Des enfants handicapés mentaux en famille : problématique de la prise en charge et de l'accompagnement psycho-éducatif des parents.                   | Madame   | Yasnoga Félicité | BARRO/COULIBAL Y | <a href="mailto:byasnog@gmail.com">byasnog@gmail.com</a>                 | Burkina Faso |
| STH-5-S3-COL-33          | Connaissances et Pratiques des Étudiants en Pharmacie à l'Université Cheikh Anta Diop sur l'Utilisation et la Résistance aux Antibiotiques (Sénégal). | Monsieur | Oumar            | BASSOUM          | <a href="mailto:oumar.bassoum@ucad.edu.sn">oumar.bassoum@ucad.edu.sn</a> | Sénégal      |
| <b>STH-3-S1-COP-7</b>    | Contribution des TIC à la gestion de la Covid-19 au Burkina Faso.                                                                                     | Monsieur | Lucien           | BATCHO           | <a href="mailto:lucien.batcho@gmail.com">lucien.batcho@gmail.com</a>     | Burkina Faso |
| <b>STH-1-S2-COL-23</b>   | Les contributions à la riposte contre le coronavirus au Burkina Faso, dynamique vers un système résilient : résultats d'un living mapping.            | Madame   | Fadima Yaya      | BOCOUM           | <a href="mailto:fadimabocoum@yahoo.fr">fadimabocoum@yahoo.fr</a>         | Burkina Faso |
| <b>STH-3-S1-COL-11</b>   | Acceptabilité des mesures de distanciation sociale : comment dire à quelqu'un de ne pas te rendre visite ? .                                          | Madame   | Fadima Yaya      | BOCOUM           | <a href="mailto:fadimabocoum@yahoo.fr">fadimabocoum@yahoo.fr</a>         | Burkina Faso |
| <b>STH-5-S7-COL-82</b>   | The financial architecture of vector borne diseases in Burkina Faso: Trends and allocations patterns.                                                 | Madame   | Fadima Yaya      | BOCOUM           | <a href="mailto:fadimabocoum@yahoo.fr">fadimabocoum@yahoo.fr</a>         | Burkina Faso |
| <b>STH-3-S1-COL-12</b>   | Perceptions de la COVID-19 des personnels de santé de première                                                                                        | Madame   | Fadima Yaya      | BOCOUM           | <a href="mailto:fadimabocoum@yahoo.fr">fadimabocoum@yahoo.fr</a>         | Burkina Faso |

| Code Présentation       | Titre communication                                                                                                                                                       | Titre    | Prénom(s)            | Nom      | Email                                                                        | Pays         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                         | ligne de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso.                                                                                                                           |          |                      |          |                                                                              |              |
| <b>STH-1-S3-COP-25</b>  | Aspects épidémiologiques et management de la COVID 19 au Burkina Faso : Cas du District sanitaire de Tenkodogo.                                                           | Monsieur | Dounsoe Jules Valéry | BONZI    | <a href="mailto:julesvalerybonzi@yahoo.fr">julesvalerybonzi@yahoo.fr</a>     | Burkina Faso |
| <b>STH-5-S9-COP-102</b> | Etude de la gestion des déchets biomédicaux dans le district sanitaire de Goudiry au Sénégal.                                                                             | Monsieur | Martial Coly         | BOP      | <a href="mailto:martialcoly.bop@uadb.edu.sn">martialcoly.bop@uadb.edu.sn</a> | Sénégal      |
| <b>STH-5-S7-COP-76</b>  | Évaluation des déterminants de l'utilisation des mutuelles de santé par la population de la région de Ziguinchor.                                                         | Monsieur | Martial Coly         | BOP      | <a href="mailto:martialcoly.bop@uadb.edu.sn">martialcoly.bop@uadb.edu.sn</a> | Sénégal      |
| <b>STH-5-S5-COP-55</b>  | Stratégie intégrée de détection précoce et de prise en charge des cas de noma dans la région du sahel au Burkina-Faso.                                                    | Monsieur | Souleymane           | BOUGOUM  | <a href="mailto:bougoums@yahoo.fr">bougoums@yahoo.fr</a>                     | Burkina Faso |
| <b>STH-5-S5-COP-49</b>  | Santé bucco-dentaire et grossesse : Connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de périnatalité dans les centres hospitaliers universitaires de Ouagadougou. | Monsieur | Fatao                | BOUGSERY | <a href="mailto:bougseryf@gmail.com">bougseryf@gmail.com</a>                 | Burkina Faso |
| <b>STH-2-S2-COP-17</b>  | Investigation autour des cas de fièvre jaune à Koundara et à Kouroussa en Guinée, Janvier 2021.                                                                           | Monsieur | NABY                 | CAMARA   | <a href="mailto:nabycamarap47@gmail.com">nabycamarap47@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| <b>STH-2-S4-COP-46</b>  | Evaluation du système de surveillance de la rougeole à                                                                                                                    | Monsieur | NABY                 | CAMARA   | <a href="mailto:nabycamarap47@gmail.com">nabycamarap47@gmail.com</a>         | Burkina Faso |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                       | Titre    | Prénom(s)       | Nom            | Email                                                                | Pays                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   | Conakry, Guinée du 01 janvier au 31 décembre 2020.                                                                                        |          |                 |                |                                                                      |                      |
| STH-2-S2-COP-15   | Profil épidémiologique de la rougeole en Guinée, 2004-2020.                                                                               | Monsieur | NABY            | CAMARA         | <a href="mailto:nabycamarap47@gmail.com">nabycamarap47@gmail.com</a> | Burkina Faso         |
| P-02              | Investigation autour d'un cas Ebola confirmé en Côte d'Ivoire en provenance de Guinée, Août 2021.                                         | Monsieur | NABY            | CAMARA         | <a href="mailto:nabycamarap47@gmail.com">nabycamarap47@gmail.com</a> | Burkina Faso         |
| STH-1-S1-COL-12   | Investigation des cas suspects de COVID-19 dans le District Sanitaire de Nongr-Massom, Ouagadougou, Burkina-Faso, Mars-Mai 2020.          | Monsieur | Marcelino       | CORREIA NANQUE | <a href="mailto:sr.marcel86@gmail.com">sr.marcel86@gmail.com</a>     | République de Guinée |
| STH-5-S10-COL-116 | Risk factors for post-traumatic stress disorder in survivors of a road crash cohort: Results at 12 months of prospective follow-up.       | Monsieur | Donatien        | DADDAH         | <a href="mailto:donadah@yahoo.fr">donadah@yahoo.fr</a>               | Bénin                |
| STH-5-S8-COP-85   | Impact de l'initiation rapide du traitement antiretroviral sur la réponse thérapeutique chez les HSH en Afrique de l'Ouest.               | Monsieur | Ter Tiero Elias | DAH            | <a href="mailto:tertiero81@yahoo.fr">tertiero81@yahoo.fr</a>         | Burkina Faso         |
| STH-5-S8-COP-90   | Suivi préventif trimestriel et incidence du VIH chez des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes en Afrique de l'Ouest. | Monsieur | Ter Tiero Elias | DAH            | <a href="mailto:tertiero81@yahoo.fr">tertiero81@yahoo.fr</a>         | Burkina Faso         |
| STH-5-S6-COP-64   | L'obésité des adolescents : un problème émergent en milieu scolaire au Burkina Faso.                                                      | Monsieur | Désiré Lucien   | DAHOUROU       | <a href="mailto:ddahourou@yahoo.fr">ddahourou@yahoo.fr</a>           | Burkina Faso         |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                                                          | Titre    | Prénom(s)        | Nom     | Email                                                                      | Pays         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S1-COP-6    | Evaluation de l'efficacité thérapeutique de deux combinaisons à base d'artémisinine pour le traitement du paludisme simple chez les enfants au Burkina Faso                                  | Monsieur | Siaka            | DEBE    | <a href="mailto:sk.debe@gmail.com">sk.debe@gmail.com</a>                   | Burkina Faso |
| STH-5-S6-COP-67   | Effets de la politique de gratuité des soins sur la fréquentation des services de santé par les enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso : analyse en séries chronologiques interrompues | Monsieur | Siaka            | DEBE    | <a href="mailto:sk.debe@gmail.com">sk.debe@gmail.com</a>                   | Burkina Faso |
| STH-5-S3-COL-32   | Antibiotic Susceptibility of Enterobacteriales and Cocci Uropathogens In Patients Attending Regional Hospital in Burkina Faso: Cross-sectional Study.                                        | Monsieur | René             | DEMBELE | <a href="mailto:simavedemb@gmail.com">simavedemb@gmail.com</a>             | Burkina Faso |
| STH-2-S1-COP-4    | Analyse de données de surveillance de la Fièvre Jaune Mali, 2010 à 2019.                                                                                                                     | Monsieur | Hamadou Boubacar | DIABY   | <a href="mailto:hamadoudiaby1@gmail.com">hamadoudiaby1@gmail.com</a>       | Mali         |
| STH-2-S3-COP-28   | Profil épidémiologique des animaux mordeurs mise en observation à l'Ecole Nationale d'Elevage et de Santé Animale, Burkina Faso 2016 – 2020.                                                 | Madame   | Djénèbou         | DIAKITE | <a href="mailto:diakitdjnbou@yahoo.fr">diakitdjnbou@yahoo.fr</a>           | Burkina Faso |
| STH-3-S2-COL-18   | Facteurs associés à l'acceptabilité des mesures gouvernementales face à la COVID-19 au Sénégal.                                                                                              | Monsieur | Amadou Ibra      | DIALLO  | <a href="mailto:dialloamadouibra@gmail.com">dialloamadouibra@gmail.com</a> | Sénégal      |
| STH-5-S4-COL-45   | Etude de la connaissance et de la prévalence du diabète en milieu rural sénégalais en 2020.                                                                                                  | Monsieur | Amadou Ibra      | DIALLO  | <a href="mailto:dialloamadouibra@gmail.com">dialloamadouibra@gmail.com</a> | Sénégal      |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                                   | Titre    | Prénom(s)      | Nom    | Email                                                                      | Pays         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P-12              | Connaissance, Attitudes et pratique sur la rage à Niakhène au Sénégal en 2020.                                                                                        | Monsieur | Amadou Ibra    | DIALLO | <a href="mailto:dialloamadouibra@gmail.com">dialloamadouibra@gmail.com</a> | Sénégal      |
| STH-5-S2-COP-19   | Déclarations et pratiques des mères en matière d'allaitement exclusif en milieu rural au Burkina Faso.                                                                | Monsieur | Abdoulaye Hama | DIALLO | <a href="mailto:hamadial@yahoo.fr">hamadial@yahoo.fr</a>                   | Burkina Faso |
| STH-5-S6-COP-63   | Prévalence et facteurs associés à la mise au sein précoce en milieu rural au Burkina Faso.                                                                            | Monsieur | Abdoulaye Hama | DIALLO | <a href="mailto:hamadial@yahoo.fr">hamadial@yahoo.fr</a>                   | Burkina Faso |
| STH-5-S6-COP-62   | Motifs et délai avant la ré-hospitalisation chez les nourrissons de 2 à 23 mois dans le service de pédiatrie du Centre Hospitalier Régional de Banfora, Burkina Faso. | Monsieur | Abdoulaye Hama | DIALLO | <a href="mailto:hamadial@yahoo.fr">hamadial@yahoo.fr</a>                   | Burkina Faso |
| STH-2-S2-COP-20   | Fréquence de la méningite à Haemophilus influenzae chez l'enfant de 0 à 15 ans au Burkina Faso de 2008 à 2018.                                                        | Monsieur | Ismaël         | DIALLO | <a href="mailto:illah_diallo@hotmail.com">illah_diallo@hotmail.com</a>     | Burkina Faso |
| STH-2-S4-COP-38   | Système d'information pour la gestion des épidémies au Burkina Faso : Entre théorie et réalité.                                                                       | Monsieur | Cheick Omar    | DIALLO | <a href="mailto:cheick23@gmail.com">cheick23@gmail.com</a>                 | Burkina Faso |
| STH-5-S1-COL-12   | Le paludisme chez les enfants de quatre districts sanitaires du Burkina Faso en contexte de chimio-prévention saisonnière.                                            | Monsieur | Mamoudou       | DIALLO | <a href="mailto:dmbf.diallo@gmail.com">dmbf.diallo@gmail.com</a>           | Burkina Faso |
| P-06              | Evaluation de l'hygiène orale chez des patients présentant un besoin de réhabilitation prothétique.                                                                   | Monsieur | Abdoulaziz     | DIARRA | <a href="mailto:abdoulaziz483@yahoo.fr">abdoulaziz483@yahoo.fr</a>         | Burkina Faso |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                             | Titre    | Prénom(s)      | Nom      | Email                                                                      | Pays          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| P-07              | Prévalence des gingivites induites uniquement par la plaque au centre municipal de santé bucco-dentaire de la ville de Ouagadougou.             | Monsieur | Abdoulaziz     | DIARRA   | <a href="mailto:abdoulaziz483@yahoo.fr">abdoulaziz483@yahoo.fr</a>         | Burkina Faso  |
| STH-1-S3-COL-27   | Analyse de gestion des crises sanitaires épidémiques et pandémiques face au dilemme de l'approche médicale contre l'approche de santé publique. | Monsieur | Bassalia       | DIAWARA  | <a href="mailto:dbassalia3@gmail.com">dbassalia3@gmail.com</a>             | Bénin         |
| STH-5-S5-COP-59   | Cancers de la cavité orale et facteurs associés en Afrique subsaharienne : revue systématique de la littérature.                                | Monsieur | Amadou         | DIENG    | <a href="mailto:adieng00@gmail.com">adieng00@gmail.com</a>                 | Sénégal       |
| STH-3-S1-COL-10   | Modèles d'hésitation vaccinale contre la COVID-19 : quelle place pour la littératie en santé ?                                                  | Monsieur | Serigne Ndamé  | DIENG    | <a href="mailto:serigneddas@gmail.com">serigneddas@gmail.com</a>           | Sénégal       |
| STH-5-S5-COP-56   | Inégalités sociales de carie dentaire des enfants sénégalais de Pikine, Sénégal : Faut-il incriminer les déterminants familiaux ?               | Monsieur | Serigne Ndamé  | DIENG    | <a href="mailto:serigneddas@gmail.com">serigneddas@gmail.com</a>           | Sénégal       |
| STH-5-S8-COP-96   | Evaluation de la qualité des services offerts aux consommateurs d'héroïne par le Centre des Addictions de Dakar                                 | Monsieur | Cheikh Tacko   | DIOP     | <a href="mailto:cheikhtackodiop@gmail.com">cheikhtackodiop@gmail.com</a>   | Sénégal       |
| STH-3-S2-COL-21   | Informations et dynamiques comportementales face à la lutte contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire : de mars 2020 à aujourd'hui.                   | Monsieur | N'Cho François | DOFFOU   | <a href="mailto:ncho.doffou@uvci.edu.ci">ncho.doffou@uvci.edu.ci</a>       | Côte d'Ivoire |
| P-05              | Investigation de Cas de COVID 19 au District Sanitaire Boulmiougou,                                                                             | Monsieur | Bue            | DOMINGOS | <a href="mailto:clodedomingos@yahoo.com.br">clodedomingos@yahoo.com.br</a> | Guinée-Bissau |

| Code Présentation      | Titre communication                                                                                                           | Titre    | Prénom(s) | Nom           | Email                                                                    | Pays                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        | Ouagadougou, Burkina Faso, Mai 2020.                                                                                          |          |           |               |                                                                          |                      |
| <b>STH-1-S1-COP-6</b>  | Pratiques de port des équipements de protection individuelle des agents de santé du CHUP-CDG dans le contexte de la COVID-19. | Monsieur | Daniel    | DORI          | <a href="mailto:doridaniel@ymail.com">doridaniel@ymail.com</a>           | Burkina Faso         |
| <b>STH-2-S4-COP-40</b> | Evaluation du système de surveillance du paludisme dans le district sanitaire de koundara, Guinée, 2021.                      | Madame   | Fatoumata | DOUMBOUYA     | <a href="mailto:fifidoumbouya24@gmail.com">fifidoumbouya24@gmail.com</a> | République de Guinée |
| <b>STH-5-S1-COP-3</b>  | Profil épidémiologique du paludisme en Guinée de 2013 à 2020.                                                                 | Madame   | Fatoumata | DOUMBOUYA     | <a href="mailto:fifidoumbouya24@gmail.com">fifidoumbouya24@gmail.com</a> | République de Guinée |
| <b>STH-2-S1-COP-9</b>  | Évaluation du système de surveillance épidémiologique de la méningite, Sikasso, Mali 2019.                                    | Madame   | Dado      | FAROTA        | <a href="mailto:dadofatota@gmail.com">dadofatota@gmail.com</a>           | Mali                 |
| <b>STH-2-S4-COP-45</b> | Analyse des Données de surveillance de la Méningite au Mali de 2010 à 2019.                                                   | Madame   | Dado      | FAROTA        | <a href="mailto:dadofatota@gmail.com">dadofatota@gmail.com</a>           | Mali                 |
| <b>STH-2-S3-COP-30</b> | Evaluation du système de surveillance de la rage au district de la ville de Tahoua ,Niger 2015 à 2019.                        | Madame   | Mariama   | GAMBO CHABLA  | <a href="mailto:nanagamboc2011@gmail.com">nanagamboc2011@gmail.com</a>   | Niger                |
| <b>STH-2-S4-COP-43</b> | Analyse de la base des données de la rage au Niger ,2015 à 2019.                                                              | Madame   | Mariama   | GAMBO CHABLA  | <a href="mailto:nanagamboc2011@gmail.com">nanagamboc2011@gmail.com</a>   | Niger                |
| <b>STH-1-S1-COL-11</b> | Facteurs associés à la mortalité liée à la COVID-19 au Niger.                                                                 | Monsieur | Mohamed   | GARBA SALIFOU | <a href="mailto:mogas78@yahoo.fr">mogas78@yahoo.fr</a>                   | Niger                |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                           | Titre    | Prénom(s)                        | Nom                 | Email                                                              | Pays         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S5-COP-51   | Periodontal Conditions and Pathogens Associated with Pre-Eclampsia: A Scoping Review.                                                         | Madame   | Jocelyne<br>Valérie<br>Wendkouni | GARE                | <a href="mailto:jvgare@yahoo.fr">jvgare@yahoo.fr</a>               | Burkina Faso |
| STH-5-S5-COP-54   | Prévalence de la carie dentaire et les facteurs associés chez les personnes handicapées mentales dans les centres spécialisés de Ouagadougou. | Madame   | Jocelyne<br>Valérie<br>Wendkouni | GARE                | <a href="mailto:jvgare@yahoo.fr">jvgare@yahoo.fr</a>               | Burkina Faso |
| STH-2-S3-COP-31   | Evaluation du système de surveillance du VIH dans la région de Tillabéri – Niger 2017 – 2019.                                                 | Monsieur | Anizeou<br>Patrick<br>Clément    | GBAGUIDI            | <a href="mailto:gpatrickfr@gmail.com">gpatrickfr@gmail.com</a>     | Niger        |
| STH-2-S3-COP-32   | Analyse des données de surveillance épidémiologique de la brucellose animale en Guinée de 2018-2020.                                          | Monsieur | Pépé                             | GBAMOU              | <a href="mailto:gbamouezeki@gmail.com">gbamouezeki@gmail.com</a>   | Burkina Faso |
| STH-5-S6-COL-69   | Contribution des écoles des maris (EDM) du District Sanitaire (DS) de Matamèye dans la promotion de la santé maternelle au Niger en 2018.     | Monsieur | Maman Bachir                     | GONI DIT<br>ALASSAN | <a href="mailto:gonialassanb@gmail.com">gonialassanb@gmail.com</a> | Niger        |
| STH-5-S9-COL-107  | Évaluation des risques professionnels du brulage du plastiques chez les soudeurs à Parakou.                                                   | Monsieur | Ahoya<br>Christophe<br>Fabien    | GOUNONGBE           | <a href="mailto:gcfabien@yahoo.ca">gcfabien@yahoo.ca</a>           | Bénin        |
| STH-5-S11-COL-122 | Évaluation de la qualité de l'eau de boisson et facteurs associés en milieu professionnel dans la ville de Parakou en 2018.                   | Monsieur | Ahoya<br>Christophe<br>Fabien    | GOUNONGBE           | <a href="mailto:gcfabien@yahoo.ca">gcfabien@yahoo.ca</a>           | Bénin        |
| STH-5-S4-COL-46   | Profil épidémiologique des dermatoses professionnelles chez les garagistes automobiles de la ville de Parakou.                                | Monsieur | Ahoya<br>Christophe<br>Fabien    | GOUNONGBE           | <a href="mailto:gcfabien@yahoo.ca">gcfabien@yahoo.ca</a>           | Bénin        |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                              | Titre    | Prénom(s)                  | Nom          | Email                                                              | Pays         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-2-S4-COP-44   | Analyse de la base de données de la grippe aviaire à influenza aviaire du Niger, de 2009 à 2019.                                                 | Madame   | Ousseina                   | GUERO MAGALE | <a href="mailto:ousseinaguero@live.fr">ousseinaguero@live.fr</a>   | Niger        |
| STH-1-S2-COP-17   | Investigation d'une épidémie de la covid-19 dans la ville de Maradi au Niger du 18 mai au 23 mai 2020.                                           | Madame   | Ousseina                   | GUERO MAGALE | <a href="mailto:ousseinaguero@live.fr">ousseinaguero@live.fr</a>   | Niger        |
| STH-5-S5-COP-53   | Epidemiological aspects of cervicofacial cellulitis due to dental origin in the city of Ouagadougou (Burkina Faso).                              | Monsieur | Wendpouiré Patrice Laurent | GUIGUIMDE    | <a href="mailto:guiguimdew@yahoo.fr">guiguimdew@yahoo.fr</a>       | Burkina Faso |
| STH-5-S6-COP-66   | Impacts possibles de la COVID-19 sur la santé de la mère et de l'enfant. État des lieux en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso.                | Monsieur | Hervé                      | HIEN         | <a href="mailto:hien_herve@hotmail.com">hien_herve@hotmail.com</a> | Burkina Faso |
| STH-1-S1-COP-1    | Profil épidémiologique et clinique des enfants et adolescents atteints de COVID-19 dans la région centrale, Togo, 2020.                          | Monsieur | Péléké Mawaba              | HILIM        | <a href="mailto:hilimalain@yahoo.fr">hilimalain@yahoo.fr</a>       | Togo         |
| STH-5-S4-COL-47   | Prévalences des facteurs de risque comportementaux de maladies non transmissibles chez les étudiants de l'Université de Parakou (Bénin) en 2021. | Madame   | Yessito Corine Nadège      | HOUEHANOU    | <a href="mailto:yessito_fr@yahoo.fr">yessito_fr@yahoo.fr</a>       | Bénin        |
| STH-3-S2-COL-22   | Connaissances, attitudes et pratiques face à la COVID-19 chez les patients souffrant de maladie cardiovasculaire à Parakou (Bénin) en 2021.      | Madame   | Yessito Corine Nadège      | HOUEHANOU    | <a href="mailto:yessito_fr@yahoo.fr">yessito_fr@yahoo.fr</a>       | Bénin        |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                                                                              | Titre    | Prénom(s)    | Nom                | Email                                                                  | Pays         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S10-COL-117 | Traumatisés graves par accidents de la route au Bénin : conditions de référence, caractéristiques des sujets et mortalité hospitalière.                                                                          | Madame   | Bella        | HOUNKPE DOS SANTOS | <a href="mailto:belle.h.2012@gmail.com">belle.h.2012@gmail.com</a>     | Bénin        |
| STH-5-S9-COP-98   | Analyse de la Base de Données du Dénombrement Annuel des Girafes dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W, Partie Nigérienne Zone Girafe de 2010 à 2019.                                               | Monsieur | Issaka Abdou | IDRISSA            | <a href="mailto:issakadriss@gmail.com">issakadriss@gmail.com</a>       | Niger        |
| STH-5-S9-COP-100  | Evaluation du Système de Surveillance Ecologique dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W, Partie Nigérienne : Cas de la Zone Girafe de 2015 à 2019.                                                   | Monsieur | Issaka Abdou | IDRISSA            | <a href="mailto:issakadriss@gmail.com">issakadriss@gmail.com</a>       | Niger        |
| STH-5-S4-COP-39   | Toxidermies graves au Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU de Bobo-Dioulasso (CHUSS).                                                                                                                    | Monsieur | Dieudonné    | ILBOUDO            | <a href="mailto:ddilboudo@gmail.com">ddilboudo@gmail.com</a>           | Burkina Faso |
| STH-1-S1-COP-5    | Effets du Covid-19 sur le système de santé sénégalais : Cas du centre de gériatrie et gériatrie de Ouakam, Dakar, Sénégal. En 2021 .                                                                             | Monsieur | Ousseynou    | KA                 | <a href="mailto:ousseynou.ka@uadb.edu.sn">ousseynou.ka@uadb.edu.sn</a> | Sénégal      |
| STH-5-S4-COP-43   | Connaissance, attitude et pratique du personnel paramédical des districts sanitaires de Diourbel et de Bambey de la Région Médicale de Diourbel vis-à-vis du diabète : période du 10 juillet au 10 octobre 2020. | Monsieur | Ousseynou    | KA                 | <a href="mailto:ousseynou.ka@uadb.edu.sn">ousseynou.ka@uadb.edu.sn</a> | Sénégal      |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                                                      | Titre    | Prénom(s)                 | Nom    | Email                                                                  | Pays         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S6-COP-65   | Connaissances, attitudes et pratiques du personnel paramédical féminin du district sanitaire de Tivaouane de la Région Médicale de Thiés vis-à-vis du cancer du col de l'utérus en 2020. | Monsieur | Ousseynou                 | KA     | <a href="mailto:ousseynou.ka@uadb.edu.sn">ousseynou.ka@uadb.edu.sn</a> | Sénégal      |
| STH-5-S5-COL-57   | Facteurs limitant la prévention de la carie dentaire chez la femme enceinte dans le district sanitaire de Koupéla, Burkina Faso.                                                         | Monsieur | Aimé Désiré Wendpoulomd é | KABORE | <a href="mailto:dr_kabore@yahoo.fr">dr_kabore@yahoo.fr</a>             | Burkina Faso |
| STH-5-S7-COL-80   | Management de la qualité du soin : enquête à l'unité d'Odontologie Conservatrice-Endodontie du Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire de Ouagadougou.                                  | Monsieur | Aimé Désiré Wendpoulomd é | KABORE | <a href="mailto:dr_kabore@yahoo.fr">dr_kabore@yahoo.fr</a>             | Burkina Faso |
| STH-5-S5-COL-58   | La carie dentaire et ses complications : principaux motifs d'indication d'avulsion au centre municipal de santé bucco-dentaire de Ouagadougou, Burkina Faso.                             | Monsieur | Aimé Désiré Wendpoulomd é | KABORE | <a href="mailto:dr_kabore@yahoo.fr">dr_kabore@yahoo.fr</a>             | Burkina Faso |
| STH-5-S10-COP-109 | Effet du portage céphalique sur les paramètres cinématiques de la marche chez les enfants de 8 à 11 ans.                                                                                 | Monsieur | André                     | KABORE | <a href="mailto:ndrewkab77@gmail.com">ndrewkab77@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-3-S2-COL-20   | Communication de santé publique et Covid-19 dans l'espace public télévisuel au burkina.                                                                                                  | Monsieur | Lacina                    | KABORE | <a href="mailto:Lacinakabore@gmail.com">Lacinakabore@gmail.com</a>     | Burkina Faso |
| STH-5-S8-COP-86   | Adhésion au traitement des travailleuses du sexe PVVIH de la ville de Ouagadougou : analyse des déterminants selon les acteurs clés                                                      | Monsieur | Ahmed                     | KABORE | <a href="mailto:ahmedkaboreza@gmail.com">ahmedkaboreza@gmail.com</a>   | Burkina Faso |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                                                                   | Titre    | Prénom(s)  | Nom       | Email                                                                      | Pays         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-SS-COP-Y1   | Facteurs associés au faible poids de naissance dans la ville de Ouagadougou : étude cas-témoins                                                                                                       | Monsieur | Jean       | KABORE    | <a href="mailto:Jeankabore.muraz@gmail.com">Jeankabore.muraz@gmail.com</a> | Burkina Faso |
| STH-5-SS-COP-Y2   | Hypertension artérielle incidente et facteurs associés dans les établissements pénitentiaires au Burkina Faso                                                                                         | Monsieur | Jean       | KABORE    | <a href="mailto:Jeankabore.muraz@gmail.com">Jeankabore.muraz@gmail.com</a> | Burkina Faso |
| STH-5-S3-COP-29   | Caractérisation de la résistance aux antibiotiques, identification des gènes de résistance et des plasmides de souches de Salmonella isolées de poulets au Burkina Faso.                              | Madame   | ASSETA     | KAGAMBEGA | <a href="mailto:kagambega.asset@gmail.com">kagambega.asset@gmail.com</a>   | Burkina Faso |
| STH-3-S2-COP-13   | Perception de la communauté sur le positionnement du Ministère de la santé (MS) en réponse à la COVID-19 au Burkina Faso .                                                                            | Monsieur | Moubassira | KAGONE    | <a href="mailto:kmoubache@yahoo.fr">kmoubache@yahoo.fr</a>                 | Burkina Faso |
| STH-5-S1-COP-5    | Perception de la communauté sur la prévention du paludisme après l'introduction de nouvelles moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) dans les districts sanitaires de Banfora, Gaoua et Orodara. | Monsieur | Moubassira | KAGONE    | <a href="mailto:kmoubache@yahoo.fr">kmoubache@yahoo.fr</a>                 | Burkina Faso |
| STH-2-S3-COL-36   | Investigation d'une épidémie de coqueluche à Sikasso, Mali, 2020.                                                                                                                                     | Monsieur | Oumar      | KAMPO     | <a href="mailto:baroukampo@yahoo.fr">baroukampo@yahoo.fr</a>               | Mali         |
| STH-5-S3-COP-27   | Activité anti-résistance bactérienne de Securigaster longepedunculata                                                                                                                                 | Monsieur | Issa       | KARAMA    | <a href="mailto:isdok57@gmail.com">isdok57@gmail.com</a>                   | Burkina Faso |

| Code Présentation      | Titre communication                                                                                                                                                                                           | Titre    | Prénom(s)    | Nom          | Email                                                                | Pays         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        | Fresen (Polygalaceae) : Activité anti-quorum sensing et anti-biofilm.                                                                                                                                         |          |              |              |                                                                      |              |
| STH-5-S3-COP-25        | Pneumococcal Carriage and Antibiotic Resistance in Children Younger than 5 Years in Nouna District, Burkina Faso.                                                                                             | Monsieur | Dramane      | KIEMDE       | <a href="mailto:kiemdedra@gmail.com">kiemdedra@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| <b>STH-5-S8-COP-92</b> | Modélisation mathématique de la transmission du virus de l'hépatite B.                                                                                                                                        | Monsieur | Adama        | KIEMTORE     | <a href="mailto:kiemtoreadama@gmail.com">kiemtoreadama@gmail.com</a> | Burkina Faso |
| P-15                   | Rôle de la société civile et contribution des acteurs communautaires dans la lutte contre la COVID-19 au Burkina Faso.                                                                                        | Monsieur | Joël Arthur  | Kiendrébéogo | <a href="mailto:jkiendre@gmail.com">jkiendre@gmail.com</a>           | Burkina Faso |
| P-09                   | Contribution de la société civile à la promotion de la redevabilité dans les systèmes de santé en Afrique : le cas de l'Observatoire Communautaire sur l'Accès aux Services de Santé (OCASS) au Burkina Faso. | Monsieur | Joël Arthur  | Kiendrébéogo | <a href="mailto:jkiendre@gmail.com">jkiendre@gmail.com</a>           | Burkina Faso |
| <b>STH-5-S5-COP-52</b> | Prévalence des affections bucco-dentaires et besoins en soins des personnes handicapées mentales dans les centres spécialisés de Ouagadougou, Burkina Faso.                                                   | Monsieur | Filwende Dan | Kientega     | <a href="mailto:dkientega@gmail.com">dkientega@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| <b>STH-5-S1-COP-8</b>  | Prévalence du paludisme et couverture des interventions chez les femmes enceintes dans trois districts sanitaires du Burkina Faso : résultats intermédiaires                                                  | Monsieur | Réné         | KINDA        | <a href="mailto:rnkinda@yahoo.fr">rnkinda@yahoo.fr</a>               | Burkina Faso |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                        | Titre    | Prénom(s)               | Nom            | Email                                                                    | Pays                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| STH-5-S8-COL-95   | Prévalence et facteurs associés de la consommation du cannabis chez les adolescents scolarisés au Bénin.                                                   | Madame   | Elvyre                  | KLIKPO         | <a href="mailto:eklikpo@gmail.com">eklikpo@gmail.com</a>                 | Bénin                |
| STH-3-S2-COL-19   | COVID-19 en Côte d'Ivoire : Impact des rumeurs dans la stratégie gouvernementale de lutte contre la pandémie.                                              | Monsieur | komenan<br>simon pierre | KOFFI          | <a href="mailto:nanmeko@gmail.com">nanmeko@gmail.com</a>                 | Côte d'Ivoire        |
| STH-5-S9-COL-108  | Prévalence et facteurs associés à la surcharge pondérale chez les adolescents scolarisés, Conakry, Guinée, mars 2020.                                      | Monsieur | Enogo                   | KOIVOGUI       | <a href="mailto:enogo78@gmail.com">enogo78@gmail.com</a>                 | République de Guinée |
| P-10              | Investigation d'un cas confirmé de Rougeole, Aire sanitaire Duokro, District Sanitaire Yamoussoukro, Région Sanitaire Bélér, Cote d'Ivoire, Aout 2021.     | Madame   | Cynthia Djaya           | KOUAME / N'DRI | <a href="mailto:kouamecynthia03@gmail.com">kouamecynthia03@gmail.com</a> | Burkina Faso         |
| STH-1-S2-COL-20   | Raisons de la vaccination contre la COVID-19 chez les personnes vaccinées à l'antenne régionale d'hygiène publique de Bouaké, Côte d'Ivoire, juillet 2021. | Monsieur | Damus Paquin            | KOUASSI        | <a href="mailto:damuspaquin@gmail.com">damuspaquin@gmail.com</a>         | Côte d'Ivoire        |
| STH-3-S1-COL-8    | Acceptabilité de la vaccination contre la Covid-19 par les agents de santé de la région sanitaire de Gbèkè, Côte d'Ivoire, 2021.                           | Monsieur | Damus Paquin            | KOUASSI        | <a href="mailto:damuspaquin@gmail.com">damuspaquin@gmail.com</a>         | Côte d'Ivoire        |
| STH-3-S1-COL-9    | Vécu psychosocial des patients de la COVID-19 lors de leur confinement.                                                                                    | Monsieur | Damus Paquin            | KOUASSI        | <a href="mailto:damuspaquin@gmail.com">damuspaquin@gmail.com</a>         | Côte d'Ivoire        |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                       | Titre    | Prénom(s)        | Nom        | Email                                                                            | Pays         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-2-S2-COP-16   | Epidemiological profile of bite and rabies cases in the Republic of Guinea, 2011 – 2020.                                                  | Monsieur | Fassou           | KOUROUMA   | <a href="mailto:fassoukourouma8@gmail.com">fassoukourouma8@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-2-S2-COP-19   | Evaluation du Système de Surveillance des morsures et de la Rage, région de Conakry, République de Guinée, 2018-2020.                     | Monsieur | Fassou           | KOUROUMA   | <a href="mailto:fassoukourouma8@gmail.com">fassoukourouma8@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-5-S4-COP-37   | Facteurs pronostiques de la létalité des Accidents Vasculaires Cérébraux au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou du Burkina Faso. | Monsieur | HERVE            | KPODA      | <a href="mailto:kpodaherve@yahoo.fr">kpodaherve@yahoo.fr</a>                     | Burkina Faso |
| STH-5-S9-COP-104  | Prévalence et facteurs associés à l'hygiène des mains chez les adolescents scolarisés au Bénin                                            | Monsieur | Alphonse         | KPOZEHOUEN | <a href="mailto:alphonse.kpozehouen@gmail.com">alphonse.kpozehouen@gmail.com</a> | Bénin        |
| STH-5-S9-COP-105  | Accès aux ressources d'hygiène des mains dans les ménages béninois : Une analyse de l'Enquête Démographique et Sanitaire de 2018          | Monsieur | Alphonse         | KPOZEHOUEN | <a href="mailto:alphonse.kpozehouen@gmail.com">alphonse.kpozehouen@gmail.com</a> | Bénin        |
| STH-2-S1-COP-3    | Investigation d'une épidémie de choléra à Katanga dans la commune du Golfe 1, Grand Lomé, Togo, Novembre 2020.                            | Monsieur | Joseph Yendoukoi | LABITE     | <a href="mailto:labyen2@gmail.com">labyen2@gmail.com</a>                         | Togo         |
| STH-1-S1-COP-8    | Caractéristiques socio-épidémiologiques et cliniques des patients atteints de la COVID-19 au Niger 2020.                                  | Monsieur | Moussa           | MAMADOU    | <a href="mailto:mamadoumoussa2000@yahoo.fr">mamadoumoussa2000@yahoo.fr</a>       | Niger        |
| STH-1-S1-COP-2    | Etude des facteurs associés à la COVID-19 chez les personnes suspectes dans le district sanitaire I de Niamey.                            | Monsieur | Moussa           | MAMADOU    | <a href="mailto:mamadoumoussa2000@yahoo.fr">mamadoumoussa2000@yahoo.fr</a>       | Niger        |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                          | Titre    | Prénom(s)         | Nom      | Email                                                                      | Pays         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S4-COP-41   | Facteurs associés à la non observance thérapeutique chez les drépanocytaires au Centre national de référence de la drépanocytose (CNRD) Niamey- Niger, 2021. | Monsieur | Moussa            | MAMADOU  | <a href="mailto:mamadoumoussa2000@yahoo.fr">mamadoumoussa2000@yahoo.fr</a> | Niger        |
| STH-5-S6-COP-61   | Facteurs associés à l'administration tardive du BCG en milieu rural au Burkina Faso.                                                                         | Monsieur | Bountogo          | MAMADOU  | <a href="mailto:drbountogo@yahoo.fr">drbountogo@yahoo.fr</a>               | Burkina Faso |
| STH-5-S9-COP-103  | Intoxication alimentaire mortelle dans une famille au Burkina Faso: apport des analyses toxicologiques dans la recherche des causes de décès.                | Monsieur | Stanislas Dimitri | MEDA     | <a href="mailto:dimmedas@yahoo.fr">dimmedas@yahoo.fr</a>                   | Burkina Faso |
| STH-5-S2-COP-16   | Déterminants de la prise de décision des césariennes en urgence : cas d'étude à l'hôpital de district de Dafra, à Bobo Dioulasso, Burkina Faso.              | Monsieur | Ziémé Clément     | MEDA     | <a href="mailto:medacle1@yahoo.fr">medacle1@yahoo.fr</a>                   | Burkina Faso |
| STH-5-S7-COP-74   | Audit de gestion et pratiques de prescription en consultation de médecine dans les hôpitaux de district, région des Hauts-Bassins, Burkina-Faso.             | Monsieur | Ziémé Clément     | MEDA     | <a href="mailto:medacle1@yahoo.fr">medacle1@yahoo.fr</a>                   | Burkina Faso |
| STH-5-S8-COP-91   | Facteurs de demande d'examen de dépistage de l'hépatite virale B (VHB) chez les femmes enceintes dans la région des Hauts Bassins.                           | Monsieur | Ziémé Clément     | MEDA     | <a href="mailto:medacle1@yahoo.fr">medacle1@yahoo.fr</a>                   | Burkina Faso |
| STH-5-S4-COL-44   | Performance d'une communication pour le changement de                                                                                                        | Madame   | Clémence Germaine | METONNOU | <a href="mailto:metonnouc@yahoo.fr">metonnouc@yahoo.fr</a>                 | Bénin        |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                             | Titre    | Prénom(s)     | Nom                         | Email                                                                                    | Pays         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   | comportement chez les personnes à risque du diabète de type 2 au Bénin.                                                                                         |          |               |                             |                                                                                          |              |
| STH-1-S2-COL-22   | Facteurs associés au non-port de masques durant la pandémie de COVID-19, district sanitaire de Ratoma, Guinée, avril 2020.                                      | Monsieur | Tamba Jacques | MILLIMOUNO                  | <a href="mailto:millimounotambajacques1@gmail.com">millimounotambajacques1@gmail.com</a> | Burkina Faso |
| STH-5-S1-COP-2    | Indice de préparation des services de santé relatifs au paludisme et association avec la létalité palustre infantile.                                           | Monsieur | Ourohiré      | MILLOGO                     | <a href="mailto:ouohire2001@yahoo.fr">ouohire2001@yahoo.fr</a>                           | Burkina Faso |
| STH-3-S2-COP-17   | Expérience des adolescents avec la COVID-19 en Afrique sub-Saharienne Résultats d'une enquête téléphonique au Burkina Faso, en Éthiopie et au Nigeria.          | Monsieur | Ourohiré      | MILLOGO                     | <a href="mailto:ouohire2001@yahoo.fr">ouohire2001@yahoo.fr</a>                           | Burkina Faso |
| STH-1-S2-COP-19   | Profil épidémiologique des patients atteints de Covid-19 dans le district de ksar, Nouakchott, Mauritanie du 16 mai au 15 août 2020.                            | Monsieur | Yacoub        | Mohamed El Kory Sidi Mactar | <a href="mailto:y.sidimoctar@gmail.com">y.sidimoctar@gmail.com</a>                       | Mauritanie   |
| STH-5-S11-COP-123 | Etude de la disponibilité des produits à base de plantes médicinales dans les établissements de vente de produits alimentaires.                                 | Madame   | Aminata       | Nacoulma                    | <a href="mailto:natanac5@gmail.com">natanac5@gmail.com</a>                               | Burkina Faso |
| STH-5-S3-COP-28   | Profil de susceptibilité aux antifongiques des souches cliniques de Candida albicans isolées au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso. | Monsieur | Seydou        | Nakanabo Diallo             | <a href="mailto:seydou.nakanabo@centre-muraz.bf">seydou.nakanabo@centre-muraz.bf</a>     | Burkina Faso |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                             | Titre    | Prénom(s)        | Nom       | Email                                                                | Pays         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S4-COP-40   | Connaissances et pratiques de la prescription des activités physiques et sportives par les médecins.                                            | Madame   | Brigitte         | Nana      | <a href="mailto:nanabrigitte@ymail.com">nanabrigitte@ymail.com</a>   | Burkina Faso |
| STH-5-S1-COP-10   | Évaluation de l'effet de la CPS sur la prévalence du paludisme et la diversité génétique de Plasmodium falciparum à Saponé.                     | Monsieur | Seni             | NIKIEMA   | <a href="mailto:seninikiema@yahoo.fr">seninikiema@yahoo.fr</a>       | Burkina Faso |
| STH-5-S9-COP-99   | Abondance et diversité des moustiques vecteurs de pathogènes en milieu hospitalier : cas de l'hôpital de district de Nouna, Burkina Faso.       | Monsieur | Moustapha        | Nikiema   | <a href="mailto:moustapha8nik@gmail.com">moustapha8nik@gmail.com</a> | Burkina Faso |
| STH-1-S2-COP-18   | Investigation d'un foyer de COVID-19, village de Gana, District sanitaire de Kombissiri, Région Centre-sud, Burkina Faso, Juillet 2020.         | Monsieur | Franck Palamanga | OBULBIGA  | <a href="mailto:obulbigafranck@yahoo.fr">obulbigafranck@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |
| STH-5-S7-COL-79   | Distance des formations sanitaires primaires et utilisation des services de santé par les enfants d'âge préscolaire.                            | Monsieur | Mamadou          | OUATTARA  | <a href="mailto:md.ouattara@yahoo.fr">md.ouattara@yahoo.fr</a>       | Burkina Faso |
| STH-5-S7-COL-81   | Indication de la prescription d'antibiotiques chez les enfants dans les formations sanitaires primaires dans les zones rurales du Burkina Faso. | Monsieur | Mamadou          | OUATTARA  | <a href="mailto:md.ouattara@yahoo.fr">md.ouattara@yahoo.fr</a>       | Burkina Faso |
| STH-5-S6-COL-71   | Épidémiologie de l'insuffisance pondérale chez les nourrissons dans les zones rurales du Burkina Faso.                                          | Monsieur | Mamadou          | OUATTARA  | <a href="mailto:md.ouattara@yahoo.fr">md.ouattara@yahoo.fr</a>       | Burkina Faso |
| STH-1-S2-COP-13   | Conséquences imprévisibles des pratiques d'atténuation des risques liés au COVID-19 : Les dispositifs à                                         | Monsieur | W. Mathias       | OUEDRAOGO | <a href="mailto:math25x@yahoo.fr">math25x@yahoo.fr</a>               | Burkina Faso |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                           | Titre    | Prénom(s)             | Nom       | Email                                                        | Pays         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|                   | lavage de mains (DLMs) pourraient augmenter le risque de transmission de la dengue.                                                           |          |                       |           |                                                              |              |
| STH-2-S3-COP-27   | Évaluation de la surveillance électronique des paralysies flasques aiguës dans le district sanitaire de Dori, Burkina Faso, 2021.             | Monsieur | Hamed Sidwaya         | OUEDRAOGO | <a href="mailto:hamsid2001@yahoo.fr">hamsid2001@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |
| STH-5-S5-COP-50   | La carie dentaire et ses complications chez l'enfant : étude au Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire de Ouagadougou.                      | Madame   | Carole Nathalie Ténin | OUEDRAOGO | <a href="mailto:catenao@yahoo.fr">catenao@yahoo.fr</a>       | Burkina Faso |
| STH-5-S2-COP-14   | Facteurs associés aux abandons ou aux changements de méthodes contraceptives modernes au Burkina Faso.                                        | Monsieur | Smaila                | OUEDRAOGO | <a href="mailto:smaila11@yahoo.fr">smaila11@yahoo.fr</a>     | Burkina Faso |
| STH-5-S2-COP-15   | Etude des déterminants des accouchements dans le service d'obstétrique du Centre Hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO.                 | Monsieur | Smaila                | OUEDRAOGO | <a href="mailto:smaila11@yahoo.fr">smaila11@yahoo.fr</a>     | Burkina Faso |
| STH-5-S2-COP-17   | Urgences dans le service de maternité du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO : mode d'entrée et qualité de la prise en charge. | Monsieur | Smaila                | OUEDRAOGO | <a href="mailto:smaila11@yahoo.fr">smaila11@yahoo.fr</a>     | Burkina Faso |
| STH-5-S5-COP-60   | Prévalence des malocclusions dentaires et besoin en traitement orthodontique des élèves de la ville de Boromo.                                | Monsieur | Youssouf              | OUEDRAOGO | <a href="mailto:ouedraogoy@yahoo.fr">ouedraogoy@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                      | Titre    | Prénom(s)  | Nom                | Email                                                              | Pays         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-1-S1-COP-3    | Expérience du LNR-FHV dans la gestion de crise sanitaire : Déploiement du Laboratoire mobile P3 pour le diagnostic du COVID-19.                          | Monsieur | Saidou     | OUEDRAOGO          | <a href="mailto:saidou.muraz@yahoo.fr">saidou.muraz@yahoo.fr</a>   | Burkina Faso |
| STH-5-S1-COP-9    | Réponses humorales de <i>Plasmodium falciparum</i> chez des enfants et adultes semi-immuns vivant à Saponé au Burkina Faso                               | Monsieur | Nicolas    | OUEDRAOGO          | <a href="mailto:onicolas85@yahoo.fr">onicolas85@yahoo.fr</a>       | Burkina Faso |
| STH-3-S2-COP-14   | Conduites suicidaires chez les populations déplacées internes : résultats préliminaires d'une étude réalisée en 2021 dans trois régions au Burkina Faso. | Monsieur | Laurent T. | OUEDRAOGO          | <a href="mailto:laurent_tikar@yahoo.fr">laurent_tikar@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |
| STH-3-S1-COP-3    | Résultats préliminaires de l'étude sur l'état de stress post-traumatique en population générale au Burkina Faso en 2021.                                 | Monsieur | Laurent T. | OUEDRAOGO          | <a href="mailto:laurent_tikar@yahoo.fr">laurent_tikar@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |
| STH-3-S2-COP-15   | Résultats préliminaires sur la dépression chez la femme en population générale au Burkina Faso en 2021.                                                  | Monsieur | Laurent T. | OUEDRAOGO          | <a href="mailto:laurent_tikar@yahoo.fr">laurent_tikar@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |
| STH-3-S2-COP-16   | Connaissances et attitudes des populations déplacées internes (PDI) sur la covid-19 au Burkina Faso en 2021 : résultats préliminaires.                   | Monsieur | Laurent T. | OUEDRAOGO          | <a href="mailto:laurent_tikar@yahoo.fr">laurent_tikar@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |
| STH-3-S1-COP-5    | Gestion de la maladie à Corona virus dans la ville de Bobo-Dioulasso : pour une analyse des pratiques de l'autorité en période de crise sanitaire.       | Madame   | Awa        | OUEDRAOGO/<br>YMBA | <a href="mailto:ymbaw@yahoo.fr">ymbaw@yahoo.fr</a>                 | Burkina Faso |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                          | Titre    | Prénom(s)      | Nom      | Email                                                                  | Pays         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-2-S1-COP-5    | Système burkinabè de pharmacovigilance : réglementation, organisation et principaux défis.                                                   | Monsieur | Kampadilemba   | OUOBA    | <a href="mailto:ouobakampa@gmail.com">ouobakampa@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-2-S1-COP-6    | Pharmacovigilance des médicaments à base de plantes en pédiatrie.                                                                            | Monsieur | Kampadilemba   | OUOBA    | <a href="mailto:ouobakampa@gmail.com">ouobakampa@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-5-S3-COL-34   | Prevalence and antibioresistance of Escherichia coli and Salmonella isolated from lettuce and irrigation water in Ouagadougou, Burkina Faso. | Monsieur | Sibiri Sylvain | ROUAMBA  | <a href="mailto:rousib@yahoo.fr">rousib@yahoo.fr</a>                   | Burkina Faso |
| STH-1-S1-COP-9    | Investigation d'un cluster de COVID-19 dans une communauté confessionnelle, district sanitaire de l'Ogou, Togo, 2020.                        | Madame   | Monfaye        | SABI     | <a href="mailto:monfayesabi88@yahoo.fr">monfayesabi88@yahoo.fr</a>     | Togo         |
| STH-2-S3-COP-33   | Épidémiologie du choléra au Togo de 2011 à 2019.                                                                                             | Madame   | Monfaye        | SABI     | <a href="mailto:monfayesabi88@yahoo.fr">monfayesabi88@yahoo.fr</a>     | Togo         |
| STH-2-S1-COP-2    | Surveillance sentinelle de la dengue dans la ville de Ouagadougou : la part explicative du temps et de l'environnement.                      | Monsieur | Kéamou Tokpa   | SAGNO    | <a href="mailto:kjnsagno@gmail.com">kjnsagno@gmail.com</a>             | Burkina Faso |
| STH-5-S6-COL-72   | Facteurs associés à la mise en œuvre des recommandations des audits de décès maternels dans deux zones sanitaires au Bénin.                  | Monsieur | Jacques        | SAIZONOU | <a href="mailto:saizonoujacques@yahoo.fr">saizonoujacques@yahoo.fr</a> | Bénin        |
| STH-5-S7-COL-77   | Impact des normes et protocoles de prise en charge sur la qualité des soins dans les hôpitaux de zone Bénin.                                 | Monsieur | Jacques        | SAIZONOU | <a href="mailto:saizonoujacques@yahoo.fr">saizonoujacques@yahoo.fr</a> | Bénin        |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                           | Titre    | Prénom(s) | Nom    | Email                                                                | Pays         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-2-S1-COP-11   | Investigation d'un cas de Rage humaine à Yirimadio dans le district sanitaire de la Commune VI de Bamako, Mali, Juillet 2020. | Monsieur | Soumaïla  | SAMAKE | <a href="mailto:soumi.samake@yahoo.fr">soumi.samake@yahoo.fr</a>     | Mali         |
| STH-2-S2-COP-14   | Analyse des données de surveillance de la Péripleumonie Contagieuse Bovine au Mali de 2011 à 2020.                            | Monsieur | Soumaïla  | SAMAKE | <a href="mailto:soumi.samake@yahoo.fr">soumi.samake@yahoo.fr</a>     | Mali         |
| STH-2-S2-COP-23   | Évaluation du Système de Surveillance de la Péripleumonie Contagieuse Bovine dans le District de Bamako au Mali, 2019-2020.   | Monsieur | Soumaïla  | SAMAKE | <a href="mailto:soumi.samake@yahoo.fr">soumi.samake@yahoo.fr</a>     | Mali         |
| STH-5-S2-COL-22   | Facteurs associés aux décès maternels au Centre de Santé de Référence de Koulikoro de 2009 à 2018.                            | Monsieur | Oumar     | SANGHO | <a href="mailto:osangho75@gmail.com">osangho75@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-2-S4-COL-48   | Evaluation du système de surveillance épidémiologique de la rougeole en Communes I et II de Bamako, Mali, 2014-2018.          | Monsieur | Oumar     | SANGHO | <a href="mailto:osangho75@gmail.com">osangho75@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-1-S2-COL-24   | Epidémiologie et Connaissances, attitudes et pratiques de la COVID-19 dans la Région de Tombouctou au Mali.                   | Monsieur | Oumar     | SANGHO | <a href="mailto:osangho75@gmail.com">osangho75@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-5-S7-COL-84   | Rôle du pharmacien dans la mise en œuvre de la politique de l'Assurance Maladie Obligatoire au Mali.                          | Monsieur | Aboubacar | SANGHO | <a href="mailto:sanboucar@gmail.com">sanboucar@gmail.com</a>         | Mali         |
| STH-1-S1-COL-10   | Évaluation des pratiques d'hygiène et de prévention de la COVID_19 au CHU Point G du Mali.                                    | Monsieur | Moussa    | SANOGO | <a href="mailto:moussanogo2002@yahoo.fr">moussanogo2002@yahoo.fr</a> | Mali         |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                                              | Titre    | Prénom(s)        | Nom      | Email                                                          | Pays         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S11-COL-125 | Santé bucco-dentaire des enfants et jeunes du centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou.                                                                 | Madame   | Orokia           | SANOGO   | <a href="mailto:sorokia7@gmail.com">sorokia7@gmail.com</a>     | Burkina Faso |
| STH-2-S1-COP-7    | Dualité du système de surveillance épidémiologique en contexte pandémique, nécessité d'appropriation des soins de santé primaire au Burkina Faso.                                | Monsieur | Hamidou          | SANOU    | <a href="mailto:hsanou@ymail.com">hsanou@ymail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-5-S10-COP-112 | Représentations et pratiques relationnelles en milieu de soins dans le contexte de gratuité au Burkina Faso.                                                                     | Monsieur | Maurice          | SARIGDA  | <a href="mailto:maursarigda@yahoo.fr">maursarigda@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |
| STH-2-S2-COP-18   | Les épidémies de méningites à Neisseria meningitidis au Burkina : revue systématique.                                                                                            | Monsieur | Mamoudou         | SAVADOGO | <a href="mailto:savadoma@gmail.com">savadoma@gmail.com</a>     | Burkina Faso |
| STH-5-S3-COP-26   | Panorama des pathologies parasitaires dans le service des maladies infectieuses du CHU YO de 2010 à 2019.                                                                        | Monsieur | Mamoudou         | SAVADOGO | <a href="mailto:savadoma@gmail.com">savadoma@gmail.com</a>     | Burkina Faso |
| STH-1-S1-COP-7    | Étude comparative des manifestations cliniques observées chez les patients positifs versus patients négatifs de COVID-19 au CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou (Burkina Faso). | Monsieur | Mamoudou         | SAVADOGO | <a href="mailto:savadoma@gmail.com">savadoma@gmail.com</a>     | Burkina Faso |
| P-01              | Le syndrome de prune Belly, quand une malformation supplée à une thérapeutique !                                                                                                 | Monsieur | Wendmetta Hubert | SAWADOGO | <a href="mailto:wendmettah@gmail.com">wendmettah@gmail.com</a> | Burkina Faso |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                            | Titre    | Prénom(s)            | Nom      | Email                                                                                        | Pays         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S3-COL-36   | Association entre l'anticoagulant lupique et la pré-éclampsie sévère / éclampsie à Ouagadougou au Burkina Faso.                                | Monsieur | Salam                | SAWADOGO | <a href="mailto:salam.sawadogo@student.uclouvain.be">salam.sawadogo@student.uclouvain.be</a> | Burkina Faso |
| STH-5-S10-COL-118 | Enquête de satisfaction des utilisateurs de produits sanguins du Centre national de transfusion sanguine selon le modèle tétraclasse de Llosa. | Monsieur | Abdoul-Guaniyi       | SAWADOGO | <a href="mailto:lesage2004bk@yahoo.fr">lesage2004bk@yahoo.fr</a>                             | Burkina Faso |
| STH-5-S10-COP-115 | Douleurs lombaires chez les joueurs seniors de handball dans la ville de Ouagadougou.                                                          | Monsieur | Amidou               | SAWADOGO | <a href="mailto:sawa.amidou@gmail.com">sawa.amidou@gmail.com</a>                             | Burkina Faso |
| STH-5-S7-COP-73   | Etude de l'activité hépatoprotectrice de l'extrait aqueux de Celosia trigyna linn chez le rat de souches wistar.                               | Madame   | Aimée Touwindséda    | SAWADOGO | <a href="mailto:wendja258@yahoo.fr">wendja258@yahoo.fr</a>                                   | Burkina Faso |
| STH-2-S2-COP-21   | Investigation de cas d'ictères fébriles dans le district sanitaire de Barsalogho en 2020.                                                      | Monsieur | Dofini-Tuan Ma-Wanni | SENI     | <a href="mailto:dofiniren@yahoo.fr">dofiniren@yahoo.fr</a>                                   | Burkina Faso |
| STH-2-S4-COP-41   | Evaluation du système de surveillance de la méningite en commune V du district de Bamako, Janvier 2015 - Décembre 2019.                        | Monsieur | Toumani              | SIDIBE   | <a href="mailto:sidibetoumani84@yahoo.fr">sidibetoumani84@yahoo.fr</a>                       | Mali         |
| STH-2-S4-COP-42   | Analyse des données de surveillance de la rougeole, Mali 2016-2020.                                                                            | Monsieur | Toumani              | SIDIBE   | <a href="mailto:sidibetoumani84@yahoo.fr">sidibetoumani84@yahoo.fr</a>                       | Mali         |
| STH-1-S1-COP-4    | Investigation d'un cas de COVID-19 dans l'aire de santé de Makandiamougou, District sanitaire de Kita, Septembre 2020.                         | Monsieur | Toumani              | SIDIBE   | <a href="mailto:sidibetoumani84@yahoo.fr">sidibetoumani84@yahoo.fr</a>                       | Mali         |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                                                   | Titre    | Prénom(s)      | Nom    | Email                                                                    | Pays         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S2-COL-23   | Facteurs associés aux besoins non satisfaits en contraceptifs modernes chez les jeunes filles au Togo.                                                                                | Monsieur | ALIDOU         | SMAILA | <a href="mailto:ismoson@gmail.com">ismoson@gmail.com</a>                 | Togo         |
| STH-5-S2-COP-20   | Déterminants de l'utilisation des méthodes contraceptives chez les étudiantes de l'Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso.                                                          | Monsieur | Armel Emmanuel | SOGO   | <a href="mailto:sogoarmel@gmail.com">sogoarmel@gmail.com</a>             | Burkina Faso |
| STH-5-S1-COP-1    | Variation temporelle de la distribution des allèles eba175 chez des enfants atteint de paludisme simple à Banfora, Burkina Faso                                                       | Monsieur | Salif          | SOMBIE | <a href="mailto:salifsombie@yahoo.fr">salifsombie@yahoo.fr</a>           | Burkina Faso |
| STH-1-S2-COP-15   | Analyse de la première année de la pandémie de la COVID-19 dans la région de Ouest Africaine.                                                                                         | Monsieur | Serge          | SOMDA  | <a href="mailto:manituo@gmail.com">manituo@gmail.com</a>                 | Burkina Faso |
| STH-5-S2-COP-13   | Évaluation de l'adhésion du personnel de soins à la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfance (PCIME) dans le contexte de Gratuité des soins au Burkina Faso : Etude PAASME. | Monsieur | Satouro Arsene | SOME   | <a href="mailto:satourosome2011@gmail.com">satourosome2011@gmail.com</a> | Burkina Faso |
| STH-2-S3-COP-25   | Correction des données du SNIS après les mouvements d'humeur des agents de santé en 2019 : données de vaccination.                                                                    | Monsieur | André          | SOME   | <a href="mailto:someandre10@gmail.com">someandre10@gmail.com</a>         | Burkina Faso |
| STH-1-S3-COP-26   | Modèle épidémiologique fractionnaire SEIRS au sens de Caputo: application à la dynamique de propagation de la COVID-19.                                                               | Monsieur | Windjiré       | SOME   | <a href="mailto:windjirsome@gmail.com">windjirsome@gmail.com</a>         | Burkina Faso |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                            | Titre    | Prénom(s)         | Nom        | Email                                                            | Pays          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| STH-5-S7-COL-78   | Évaluation de la performance d'un service de chirurgie du CNHU-HKM, Bénin, dans le contexte de la COVID-19 en 2021.                            | Monsieur | Ghislain Emmanuel | SOPOH      | <a href="mailto:ghislainsop@yahoo.fr">ghislainsop@yahoo.fr</a>   | Bénin         |
| STH-1-S2-COL-21   | Facteurs associés à l'observance des mesures de prévention primaire de la COVID-19 dans deux marchés populaires à Cotonou en 2021.             | Monsieur | Ghislain Emmanuel | SOPOH      | <a href="mailto:ghislainsop@yahoo.fr">ghislainsop@yahoo.fr</a>   | Bénin         |
| STH-5-S7-COL-83   | Facteurs associés à l'utilisation irrationnelle des médicaments dans les ménages de la zone sanitaire Abomey-Calavi/So-Ava, au Bénin, en 2021. | Monsieur | Ghislain Emmanuel | SOPOH      | <a href="mailto:ghislainsop@yahoo.fr">ghislainsop@yahoo.fr</a>   | Bénin         |
| STH-5-S1-COP-7    | Impact des moustiquaires de nouvelle génération sur la prévalence du paludisme, un an après leur introduction au Burkina Faso                  | Monsieur | Harouna           | SORE       | <a href="mailto:soreharoun@yahoo.fr">soreharoun@yahoo.fr</a>     | Burkina Faso  |
| STH-2-S2-COP-22   | Analyse des données de surveillance de la méningite bactérienne en Côte d'Ivoire de 2014 à 2019.                                               | Monsieur | Pegnontaye Moussa | SORO       | <a href="mailto:kounansoro@gmail.com">kounansoro@gmail.com</a>   | Côte d'Ivoire |
| STH-5-S10-COP-111 | Fracture de la jambe à l'hôpital général de référence de Niamey : aspect épidémiologique et lésionnel.                                         | Monsieur | Harouna Bouzou    | Souleymane | <a href="mailto:leymane45@gmail.com">leymane45@gmail.com</a>     | Niger         |
| STH-5-S10-COP-110 | Évaluation de l'âge osseux par l'IRM.                                                                                                          | Monsieur | Harouna Bouzou    | Souleymane | <a href="mailto:leymane45@gmail.com">leymane45@gmail.com</a>     | Niger         |
| STH-5-S4-COP-42   | Mesures hygiéno-diététiques appliquées par les diabétiques suivis à Bouake, Côte d'Ivoire.                                                     | Monsieur | Sory Ibrahim      | SOUMAHORO  | <a href="mailto:ssoryibrahim@yahoo.fr">ssoryibrahim@yahoo.fr</a> | Côte d'Ivoire |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                         | Titre    | Prénom(s)    | Nom       | Email                                                                    | Pays                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| STH-5-S4-COP-38   | Prévention des maladies non transmissibles et sport selon les fonctionnaires de la ville de Bouake, Côte d'Ivoire.                          | Monsieur | Sory Ibrahim | SOUMAHORO | <a href="mailto:ssoryibrahim@yahoo.fr">ssoryibrahim@yahoo.fr</a>         | Côte d'Ivoire        |
| STH-5-S6-COL-68   | Évaluation qualitative du projet pilote des Sage-Femmes Itinérantes (SAFI) dans le district de Thilogne au Sénégal.                         | Monsieur | Papa Gallo   | SOW       | <a href="mailto:papagallo.sow@uadb.edu.sn">papagallo.sow@uadb.edu.sn</a> | Sénégal              |
| STH-2-S4-COP-37   | Profil épidémiologique du choléra en Guinée 2010-2020.                                                                                      | Monsieur | Mamadou Dian | SOW       | <a href="mailto:mamadoudsow77@gmail.com">mamadoudsow77@gmail.com</a>     | République de Guinée |
| STH-2-S4-COP-47   | Evaluation du système de surveillance sentinelle du choléra en Guinée, 2018.                                                                | Monsieur | Mamadou Dian | SOW       | <a href="mailto:mamadoudsow77@gmail.com">mamadoudsow77@gmail.com</a>     | République de Guinée |
| STH-1-S2-COP-14   | Investigation des cas confirmés de covid-19 dans le district sanitaire de Mandiana, Guinée du 11 au 30 août 2020.                           | Monsieur | Mamadou Dian | SOW       | <a href="mailto:mamadoudsow77@gmail.com">mamadoudsow77@gmail.com</a>     | République de Guinée |
| STH-5-S2-COL-21   | Facteurs explicatifs de la pratique contraceptive moderne des femmes fréquentant les formations sanitaires du district de Youwarou au Mali. | Monsieur | Ousmane      | SYLLA     | <a href="mailto:ousmanesylla019@gmail.com">ousmanesylla019@gmail.com</a> | Mali                 |
| STH-2-S2-COL-24   | Epidémiologie de la tuberculose en milieu communautaire à konobougou, Mali.                                                                 | Monsieur | Ousmane      | SYLLA     | <a href="mailto:ousmanesylla019@gmail.com">ousmanesylla019@gmail.com</a> | Mali                 |
| STH-5-S2-COL-24   | Gender-Based Violence in Mali : A Hidden Disaster in Schools.                                                                               | Monsieur | Ousmane      | SYLLA     | <a href="mailto:ousmanesylla019@gmail.com">ousmanesylla019@gmail.com</a> | Mali                 |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                                                                 | Titre    | Prénom(s)              | Nom        | Email                                                                      | Pays         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P-03              | Adéquation du besoin en formation du personnel de soins de Santé Maternelle et Infantile (SMI) Au Burkina Faso.                                                                                     | Monsieur | Ousmane                | SYLLA      | <a href="mailto:ousmanesylla019@gmail.com">ousmanesylla019@gmail.com</a>   | Mali         |
| P-04              | Financement de la caisse de solidarité du district sanitaire de Youwarou au Mali : une revue systématique de littérature.                                                                           | Monsieur | Ousmane                | SYLLA      | <a href="mailto:ousmanesylla019@gmail.com">ousmanesylla019@gmail.com</a>   | Mali         |
| STH-5-S1-COP-11   | Hétérogénéité de la prévalence des marqueurs moléculaires associés à la résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques dans les trois faciès épidémiologiques du paludisme au Burkina Faso. | Monsieur | W Casimir              | TARAMA     | <a href="mailto:casimir_tarama@hotmail.com">casimir_tarama@hotmail.com</a> | Burkina Faso |
| STH-2-S3-COP-29   | Mise en place d'une surveillance épidémiologique des méningites bactériennes basée sur les aires de santé au Niger.                                                                                 | Monsieur | Jean                   | TESTA      | <a href="mailto:jeantesta1@gmail.com">jeantesta1@gmail.com</a>             | Burkina Faso |
| STH-5-S11-COP-124 | Activités anti-inflammatoires in vivo et in vitro d'extraits de Pandiaka Angustifolia (Vahl.) Hepper (Amaranthacées) utilisés en médecine traditionnelle au Burkina Faso.                           | Monsieur | Ahadi Mamadou Emmanuel | THIOMBIANO | <a href="mailto:esterfils@gmail.com">esterfils@gmail.com</a>               | Burkina Faso |
| STH-2-S1-COP-1    | Évaluation du système de surveillance de la rougeole, district sanitaire de Tambacounda, Sénégal, 2019.                                                                                             | Monsieur | Samba                  | THIOUB     | <a href="mailto:samba.thioub@yahoo.fr">samba.thioub@yahoo.fr</a>           | Sénégal      |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                      | Titre    | Prénom(s)      | Nom    | Email                                                                  | Pays          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| STH-2-S1-COP-8    | Profil épidémiologique de la fièvre jaune au Sénégal de 2013 à 2019.                                                                     | Monsieur | Samba          | THIOUB | <a href="mailto:samba.thioub@yahoo.fr">samba.thioub@yahoo.fr</a>       | Sénégal       |
| STH-2-S3-COP-34   | Investigation d'un cas confirmé de Poliomyélite dans le district sanitaire de Koumassi, Abidjan, Côte d'Ivoire, Octobre 2020.            | Madame   | Zolou Marie    | TIA    | <a href="mailto:marytia87@yahoo.fr">marytia87@yahoo.fr</a>             | Côte d'Ivoire |
| STH-3-S1-COP-2    | COVID-19 : Observance des mesures barrières dans les officines de pharmacie privées au Mali.                                             | Monsieur | Ousmane        | TOURE  | <a href="mailto:ousmane20infss@gmail.com">ousmane20infss@gmail.com</a> | Mali          |
| STH-3-S1-COP-4    | COVID-19 : Observance des mesures barrières dans le commerce de denrées alimentaires dans le district de Bamako.                         | Monsieur | Ousmane        | TOURE  | <a href="mailto:ousmane20infss@gmail.com">ousmane20infss@gmail.com</a> | Mali          |
| STH-5-S3-COP-30   | Evaluation en milieu naturel de l'efficacité de la pommade MAÏA® contre les moustiques de Goden au Burkina Faso.                         | Monsieur | Alphonse       | TRAORE | <a href="mailto:traorealphonse@yahoo.fr">traorealphonse@yahoo.fr</a>   | Burkina Faso  |
| STH-5-S8-COP-93   | Prévalence de l'hépatite virale B chez les travailleurs d'une entreprise agro-alimentaire à Bobo-Dioulasso                               | Monsieur | Issa           | TRAORE | <a href="mailto:placitra@yahoo.fr">placitra@yahoo.fr</a>               | Burkina Faso  |
| STH-5-S9-COP-97   | Conditions de travail des salariés au poste de décorticage d'anacardes à Bobo-Dioulasso                                                  | Monsieur | Issa           | TRAORE | <a href="mailto:placitra@yahoo.fr">placitra@yahoo.fr</a>               | Burkina Faso  |
| STH-5-S9-COP-106  | Investigation de cas suspect de toxoinfection alimentaire dans le village de Mignoré, District sanitaire de Vavoua, Côte d'Ivoire, 2021. | Monsieur | Affou Séraphin | WOGNIN | <a href="mailto:seraphinwn@gmail.com">seraphinwn@gmail.com</a>         | Côte d'Ivoire |

| Code Présentation | Titre communication                                                                                                                                                                                                        | Titre    | Prénom(s)           | Nom     | Email                                                                | Pays         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| STH-5-S1-COP-4    | Analysis of the impact of malaria on the labour productivity of cotton farmers in Burkina Faso                                                                                                                             | Monsieur | Seydou              | YABRE   | <a href="mailto:yabreseydou@yahoo.fr">yabreseydou@yahoo.fr</a>       | Burkina Faso |
| STH-5-S2-COP-18   | Fréquence et facteurs liés au décès maternels lors des ruptures utérines au département de gynécologie, d'obstétrique et de médecine de la reproduction du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo Dioulasso. | Monsieur | Barnabé             | YAMEOGO | <a href="mailto:barnayam@yahoo.fr">barnayam@yahoo.fr</a>             | Burkina Faso |
| STH-1-S2-COP-16   | Prévalence et facteurs associés à l'hésitation à la vaccination contre la COVID-19 chez les utilisateurs des réseaux sociaux, Burkina Faso.                                                                                | Monsieur | Issouf              | YAMEOGO | <a href="mailto:dryamis@yahoo.fr">dryamis@yahoo.fr</a>               | Burkina Faso |
| STH-5-S8-COP-88   | Facteurs associés à la mortalité et à la perte de vue après initiation antirétrovirale au district sanitaire de Boromo.                                                                                                    | Monsieur | Issouf              | YAMEOGO | <a href="mailto:dryamis@yahoo.fr">dryamis@yahoo.fr</a>               | Burkina Faso |
| STH-2-S4-COP-39   | Délais diagnostiques de la tuberculose pulmonaire et facteurs associés à leur allongement dans la région de Boké, Guinée, 2019-2020.                                                                                       | Madame   | Pauline Kiswendsida | Yanogo  | <a href="mailto:yanogo.pauline@yahoo.fr">yanogo.pauline@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |
| P-13              | Facteurs associés au paludisme chez les cas suspects de paludisme dans les cinq districts sanitaires de Niamey, Niger, 2019.                                                                                               | Madame   | Pauline Kiswendsida | Yanogo  | <a href="mailto:yanogo.pauline@yahoo.fr">yanogo.pauline@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |
| P-14              | Facteurs associés à la méningite à Neisseria meningitidis C dans le district de Kpendjal-Ouest au Togo en février 2019.                                                                                                    | Madame   | Pauline Kiswendsida | Yanogo  | <a href="mailto:yanogo.pauline@yahoo.fr">yanogo.pauline@yahoo.fr</a> | Burkina Faso |

| Code Présentation       | Titre communication                                                                                                                                                                                          | Titre    | Prénom(s)           | Nom                | Email                                                                      | Pays          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>STH-3-S1-COP-6</b>   | WhatsApp et lutte contre la lèpre en milieu rural ivoirien en période de covid-19.                                                                                                                           | Monsieur | Amani Charles       | YOKOLI             | <a href="mailto:ayokoli@yahoo.fr">ayokoli@yahoo.fr</a>                     | Côte d'Ivoire |
| P-08                    | Rapport d'évaluation du système de surveillance de la tuberculose animale à Niamey de janvier à décembre 2019.                                                                                               | Monsieur | Hassane             | YOUNOUSSA ALFAZAZI | <a href="mailto:hassanyounoussa2@gmail.com">hassanyounoussa2@gmail.com</a> | Niger         |
| STH-5-S3-COP-31         | Distribution, comportement et niveau d'infection des membres du complexe Anopheles gambiae en période de transmission du paludisme dans trois districts sanitaires de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso. | Monsieur | Nicolas             | ZANRE              | <a href="mailto:nicozanre12@gmail.com">nicozanre12@gmail.com</a>           | Burkina Faso  |
| <b>STH-5-S8-COP-89</b>  | Facteurs associés à la couverture par les services de prévention du VIH parmi travailleuses du sexe séronégatives au Burkina Faso.                                                                           | Monsieur | Salifou Cheik Abbas | ZERBO              | <a href="mailto:cheikabbas@gmail.com">cheikabbas@gmail.com</a>             | Burkina Faso  |
| STH-5-S3-COL-35         | Prévalence et facteurs associés aux infections transmises par la transfusion chez les donneurs de sang Burkina-Faso.                                                                                         | Madame   | Edwige              | ZOMA               | <a href="mailto:edozom@yahoo.fr">edozom@yahoo.fr</a>                       | Burkina Faso  |
| <b>STH-5-S9-COP-101</b> | Situation nationale de la résistance aux insecticides chez Aedes aegypti principal vecteur de la transmission des arboviroses au Burkina-Faso                                                                | Monsieur | Soumanaba           | ZONGO              | <a href="mailto:zongosoumanaba@gmail.com">zongosoumanaba@gmail.com</a>     | Burkina Faso  |



## RESUMES DES COMMUNICATIONS ORALES

# ***RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ORALES***

## **Sous-thème 1 : La science de l'analyse et de la gestion des risques et des urgences en santé publique**

## Sous-thème 1 Session1

### STH-1-S1-COP-1

#### Profil épidémiologique et clinique des enfants et adolescents atteints de COVID-19 dans la région centrale, Togo, 2020

**HILIMP. M**<sup>\*1</sup>, TCHALLA A. E <sup>2</sup>,  
TIENDREBEOGO S.<sup>3</sup>, N'DJAO A.<sup>1</sup>, SABI M.<sup>1</sup>,  
LABITE Y.<sup>1</sup>, AMENYIDO N.<sup>1</sup>, BARRY D.<sup>3</sup>,  
ASSANE H.<sup>4</sup>, YANOGO P <sup>3</sup>, SOPOH E.<sup>5</sup>

1 Master BFELTP, Université Joseph Ki Zerbo de  
Ouagadougou (Résident du Togo)

2 Coordination Technique du Projet de  
Renforcement de la Surveillance à base  
Communautaire des PFA en Afrique (RDC)

3 Coordination BFELTP (Burkina Faso)

4 Direction de Lutte contre la Maladie, Ministère de  
la Santé (Togo)

5 Institut Régional de Santé Publique Comlan  
Alfred Quenum, de Ouidah (Bénin)

\*Email : [hilimalain@yahoo.fr](mailto:hilimalain@yahoo.fr), Cel:  
0022891607996

**Introduction :** Le Togo a notifié son premier cas de COVID-19 le 6 mars 2020. Depuis lors, des cas chez les enfants et adolescents y ont été enregistrés.

**Objectif :** Décrire le profil épidémiologique et clinique de la COVID-19 chez les enfants et adolescents de la région centrale du Togo.

**Méthode :** Nous avons conduit une étude transversale descriptive, de mars 2020 à janvier 2021, portant sur les enfants et adolescents de 0 à 19 ans confirmés positifs au SRAS-CoV2 par la RT-PCR dans la région centrale du Togo. Les données épidémiologiques et cliniques ont été extraites des bases de données des cinq districts sanitaires de la région. L'analyse a été effectuée avec SAS version 9.4.

**Résultats :** Un total de 65 cas (23%) étaient des enfants et adolescents de 0 à 19 ans sur 285 cas

confirmés sur la période. L'âge médian était de 13 ans (EIQ : 11 à 17 ans). Les enfants de 0-5 ans représentaient 8 cas (12,31%). Le sex-ratio (M/F) était de 1,10 ; 40 (61,54%) étaient des élèves, 29 (44,62%) résidaient dans le district sanitaire de Tchaoudjo, chef-lieu de région. L'infection était asymptomatique chez 92,31% des cas. Chez les cas symptomatiques, les signes retrouvés étaient la rhinorrhée (80%), la fièvre (40%), la douleur articulaire (40%), la douleur à gorge et la douleur musculaire (respectivement 20%). Deux cas ont été perdus de vue (3,08%). Aucun décès n'a été enregistré et 63 cas suivis (soit 96,92% des cas, et 100% des cas suivis) ont été guéris de la maladie.

**Conclusion :** Les enfants et adolescents atteints de la COVID étaient surtout ceux de plus de cinq ans, élèves, résident au chef-lieu de région. Ils sont asymptomatiques et la maladie reste bénigne chez eux.

**Mots clé :** SRAS-CoV2, COVID-19, Enfant, Adolescent, Togo

### STH-1-S1-COP-2

#### Etude des facteurs associés à la covid-19 chez les personnes suspectes dans le district sanitaire I de Niamey.

**Mamadou Moussa**<sup>1,2</sup>, Yanogo Pauline<sup>2, 3</sup>,  
Kaboré Jean <sup>4</sup>, Diallo Fadima<sup>2</sup>, Djibo Issifou<sup>1</sup>,  
Meda Nicolas<sup>2,3</sup>

#### Affiliate:

1. Niger Ministry of Health

2. Burkina Field Epidemiology Training Program, University Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina

3. Faculty of Medicine, JKZ University, Burkina Faso

4. Institut de Recherche en Science de la Santé (IRSS), CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso,
5. African Field Epidemiology Network (AFENET)

**Author's**

**Email:**

[mamadoumoussa2000@yahoo.fr](mailto:mamadoumoussa2000@yahoo.fr)

## Introduction

En Décembre 2019, une épidémie d'infection par coronavirus 2 du syndrome respiratoire aiguë sévère nommée COVID-19 était découverte en Chine. Le Niger avait enregistré son premier cas de COVID-19 le 19 Mars 2020 et avait notifié 924 cas au 21 Mai 2020 avec 721 cas à Niamey. Le District un(I) comptait 341 cas (47,23%) des cas de la région de Niamey et 36,90% des cas du pays.

L'objectif de cette étude est d'expliquer la fréquence des COVID-19 dans le District sanitaire I de Niamey.

## Méthodes

Il s'agit d'une étude transversale descriptive à visée analytique des cas de Covid-19 réalisée du 27 Mai au 03 Juin 2020. Nous avons procédé à une analyse univariée pour expliquer le statut et l'évolution. Toutes les variables qui avaient une p-value inférieure ou égale à 0,20 en analyse univariée ont été mises dans un modèle de régression logistique binaire.

## Résultats

Au total 734 cas suspects ont été testés dont 349 positifs à la covid-19 soit 47,5% de taux de positivité. Sur les 349 cas positifs 16 étaient décédés soit une létalité de 4,6%.

L'âge médian était de 43 ans (27 - 56 ans). La tranche d'âge 45- 60 ans représentait 28,6%.

Les signes retrouvés étaient dominés par la fièvre et la toux.

L'analyse multivariée avait montré qu'il existe une association significative ( $p\text{-value} < 0,05$ ) entre la transmission de la Covid-19 avec l'existence de Comorbidités ; le contact avec un cas positif, le sexe, la visite d'un établissement sanitaire, le fait d'être en contact avec une personne ayant une affection respiratoire aiguë et l'âge.

## Conclusion

La covid19 est très fréquente chez les cas suspects dans le district I de Niamey. La sensibilisation pour prévenir la maladie doit cibler toute la population en mettant un accent sur les hommes, les personnes âgées ou vivant avec des comorbidités, en contact avec une personne atteinte d'une affection respiratoire aiguë.

## STH-1-S1-COP-3

### Expérience du LNR-FHV dans la gestion de crise sanitaire : Déploiement du Laboratoire mobile P3 pour le diagnostic du COVID-19

KAGONE S. Thérèse<sup>1</sup>, OUEDRAOGO Saïdou<sup>1</sup>, ZANGO Alidou<sup>1</sup>, ROUAMBA Issé<sup>1</sup>, SEMDE N. Barthelemy<sup>1</sup>, TINTO Bachirou<sup>1</sup>, DA sié Bafoudji<sup>1</sup>, KIENTEGA Issaka<sup>1</sup>, BICABA Brice<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Centre MURAZ, <sup>2</sup>CORUS.

Mail : [saidou.muraz@yahoo.fr](mailto:saidou.muraz@yahoo.fr),  
[therese.kagone@gmail.com](mailto:therese.kagone@gmail.com)

**Introduction :** Le Burkina Faso a connu ses premiers cas confirmés de Covid-19 le 9 Mars 2020. Le LNR-FHV est intervenu dans le diagnostic en Juin 2020 par l'utilisation de sa plateforme de Laboratoire mobile P3 au Centre MURAZ. En Novembre 2020, en collaboration avec le ministère de la santé, le ministère de la défense et des anciens combattants, le laboratoire mobile P3 a été sollicité pour le diagnostic systématique de covid-19 des contingents militaires en partance et de retour du front.

**Objectifs :** réaliser le diagnostic biologique de Covid-19 chez les contingents militaires en partance et de retour du front au camp SND de Loumbila/Burkina Faso.

**Méthodologie :** Le laboratoire mobile P3 a servi de cadre pour le diagnostic. Des prélèvements oro-nasopharyngés ont été reçus, extraient par le kit d'extraction EURx. Pour l'amplification, une première PCR a permis de faire un screening et une seconde PCR pour confirmation (gène N ciblé) sur les échantillons positifs. Les données ont été saisies sur le logiciel Excel. Les résultats individuels ont été imprimés sur place et remis. Une partie des échantillons positifs à la PCR ont été séquencés au centre MURAZ

**Résultats :** Au total 1 675 échantillons ont été reçus et analysés. L'âge moyen des participants était de 29,9 ans avec des extrêmes de 0,5 à 83 ans et un sexe ratio H/F de 9,8. Cent soixante-sept (167) cas positifs diagnostiqués, 54 étaient des dépistages systématiques avant regroupement et 43 pour des contrôles de cas confirmés. Parmi les positifs, 41 ont été séquencés et les clades 19B (56,1%), 20A (26,8%) et 20B(17,1) ont été rencontrés.

**Conclusion :** Le LNR-FHV a joué un rôle important dans la gestion de la crise de Covid-19 à travers son laboratoire mobile P3. Ce déploiement a sans doute contribué à éviter la propagation de la maladie au sein des contingents.

**Mots Clés :** Covid-19, déploiement, séquencées, PCR, LNR-FHV, P3

## STH-1-S1-COP-4

### Investigation d'un cas suspect de la COVID-

### 19 dans l'aire de santé de Makandiamougou, district sanitaire de Kita, Septembre 2020

**Toumani SIDIBE<sup>1</sup>**, Assetou DEMBELE<sup>2</sup>, Fousseyni DIARRA<sup>3</sup> Pauline k YANOGO<sup>1</sup>, Issa SY<sup>2</sup>, Sory Ibrahim YOROTE<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Burkina Field Epidemiology and Laboratory Training Program

<sup>2</sup>Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, Bamako, Mali

<sup>3</sup>Centre de Santé de Référence de Kita

**Adresse :** Résident BFELTP, Tél 00223 76361968

Email : [sidibetoumani84@yahoo.fr](mailto:sidibetoumani84@yahoo.fr)

**Introduction :** la COVID-19 est une maladie virale émergente très contagieuse due à un nouveau Coronavirus (SARS-CoV2). Le Mali a rejoint la communauté internationale en confirmant ces premiers cas de COVID-19, le 25 mars 2020. L'objectif était d'investiguer un cas de covid-19 dans l'aire de santé de Makandiamougou et d'identifier rapidement les cas secondaires potentiels infectés par les cas primaires connus.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude transversale descriptive d'un cas suspect de Covid-19 dans l'aire de santé de Makandiamougou. Nous avons procédé à un recensement de tous les contacts proches du cas suspect, recueillie les informations avec le cas suspect et une revue documentaire à la recherche d'autres cas supplémentaires.

**Résultats :** Nous avons enregistré un cas confirmé et 23 sujets contacts. Le cas confirmé était une ménagère de 45 ans importé de Bamako qui est l'épicentre de l'épidémie et a été transféré au centre de prise en charge. La durée de confinement des cas contacts était de 14 jours à partir de la date du dernier contact

avec le cas confirmé 48 heures avant l'apparition des symptômes. Au terme de la quatorzaine du confinement, aucun n'avait présenté de symptôme et aucun dépistage systématique n'avait été fait pendant et à la fin du suivi en l'absence de symptôme.

**Conclusion :** L'identification rapide des contacts du cas confirmé et leur suivi ont permis d'empêcher la propagation de l'infection à COVID-19 dans cette communauté par la mise en place des mesures de confinement. Nous recommandons la promotion des mesures barrières et le renforcement des activités de surveillance épidémiologique.

**Mots clés:** Investigation, Covid-19, Makandiamougou, Kita.

## STH-1-S1-COP-5

**Effets du Covid-19 sur le système de santé sénégalais : Cas du centre de gérontologie et gériatrie de Ouakam, Dakar, Sénégal. En 2021**

**Ousseynou Ka<sup>1</sup>**, El Hadji Mbaye<sup>2</sup>, Ndeye Fatou Ngom Gueye<sup>3</sup>, Cheikh Tacko Diop<sup>1</sup>, Mountaga Elimane Dia<sup>1</sup>, Abdoul Aziz Ndiaye<sup>1</sup>, Papa gallo Sow<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Département Santé Communautaire UFR Santé et Développement Durable/Université Alioune Diop de Bambey, <sup>3</sup>Université Gaston Berger de Saint Louis, <sup>3</sup>Département Médecine UFR Santé et Développement Durable/Université Alioune Diop de Bambey,

**Email :** [ousseynou.ka@uadb.edu.sn](mailto:ousseynou.ka@uadb.edu.sn) ou [siboryka@gmail.com](mailto:siboryka@gmail.com) – **Tél :** 00 221 77 616 49 98 – **BP :** 7568 Dakar Médina Sénégal.

**Introduction :** La lutte contre l'infection au COVID 19 repose essentiellement sur l'application des mesures barrières et restrictives de déplacement des populations

dont les personnes âgées et la vaccination. Pourtant le financement du centre de gérontologie de Ouakam provient en partie de la contribution financière des usagers.

**L'objectif** était de déterminer les effets du Covid 19 sur les prestations, d'apprécier les difficultés rencontrées par les usagers et de déterminer les stratégies adoptées aussi bien par le personnel de santé que les usagers face au Covid 19.

**Méthodologie :** il s'agissait d'une enquête descriptive et qualitative menée auprès des prestataires du centre de gérontologie et gériatrie de Ouakam et des usagers de cette structure durant la période du 3 au 20 Juin 2021.

**Résultats :** Il a été constaté une baisse notable de la fréquentation de la structure par les usagers responsable d'une diminution significative des prestations médicales variant de 15 à 41% et d'une chute concomitante des ressources financières. Cette situation a affecté la motivation des agents de soutien, le renouvellement du stock de médicaments essentiels, l'achat d'intrants pour le laboratoire mais aussi pour les produits de nettoyage, la maintenance des équipements. Des usagers ont été confrontés à la rupture de la continuité des soins pouvant être responsable de décompensation de leurs pathologies chroniques. Face à cette réalité, les usagers se sont adaptés en mettant en œuvre des stratégies comme la sollicitation d'avis médicaux ou de consultations par téléphone, les consultations médicales à domicile, le recours à l'avis du pharmacien de proximité, à la médecine traditionnelle, l'abandon thérapeutique ; certains usagers insinuant même des signes

Covid pour se faire consulter par le personnel médical.

**Conclusion :** Des recommandations ont été formulées pour améliorer la résilience du système de santé vis-à-vis de cette catégorie de population.

**Mots clés :** Covid 19, effets, système de santé, centre de gérontologie et gériatrie, Sénégal

## STH-1-S1-COP-6

### Pratiques de port des équipements de protection individuelle des agents de santé du CHUP-CDG dans le contexte de la COVID-19

**Daniel DORI<sup>1,3,\*</sup>**, Inoussa TAPSOABA<sup>1</sup>, Rasmané SEMDE<sup>1</sup>, Rasmata OUEDRAOGO<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup> Laboratoire du Développement du Médicament, Ecole Doctorale Sciences et Santé, Université Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso ;

<sup>2</sup> Laboratoire des Maladies Transmissibles, Ecole Doctorale Sciences et Santé, Université Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso ;

<sup>3</sup> Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG), BP 1198 –Ouagadougou – 01, Burkina Faso

(\*) Communicateur : Dr Daniel DORI, Laboratoire du Développement du Médicament, EDS, Université Joseph KI-Zerbo, 03 P.O Box 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso; Phone. (+ 226) 70 14 67 30; E-mail: [doridaniel@gmail.com](mailto:doridaniel@gmail.com)

**Introduction :** En milieu hospitalier, de nombreux agents infectieux sont susceptibles d'être transmis aux professionnels de santé et aux patients, dont la plupart sont véhiculés par le sang et autres liquides biologiques. Afin de contribuer à renforcer la sécurité et la qualité des soins dans le contexte de la pandémie à

coronavirus, la présente étude a été conduite au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG) du Burkina Faso.

**Objectif :** Évaluer les connaissances, attitudes et pratiques du personnel de santé sur le port des équipements de protection individuelle (EPI) dans le contexte de la COVID-19.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive conduite sur une période de six semaines (du 01 juin au 15 juillet 2020). La population d'étude était représentée par les médecins, les biologistes, les attachés de santé, les infirmiers non spécialistes, les technologues biomédicaux et les garçons et filles de salle. Les données ont été recueillies au moyen de questionnaires auto-administrés et d'une grille d'observation.

**Résultats :** Au total sur 350 participants attendus, 282 agents ont répondu aux questionnaires et 296 agents ont été observés. Parmi ceux-ci, 24% des agents enquêtés affirmaient avoir reçu une formation sur les EPI. Les connaissances des rôles et les indications de ces équipements étaient bien connues par la majorité des participants. La quasi-totalité des participants soit 98,94% et 98,58% estimait porter régulièrement respectivement la blouse et le masque au cours des soins. Cependant à l'observation, certains EPI étaient faiblement utilisés, notamment le tablier (11,54%), les lunettes de protection (1,56%) et la tenue professionnelle (46,28%).

**Conclusion :** La présente étude montre que les connaissances et les pratiques des agents de santé vis-à-vis du port de certains EPI restent insuffisantes. Un programme de formation et de

sensibilisation doit être envisagé afin de renforcer leur usage en milieu hospitalier.

**Mots-clés :** Connaissances ; Attitudes ; Pratiques ; Agents de santé ; équipements de protection individuelle.

### STH-1-S1-COP-7

**Étude comparative des manifestations cliniques observées chez les patients positifs versus patients négatifs de COVID-19 au CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou (Burkina Faso)**

**Savadogo Mamoudou<sup>1</sup>**, Diallo Ismaël<sup>2</sup>, Sondo K Apoline<sup>1</sup>

- 1) Service des maladies infectieuses du CHU Yalgado Ouédraogo
- 2) service de médecine interne du CHU Yalgado Ouédraogo

**Introduction :** la pandémie de COVID-19 en cours n'a pas épargné le Burkina Faso qui a enregistré ses premiers cas depuis le 09 mars 2020.

**Objectifs :** comparer les manifestations cliniques observées chez les patients positifs Versus patients négatifs de COVID-19.

**Méthodes :** il s'est agi d'une étude transversale descriptive et analytique qui s'est déroulée du 05 Avril 2020 au 04 Mai 2020.

**Résultats :** Durant la période d'étude, 151 patients suspects de COVID-19 ont été reçus au CHU Yalgado Ouédraogo. Le test de la COVID-19 a été positif chez 14 patients, soit un taux de positivité de 9%. Sur le plan clinique, une température supérieure à 38°C était retrouvée chez 28% des patients COVID+ contre 62% des patients COVID- ( $p=0,013$ ) ; la toux était présente chez 64% des patients COVID+ contre 69% des patients COVID- ( $p=0,33$ ). Une dyspnée était retrouvée chez 57%

des patients COVID+ contre 60% des patients COVID- ( $p=0,86$ ). Une détresse respiratoire était présente chez 28% des patients COVID+ contre 9% des patients COVID- ( $p=0,02$ ). Les patients souffrant de détresse respiratoire avaient 4 fois plus de risque de faire une infection au coronavirus ( $OR=4,03$ ). Quatorze pour cent (14%) des patients COVID+ avaient des algies diffuses contre 2% des patients COVID négatifs ( $p=0,04$ ).

**Conclusion :** le clinicien devrait penser à la COVID-19 devant une détresse respiratoire associée à des algies diffuses.

**Mots clés :** manifestations cliniques, comparaison, COVID-19 positif, COVID-19 négatif, cas suspects de COVID-19.

### STH-1-S1-COP-8

**Caractéristiques socio-épidémiologiques et cliniques des patients atteints de la covid-19 au Niger 2020**

**Mamadou Moussa<sup>1,2</sup>**, Yanogo Pauline<sup>2, 3</sup>, Kaboré Jean<sup>4</sup>, Otshudiandjeka O.B. Joseph<sup>2, 5</sup>, Diallo Fadima<sup>2</sup>, Djibo I<sup>1</sup>, Moustapha Adamou<sup>1</sup>, Omarou Batouré<sup>6</sup> Meda Nicolas<sup>2, 3</sup>

#### Affiliations:

1. Ministère de la santé du Niger
2. Burkina Field Epidemiology Training Program, University Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina
3. Faculty of Medicine JKZ University, Burkina Faso
4. Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso,
5. African Field Epidemiology Network (AFENET)
6. OMS, RIO, Niger

**Authors:**

**EMAIL:**

[mamadoumoussa2000@yahoo.fr](mailto:mamadoumoussa2000@yahoo.fr)

#### **Introduction**

En Décembre 2019 une épidémie d'infection par coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigüe sévère (SRAS-COV2) s'est produite à Wuhan en Chine. Elle est classée parmi les urgences de santé publique de portée internationale selon l'OMS le 30 Janvier 2020 et comme pandémie le 11 Mars 2020. Le Niger a enregistré son premier cas le 19 mars 2020 et compte à la date du 4 Octobre 2020, 1200 cas dont 69 décès.

L'objectif de ce travail est d'étudier les caractéristiques socio-épidémiologiques et cliniques des patients atteints de la COVID19 au Niger.

### **Matériels et méthodes**

Nous avons conduit une étude descriptive rétrospective des cas de Covid-19 au Niger

L'étude s'est déroulée du 19 octobre au 30 Décembre 2020. L'échantillonnage a été exhaustif pour les 8069 personnes testées. L'analyse a été effectuée à l'aide du logiciel Epi-info version 7.2.5. Des proportions et des fréquences ont été calculées.

### **Résultats**

Mille deux cent dix (1210) personnes étaient positives à la Covid-19 au 19 octobre 2019 soit 15% de taux positif. Les hommes représentaient 68% des cas (820/1210). L'âge médian était de 41 ans. Sur l'ensemble des cas, 74,38 % (900/1210) provenaient de la région de Niamey, 15,45% étaient des travailleurs des secteurs de la santé, les infirmiers représentaient 60% des cas. Globalement, 32,98% ont affirmé avoir un contact avec une personne présentant une affection respiratoire aigüe. La fièvre et la toux étaient retrouvés chez 18,02 %. L'hypertension artérielle était retrouvée chez 115 patients soit

9,50 %. Les décès représentaient 5,70% et 63,77 % (48/69) était âgé de plus de 60 ans.

### **Conclusion**

Dans cette étude les patients atteints de covid-19 étaient majoritairement des jeunes et l'hypertension artérielle était la comorbidité fréquente et les signes cliniques majeurs étaient la fièvre et la toux. Le respect des mesures barrières particulièrement chez les personnes âgées contribuera à réduire les décès liés à la covid-19.

**Mots clés :** caractéristiques socio épidémiologiques et cliniques, Covid-19, Niger

### **STH-1-S1-COP-9**

**Investigation d'un cluster de COVID-19 dans une communauté confessionnelle, district sanitaire de l'Ogou, Togo, 2020.**

**SABI M.**<sup>1</sup>, HALATOKO W.<sup>2</sup>, TCHALLA A. E.<sup>3</sup>, ABRANGAO A.<sup>4</sup>, FONVI A.<sup>4</sup>, ASSANE H.<sup>5</sup>, KINDE R.<sup>6</sup>, BARRY D.<sup>7</sup>, YANOGO K. P.<sup>7</sup>, NYAMETSO D.<sup>8</sup>

1 Master 2 BFELTP Cohorte 6, Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou (Résident du Togo)

2 Institut National d'Hygiène (Togo)

3 District sanitaire de Haho (Togo)

4 District Sanitaire de l'Ogou (Togo)

5 Direction de la Lutte contre la Maladie et problèmes de santé publique, Ministère de la Santé (Togo)

6 Coordination nationale FETP (Togo)

7 Université Joseph KIZERBO, BFELTP (Ouagadougou)

8 Direction Régionale de la Santé, Région des plateaux (Togo)

Email : [monfayesabi88@yahoo.fr](mailto:monfayesabi88@yahoo.fr) ; Cel: 0022890855821

### **Introduction**

Le 14 Juillet 2020 un cas confirmé de COVID-19 a été notifié dans une communauté de sœurs

religieuses du district sanitaire de l'Ogou. Une investigation a été conduite pour décrire l'ampleur de la maladie et mettre en place les mesures de contrôle et de prévention.

### Méthodes

Nous avons mené une étude descriptive de juillet - août 2020 portant sur les cas de COVID-19 survenus dans une communauté de sœurs religieuses à Atakpamé. Le cas confirmé était toute personne ayant un test d'amplification génétique positif au SRAS-CoV2. Nous avons recherché les contacts du cas index. Les données ont été collectées à l'aide de fiches d'investigation par entretien individuel et revue documentaire. Nous avons calculé, les proportions, les médianes, les percentiles et les ratios.

### Résultats

Le cas index était une sœur religieuse de 54 ans avec un antécédent anxiodépressif résidant dans une communauté de 13 religieuses abritant un internat et un complexe scolaire. L'effectif total de la communauté était de 34. Nous avons identifié 133 contacts dont 12 (9,02%) sœurs religieuses. Neuf contacts ont été confirmés au SRAS-COV2 dont 55,56% religieuses soit un taux d'attaque secondaire de 38,46 pour 100 sœurs religieuses en 21 jours ; 22,22% élèves ; 11,11% enseignant et 11,11% chauffeur. L'âge médian était de 40 ans (IIQ=29-54 ans). Le sexe ratio H/F des cas était de 1/4. 90% des cas étaient asymptomatiques. Un cas (10%) était symptomatique : toux, fièvre, asthénie, écoulement nasal. Après un suivi médian de 10 jours, la fin de l'épidémie fut déclarée le 11 Août en communauté.

### Conclusion

L'investigation du cas de COVID-19 dans une communauté confessionnelle d'Atakpamé a permis, d'isoler les contacts et de prendre en charge les cas. La mise en place des mesures de prévention et contrôle a permis de limiter la propagation de la maladie en communauté et dans l'école.

**Mots clés :** Cluster, communauté confessionnelle, Togo, 2020

### STH-1-S1-COL-10

#### Évaluation des pratiques d'hygiène et de prévention de la Covid\_19 au CHU Point G du Mali

**Sanogo M<sup>1,2</sup>**, Tonnang RGT <sup>2</sup>

1-Faculté de Médecine et d'odontostomatologie de Bamako, Mali

2-Faculté de Pharmacie de Bamako, Mali

**Correspondance :** Dr Moussa Sanogo, Ph. D Maitre - Assistant en Gestion des systèmes de santé, USTTB. Bamako. Email : [moussanogo2002@yahoo.fr](mailto:moussanogo2002@yahoo.fr)

**Introduction :** Le monde fait face depuis décembre 2019 à une crise sanitaire dénommée « coronavirus » en abrégée Covid\_19. Le Mali a enregistré son premier cas en mars 2020 et connaît une progression exponentielle des cas. L'objectif de ce travail a été d'évaluer chez le personnel les pratiques d'hygiène et de prévention de la maladie à coronavirus Covid\_19 au centre Hospitalo Universitaire du Point G au Mali.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude descriptive transversale allant du mois d'avril à juin 2020 pour les centres d'isolement et d'août à septembre 2020 pour les différents services incluant le personnel médical et technicien de surface travaillant dans les centres d'isolement

et de traitement de la Covid\_19 et dans les différents services de l'hôpital.

**Résultats :** Au total 82 agents des deux centres d'isolement et de traitement du covid\_19 de l'hôpital ont été enquêtés. Il s'agit des médecins spécialistes 2,4%, des médecins généralistes 23,2%, des médecins en cours de spécialisation (DES) 2,4%, du personnel de soutien 23,2 %, et des infirmiers 46,4%. Parmi le personnel de soins 66,7% ont suivi une formation sur le lavage des mains et la prévention des infections liées aux soins, tandis que seulement 30,2 l'ont été sur la préparation de la solution hydro alcoolique. Certaines insuffisances ont été constatées dans la pratique du lavage des mains, l'observation des gestes barrières. Le déficit dans le port des équipements de protection et la mauvaise qualité du matériel de nettoyage ont été rappelés. La gestion des déchets demeure également problématique.

**Conclusion :** Le respect des mesures d'hygiène et de prévention liées à la Covid\_19 pose problème à l'hôpital du point G. La réorganisation des services au vu du contexte s'impose et la mise à disposition de moyens conséquents.

**Mots clés :** Hygiène, Covid\_19, personnel, Hôpital, Mali

## STH-1-S1-COL-11

### Facteurs associés à la mortalité liée à la COVID-19 au Niger

<sup>1,5</sup>**GARBA SALIFOU Mohamed** ; <sup>1,2</sup>Désiré Lucien DAHOUROU ; <sup>3,5</sup>Goni A. M. Bachir ; <sup>1,5</sup>SAIDOU Doulbakou ; <sup>1,6</sup>ALIDOU Smaila ; <sup>4,6</sup>DAOUDA Saley

#### Affiliation

<sup>1</sup>Université Joseph Ki-Zerbo

<sup>2</sup>Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>3</sup> Direction de la Surveillance et de la Riposte aux Epidémies du Niger

<sup>4</sup> Direction Générale de la Santé Publique du Niger

<sup>5</sup> Ministère de la Santé Publique de la Population et de l'Action Sociale du Niger

<sup>6</sup>Ministère de la Santé, Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins, Togo

#### Introduction

Depuis décembre 2019 sévit une épidémie de la maladie émergente à coronavirus 2019 (COVID-19), causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2). Notre étude avait pour objectif de décrire la mortalité du COVID-19 et d'identifier ses facteurs associés au Niger.

#### Matériels et méthodes

Une étude de cohorte prospective a été conduite du 19 mars 2020 au 18 mars 2021 au Niger. Les données ont été extraites de la récapitulation en cours de la surveillance épidémiologique menée par la Direction de Surveillance et de la Riposte des Epidémies (DSRE) de la république du Niger. Les personnes dépistées pour l'infection par le SARS-CoV-2 à l'aide de test PCR au cours de la période d'étude du 19 mars 2020 à 18 juin 2021 ont été inclus. La régression logistique a été utilisée pour identifier les facteurs associés à la positivité du test PCR et au décès.

**Résultats :** Au total, 30175 patients ont été testés pour la COVID-19, parmi lesquels 4710 étaient positifs à la PCR. Parmi les 4616 cas confirmés (98%) avec des résultats cliniques disponibles, 186 (4%) étaient décédés. Le facteur indépendamment associé à la positivité du test de la COVID-19 était la toux (ORa :

2,71 ; IC95% : 6,70-8,52). La probabilité de décès était significativement plus élevée pour les patients âgés de plus de 60 ans (ORa : 9,92 ; IC95% : 2,90-33,98) et hypertendus (ORa : 2,10 ; IC95% : 1,18-3,75).

**Conclusion** Les facteurs de risque associés à la positivité du test de la COVID-19 et à la mortalité subséquente dans la population nigérienne sont similaires à ceux rapportés dans les études d'autres pays et devraient orienter les décisions cliniques pour les tests COVID-19 et l'hospitalisation des malades de COVID-19

**Mots clés:** COVID-19; PCR positive; mortalité; facteurs associés; Niger

## STH-1-S2-COL-12

### Investigation des cas suspects de Covid-19 dans le District Sanitaire de Nongr-Massom, Ouagadougou, Burkina-Faso, Mars-Mai 2020

**Marcelino Correia Nanque**<sup>1,2</sup>, Jean Kaboré<sup>3</sup>, Pauline Yanogo<sup>1,4</sup>, Nicolas Meda<sup>1,4</sup>,

#### Affiliations

1 : Programme de formation en épidémiologie de terrain et en laboratoire au Burkina Faso, Université Joseph KI ZERBO

2 : Réseau africain d'épidémiologie de terrain (AFENET)

3 : Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Centre national de la recherche scientifique et technologique, Ouagadougou, Burkina Faso ;

4 : UFR des Sciences de la Santé, Université Joseph KI ZERBO, Burkina Faso

Auteur correspondant : sr.marcel86@gmail.com

Année : 2020

**Introduction :** A la date du 10 octobre 2021, l'OMS estime à 23 229 951, le nombre de cas confirmés et à 4 859 277 le nombre de décès dus à la covid-19. Le taux de létalité du coronavirus

dépend entre autres de la qualité des services de santé, de la nature des réponses des autorités sanitaires, de l'âge moyen et de l'état de santé général des patients. L'Objectif de ce travail est d'investiguer les cas du COVID 19 dans le district sanitaire de Nongr-Massom à Ouagadougou de mars à mai 2020.

**Méthodologie :** Nous avons mené une étude descriptive transversale des cas de COVID-19 survenus dans le district sanitaire de Nongr-Massom. Notre échantillon était exhaustif (domiciles et formations sanitaires) et a porté sur tous les cas notifiés via les alertes, la recherche active et leurs contacts. Une recherche des cas supplémentaires dans les formations sanitaires a été faite.

**Résultats :** Entre mars et mai 2020, 260 cas ont été notifiés dans la base du District sanitaire de Nongr-Massom avec 3 décès (1.15%) soit un taux de létalité de 1%. La tranche d'âge 31 à 40 ans est la plus touchée avec 60% des cas. L'âge médian était de 42 ans. Les hommes ont été les plus atteints avec 56%. Deux cent vingt-neuf (229) cas correspondent à 88% n'avaient pas de trace dans leur district de provenance (NC) y compris les décès.

**Conclusion :** Les jeunes ont été plus exposés à la maladie, selon le mode de vie qu'ils mènent à cette époque et le non-respect des mesures préventives décrétées par les autorités sanitaires pour la prévention de la maladie. Cela a probablement entraîné une augmentation significative des cas de covid-19.

**Mots-clés :** Symptômes, Cas, COVID-19, investigation, Burkina.

## Sous-thème 1 Session 2

### STH-1-S2-COP-13

**Conséquences imprévisibles des pratiques d'atténuation des risques liés au COVID-19 : impact sur la transmission de la dengue.**

**W. Mathias OUEDRAOGO<sup>1,3</sup>**, Sylvie FASINE<sup>2</sup>, Nicolas ZANRE<sup>1</sup>, Antoine SANON<sup>1</sup> and Athanase BADOLO<sup>1</sup>.

1. Laboratoire d'Entomologie Fondamentale et Appliquée (LEFA), UFR/SVT, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
2. Institut Nationale de Recherche Biomédicale (INRB), Kinshasa, RD Congo
3. Programme National de lutte contre les Maladies Tropicales Négligées/Ministère de la Santé, Ouagadougou, Burkina Faso

Adresse du présentateur : OUEDRAOGO W Mathias, Tel : 00226 70078156, adresse Email : [math25x@yahoo.fr](mailto:math25x@yahoo.fr)

**Introduction :** Le Burkina Faso, pays endémique à la dengue qui est une maladie à transmission vectorielle causée par *Aedes aegypti*, a connu la pandémie de COVID-19. Cette pandémie a occasionné l'installation de lave-mains (HWDs) dans les lieux publics (LP) comme mesure de prévention.

**Objectif :** Evaluer la contribution des HWDs à la prolifération d'*Aedes aegypti* dans les LP.

**Méthodes :** Entre Septembre et Octobre 2020, nous avons prospecté 61 LP dans la ville de Ouagadougou à la recherche de potentiels gites larvaires de moustiques. Ces LP sont : Lieux de culte, d'éducation, commissariats de police, services municipaux, établissements de santé, gares routières, les services du ministère de l'économie et des finances, et autres. Les

potentiels gites larvaires dont les HWDs ont été recensés et les immatures de moustiques collectées et dénombrées. Les nymphes ont été élevées au stade adulte pour l'identification des espèces.

**Résultats :** 924 récipients potentiels gites larvaires ont été retrouvés dont 660 hébergeant des immatures d'*Aedes aegypti*. Les récipients issus des HWDs étaient les potentiels gites larvaires les plus prédominants, avec une prévalence de 41,23% (381/924). Ces conteneurs avaient un taux de positivité plus élevé (37,42%) et étaient aussi les plus productifs, suivis des pneus et des petits conteneurs (SC). Les HWDs ont produit 44,73 % et 41,02 % de la faune larvaire et nymphale d'*Aedes aegypti* respectivement. Les proportions de récipients de HWDs positifs à *Aedes aegypti* variaient significativement entre les LP ( $p < 0,0001$ ).

**Conclusion :** Les HWDs ont montré une prévalence élevée, des taux de positivité et de productivité élevés pour *Aedes aegypti*. Par conséquent, ils contribueraient à l'abondance du vecteur de la dengue, et donc au risque de transmission de Denv. Ces résultats doivent être pris en compte pour guider les efforts du ministère de la santé dans sa lutte permanente contre les maladies.

**Mots clés :** Dengue, COVID-19, Lave-mains, *Aedes aegypti*, gite, Ouagadougou.

### STH-1-S2-COP-14

**Investigation de six (6) cas confirmés de covid-19 dans le district sanitaire de Mandiana, région de Kankan, Guinée du 11 au 30 aout 2020.**

**Sow MD** ; Barry AM ; Barry D ; Keita S ; Yanogo P ; Kabore J ; Gbamou N ; Millimono TJ ; Barry M.

### Introduction

Le 23 juillet 2020, la DPS de Mandiana a notifié 6 cas positifs de Covid-19 à l'ANSS. Une investigation préliminaire a été faite par l'EPARE qui a sollicité un appui du niveau régional et central à travers l'ANSS pour une investigation approfondie. C'est ainsi qu'une équipe conjointe s'est rendue dans le village de Loïla pour appuyer l'EPARE de Mandiana.

### Méthode

Il s'agissait d'une étude transversale de type descriptif portant sur des cas confirmés de COVID-19 à Mandiana du 11 au 30 août 2020. La collecte des données a été faite à l'aide des formulaires d'investigation de cas confirmés et des fiches d'identification et de suivi des contacts. Les fréquences, proportions, moyennes et ratios ont été calculés.

### Résultats

Un effectif de 5 ingénieurs de mines et 1 médecin en partance pour le Maroc a été testé PCR positif au SRAS-CoV2 parmi 23 personnes par l'INSP de Conakry. L'ensemble des travailleurs de la SMM avait été considéré comme contacts. Un effectif de **1280** travailleurs a été testé dont **159** positifs à la PCR, soit un indice de positivité de **12,4%**. L'âge moyen était de **34,95** ans avec des extrêmes de **19** à **62** ans. On note une prédominance masculine de **95%** avec un ratio H/F de **19**. Le traitement était à base d'Hydroxychloroquine/Azithromycine et

CaC1000. L'évolution a été favorable et aucun décès n'a été enregistré.

### Conclusion

La présente investigation autour des cas confirmés de COVID-19 a permis de confirmer la circulation du virus à Mandiana. Il s'agissait d'une flambée épidémique de COVID-19 avec l'allure d'une transmission communautaire.

**Mots clés:** *Investigation, COVID 19, Mandiana*

## STH-1-S2-COP-15

### Analyse de la première année de la pandémie de la COVID-19 dans la région de Ouest Africaine

**Serge M.A. SOMDA<sup>1</sup>**; Aristide R. BADO<sup>1</sup>; Abdramane SOW<sup>2</sup>; Virgil LOKOSSOU<sup>3</sup>; Sybil OSSEI-A-YEBOAH<sup>2</sup>; Tome CA<sup>1</sup>; Nanlop OGBUREKE<sup>4</sup>; Stanley OKOLO<sup>4</sup>; Issiaka SOMBIE<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Département de la Planification et de l'Information Sanitaire, Organisation Ouest Africaine de la Santé, Bobo-Dioulasso, Hauts-Bassins, Burkina Faso

<sup>2</sup> Département de la Santé Publique et de la Recherche, Organisation Ouest Africaine de la Santé, Bobo-Dioulasso, Hauts-Bassins, Burkina Faso

<sup>3</sup> Centre Régional de Surveillance et de Contrôle des Maladies, Organisation Ouest Africaine de la Santé, Bobo-Dioulasso, Hauts-Bassins, Burkina Faso

<sup>4</sup> Direction Générale, Organisation Ouest Africaine de la Santé, Bobo-Dioulasso, Hauts-Bassins, Burkina Faso

**Introduction :** La maladie COVID-19 a été pour la première fois Afrique de l'Ouest en fin février 2020 et durant le mois de mars qui a suivi atteint tous les pays.

**Objectif principal de l'étude :** étudier l'évolution de la COVID-19 au cours de la

première année depuis son apparition en Afrique de l'Ouest.

**Méthodes :** L'évolution du nombre de cas journalier et hebdomadaire, l'incidence, le nombre de décès, la létalité sont décrits dans la région et dans les pays. Les tests pour le dépistage ainsi les mesures non pharmaceutiques de riposte ont également été analysées. Les données ont été collectées auprès de tous les 15 états de la région.

**Résultats :** Au 31 mars 2021, la région CEDEAO comptait 429 760 cas de COVID-19 et 5 620 décès ceux qui représentaient 10% des cas et 10% des décès enregistrés en Afrique, même si elle représente 30% de la population continentale. L'incidence était de 1111 personnes par million de population et le taux de létalité était 1,31%. La région a connu deux vagues d'épidémie majeures avec des caractéristiques différentes. En termes d'évolution on a assisté à une augmentation de la létalité au départ mais ensuite a ensuite décliné pour se maintenir en un plateau atteindre un plateau. On notait une évolution de l'épidémie différente entre pays de même que la mise en place des mesures non pharmaceutiques et les stratégies de dépistage.

**Conclusion :** La première année de l'évolution de l'épidémie a montré une faible contribution de la région Ouest Africaine en termes de cas et de décès en Afrique comparée à sa population avec des différences entre pays. Des études ultérieures devraient aider à mieux comprendre les différences entre pays.

**Mots Clés :** COVID- 19 ; CEDEAO ; Incidence ; Létalité ; Nombre de Reproduction Effectif.

## STH-1-S2-COP-16

### **Prévalence et facteurs associés à l'hésitation à la vaccination contre la COVID-19 chez les utilisateurs des réseaux sociaux, Burkina Faso**

**L. Yameogo**<sup>1</sup>, L. Traoré<sup>1</sup>, A.M. Nyambre<sup>1</sup>, M. Diallo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Expertise Santé Afrique - Ouagadougou (Burkina Faso)

Adresse email : [dryamis@yahoo.fr](mailto:dryamis@yahoo.fr) (I. Yaméogo)

**Introduction :** L'hésitation vaccinale contre la COVID-19 constitue une préoccupation sanitaire au Burkina Faso dans un contexte où le pays se prépare à l'introduction et au déploiement du vaccin contre ladite maladie. Cette situation est illustrée par le débat entretenu par les populations à travers les différents canaux de communications dont les réseaux sociaux.

**Objectif principal de l'étude :** Etudier la prévalence et les facteurs associés à l'hésitation à la vaccination contre la COVID-19 chez les utilisateurs des réseaux sociaux au Burkina Faso.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale analytique conduite entre le 26 Mars et le 27 Juin 2021. Un questionnaire électronique conçu sur kobotoolbox a été distribué via un lien sur les réseaux sociaux Facebook et WhatsApp. Un échantillonnage en boule de neige a été utilisé. Ont été incluses dans l'étude, les personnes âgées d'au moins 18 ans et résident au Burkina Faso. Nous avons collecté les données sur l'intention des participants à se faire vacciner contre la COVID-19. Le modèle de régression logistique a été utilisé pour rechercher les facteurs associés à l'hésitation à la vaccinale.

**Résultats :** Au total, 345 individus ont participé à l'étude. L'hésitation vaccinale concernait 80% (IC<sub>95%</sub>:75,38-84,09) des participants. Après analyse multivariée, les facteurs statistiquement associés à l'hésitation vaccinale étaient : la profession "agents de santé" (ORa=5,25; IC<sub>95%</sub>:1,69-16,23) et le fait d'être modérément ou très inquiet des éventuels effets secondaires des vaccins (ORa=6,11; IC<sub>95%</sub>:2,36-15,86).

**Conclusion :** La prévalence de l'hésitation à la vaccination contre la COVID-19 était élevée chez les utilisateurs des réseaux sociaux. L'étude a permis d'identifier un groupe de plus grande résistance nécessitant une attention particulière des stratégies de santé publique pour assurer une bonne couverture vaccinale.

**Mots clés :** Covid-19, hésitation vaccinale, réseaux sociaux, Burkina Faso

## STH-1-S2-COP-17

**Investigation d'une épidémie de la covid-19 dans la ville de Maradi au Niger du 18 mai au 23 mai 2020.**

**GUERO M. Ousseina<sup>1</sup>**

([ousseinaguero@live.fr](mailto:ousseinaguero@live.fr)), Hamedine.

S.<sup>2</sup>([lolidije@yahoo.fr](mailto:lolidije@yahoo.fr)),

Otshudiandjeka J.B<sup>4</sup> ([otshujose@yahoo.fr](mailto:otshujose@yahoo.fr)),

Y.Pauline <sup>1,3</sup> ([yanogo.pauline@yahoo.fr](mailto:yanogo.pauline@yahoo.fr)),

Fadima Diallo <sup>3</sup> ([mi.raina@hotmail.com](mailto:mi.raina@hotmail.com)),

N.Meda <sup>1,3</sup> ([nicolas.meda@gmail.com](mailto:nicolas.meda@gmail.com));

### **Affiliations**

1. Burkina Field Epidemiology Training Program University PR Joseph Ki Zerbo Burkina Faso,

2. Ministère de l'environnement et de la lutte contre la désertification du Niger,

3. Faculté de médecine de l'université JKZ Burkina Faso,

4. African Field Epidemiology Network (AFENET),

**Introduction :** En décembre 2019, une épidémie locale de pneumonie de cause initialement inconnue a été détectée à Wuhan (Hubei, Chine), Elle s'est ensuite répandue sur la planète à partir de janvier 2020 et devenir un problème de santé publique d'envergure mondiale. Le Niger n'a pas été épargné par cette crise sanitaire et a enregistré son premier cas de coronavirus le 19 mars 2020. La région de MARADI, une des huit régions du Niger quant à elle a notifié son premier cas le 29 Mars 2020. L'objectifs principal de l'étude a été d'investiguer les cas de covid19 dans ville de Maradi au Niger.

**Méthodes :** Il s'agit d'une d'étude transversale descriptive de l'épidémie de Covid-19. Elle s'est déroulé du 18 Mai au 23 Mai 2020 et a concerné toute la population de ville Maradi. Les analyses ont été effectuée à l'aide du logiciel Epi-info version 7.2.2.6. Des proportions des moyennes des fréquences ont été calculés.

**Résultats :** Dans la ville de Maradi, sur dix-sept (17) cas suspects cinq (05) cas se sont révélés positifs. Sur ces cinq (05) malades, on a enregistré quatre (04) guérisons et un (01) décès soit une létalité=20%. L'incidence est de 1,3 cas/100000hbs. Tous les cas positifs sont de sexe masculin. La moyenne d'âge des cas est de 49 ans, l'âge médian 48ans et le mode 23ans. Ces cas sont sans notion de voyage ni de visite d'un centre de santé. La tranche d'âge qui a eu plus de cas suspect est celle de 20-40ans avec 47,05%. On note 107 contacts directs. 63,85% été les membres de famille des cas confirmé et 27,78% des agents de santé.

**Conclusion :** Malgré tous les efforts des autorités sanitaires, La ville de Maradi n'a pas été épargnée 19 et a dû faire face à plusieurs cas de la maladie.

**Mots clé :** covid-19 ; Maradi ; Niger ;

## STH-1-S2-COP-18

**Investigation d'un foyer de COVID-19, village de Gana, District sanitaire de Kombissiri, Région Centre-sud, Burkina Faso, Juillet 2020.**

**OBULBIGA Franck Palamanga<sup>1&2</sup>,**

BICABA B<sup>2</sup>, NIKIEMA M<sup>2</sup>, YAMEOGO I<sup>3</sup>,  
YANOGO P<sup>1</sup>, BARRY D<sup>1</sup>, DIALLO F<sup>1</sup>,  
KABORE J<sup>4</sup>, DIPAMA D<sup>5</sup>, MEDA N<sup>1</sup>.

1 = Burkina Field Epidemiology and laboratory Training Program (BFELTP), Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou

2 = Centre de réponse aux urgences sanitaires (CORUS), INSP, Ouagadougou

3 = Direction de la protection de la santé de la population (DPSP), ministère de la santé

4 = Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS), CNRST, Ouagadougou

5 = Direction régionale de la santé du Centre Sud, Ministère de la santé

**Auteur :** OBULBIGA Franck Palamanaga, Tel : +226 64 77 77 71, [obulbigafranck@yahoo.fr](mailto:obulbigafranck@yahoo.fr)

**Introduction :** Le 5 Juillet 2020, le district sanitaire de Kombissiri a été alerté de la confirmation de trois nouveaux cas de COVID-19 chez des voyageurs entrant de la Côte d'Ivoire, séjournant dans une cité universitaire à Gana, Kombissiri. Nous avons mené une investigation afin de circonscrire la flambée.

**Méthodes :** Nous avons conduit une étude transversale descriptive. Les données ont été collectées du 07 Juillet au 09 Août 2020 : une revue documentaire des dossiers des malades,

des entretiens avec les cas confirmés et contacts lors de l'investigation du foyer de COVID-19 dans le village de Gana ont été menés. Le cadre d'analyse a porté sur la description des cas confirmés en temps, lieu et personne et des caractéristiques cliniques, biologique et thérapeutique des cas.

**Résultats :** Au total 208 cas contacts et 23 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés soit un taux de positivité de 9,6% (20/208). Les résultats montrent que le taux d'attaque global était de 76,3/ 100000 habitants, 86,9 % des cas confirmés résidaient à Gana. L'âge médian (min ; max) était de 19 ans (17 ; 31). Le sexe ratio était de 0,15 en faveur de la femme et 56,5 % des étudiants étaient de nationalité ivoirienne. (. Les cas symptomatiques représentaient 73,91% de l'ensemble. Les symptômes étaient mineurs et les plus courants étaient les céphalées (30,4%) et l'asthénie (30,4%). Tous les cas confirmés ont été traités conformément au protocole national (Hydroxy chloroquine + azithromycine). Tous ont été déclarés guéris, sans décès enregistré.

**Conclusion :** L'investigation a permis de mitiger le foyer. Une bonne préparation des districts, une bonne communication, le respect des mesures de prévention et une surveillance étroite sont indispensables dans la gestion des foyers communautaires.

**Mots clés :** Investigation, Foyer, COVID-19, Gana, Kombissiri, Burkina Faso

## STH-1-S2-COP-19

**Profil épidémiologique des patients atteints de Covid-19 dans le district de ksar, Nouakchott, Mauritanie du 16 mai au 15 août 2020.**

**Mohamed El Kory Sidi Mactar Y.**, Mohamed Ahmed Mohamedou, Ely Mahmoud Med. M, Djibril Barry, Yanogo Pauline, Meda Nicolas, Ahmed Bezeid El Mamy Beyatt

En décembre 2019, le bureau de l'OMS en Chine a été informé de cas de pneumonie de cause inconnue dans la ville de Wuhan. Le 30 janvier 2020, l'OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. Le premier cas en Afrique était le 14 février 2020 en Égypte. Le 13 mars 2020, la Mauritanie a enregistré son premier cas.

Notre étude est menée du 16 mai au 15 août 2020. La population était constituée de l'ensemble de la population du district de Ksar. Elle est constituée de tous les cas suspects de COVID-19 pendant la période d'étude. L'analyse a été réalisée à l'aide du logiciel Epi-info et Excel.

Au total 684 personnes ont été prélevées et testées par RT-PCR, 111 ont été confirmées positives et 24 décès ont été enregistrés (soit un TL de 21,6%). L'âge moyen était de 27,27 ans. Le groupe d'âge de 0 à 25 ans était le plus touché avec (40/111) cas positifs de covid-19, suivi de (24/111) cas confirmés dans le groupe d'âge de 46 à 65 ans. La fréquence du covid-19 semble être plus élevée chez les femmes (60,4%) que chez les hommes (39,6%) avec (RR=1,08, IC 95% [1,012-1,15] ; p=0,013). La majorité des décès étaient des femmes (62,5 % ; RR =0,66, IC 95% [0,46-0,94] ; p<0,013) et l'incidence cumulée était de 1,73/1000. Parmi les cas confirmés, les principaux symptômes rapportés étaient : fièvre, mal de gorge et dyspnée.

Le dispositif d'intervention a permis de suivre et de retracer les cas contacts en plus du confinement des contacts directs du cas confirmé malgré la propagation rapide du covid-19 et la densité de population dans le district. Le taux de létalité était de 21,62%. Malheureusement, il n'existe aucune thérapie efficace contre cette maladie. Cette absence de thérapie rend la vaccination essentielle.

**Keywords**— Cas, Covid-19, Ksar, Nouakchott, Mauritanie.

### STH-1-S2-COL-20

**Raisons de la vaccination contre la Covid-19 chez les personnes vaccinées à l'antenne régionale d'hygiène publique de Bouaké, Côte d'Ivoire, juillet 2021**

**Soumahoro Sory Ibrahim** (1,2), Irika Opri (1,2), Kouassi Damus Paquin (1,2), Coulibaly M'Bégnan (1,2), Kouadio Arsène Déby (1,2), Yao Gnissan Auguste (1,2), Yéo Salifou (2), Ouaga Jean-Marie (2), Tano Mouanta Maryse (1,2), Gbayou Dylane (2), Ouattara Ismael (1,2).

(1) Université Alassane OUATTARA

(2) Antenne régionale d'hygiène publique

**Contexte :** Selon l'OMS les vaccins contre la COVID-19 sont sans danger. Cependant, il subsiste des réticences quant à la vaccination. C'est dans ce contexte que nous avons mené cette étude auprès de sujets vaccinés afin d'identifier leurs motivations.

**Méthodologie :** Nous avons mené une étude transversale à visée descriptive durant le mois de juillet 2021.

**Résultat :** Au total, 510 personnes vaccinées ont été interrogées dont 64,71% de sujets de sexe masculin. Parmi nos enquêtés, 2,16%

avaient déjà fait la maladie dont 48,53% avaient présenté une forme grave. Les musulmans étaient majoritaires (79,02%). La principale source d'information sur le vaccin contre la covid-19 était la télévision à 91,98%. Les raisons de la vaccination étaient le risque de contracter la maladie (93,25%), notamment les formes graves (88,02%), les exigences de voyage (15,42%) et pour 4,13% la perte d'un proche du fait de la covid-19. Pour d'autres, c'étaient la difficulté d'observation des mesures barrières (27,56%) ou la gratuité du vaccin (10,12%).

**Conclusion :** De cette étude, il ressort une mécompréhension de la vaccination et le maintien de l'observation des mesures barrières. La correction de cette incompréhension permettrait de limiter la propagation de la maladie entre sujets vaccinés et non vaccinés.

**Mots clés :** Covid-19, vaccin, Côte d'Ivoire

## STH-1-S2-COL-21

### Facteurs associés à l'observance des mesures de prévention primaire de la COVID-19 dans deux marchés populaires à Cotonou en 2021

Sopoh Ghislain Emmanuel<sup>1</sup>, Azon Kouanou Angèle<sup>2, 3</sup>, Sossa-Jerôme Charles<sup>4</sup>, Chaïd Aminou<sup>2</sup>

#### Affiliations

<sup>1</sup> Département Santé et Environnement, Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenum de Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>2</sup> Service de médecine interne, Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Ministère de la Santé, Bénin

<sup>3</sup> Ecole de Médecine, Faculté des sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>4</sup> Département Promotion de la santé, Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenum de Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

**Adresses :** SGE : [ghislainsop@yahoo.fr](mailto:ghislainsop@yahoo.fr), AKA: [angele.azonkouanou@gmail.com](mailto:angele.azonkouanou@gmail.com), SJC: [sossajero@yahoo.com](mailto:sossajero@yahoo.com), CA: [chaïd@outlook.com](mailto:chaïd@outlook.com)

**Introduction :** L'observance des mesures de prévention primaire (OMPP) de la COVID-19 dans les milieux à forte fréquentation, sont peu documentés.

**Objectif :** Identifier les facteurs associés à l'OMPP de la COVID-19 dans deux marchés (Ganhi et St Michel) de Cotonou au Bénin en 2021.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale analytiques, impliquant 435 vendeurs sélectionnés selon la technique des itinéraires. L'OMPP de la COVID-19 a ainsi été appréciée, avec le model comportemental HBM (Health Belief Model), par rapport à la perception de la gravité et du risque de la COVID-19, la perception de l'efficacité, du bénéfice et des obstacles à la mise en œuvre des MPP, ainsi que des caractéristiques individuels et l'organisation des marchés. Les facteurs associés ont été identifiés par la régression logistique.

**Résultats :** Les enquêtés sont âgés en moyenne de 34,42±10,82 ans, de sexe féminin (73,8%), avec un revenu moyen était jugé suffisant (73,1%). Ils respectent en majorité la distanciation physique (60,5%), mais seulement 30,3% sont vaccinés. Le port de masque et le lavage des mains sont correctement observés respectivement par 87,4% et 92,2% des enquêtés. L'OMPP globale est bonne (60,5%). Le revenu moyen suffisant et la croyance en la

qualité des vaccins étaient significativement associés à l'OMPP dans les deux marchés. Par ailleurs, on note également dans le marché Ganhi, la croyance globale adéquate sur la COVID-19, la disponibilité de gel, de sources d'information fiables ainsi que l'influence des pairs et médias, et dans le marché de Saint Michel, la connaissance de cas dans la famille et/ou l'entourage, la croyance en l'efficacité des mesures pour la protection des proches et de la communauté et la facilité d'accès à l'information.

**Conclusion :** Ces résultats encourageants témoignent de l'impact positif des actions de communication intensives sur la COVID-19 dans la communauté.

**Mots clés :** Observance, Prévention primaire, vaccination, COVID-19, Marchés, Bénin

## STH-1-S2-COL-22

**Facteurs associés au non-port de masques durant la pandémie de COVID-19 dans le district sanitaire de Ratoma, Guinée, avril 2020.**

**Tamba Jacques Millimouno<sup>1,2,3,4</sup>**, Pauline K. Yanogo<sup>1,2</sup>; Faya Martin Millimouno<sup>1</sup> Joseph B. Otshudiandjeka<sup>1,5</sup>, Bernard Sawadogo<sup>1,5</sup>, Marianne<sup>1,5</sup>, Sia Marie Millimouno<sup>6</sup>, Fadima R.M. Diallo<sup>1</sup>, Sakoba Keita<sup>3, 4</sup>, Nicolas. MEDA<sup>1,2</sup>

### Affiliations

1. Programme de formation en épidémiologie et laboratoire de terrain du Burkina ;
2. Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo ;
3. Agence nationale de la sécurité sanitaire ANSS, Guinée ;
4. Programme de formation en épidémiologie de terrain de la Guinée ;

5. Réseau Africain d'épidémiologie de terrain ;

6. Institut de formation et de performance en santé, Guinée.

**Introduction :** En Guinée, le taux d'attaque du COVID-19 est passé de 0, 13 à 11,25 cas/100000 habitants de mars en avril 2020, malgré que le port de masque par la population toute entière avait été rendu obligatoire comme l'a recommandé l'OMS. Cette recommandation n'étant pas suivie à Ratoma foyer de la pandémie en Guinée, nous avons mené une étude pour comprendre le pourquoi.

**Objectif :** Identifier les facteurs associés au non-port de masque afin de mieux prendre des actions ciblées du contrôle de la COVID-19.

**Méthode :** Nous avons mené une étude transversale à visée analytique en avril 2020 à Ratoma. Une régression logistique a été utilisée pour identifier les facteurs associés au non-port de masque par les populations. Des OR et IC95% ont été estimés. Les analyses ont été faites en Epi info 7.2 et Stata et les résultats présentés en tableaux.

**Résultats :** Nous avons interviewé 1624 participants. L'âge médian des participants était de 37 ans ; plus de 50% d'entre eux n'avaient pas porté de masques et 44% ne connaissaient pas en utiliser.

L'âge (OR=0,71 ; IC95%=[0,56 – 0,89] ; p=0,003), le non voisinage avec un cas de COVID-19 (OR=0,00 ; IC 95 % = [0,00 – 0,17]) ; p<0.0001), le coût élevé du masque (OR=0,02 ; IC 95 % = [0,00 – 0,17] ; p<0.0001) ont été identifiés comme facteurs significativement associés au non-port de masques dans le district sanitaire de Ratoma.

**Conclusion :** L'intolérance au masque, le prix élevé du masque, le non voisinage avec un cas du COVID-19 ont indépendamment été associés au non-port de masque. Nous recommandons de fournir des masques à prix abordable pour la population, accentuer la sensibilisation, améliorer les pratiques d'utilisation des masques accompagnée de distribution surtout dans les zones silencieuses.

**Mots clefs :** Non-port, facteurs associés, COVID-19, Ratoma

### STH-1-S2-COP-23

**Les contributions à la riposte contre le coronavirus au Burkina Faso, dynamiques vers un système résilient : résultats d'un living mapping**

**Fadima YAYA BOCOUM<sup>1 2</sup>**, Siaka LOUGUE<sup>1</sup>, Djamina DIALLO<sup>1</sup>, Maxime K. DRABO<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS), Département BIOMED/SP, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>2</sup> African Population Health Research Center (APHRC), WARO, Dakar, Sénégal

**Presenting author:** Fadima YAYA BOCOUM, IRSS, APHRC/WARO, +226 76 50 34 37, [fadimabocoum@yahoo.fr](mailto:fadimabocoum@yahoo.fr)

#### Contexte

Pour faire face à la pandémie COVID-19, un plan de riposte avec un budget a été élaboré au Burkina Faso. Soutenir les efforts de la riposte a nécessité de mobiliser davantage de ressources auprès de divers acteurs. Les initiatives nationales ont permis de mobiliser des ressources financières et matérielles. De ce fait notre étude a eu pour but d'effectuer un living mapping de la mobilisation des différents acteurs.

#### Méthode

Notre étude a consisté à faire une revue de toutes les contributions faites dans le cadre de la covid19 de Mars 2020 à Mars 2021 au Burkina Faso. Un recensement exhaustif des contributions a été effectué à travers l'utilisation de mots clés pour la recherche qui étaient « don », « covid-19 », « coronavirus », « Burkina Faso ». Un système de veille a été mis en place à partir d'octobre 2020 sur les sites web Burkinabè. Les variables concernant la date du don, la nature du don, le nom du donateur et du bénéficiaire, la nature du donateur et du bénéficiaire et le montant du don ont été collectées. Les données ont ensuite été compilées dans une grille créée dans le logiciel Excel et une analyse en a été faite à l'aide de SPSS version 20.

#### Résultats

Au total 252 dons ont été recensés sur la période. La majorité des dons était en nature (72%) et peu en espèce (13%). L'estimation financière s'élève à plus de 17 millions d'euros. Le secteur privé est le premier contributeur (30,5%) à la riposte contre la covid 19 alors que les partenaires financiers traditionnels du secteur de la santé représentaient 17%. Les principaux contributeurs du secteur privé étaient principalement les entreprises privées (20%), les sociétés minières (6,1%) et les sociétés financières (4,5%). Les principaux bénéficiaires étaient l'administration publique (45%) et les populations (19%).

#### Conclusion

Le défi de la riposte à la covid-19 a vu naître une mobilisation inédite au Burkina Faso. Ainsi le secteur privé est le premier contributeur. Cela

pourrait s'expliquer par le fait des effets qui ont été durement ressentis par ce secteur. Cette dynamique des dons au-delà de cette crise sanitaire, doit être comprise pour en faire un levier de mobilisation des financements domestiques au Burkina Faso.

**Mots clés :** covid19, cartographie, secteur privé, Burkina Faso

## STH-1-S2-COL-24

### Epidémiologie et Connaissances, attitudes et pratiques de la COVID-19 dans la Région de Tombouctou au Mali

**Oumar Sangho**<sup>1,2,3\*</sup>, Allasseini Balam<sup>4</sup>, Aboubacar Sangho<sup>5</sup>, Abdoulaye Dembélé<sup>2</sup>, Ildevert Germain Momo Zefack<sup>2</sup>, Ousmane Ly<sup>3</sup>, Ousmane Boua Togola<sup>6</sup>, Abdoulaye Konaté<sup>2</sup>, Souleymane Sawadogo<sup>2</sup>, Boubacar Camara<sup>2</sup>, Moussa Hama Sankaré<sup>4</sup>, Djibril Kassogu<sup>7</sup>, Tyeri Dackou<sup>2</sup>, Fanta Sangho<sup>1</sup>, Hamadoun Sangho<sup>3</sup>

1. Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Biologiques et Médicales, Faculté de Pharmacie (FAPH), Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), Mali
2. Agence Nationale de Télésanté et d'Informatique Médicale (ANTIM), Hamdallaye ACI, Bamako, Mali
3. Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique et Spécialités, Faculté de Médecine et d'Odonto-Stomatologie (FMOS), USTTB, Mali
4. Direction Régionale de la Santé de Tombouctou, Mali
5. Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Pharmaceutiques, FAPH/USTTB, Mali

6. Sous-direction Prévention et lutte contre la maladie de la Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, Bamako, Mali

7. Hôpital Régional de Tombouctou, Mali

\* **Dr Oumar Sangho**, MD, MPH, PhD, Maître Assistant en Epidémiologie au Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Biologiques et Médicales de la Faculté de Pharmacie, Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), Bamako, Tél : (+223) 76 22 58 77 / 66 76 67 82, Email : [osangho75@gmail.com](mailto:osangho75@gmail.com), ORCID ID : 0000-0003-2856-0395

**Introduction :** Le Mali a enregistré ses premiers cas de COVID-19 le 25 mars 2020. La Région de Tombouctou est devenue la deuxième Région la plus touchée en termes de nombre de cas après le District de Bamako avec 18,5% du total des cas confirmés du pays. L'objectif de ce travail était d'évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques de la population de Tombouctou en matière de COVID-19.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude transversale sur les données de surveillance de la COVID-19 de la Région de Tombouctou et du centre d'appel d'urgence santé de l'Agence Nationale de Télésanté et d'Informatique Médicale. Les variables d'intérêts ont été extraites de la base et analysées sur Excel 2016 et SPSS 21. Les fréquences, taux et ratio ont été calculés.

**Résultats :** Au total 1851 cas suspects en provenance de tous les districts de la Région ont été testés à la RT-PCR dont 572 confirmés soit un taux de positivité de 30,9%. La tranche d'âge de 15-34ans était la plus représentée avec 47,7% de cas confirmés. Le sex ratio (homme/femme)

des cas confirmés était de 2,67. La ville de Tombouctou était l'épicentre de la COVID-19 avec 40,8% des cas confirmés. Le taux de dépistage d'environ 2‰ (1851/928.000) a connu son pic entre les semaines 22-23 avec une létalité de 2,8%. Sur les 1533 appelants, 40,8% vivaient dans la ville de Tombouctou, l'âge moyen était de 22,39 ans avec un sex ratio (homme/femme) de 2,14. Les Elèves/étudiants étaient majoritaires avec 36,3%. Les 24,5% (376/1533) des utilisateurs avaient appelé en juin, 80,4% des appels avaient un motif d'informations, 96,8% étaient satisfaits.

**Conclusion :** Les jeunes et hommes seraient les plus susceptibles d'être infectés par la COVID-19. Le centre d'appel est une opportunité pour le renforcement de la sensibilisation.

**Mots-clés :** COVID-19, surveillance, connaissances, attitudes, Mali.

## Sous-thème 1 Session 3

### STH-1-S3-COP-25

#### Aspects épidémiologiques et management de la COVID 19 au Burkina Faso : Cas du District sanitaire de Tenkodogo

**Dounsoe J.V. BONZI**<sup>1</sup>, Maxime K. DRABO<sup>2</sup>

1 : Ministère de la Santé Burkina Faso/Impétrant Master de Santé Publique UJKZ

2 : Centre National de Recherche Scientifique et Technologique/IRSS

**Introduction :** Le Burkina Faso à l'instar d'autres pays de la sous-région n'avait jamais fait face à une urgence de santé publique internationale d'une telle ampleur et son système de santé a été mis à rude épreuve.

**Objectif général :** Réaliser un état des lieux relatif à la gestion de la Covid-19 dans les Districts sanitaires : cas de Tenkodogo.

**Méthodologie :** Etude transversale descriptive à visée analytique, allant du 09 Mars 2020 au 30 Juin 2021.

**Résultats :** Les sexe ratio était de 1,11 en faveur des femmes. Les femmes représentaient 58,84% des Patients/Accompagnants contre 42,86% des prestataires. La létalité était de 1,41% sans comorbidité et concernait la tranche d'âge de [15 – 49 ans]. La PCR était le seul test de diagnostic de la COVID-19 avec un taux de positivité de 21,13%. La tranche d'âge la plus touchée était celle de [15 – 49 ans] avec une proportion de 78,87%. La moins touchée était celle de [60 – 64 ans] avec une proportion de 1,41%. Le taux de suivi des contacts était de 92,02%. La gestion du dépistage était centralisée sans dévolution au niveau périphérique. La surveillance participative, basée sur les événements durant la période était en phase d'implémentation. La qualité des soins a été perçue sous l'angle de la disponibilité en équipement, en médicaments et aussi sous l'angle du comportement des agents de santé. L'application des recommandations issues des messages souffre du fait de la durée de la pandémie et des habitudes de vies antérieures de la population.

**Conclusion :** Le Burkina Faso devrait s'atteler au renforcement de la veille sanitaire et au développement de mécanismes adaptés à son contexte socio-culturel et économique pour une plus grande efficacité et efficience des stratégies de riposte.

**Mots clés :** COVID-19, gestion de la COVID-19, surveillance épidémiologique, management de la COVID-19.

**STH-1-S3-COP-26**

**Modèle épidémiologique fractionnaire SEIRS au sens de Caputo: application à la dynamique de propagation de la COVID-19**

**SOME Windjiré**, doctorant à l'Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ)

Email : [windjirsome@gmail.com](mailto:windjirsome@gmail.com)

Dr LAMIEN Kassienou, maître-assistant à l'Institut des Sciences (IDS)

Email : [basilelakas@gmail.com](mailto:basilelakas@gmail.com)

Pr SO Ousséni, professeur titulaire à l'Institut des Sciences (IDS)

Email : [sousseni@gmail.com](mailto:sousseni@gmail.com)

Pr SOME Blaise, professeur titulaire à l'Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ)

Email : [blaisesomeouaga1@gmail.com](mailto:blaisesomeouaga1@gmail.com)

Dans cet article nous présentons un modèle épidémiologique fractionnaire SEIRS au sens de Caputo. Plusieurs auteurs ont effectué des travaux dans ce sens mais au niveau de l'analyse mathématique, ils ont utilisé la dérivation partielle classique. Au cours de nos travaux, nous avons utilisé la dérivation partielle fractionnaire d'ordre  $\alpha$  au sens de Caputo dans l'analyse du modèle formulé. Nous avons prouvé que le modèle mathématiquement bien posé admettant un équilibre sans maladie stable et un équilibre endémique dont la nature n'a pas été déterminée à cause des difficultés liées à l'utilisation des conditions initiales ; lesquelles difficultés nous ont contraint à circonscrire le paramètre  $\alpha$  dans le domaine

$]0 ; 1[ \setminus \{ \frac{1}{2n} ; n \in \mathbb{N} \}$ . Le nombre de reproduction de base  $R_0$  a été déterminé et donne le sens de l'évolution de la maladie.

L'application à la dynamique propagation de la covid-19 est faite à travers la simulation numérique.

**Mots clés :** Modèle, épidémiologique, fractionnaire, SEIRS, simulation,  $R_0$

**STH-1-S3-COL-27**

**Analyse de gestion des crises sanitaires épidémiques et pandémiques face au dilemme de l'approche médicale contre l'approche de santé publique**

**BASSALIA D.**<sup>1</sup>, AKA E.J.<sup>1,2</sup>, YEO A.F.<sup>1</sup>, KONAN E.<sup>1,2</sup>, SACKOU-KAKOU J.<sup>1,3</sup>, TIEMBRE I.<sup>1,2</sup>, YAVO W.<sup>1,3</sup>, DOSSO M.<sup>2,4</sup>

<sup>1</sup>Centre de Recherche et d'Etudes en Populations, Politiques et systèmes de santé, Institut National de Santé publique, Abidjan, Côte d'Ivoire ;

<sup>2</sup>UFR des Sciences Médicales de l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire ;

<sup>3</sup>UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan ;

<sup>4</sup>Institut Pasteur, Département de Microbiologie, Abidjan, Cote d'Ivoire.

E-mail : [dbassalia3@gmail.com](mailto:dbassalia3@gmail.com)

**Introduction :** La gestion des crises sanitaires est confrontée au dilemme entre l'approche médicale contre l'approche de santé publique. L'orientation de gestion la plus appliquée est l'approche médicale, malgré les proclamations officielles en faveur de l'approche de santé publique. Cette situation conduit à une inefficacité de gestion des crises. Qu'est ce qui explique cela ? et comment sortir du dilemme ? L'objectif du travail est de proposer des solutions pour promouvoir l'approche de santé publique dans cette gestion.

**Méthode :** La méthode reposait sur une réflexion en équipe associée à la revue documentaire. L'analyse repose le brainstorming de l'équipe pour identifier les causes et les solutions. Cette analyse a été complétée par des données recensées lors de la revue documentaire.

**Résultats :** Les causes identifiées étaient multiples, notamment l'abondance des cliniciens disponibles face à la faible masse critique des médecins de santé publique, l'insuffisance des ressources logistiques et financières pour les interventions de santé publique, l'insuffisance de culture de santé publique face à une culture médicale hypertrophique, le manque d'évaluation de la gestion des crises pour en tirer les leçons, l'immixtion des autorités politiques dans la gestion, le manque de préparation des acteurs concernés par la gestion des crises, etc..

Pour adresser le dilemme, il ressort de former d'avantages de spécialistes de santé publique, de préparer en amont la gestion des crises sanitaires à travers la formation des acteurs et la mise en place de dispositions logistiques et financières, d'évaluer la gestion des crises antérieures pour en tirer des leçons, d'instaurer une véritable culture de santé publique de gestion des crises sanitaires, éviter l'immixtion politique dans la gestion technique.

**Conclusion :** Promouvoir une approche de santé publique de gestion des crises sanitaires est un gage d'une plus grande efficacité. Aussi, les solutions de résolution du dilemme posé ne sont pas insurmontables et laissent à espérer.

**Mots-clés :** Gestion, crises sanitaires, approche médicale, approche santé publique.

## **Sous-thème 2 : Les pratiques de surveillance épidémiologique dans le cadre des vigilances sanitaires**

## Sous-thème 2 Session 1

### STH-2-S1-COP-1

#### Evaluation du système de surveillance de la rougeole, district sanitaire de Tambacounda, Sénégal, 2019

**Samba THIOUB**<sup>1,2</sup>, Mathias NDIAYE<sup>2,3</sup>, Pauline Kiswendsida YANOGO<sup>2,4</sup>, Simon TIENDREBEOGO<sup>2</sup>, Nicolas MEDA<sup>2,4</sup>

1. Centre de santé de Tambacounda, Tambacounda, Sénégal
2. Burkina Field Epidemiology Training Program, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
3. Direction des laboratoires, Dakar, Sénégal
4. Département de Santé Publique, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

**Auteur correspondant :** **Samba THIOUB**, Centre de santé de Tambacounda, Tambacounda, Sénégal, Téléphone : 00221 77 420 04 23, Email : [samba.thiouba@yahoo.fr](mailto:samba.thiouba@yahoo.fr)

**Introduction :** La rougeole est une maladie à potentiel épidémique qui pose un problème de santé publique mondiale. Le Sénégal a connu des épidémies meurtrières avec 20000 cas et 1000 décès avant 2019. La région de Tambacounda qui couvre 21,7% du territoire national et frontalière avec 3 pays, représente un élément central dans le dispositif de surveillance épidémiologique. Elle a notifié 97 cas suspects de rougeole en 2019 dont 5 confirmés. Le district sanitaire de Tambacounda, carrefour dans la région, avec un taux d'abandon rougeole/rubéole de 14% en 2019, a notifié 16 cas suspects de rougeole dont 3 confirmés.

**Objectif principal :** Evaluer le système de surveillance de la rougeole dans le district sanitaire de Tambacounda du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019.

**Méthodes :** Une étude transversale descriptive a été réalisée. L'évaluation était basée sur les références du guide d'évaluation des systèmes de surveillance du CDC. L'échantillonnage était non probabiliste et portait sur 52% des structures impliquées dans la surveillance : 2 centres de santé sur 3, 11 postes de santé sur 24, le district et la région médicale. Le système a été décrit et les attributs (utilité, stabilité, simplicité, qualité des données) estimés. Un

questionnaire et une fiche d'extraction des données ont été utilisés.

**Résultats :** La surveillance de la rougeole du district épousait l'architecture du ministère de la santé. Elle était active et passive à trois niveaux : communautaire, poste de santé et district. 100% des prestataires enquêtés étaient formés. Les données étaient transmises hebdomadairement via la plateforme DHIS2. La rétro-information était de 82%. Le système était utile. La stabilité et la simplicité étaient de 100% et l'exhaustivité de 82%.

**Conclusion :** La surveillance de la rougeole était organisée, fonctionnelle, utile, stable et simple. La qualité des données était à améliorer avec l'exhaustivité du remplissage des fiches.

**Mots clés :** **Evaluation, Surveillance, Rougeole, Tambacounda, 2019**

### STH-2-S1-COP-2

#### Surveillance sentinelle de la dengue dans la ville de Ouagadougou : la part explicative du temps et de l'environnement.

**Sagno Kéamou Tokpa**<sup>1</sup>, Sondo K Apoline<sup>2</sup>, Dahourou Lucien Désiré<sup>3</sup>, Kagone Therese<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Etudiant à l'UFR/SDS, Master de Santé Publique, Université Joseph Ki-Zerbo, [kjnsagno@gmail.com](mailto:kjnsagno@gmail.com)

<sup>2</sup>Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>3</sup>Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Département de Biomédical/Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>4</sup>Centre MURAZ, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

**Introduction :** La dengue est une infection virale qui se transmet à l'homme par la piqûre des femelles infectées de moustiques, principalement de l'espèce *Aedes aegypti*. L'infection chez l'homme est souvent inapparente mais peut entraîner un large éventail de manifestations cliniques, allant d'une fièvre légère au syndrome de choc de la dengue potentiellement mortel. L'objectif de cette étude était de caractériser les cas de dengue survenus dans la ville de Ouagadougou dans les périodes de 2018 et 2019.

**Matériel et méthodes :** Nous avons conduit une étude transversale conduite dans les sites sentinelles de prise en charge des cas de la dengue au cours des années 2018 et 2019. Les cas suspects de dengue (température corporelle  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ ) ou des antécédents de fièvre (autodéclarée) pendant  $\leq 7$  jours reçus et pris en charge dans un des sites sentinelles de surveillance de la ville de Ouagadougou.

**Résultats :** la majorité des notifications des cas suspects de dengue était faite en 2018 pendant que le nombre de cas positifs était plus élevé en 2019. Les caractéristiques des cas étaient celles de patients jeunes (âge<30), élèves, prédominance féminine et résidant au secteur 37. L'année 2019 (ORa=20,34[10,48 – 39,46]), temps de chaleur (ORa=0,02[0,0048 – 0,14]) ; la résidence près de la forêt Bengr-weogo (ORa=3,14 [1,88 – 5,25]) étaient des facteurs associés à la survenue des cas de dengue.

**Conclusion :** Le renforcement de la collaboration de tous les acteurs impliqués dans le système de la surveillance sentinelle pourrait améliorer davantage dans le programme de surveillance.

**Mots-clés :** Surveillance sentinelle, Dengue, Ouagadougou.

### STH-2-S1-COP-3

#### Investigation d'une épidémie de choléra à Katanga dans la commune du Golfe 1, Grand Lomé, Togo, Novembre 2020

**LABITE Y.<sup>1</sup>**, KABORE J.<sup>3</sup>, N'DJAO A.<sup>1</sup>, SABI M.<sup>1</sup>, HILIM P. M.<sup>1</sup>, AMENYIDO N.<sup>1</sup>, DEGUE K.<sup>4</sup>, ASSANE H.<sup>5</sup>, YANOGO P.<sup>2</sup>

1 Master BFELTP, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou (Résidents du Togo)

2 Burkina Field Epidemiology and Laboratory Training Program

3 Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso

4 Direction Régionale de la Santé Grand Lomé, Commune de Golfe 1 (Togo)

5 Direction de la Lutte contre la Maladie et des Programmes de Santé Publique, Togo

\*Email: [labyen2@gmail.com](mailto:labyen2@gmail.com)

Téléphone:(00228)90244872

**Introduction:** Des cas de diarrhées avec vomissements ont été signalés dans le village de Katanga dans la commune de Golfe 1 au Togo. Nous avons mené une investigation pour décrire la survenue du choléra dans la commune.

**Méthodes:** Nous avons conduit une étude descriptive sur les cas de choléra survenus dans la commune de Golfe 1 entre le 11 novembre et le 5 décembre 2020. Le cas présumé était toute personne résidant dans la commune de Golfe 1 présentant une diarrhée aqueuse aiguë, avec ou sans vomissements. Le cas confirmé était tout cas présumé chez qui la coproculture a révélé la présence de *Vibrio cholerae* ou tout cas présumé

ayant un lien épidémiologique avec un cas confirmé.

**Résultats:** Du 11 novembre 2020 au 5 décembre 2020, 47 cas ont été détectés dont 3 cas communautaires. La létalité était de 4.3 %. L'âge médian des cas était de 25 ans (17 - 35ans). Le sex-ratio H/F était de 1.94. Le cas index âgé de 49 ans est un chauffeur occasionnel à la zone franche et gardien de latrines résidant dans le quartier Adankomé. Les échantillons de selles positifs au *Vibrio cholerae* étaient (47,82%) dont 54,54% chez les pêcheurs. Les principaux signes cliniques étaient : diarrhée aqueuse (100%), vomissements (74%). Les principales caractéristiques environnementales recensées à l'issue des entretiens étaient: Latrines publiques fonctionnelles payantes (100%), fontaines publiques non fonctionnelles (100%), défécation à l'air libre (70%), puits non protégés (99%).

**Conclusion:** Les sources d'approvisionnement d'eau caractérisées par des puits insalubres, avec une défécation à l'air libre fréquente pourraient expliquer la survenue de l'épidémie de choléra dans la commune du Golfe 1. Nous recommandons d'améliorer la salubrité de l'environnement et la propreté des points d'eau situés dans la commune.

**Mots clé:** Choléra, *Vibrio cholerae*, Katanga, Golfe 1, Togo, 2021

### STH-2-S1-COP-4

#### Analyse de données de surveillance de la Fièvre Jaune Mali, 2010 à 2019

**H. B. DIABY<sup>1</sup>** ([hamadoudiaby1@gmail.com](mailto:hamadoudiaby1@gmail.com)), Y. KONE<sup>2</sup> ([ykone203@gmail.com](mailto:ykone203@gmail.com)), M. KONE<sup>2</sup> ([dmoussakone@yahoo.fr](mailto:dmoussakone@yahoo.fr)), B. TRAORE<sup>2,3</sup> ([bouyaguitra@gmail.com](mailto:bouyaguitra@gmail.com)), D. BARRY<sup>1,4</sup> ([djilrou@yahoo.fr](mailto:djilrou@yahoo.fr)), H. KEÏTA<sup>3,5</sup> ([hankeit77@gmail.com](mailto:hankeit77@gmail.com)), F. Diallo<sup>1,6</sup> ([mi.raina@hotmail.com](mailto:mi.raina@hotmail.com)), Pauline. Y<sup>1,6</sup> ([yanogo.pauline@yahoo.fr](mailto:yanogo.pauline@yahoo.fr)), N. Meda<sup>1,6</sup> ([nicolas.meda@gmail.com](mailto:nicolas.meda@gmail.com)), J. KABORE<sup>7</sup> ([jck238@gmail.com](mailto:jck238@gmail.com))

1. Burkina Field Epidemiology and Laboratory Training Program (BFELTP), University Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

2. Direction General de la Santé et de l'Hygiène Publique, Mali

3. Resident Advisor Frontline Field Epidemiology Training Program African Field Epidemiology Network, Bamako, Mali

4. Coordinator training BFELTP

5. Field Coordinator, Field Epidemiology Training Program, Bamako, Mali

6. Faculty of Medicine, University Ouaga 1 Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

7. Epidemiologist, Researcher National Centre for Scientific and Technology Research Institute for Research in Health Science, Ouagadougou, Burkina Faso

**Introduction :** La fièvre jaune est une fièvre hémorragique virale qui affecte chaque année approximativement 200 000 personnes dans le monde entraînant environ 30 000 décès. Entre Janvier 2010 et 31 Décembre 2019 les structures de santé ont notifié à l'INSP 1628 échantillons de cas suspects de fièvre jaune. Au Mali, en application du RSI, a introduit dans son Programme Elargie de Vaccination (PEV) le Vaccin anti Amaril entre 2001 et 2017 chez les enfants âgés de 9 mois.

**Objectif principal :** Analyser les données de surveillance épidémiologique de la fièvre jaune.

**Méthode :** Nous avons mené une étude transversale descriptive. Les informations ont été recueillies dans la base de données nationale de la fièvre jaune. Nos variables étaient d'ordres sociodémographiques, biologiques. Un cas suspect était défini comme toute personne présentant une fièvre, avec apparition d'un ictère dans les 14 jours des premiers symptômes. Nous avons calculé les fréquences, les proportions en utilisant Epi-info 7.2, Excel 2010.

**Résultats :** 1628 cas suspects et 23 cas confirmés ont été signalés. Le sexe ratio 1,6. Les moins de 15 ans (55,5%) ont été les plus représentés. Les cas suspects notifiés n'avaient jamais reçu une dose de vaccin dans 82%. Parmi tous les cas confirmés, 83% des cas vivaient dans des zones rurales et 17% dans des zones urbaines. L'analyse des échantillons de sang au laboratoire a révélé un cas de rougeole, deux cas de fièvre de la vallée du Rift et un cas de West Nile et virus Zika. Les régions de Kayes (8) et Sikasso (10) étaient plus touchés par ces épidémies.

**Conclusion :** Cette analyse rappelle la fréquence élevée du retard dans la vaccination des enfants au Mali. La fièvre jaune reste endémique au Mali. La proportion des non vaccinés est très élevée malgré la vaccination de routine à travers le PEV.

**Mots clés :** Analyse, Fièvre jaune, Mali 2010-2019

## STH-2-S1-COP-5

### Système burkinabè de pharmacovigilance : réglementation, organisation et principaux défis

**Kampadilemba OUOBA**, Rasmané SEMDE  
Laboratoire du Développement du Médicament (LADME), Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM), Ecole doctorale sciences et santé (ED2S), université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou, Burkina Faso

#### Introduction

Le drame de la thalidomide survenu au début des années 60, a depuis lors suscité des exigences de plus en plus rigoureuses concernant la surveillance de la sécurité d'emploi des médicaments. Cette surveillance qui relève de la responsabilité partagée entre les fabricants et les Etats doit être assurée par le système de pharmacovigilance, dont le rôle est de détecter, évaluer et prévenir les préjudices associés à l'utilisation des médicaments : effets indésirables, échecs thérapeutiques, erreurs médicamenteuses, pharmacodépendance, etc. Le présent travail vise à décrire la réglementation, l'organisation et les défis majeurs du système burkinabè de pharmacovigilance.

#### Méthodes

Une étude transversale descriptive a permis de collecter les textes réglementaires et autres documents normatifs relatifs au système de pharmacovigilance du Burkina Faso. Une analyse documentaire a été réalisée afin d'explorer les aspects réglementaires, organisationnels, ainsi que les défis de ce système.

#### Résultats

Le décret n°2012-1033/PRES/PM/MS portant création, attributions et organisation d'un système national de vigilance des produits de santé à usage humain constitue la base réglementaire du système burkinabè de pharmacovigilance. Ses arrêtés d'application ont permis d'instituer un circuit officiel de notification des effets indésirables et des organes décisionnels indépendants. Ce système relève aujourd'hui des missions de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Il est organisé principalement autour des professionnels de santé, des structures sanitaires publiques et privées, des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, des centres

de recherche, du comité technique et de la commission nationale de vigilance des produits de santé.

### Conclusion

Ce cadre réglementaire et organisationnel permet d'évaluer en continue la balance bénéfice/risque des médicaments. Toutefois, le système burkinabè de pharmacovigilance fait aujourd'hui face à trois défis majeurs : la sous-notification, la non-inclusion des patients des notificateurs légaux et l'absence d'un financement pérenne.

**Mots clés :** Pharmacovigilance ; système ; réglementation ; organisation ; Burkina Faso.

## STH-2-S1-COP-6

### Pharmacovigilance des médicaments à base de plantes en pédiatrie

**Kampadilemba** <sup>1,2</sup>, **OUOBA** <sup>1,2</sup>, Hélène LEHMANN<sup>3</sup>, Jean-Yves PABST<sup>2</sup>, Rasmané SEMDE<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratoire du Développement du Médicament (LADME), Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM), Ecole doctorale sciences et santé (ED2S), université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>2</sup> EA 7307, Centre d'études internationales et européennes (CEIE), faculté de pharmacie, université de Strasbourg, 74, route du Rhin, 67400 Illkirch, France

<sup>3</sup> EA 4487, Centre de recherches en droit et perspectives du droit, faculté de pharmacie, université de Lille, rue du Professeur-Laguesse, BP 53, 59006 Lille, France

### Introduction

Les médicaments à base de plantes constituent la principale médication en médecine complémentaires et alternatives. Ils font l'objet d'un fort recours même chez les groupes à risques potentiels comme en pédiatrie. Ce fort recours repose sur la perception populaire selon laquelle les médicaments d'origine naturelle sont sans risques pour la santé, comparativement aux médicaments chimiques. Ce travail vise donc à faire un état des lieux des risques liés à l'utilisation des médicaments à base de plantes chez l'enfant.

### Méthodes

Il s'est agi d'une revue narrative réalisée à partir des bases de données bibliographiques PubMed, Scopus, Embase et Science Direct.

Ont été inclus dans cette revue les articles évalués par les pairs et traitant des risques associés à l'utilisation des médicaments à base de plantes chez l'enfant et publiés jusqu'au 10 mai 2021.

### Résultats

Les prévalences de l'utilisation des médicaments à base de plantes chez l'enfant sont comprises entre 2,20% et 8,90% à travers le monde. Cette utilisation a occasionné 14860 effets indésirables dont 3% de réactions allergiques immédiates. Des cas d'intoxications aiguës, d'interactions entre plantes médicinales et médicaments chimiques, de dépendance et d'autres effets nocifs liés aux adulterations et/ou aux contaminations ont été également rapportés. La notification spontanée par les professionnels de santé a été la principale source de détection de ces risques.

### Conclusion

Bien que les médicaments à base de plantes aient montré leur efficacité dans la prise en charge de certaines maladies infantiles, cette revue suggère la nécessité de surveiller leur utilisation en clinique pédiatrique. Cela permettra de détecter et de notifier les éventuelles réactions indésirables, dans une perspective de prévention des risques.

**Mots clés :** Pharmacovigilance, médicaments à base de plantes, risques, enfant

## STH-2-S1-COP-7

### Dualité du système de surveillance épidémiologique en contexte pandémique, nécessité d'appropriation des soins de santé primaire au Burkina Faso.

**Sanou H.**<sup>\*1</sup>, Korbéogo G.<sup>1</sup>, Meyrowitsch DW.<sup>2</sup>, Ilboudo D.<sup>3</sup>, Drabo KM.<sup>4</sup>, Samuelsen H.<sup>2</sup>

1. Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
2. Université de Copenhague, Danemark
3. Université Thomas Sankara, Ouagadougou, Burkina Faso
4. Institut de Recherche en Science de la Santé, Burkina Faso  
[\\*hsanou@ymail.com](mailto:hsanou@ymail.com)

### Introduction

L'homme et sa mobilité sont les facteurs propageant les maladies épidémiques (Howard-Jones, 1975). Pour prévenir ces maladies, la stratégie de surveillance intégrée de la Maladie et la Riposte (SIMR), exige la participation des communautés à la collecte systématique et

continue, la notification de cas, l'investigation et à la riposte (OMS, 2016). C'est ainsi que les agents de santé à base communautaire (ASBC) furent choisis au Burkina Faso et la participation de toutes les composantes de la communauté est exigée (Ministère de la santé, 2016). Cette recherche explore la traduction de cette politique de santé communautaire en contexte COVID-19 dans le district sanitaire de Dandé (DSD).

### Méthodes

Nous avons réalisé 72 entretiens approfondis avec les acteurs de la surveillance (ICP, épidémiologistes, ASBC, etc.), les leaders locaux (conseillers, chefs de villages, tradipraticiens, etc.), et des observations dans les villages et à la frontière d'avec le Mali.

### Résultats

Notre recherche montre que les communautés et système de santé sont dans une logique de vigilance sanitaire dualiste. On a observé la mobilisation d'une kyrielle de thérapies populaires, des pratiques divinatoires et magico-religieuses alors que les entités "individu et communauté" furent ignorées dans la stratégie de surveillance biomédicale reposant sur les ASBC et les professionnels de santé. L'implication des leaders religieux (chefs de village, etc.) et locaux (conseillers municipaux) est nécessaire à cause de l'insuffisance des ASBC (une insuffisance associée à une inégale répartition qui rend inefficaces leurs interventions), des attitudes populaires de refus vis-à-vis des mesures prises et leurs « risques concurrents », et de la porosité des frontières nationales qui ne sont pas maîtrisées par les autorités sécuritaires en charge du respect des mesure de quarantaine et de fermeture des frontières.

### Conclusion

L'implication effective des autres composantes de la communauté est une garantie du respect des mesures biomédicales et de la vigilance sanitaire.

**Mots clés :** Surveillance épidémiologique, vigilance sanitaire, COVID-19, district sanitaire de Dandé.

## STH-2-S1-COP-8

### Profil épidémiologique de la fièvre jaune au Sénégal de 2013 à 2019

**Samba THIOUB**<sup>1,2</sup>, Mathias NDIAYE<sup>2,3</sup>, Jean KABORE<sup>2,4</sup>, Pauline Kiswendsida YANOGO<sup>2,5</sup>, Nicolas MEDA<sup>2,5</sup>

5. Centre de santé de Tambacounda, Tambacounda, Sénégal
6. Burkina Field Epidemiology Training Program, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
7. Direction des laboratoires, Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, Dakar, Sénégal
8. Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso
9. Département de Santé Publique, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

**Auteur correspondant :** Samba THIOUB, Centre de santé de Tambacounda, Sénégal, Téléphone : 00221 77 420 04 23, Email : [samba.thioub@yahoo.fr](mailto:samba.thioub@yahoo.fr)

**Introduction :** La fièvre jaune provoquée par le virus amaril, est responsable en zones tropicales de 200 000 cas de contaminations dont 30 000 décès, majoritairement en Afrique. Ces dix dernières années, le Sénégal a enregistré cinq épidémies.

**Objectif principal :** Décrire le profil épidémiologique de la fièvre jaune au Sénégal de 2013 à 2019.

**Méthodes :** Une étude transversale descriptive sur une base de données secondaires a été réalisée. Elle couvrait la période du 28 février 2013 au 31 mai 2019. La qualité des données a été vérifiée. Les caractéristiques sociodémographiques des cas ont été décrites en temps, lieu et personne avec des proportions et des médianes, et les performances des districts sanitaires évaluées. Le logiciel EpiInfo®7.2.4.0 a été utilisé pour toutes ces analyses.

**Résultats :** La validité des données était de 100% et l'exhaustivité de 91%, IC 95% [89,52% - 91,99%]. Au total, 2 097 suspects ont été répertoriés et 3 cas étaient positifs entre 2013 et 2015. L'âge médian des cas positifs était de 5 ans avec des extrêmes de 4 et 55 ans. Le sex-ratio (Homme/Femme) était de 0,5. L'absence de vaccination était le facteur majeur car 100% des cas n'étaient pas vaccinés et provenaient tous du milieu rural. Deux districts sur soixante-quinze (Touba et Goudiry) ont notifié des cas confirmés et 98%, IC95% [97,14% - 98,40%] des échantillons ont été reçus au laboratoire dans de bonnes conditions.

**Conclusion :** Les enfants de moins de cinq non vaccinés en milieu rural étaient plus affectés par la maladie. Une bonne couverture vaccinale et une sensibilisation continue permettront de lutter contre la fièvre jaune.

**Mots clés :** Epidémiologie, Fièvre, Jaune, Sénégal, 2019

## STH-2-S1-COP-9

### Evaluation du système de surveillance épidémiologique de la méningite, Sikasso, Mali 2019

**D.Farota**<sup>1,2</sup>, H. Kéita<sup>3</sup>, D. Barry<sup>2</sup>, Y. Koné<sup>1</sup>, B. Traoré<sup>3</sup>, I. Berthé<sup>1</sup>, O. B. Togola<sup>1,2</sup>, Y. K. Pauline<sup>2</sup>, F. Diallo<sup>2</sup>, N. Meda<sup>2</sup>.

1. Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, Bamako, Mali
2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain et de Laboratoire, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, /Université Pr Joseph Ki- Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
3. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain, Bamako, Mali

**Auteur correspondant : Dr Dado Farota,**  
Email : [dadofatota@gmail.com](mailto:dadofatota@gmail.com) ; Tel : 00223 70 41 89 70

**Introduction :** La Méningite, infection des méninges se traduit par la modification des propriétés physico-chimiques et biologiques du liquide céphalo-rachidien. L'incidence est de 2,5 à 10 pour 100 000 habitants, la mortalité de 20 à 30 % chez les nouveau-nés, 20 à 40 % chez l'adulte. Environ 30 000 cas confirmés chaque année dans la ceinture africaine de la méningite. Au Mali en 2018 ,127 cas confirmés et 10 décès ; dont 21 cas confirmés et 04 décès à Sikasso. La méningite a été inscrite sur la liste des Maladies à Déclaration Obligatoire qui font l'objet d'une surveillance à travers toute la pyramide sanitaire. Après plusieurs années de mise en œuvre du système de surveillance dans la région de Sikasso, aucune étude menée, d'où cette évaluation pour apprécier certains attributs du système de surveillance.

**Méthodes :** Une étude transversale descriptive a été conduite du 1<sup>er</sup> au 30 juin 2020 incluant tout le personnel en charge de la surveillance dans la région. La fidélité, la simplicité, la sensibilité, la réactivité, l'utilité et la qualité des données ont été appréciées. Les moyennes et les proportions ont été calculées avec le logiciel

Epi-Info 7.2. Des scores d'appréciation des attributs ont été définis : Faible (<50%) ; Moyen (≥50%<75%) ; Bon (≥75%≤100%).

**Résultats :** Au total 8 structures dont une privée enquêtées ,23 personnels interrogés, 47,82% du personnel avait plus de 4 ans d'ancienneté au poste La fidélité de mise en œuvre du plan (77,17%), la simplicité (67,39%), la sensibilité (20%), l'utilité (72,46%), la réactivité (57,96%) du système , la promptitude (52,95%).

**Conclusion :** Le système de surveillance épidémiologique de la méningite a été jugé simple, utile, peu sensible, réactif et représentatif. Ces résultats suggèrent un intérêt de former tout le personnel en charge de la surveillance sur le guide SMIR dans la région.

**Mots clés :** Evaluation, Système de surveillance, Méningite, Sikasso.

## STH-2-S1-COP-10

### Evaluation du système de surveillance de la rougeole dans le district sanitaire de Banamba, Mali, 2019.

**Aliou Badara Ballo**<sup>1,2</sup>, Pauline Kiswendsida Yanogo<sup>2,3</sup>, Djibril Barry<sup>2</sup>, Fadima Radhia Diallo Ouédraogo<sup>2</sup>, Bouyagui Traoré<sup>5</sup>, Yacouba Sangaré<sup>1</sup>, Hanine Keita<sup>5</sup>, Moussa M Koné<sup>1</sup>, Jean Kaboré<sup>4</sup>, Nicolas Meda<sup>2,3</sup>

#### Affiliations :

1. Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique du Mali ;
2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain, Burkina Faso, Université Joseph KI ZERBO ;
3. Faculté de Médecine, Université Joseph KI - ZERBO, Burkina Faso ;
4. Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) ;
5. African Field Epidemiology Network (AFENET).

**Auteur correspondant : Dr Aliou Badara BALLO,** résident au programme de Formation en Epidémiologie de Terrain, Burkina Faso, Université Joseph KI-ZERBO.

Sous-Direction de la lutte contre la maladie / Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique du Mali.

**Email :** [alibaba.abb65@gmail.com](mailto:alibaba.abb65@gmail.com), **Tel :** (00223) 76 39 00 50

**Introduction :** La rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses au monde. Au Mali, le district sanitaire de Banamba situé dans la région de Koulikoro a enregistré 39 cas

suspects en 2019. L'objectif de l'étude est d'évaluer le système de surveillance de la rougeole en 2019.

**Méthode :** il s'agissait d'une étude descriptive effectuée sur les données de surveillance de la rougeole de Banamba du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019. Nous avons calculé des proportions et des moyennes pour apprécier les différents attributs du système de surveillance selon le guide CDC ainsi que son utilité. L'analyse statistique a été faite avec le logiciel R.

**Résultats :** La fidélité de mise en œuvre du plan est de 67,71%. Parmi les enquêtés, 84 % d'entre eux collectent régulièrement des données de surveillance. Pour l'utilité, 100 % des intervenants ont mené des actions de santé publique et estiment le système simple. Dans 97,95 % des cas la communauté était impliquée. Le système de surveillance a détecté 39 cas suspects de rougeole dont 3 positifs. En termes de réactivité, le délai moyen entre une notification et une riposte était de 23,47 jours. La complétude et la promptitude des rapports étaient respectivement de 100% et 91,99%. Les données correspondaient dans 78,95% des cas avec les documents de compilation. Sur les 20 aires de santé, seules 10 avaient notifié des cas.

**Conclusion :** Le système de surveillance épidémiologique de la rougeole à Banamba est simple, utile, acceptable avec une bonne qualité des données. Cependant, il est peu sensible, peu réactif et peu représentatif. Les acteurs impliqués doivent intensifier la surveillance épidémiologique, veiller à la notification urgente des cas suspects et organiser les ripostes dans un délai de 48 heures après confirmation si nécessaire.

**Mots clés :** Evaluation, Système de surveillance, Rougeole, Banamba.

## STH-2-S1-COP-11

### Investigation d'un cas de Rage humaine à Yirimadio dans le district sanitaire de la Commune VI de Bamako, Mali, Juillet 2020.

**S Samaké**<sup>1,2\*</sup>, D Barry<sup>2</sup>, PK Yanogo<sup>2</sup>, S Coulibaly<sup>4</sup>, MS Konaké<sup>3</sup>, H Keïta<sup>5</sup>, F Diallo<sup>2</sup>, S Trésor<sup>6</sup>, S Dara<sup>7</sup>, CA Coulibaly<sup>8</sup>, N Meda<sup>2</sup>

1.Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, Bamako, Mali

2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain : Université Ougai du Pr Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

3.Centre de Santé de Référence de la commune VI de Bamako

4.Institut National de Santé Publique, Bamako, Mali

5. Réseau Africain des Epidémiologistes de Terrain, Bamako, Mali

6.Center of Disease Control in Africa, Bamako, Mali

7.Direction Nationale des Services Vétérinaires, Bamako, Mali

8.Faculté de Médecine et d'Odonto-stomatologie (FMOS)/ DERSP

**Auteur correspondant : Soumaïla SAMAKE, Résident au programme de Formation en Epidémiologie de Terrain à l'université Ouaga1 du Pr Joseph Ki-Zerbo/Direction nationale des services vétérinaires de Bamako**

**Email :** [soumi.samake@yahoo.fr](mailto:soumi.samake@yahoo.fr) Tel : 00223 76 04 65 57

**Introduction :** La rage, maladie infectieuse, zoonotique, provoquée par un virus du genre *Lyssavirus*, est un problème de santé publique. L'OMS rapporte 55.000 décès/an dû à la rage et 30 à 50% de ces décès surviennent chez des enfants de moins de 15ans. En 2019, le Mali a enregistré 394 cas de morsure de personnes par des chiens dont 2 cas de décès et 21 foyers de rage canine. Dans la 31<sup>è</sup> semaine épidémiologique de 2020, la Direction Régionale de la Santé de Bamako a été notifié d'un cas confirmé de rage humaine et nous avons conduit une investigation pour quantifier l'ampleur et rechercher d'autres cas supplémentaires.

**Méthodes :** Nous avons réalisé une étude transversale descriptive portant sur l'investigation d'un cas de rage humaine à Yirimadio. Les données ont été collectées à travers l'entretien avec le personnel. Les données ont été saisies sur Excel® 2016 et analysées avec Epi Info.7.2.4. Des fréquences et ratios ont été calculées.

**Résultats :** Au total un cas confirmé de rage humaine notifié par le centre de santé de Yirimadio, et 35 contacts ont été enregistrés. Le statut vaccinal du chien mordeur n'a pas été connu. L'âge moyen des contacts était de 35 ans. La tranche d'âge 21-40 ans était la plus représentée avec 16 personnes (46%). Le sexe masculin était majoritaire avec 51% (18/17) avec une sex-ratio de 1,05.

**Conclusion :** L'investigation nous a permis de retrouver un cas confirmé rage décédé 30 jours après son admission à l'Hôpital du Mali. Le statut vaccinal du chien mordeur n'a pas été connu. Nous recommandons la vaccination de la population canine et le recours immédiat aux

structures de santé pour la prise en charge post exposition.

**Mots clés :** Rage, Chien, Enfant, Bamako

## STH-2-S1-COP-12

### Investigation des cas de Leishmaniose cutanée dans l'aire de Sante de Zandkoom, District Sanitaire Kongoussi, Centre-Nord, Burkina Faso, Aout 2021

**D.Diakité<sup>1, 2\*</sup>**, LD . Dahourou<sup>2</sup>, D .Barry<sup>2</sup>, PK .Yanogo<sup>2</sup> B. Bicaba<sup>2</sup>, M. Nikiema<sup>2</sup>, L. Ilboudo<sup>2</sup>, LC . Ki-Zerbo<sup>3</sup>, T. Nikiema<sup>3</sup>, N. Meda<sup>2</sup>

1. Direction Générale des Services Vétérinaires, Ouagadougou, Burkina Faso ;
2. Burkina Field Epidemiology Laboratory Training Program/University Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso;
3. Direction de la Protection de la Santé de la Population, Ouagadougou, Burkina Faso ;
- 4.Direction du Centre des Opérations de Réponse aux Urgences Sanitaires, Ouagadougou, Burkina Faso ;
5. African Field Epidemiology Network (AFENET), Ouagadougou, Burkina Faso.

**Auteur correspondant :** Dr Diakité Djénèbou, Direction Générale des Services Vétérinaires, Ouagadougou, Burkina Faso, Téléphone : 00226 70 28 66 16

**Email :** [diakitdjnbou@yahoo.fr](mailto:diakitdjnbou@yahoo.fr)

**Introduction :** Au Burkina Faso, la leishmaniose fait partie des cinq maladies tropicales négligées dans la prise en charge des cas et d'intérêt en santé publique. Deux foyers avec confirmation biologique ont été déjà documentés à Ouagadougou en 1996 et à Larama en 2013. Nous rapportons les résultats épidémiologiques, cliniques et biologiques de l'investigation d'un nouveau foyer à Zandkoom, district sanitaire de Kongoussi en août 2021.

**Méthodologie :** Nous avons conduit une étude transversale descriptive sur le foyer suspect et défini les cas selon les directives techniques du ministère de la santé. Les entretiens ont concerné 227 personnes. Des animaux de compagnies ont été examinés. Des prélèvements de suc dermique et de biopsie cutanée ont été faits auprès de 19 cas suspects. Au laboratoire, des examens microscopiques de frottis de suc dermique ont été réalisés sur les échantillons. La recherche active des cas suspects a été faite dans le centre de santé de Zandkoom ainsi que dans les centres voisins. Les données collectées enregistrées sur tableur

Excel ont été importées dans le logiciel Epi info. Une analyse étiologique a été effectuée. Des fréquences et prévalence ont été calculées.

**Résultats :** Au total, 174 cas présentaient des lésions cutanées suspectes de leishmaniose dont 07 cas de leishmaniose cutanée, 159 avec des lésions évocatrices de prurigo et 08 avec des signes d'autres pathologies. Les résultats de laboratoire ont permis de confirmer 6 cas de leishmaniose cutanée à *leishmania spp* soit une prévalence n d'infectés de 0,03%. La recherche active des cas dans les centres de santé a permis de retrouver 172 cas suspects grâce à la revue documentaire.

**Conclusion :** Cette investigation confirme l'épidémie de leishmaniose cutanée à *Leishmani spp* à Zandkoom. La prise en charge des cas et les mesures préventives ont été renforcées.

**Mots clés :** Leishmaniose cutanée, Investigation, Zandkoom.

## Sous-thème 2 Session 3

## STH-2-S2-COP-13

### Rapport d'analyse des données de surveillance épidémiologique de la rougeole, Mali, 2010-2019.

**Aliou Badara Ballo<sup>1,2</sup>**, Pauline Kiswendsida Yanogo<sup>2,3</sup>, Jean Kaboré<sup>4</sup>, Djibril Barry<sup>2</sup>, Fadima Radhia Diallo Ouédraogo<sup>2</sup>, Bouyagui Traoré<sup>5</sup>, Yacouba Sangaré<sup>1</sup>, Hanine Keita<sup>5</sup>, Moussa M Koné<sup>1</sup>, Nicolas Meda<sup>2,3</sup>

1. Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique du Mali ;
2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain, Burkina Faso, Université Joseph KI ZERBO ;
3. Faculté de Médecine, Université Joseph KI - ZERBO, Burkina Faso ;
4. Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) ;
5. African Field Epidemiology Network (AFENET).

**Auteur correspondant :** Dr Aliou Badara BALLO, résident au programme de Formation en Epidémiologie de Terrain, Burkina Faso, Université Joseph KI-ZERBO.

Sous-Direction de la lutte contre la maladie / Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique du Mali.

**Email :** [Alibaba.abb65@gmail.com](mailto:Alibaba.abb65@gmail.com)

**Tel :** (00223) 76 39 00 50

**Introduction :** La rougeole constitue l'une des causes importantes de décès du jeune enfant. Le

Mali a déclaré 1485 cas de rougeole en 2018 dont 4 décès chez les moins de 5 ans. L'étude vise à déterminer le profil épidémiologique des cas de rougeole au Mali entre 2010 et 2019.

**Méthodes :** La base de données de surveillance de la rougeole et les rapports de données de couverture vaccinale de 2010 à 2019 ont été utilisés. Une analyse descriptive des données sociodémographiques et du laboratoire, a été réalisée. Des fréquences, des ratios et des risques relatifs ont été calculés à l'aide du logiciel R. Le test Khi carré ou celui de Fischer exact a été utilisé pour comparer les proportions. **Résultats :** De 2010 à 2019, sur un total de 7810 cas suspects enregistrés, 5174 cas disposant des données exploitables ont été extraits, soit une complétude de 66,25 %. La proportion des cas confirmés était de 44,78 % avec une létalité globale de 0,50 %. La promptitude dans l'envoi des échantillons au laboratoire et celle de la rétro-information des résultats aux districts étaient respectivement dans les normes recommandées dans 34,27 % et 56,60 % des cas. La tranche d'âge de 0 - 4 ans représentait 40,24 % des cas. La prédominance était masculine, soit 53,96 %. Il y'avait une forte proportion des non vaccinés (81,16%). La fréquence de la rougeole était significativement associée à l'âge < 5 ans ( $p < 0,001$ ) et aux sujets non vaccinés ( $p < 0,001$ ).

**Conclusion :** Le renforcement de la vaccination contre la rougeole est indispensable pour prévenir la maladie et pour éviter son endémicité au Mali.

**Mots clés :** Mali, rougeole, surveillance épidémiologique.

## STH-2-S2-COP-14

### Analyse des données de surveillance de la Péripleumonie Contagieuse Bovine au Mali de 2011 à 2020

**S. Samaké**<sup>1,2\*</sup>, S. Coulibaly<sup>3</sup>, D. Barry<sup>2</sup>, PK. Yanogo<sup>2</sup>, S. Dara<sup>6</sup>, CAK.Sidibé<sup>8</sup>, H. Keïta<sup>4</sup>, F. Diallo<sup>2</sup>, S. Trésor<sup>5</sup>, OB. Togola<sup>1,2</sup>, CA. Coulibaly<sup>7</sup>, N. Meda<sup>2</sup>

1.Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, Bamako, Mali

2. Field Epidemiology Training and Laboratory Program, Bamako, Mali/Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

3. Institut National de Santé Publique, Bamako, Mali

4. Field Epidemiology Training Program, Bamako, Mali

5. Center of Disease Control in Africa, Bamako, Mali

6. Direction Nationale des Services Vétérinaires, Bamako, Mali

7. Faculté de Médecine et d'Odonto-stomatologie (FMOS)/ Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique (DERSP)

8. Laboratoire central vétérinaire de Bamako

**Auteur correspondant\* : Soumaïla SAMAKE**  
**Résident au Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain à l'université Ouaga1**  
**du Pr Joseph Ki-Zerbo/Direction Nationale des Services Vétérinaires de Bamako**

**Email :** soumi.samake@yahoo.fr ; Tel : 00223 76 04 65 57

**Introduction :** La péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) est une maladie respiratoire très contagieuse et sévit de manière enzootique dans 23 d'Afrique subsaharienne dont le Mali. De 2011 à 2019, 45 foyers ont été déclarés au Mali dont 6385 bovins contaminés, 887 malades, 382 morts et 308 abattus. Nous avons analysé les données en temps lieu et personne pour soutenir les décideurs à mieux planifier les activités par rapport à la stratégie nationale.

**Méthodes :** Nous avons mené une étude transversale portant sur la base de données des échantillons suspects reçus par le laboratoire Central Vétérinaire de 2011 à 2020. Nous avons extrait les données sur Excel puis analysé à l'aide d'Epi Info.7.2.4. Des fréquences et ratio ont été calculés.

**Résultats :** Au total 1123 échantillons suspects ont été testés dont 259 positifs soit un taux de confirmation de 23,06%. Le secteur vétérinaire de Kati a enregistré le plus grand nombre de positifs avec 84 cas. Les régions de Tombouctou, Kidal, et Ménaka n'ont notifié aucun cas suspect de PPCB durant la période Le statut vaccinal des animaux n'avait pas été mentionné dans la base. La tranche d'âge de 1 à 5 ans était la plus représentée avec 55% (142/259). Le sexe femelle était majoritaire avec 59% (153/259) cas confirmés pour un sex-ratio de 0,69 en faveur des femelles.

**Conclusion :** Cette étude nous a permis de constater une sous notification, une prédominance de cas confirmés chez les femelles ainsi qu'un mauvais remplissage des supports. Nous recommandons une amélioration de la notification et du remplissage des supports à tous les niveaux. L'organisation régulière de la vaccination des bovins et l'abattage des animaux après traitement seront

une meilleure stratégie de contrôle de la maladie au Mali.

**Mots Clés :** Analyse, Péripleumonie, Bovins, Mali

### STH-2-S2-COP-15

#### Profil épidémiologique de la rougeole en Guinée, 2004-2020

**Naby CAMARA**

E-mail : [nabycamarap47@gmail.com](mailto:nabycamarap47@gmail.com)

**Introduction :** Malgré les bonnes couvertures vaccinales administratives, plusieurs flambées de rougeole ont été enregistrées en Guinée. Ce travail vise à orienter sur le profil épidémiologique de la rougeole et sur les actions de santé publique.

**Méthode :** Une analyse des données de surveillance de rougeole de 2004 à 2020 a été réalisée. A été inclus dans l'étude tout cas de rougeole confirmé par laboratoire, lien épidémiologique ou clinique. Les données des bases de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Laboratoire des fièvres hémorragiques virales et Programme élargie de vaccination ont été utilisées. Les données sur les caractéristiques cliniques, sociodémographiques, statut vaccinal et couverture vaccinale ont été analysées avec Epi Info® 7.2.

**Résultats :** De 2004 à 2020, 14.067 cas de rougeole ont été notifiés parmi lesquels 23% étaient confirmés en laboratoire, 43% par lien épidémiologique et 10% cliniquement compatibles. Les districts sanitaires étaient au vert avec un taux d'incidence inférieure à 5 cas pour 100 000 habitants. L'âge médian était de 3 ans (1an à 70 ans). Les signes rapportés étaient les éruptions cutanées 79% des cas et fièvre 74% des cas. La proportion d'échantillons reçus au laboratoire dans les 72 heures était au-dessous des normes et variait de 28% en 2010 à 56% en 2011. La tranche d'âge (<5 ans) et la non vaccination sont les facteurs de risque de survenue de la rougeole avec une différence statistiquement significative ( $p=0,001$ ).

**Conclusion :** Deux cas sur trois ont été confirmés par lien épidémiologique. Les enfants de moins de 5 ans ont été les plus touchés. Le renforcement de la vaccination chez les moins de 5 ans et le suivi de leur statut vaccinal pourraient réduire les épidémies de rougeole, en Guinée.

**Mots clés :** Rougeole, Profil, Epidémiologie, Indicateurs, Guinée

### STH-2-S2-COP-16

#### Epidemiological profile of bite and rabies cases in the Republic of Guinea, 2011 - 2020

1 Fassou Kourouma, MDV, Participant in the Burkina Epidemiology and Field Laboratory Training Program (BFELTP), Guinea

2 Dr Nouonan GBAMOU, Resident Mentor, Guinea

3 Dr Jean KABORE, Mentor, Burkina

**Background:** Guinea is committed to eliminating rabies by 2030, but the disease profile is unknown. This analysis provides a baseline to guide authorities in interventions to eliminate rabies in Guinea.

**Methods:** The WHO rabies case definition was adopted. The Ministry of Health and Ministry of Livestock dog bite and rabies databases from 2011 to 2020 were used. The sums of the scores displayed on incidence/100 000 population ( $\geq 50 = 3$ ,  $20-49 = 2$ ,  $<20 = 1$ ) and rabies case notification ( $\geq 2$  cases = 2, 1 = 1, 0 = 0) were assigned to each district. Districts were classified : high  $\geq 5$ , moderate (3-4), or low  $\leq 2$  risk. Median age, proportions, and incidence were calculated using Epi Info 7.2.

**Results:** The completeness and validity of the data was 90% and out of a total of 6,345 recorded dog bites of which 4,005 were analyzed in terms of persons, overall incidence: 15.7/100,000 inhabitants and was higher in N'Zérékoré 33.8/100,000. Median age: 15 years, age group: 1-15 years: Among the 4005 cases, 59.10% were male, 33.83% were students. Twenty-three clinical cases of rabies were recorded, males : 70% <15 years: no PEP was done. 35% of the 23 cases were from Faranah, 26% from N'Zérékoré, and five 21% from Boké, classified as high risk prefectures. From SE1 2018- SE53 2020 we noted an increase in the number of cases throughout 2019 which is due to the involvement of all structures in rabies surveillance.

**Conclusion:** Children under 15 years of age developed more rabies without receiving PEP. Low collection but high confirmation of canine rabies in N'Zérékoré Faranah and Boké, three high risk districts. Vaccination of 4,200 dogs in these districts has been completed. It is recommended to raise awareness among children under 15 years of age, improve PIPs and head sampling of dogs.

**Keywords :** epidemiological, human bites and rabies, Guinea.

## STH-2-S2-COP-17

**Investigation auteur des cas de fièvre jaune à Koundara et à Kouroussa en Guinée, Janvier 2021**

**Naby CAMARA**

E-mail : [nabycamarap47@gmail.com](mailto:nabycamarap47@gmail.com)

**Introduction :** De 2000 à 2019, la Guinée a enregistré 8 épidémies de fièvre jaune ayant affecté 1143 personnes provoquant 332 décès. Le 14 janvier 2020, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a été alerté par le laboratoire des fièvres hémorragiques virales de Conakry de 4 cas positifs aux IgM de fièvre jaune dont 3 cas à Koundara et 1 cas à Kouroussa.

**Méthode :** Une étude transversale descriptive a été réalisée dans les districts sanitaires de Koundara et Kouroussa du 16 au 20 janvier 2021. Tous les cas confirmés par laboratoire ou par clinique ont été inclus. Les données sur les caractéristiques cliniques, socio-démographiques et le statut vaccinal ont été analysées par Epi Info® 7.2.

**Résultats :** Un total de 46 cas suspects de fièvre jaune a été notifié. Trois cas probables, 14 décès et 6 cas de fièvre jaune en ont été identifiés. A Koundara, parmi les gîtes larvaires, 5 sur 13 comportaient des larves d'Aedes (positifs) dans la commune urbaine ; 3/56, 1/7, et 5/17, respectivement à Guingan, Kamaby et Sareboido. La couverture vaccinale de l'enquête dans les localités visitées de Koundara et de Kouroussa variait de 1% à 42%. Les indices Récepteur et Breteau  $\geq 20$  à Koundara et celle de Kouroussa est de 42% et les indices larvaires sont nuls.

**Conclusion :** Notre enquête montre que l'existence éventuelle de l'épidémie de fièvre jaune dans les zones prospectées est de type intermédiaire et est conditionnée par un cycle rural. Il s'agira de déterminer le modèle de propagation d'une zone à une autre à travers une étude de populations vectorielles et de réservoirs sauvage migrantes.

**Mots clés :** Fièvre jaune, Investigation, Kouroussa, Koundara, Guinée

## STH-2-S2-COP-18

**Les épidémies de méningites à *Neisseria meningitidis* au Burkina : revue systématique**

**Savadogo Mamoudou**<sup>1</sup>, Diallo Ismaël<sup>2</sup>, Sondo K Apoline<sup>1</sup>

- 1) Service des maladies infectieuses du CHU Yalgado Ouédraogo
- 2) Service de médecine interne du CHU Yalgado Ouédraogo

**Introduction :** les épidémies de méningites constituent une menace permanente au Burkina Faso.

**Objectif :** étudier les aspects épidémiologiques des méningites à *Neisseria meningitidis* au Burkina Faso

**Méthodes :** il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive avec collecte rétrospective des données de la surveillance des cas de méningite à *Neisseria meningitidis* au Burkina Faso.

**Résultats :** le Burkina Faso a été frappé par des épidémies de méningite à *Neisseria meningitidis* de sérotype A respectivement en 1957, 1985, 1994, 1995, 1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009. A côté de ce sérotype A, le sérotype W a été également responsable de plusieurs épidémies dont celles de 1992, 2001, 2002, 2003, et 2012. Les ripostes vaccinales contre ce sérotype W de *Neisseria meningitidis* se sont toujours heurtées à une pénurie de vaccin. Concernant le sérotype X de *Neisseria meningitidis*, le Burkina Faso a connu la première grande épidémie due à ce sérotype en 2010. En l'absence de vaccin contre le sérotype X, la stratégie de lutte a consisté en la prise en charge gratuite des cas. Pour le sérotype C de *Neisseria meningitidis*, après une première flambée épidémique en 1979, c'est en 2019, que ce sérotype a de nouveau été responsable d'une flambée épidémique à l'Est du Burkina Faso. La riposte vaccinale a permis de circonscrire cette épidémie. Au cours de toutes ces épidémies, les enfants étaient les plus touchés.

**Conclusion :** la circulation persistante des sérotypes W, X et C de *Neisseria meningitidis* font craindre d'autres épidémies de méningite.

**Mots clés :** épidémie, méningite, *Neisseria meningitidis*, sérotypes, Burkina Faso.

## STH-2-S2-COP-19

**Evaluation du Système de Surveillance des**

## morsures et de la Rage, région de Conakry, République de Guinée, 2018-2020

<sup>1</sup> Fassou Kourouma, MDV, Participant Programme de Formation en Epidémiologie et Laboratoire de Terrain du Burkina (BFELTP)

<sup>2</sup> Dr Nouonan GBAMOU, Résident Mentor, Guinée

<sup>3</sup> Dr Jean KABORE, Mentor, Burkina

**Introduction:** Depuis 2002, la région de Conakry a notifié 7 994 expositions humaines au risque rabique. Dont 11 cas de rage, soit une prévalence de suivis en prophylaxie de 0,42 %. En 2017 la plateforme une seule santé a été mis en place, en 2018 un plan stratégique d'élimination de la rage à l'horizon 2030 la surveillance de la rage a été renforcée dont les objectifs étaient de détecter à temps les cas de morsures et faire la prophylaxie post expositionnelle (PPE). Le système n'a pas été évalué, cette évaluation consiste à déterminer si les objectifs fixés sont atteints.

**Méthodes:** Les attributs du guide d'évaluation de système de surveillance de CDC-Atlanta ont été utilisés. Un questionnaire a été administré aux acteurs de la surveillance de santé humaine et animale du pays et une revue documentaire des outils de surveillance et l'analyse de la base de données entre 2018 et 2020 pour évaluer qualité des données, simplicité et acceptabilité, représentativité et l'utilité.

**Résultats:** Simplicité (95%) personnes ont répondu aux questionnaires, (100%) disposaient de définition des cas dont (85%) la connaissaient et la trouvaient facile contre (90%) qui estimaient que le remplissage de la fiche d'investigation était facile. Qualité des données : complétude des données : (92%) et validité : (89%). Acceptabilité : (81%) ont réalisé des prélèvements des échantillons. Représentativité : les données analysées montraient les caractéristiques sociodémographiques des cas, la tendance hebdomadaire de notification et la répartition des cas par préfecture. Utilité : Le système est utile car il a pu atteindre ses objectifs notamment la détection précoce des cas et la prise de décision.

**Conclusion:** Le système de surveillance de la rage est simple avec des données de bonne qualité pour la complétude, acceptable, représentatif très utile. Les prestataires ont été sensibilisés sur le prélèvement et l'envoi des échantillons aux différents laboratoires.

**Mots-clés :** évaluation, système surveillance, rage humaine, Guinée.

## STH-2-S2-COP-20

### Fréquence de la méningite à *Haemophilus influenzae* chez l'enfant de 0 à 15 ans au Burkina Faso de 2008 à 2018.

**I. DIALLO<sup>1</sup>, S. OUEDRAOGO<sup>6</sup>, A. OUEDRAOGO<sup>2</sup>, M. SAVADOGO<sup>2</sup>, A. DAO<sup>2</sup>, D. LY<sup>2</sup>, A. SONDO<sup>2</sup>, A. SAWADOGO<sup>3</sup>, E. A. DIENDERE<sup>4</sup>, J. ZOUNGRANA<sup>5</sup>, A. PODA<sup>5</sup>, Y. J. DRABO<sup>1</sup>.**

1. Hôpital de jour (Prise en charge VIH)/Service de Médecine Interne, Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, Ouagadougou, Burkina Faso.
2. Service de Maladies Infectieuses, Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, Ouagadougou, Burkina Faso.
3. Service de Maladies Infectieuses, Centre Hospitalier Universitaire Régional, Ouahigouya, Burkina Faso.
4. Service de Médecine Interne, Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo, Ouagadougou, Burkina Faso.
5. Service de Maladies Infectieuses, Centre Hospitalier Universitaire Souro SANOU, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
6. Département de santé publique, Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo, Ouagadougou, Burkina Faso.

**Introduction :** Les méningites bactériennes posent toujours un problème de santé publique surtout dans la ceinture méningitique malgré la vaccination. En 2019, *Haemophilus influenzae* (*Hi*) était encore responsable de 8% des cas de méningite dans la zone CEDEAO. Au Burkina Faso, la vaccination contre *Haemophilus influenzae* de type b (*Hib*) a été introduit dans le programme élargie de vaccination depuis 2006.

**Objectif :** Etudier la fréquence de la méningite à *Hi* de 2008 à 2018 au Burkina Faso.

**Méthodologie :** Etude transversale menée de juin à décembre 2020. Ont été inclus les cas de méningites bactériennes à *Hi* confirmés par un examen bactériologique, enregistrés sur la base de données de surveillance épidémiologique durant janvier 2008 à décembre 2018 au Burkina Faso.

**Résultats :** Au total, 177 cas de méningite à *Hi* ont été enregistrés. Avec 4,04 %, *Hi* était la troisième étiologie après le pneumocoque et le méningocoque. Le nombre de cas de méningites à *Hi* a connu une baisse au fil des années, mais persiste malgré une couverture vaccinale

supérieur à 100 %. La maladie sévit toute l'année avec une recrudescence en saison sèche. Les enfants de 3 mois à 3 ans étaient les plus touchés (55,93%) et la boucle du Mouhoun, la région qui comptait le plus grand nombre de cas (n=32). Les sérotypes rencontrés étaient le *Hib* (55,38 %) et *Hi non b* (14,69 %). En intention de traiter, l'évolution était défavorable dans 33,39 % des cas.

**Conclusion :** Malgré une bonne couverture vaccinale, il persiste des cas de méningites à *Hi*. Certaines régions étant plus touchées que d'autres. Il serait utile une meilleure supervision des campagnes vaccinales et réaliser des études immunologiques sur l'efficacité vaccinale de cette population fragile.

**Mots-clés :** Fréquence, méningites, *Haemophilus influenzae*, vaccination, Burkina Faso

## STH-2-S2-COP-21

### Investigation de cas d'ictères fébriles dans le district sanitaire de Barsalogho en 2020

**Dofini-Tuan M.W.Renaud Seni,**

<sup>1,2\*</sup>, D.BARRY<sup>2</sup>, A.ZIDA<sup>1</sup>,

PK.YANOGO<sup>2</sup>, I.YAMEOGO<sup>1</sup>, B. BICABA<sup>3</sup>,

D. KANIA<sup>4</sup>, L. OUEDRAOGO<sup>5</sup>, F.DIALLO<sup>2</sup>,

N. MÉDA<sup>2</sup>

1. Direction de la Prévention de la Santé de la population (DPSP), Burkina Faso
2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain/BFELTP, Université Ouaga1 du Pr Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
3. Centre des Opérations de Réponse aux Urgences Sanitaires (CORUS), Burkina Faso
4. Centre Muraz, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
5. Direction Régionale de la santé du Centre-Nord, Burkina Faso

**Auteur correspondant:** Dofini-Tuan M.W.Renaud Seni, résident à la formation en Master d'Epidémiologie de Terrain FELTP à l'Université Professeur Joseph KI-ZERBO, Tel : (226) 70581194/ 66671317/ 78540400

Email : [dofiniren@yahoo.fr](mailto:dofiniren@yahoo.fr) / [senirenaud@gmail.com](mailto:senirenaud@gmail.com)

**Introduction :** La fièvre jaune est une zoonose épidémique très contagieuse à déclaration obligatoire qui se manifeste par un syndrome ictérique d'où l'appellation ictère fébrile.

A la semaine épidémiologique 39 de l'année 2020, des cas d'ictères fébriles ont été notifiés

dans le district sanitaire de Barsalogho dans la Région du Centre-Nord du Burkina Faso. L'objectif de notre étude était d'investiguer les cas afin de les décrire en temps, lieu et personne.

**Méthodes :** Nous avons conduit une étude transversale descriptive. Les données de la surveillance du 1er juillet au 09 septembre 2020 ont été utilisées.

**Résultats :** On dénombrait 44 cas suspects d'ictère ; l'analyse des données a montré que le ratio femme/homme était de 1,75 ; de même, la moyenne d'âge des cas était de 28 ans avec un écart type de 10 ans. Nous avons noté une létalité de 20 %. Quant aux analyses biologiques réalisées, l'antigène HBS était positif pour 2 patients ; de même, le dosage des transaminases donnait des valeurs supérieures à la normale pour 04 patients. Sur 43 échantillons envoyés au laboratoire, 4 étaient positifs aux anticorps spécifiques IgM fièvre jaune. Une confirmation a permis d'affirmer la fièvre jaune, mais aussi de détecter les génomes du virus de l'Hépatite virale E. Les résultats de la reprise de 3 échantillons et de la séroneutralisation infirment la fièvre jaune. La PCR et le typage réalisé a permis de détecter le génome 2 du virus de l'hépatite E.

**Conclusion :** La flambée des cas d'ictère de Barsalogho est due à l'hépatite virale E. Les analyses de laboratoire nous ont orienté vers une origine hydrique. Tous les cas proviennent des camps des déplacés internes. Une recommandation d'amélioration des conditions de vie des déplacés internes s'avère nécessaire afin d'éviter la propagation des cas dans les districts sanitaires voisins.

**Mots clés :** investigation, ictères, hépatite virale E, Barsalogho

## STH-2-S2-COP-22

### Analyse des données de surveillance de la méningite bactérienne en Côte d'Ivoire de 2014 à 2019.

**SORO Pegnontaye Moussa<sup>1</sup>,** KOFFI Kouadio Felix<sup>2</sup>, Pauline Kiswensida Yanogo<sup>3</sup>, KABORE Jean<sup>3</sup>, JOSEPH Otshudiandjeka<sup>4</sup>, TIEMBRE Issaka<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Résident en Master Professionnel d'Epidémiologie et Laboratoire de Terrain à l'Université Joseph Ki-ZERBO, [kounansoro@gmail.com](mailto:kounansoro@gmail.com) ; <sup>2</sup>Institut National de l'Hygiène Publique de Côte d'Ivoire ;

<sup>3</sup>Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain/BFELTP, Université Ouaga1 Joseph Ki

Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ;  
4AFENET/CDC, Conseiller résident Côte d'Ivoire ;  
5Université Felix Houphouët Boigny, Ufr Sciences Médicales, département de Santé Publique, Abidjan, Côte d'Ivoire.

**Introduction :** Le centre et le nord de la Côte d'Ivoire se trouvent dans la ceinture de la méningite. Pour comprendre les tendances évolutives de cette maladie après l'introduction du MenAfriVac en 2014, nous avons analysé les données de surveillance de la méningite bactérienne sur une période de 6 ans en Côte d'Ivoire.

**Matériels et méthodes :** il s'agissait d'une étude transversale descriptive des données de surveillance de 2014 à 2019, de la méningite bactérienne. Les données sont extraites du système de gestion de l'information sanitaire du service de surveillance épidémiologique de l'Institut National de l'Hygiène Publique.

**Résultats :** Globalement, 521 cas suspects de méningite ont été notifiés dans les districts à haut risque de méningite. Environ 55% des cas suspects étaient de sexe masculin avec un sexe ratio Homme/Femme de 1,2. L'âge médian (min, max) des cas suspects était de 9 ans (0, 80). Au total, 431 échantillons de LCR ont été analysés : *Streptococcus pneumoniae* (36,92%), *Neisseria meningitidis* A et *Neisseria meningitidis* W135, 4,62 % des cas chacun. La tranche d'âge de [5-14] représentait 30,7% des cas. Le taux d'incidence moyen était de 8,2 cas pour 100000 habitants. Le taux d'attaque au cours de l'année 2016 variait de 14,23 cas pour 100000 habitants à Katiola, 18,36 cas pour 100.000 habitants à Bouna et 23,49 cas pour 100000 habitants à Nassian. Sur la période d'étude, 69 décès ont été enregistrés avec un taux de létalité de 13%.

**Conclusion :** la méningite est saisonnière dans la moitié nord de la Côte d'Ivoire. Les districts de Katiola, Bouna et de Nassian étaient les plus touchés entre 2014 et 2019. La méningite à méningocoque A est en baisse dans cette partie du pays depuis l'introduction du MenAfriVac en 2014.

**Mots clés :** Méningite bactérienne, surveillance épidémiologique, Côte d'Ivoire.

## STH-2-S2-COP-23

### Évaluation du Système de Surveillance de la Péripleurite Contagieuse Bovine dans le

### District de Bamako au Mali, 2019-2020

**S. Samaké<sup>1,2\*</sup>, S. Coulibaly<sup>3</sup>, D. Barry<sup>2</sup>, PK. Yanogo<sup>2</sup>, H. Keïta<sup>4</sup>, F. Diallo<sup>2</sup>, S. Trésor<sup>5</sup>, CA. Coulibaly<sup>6</sup>, CAK.Sidibé<sup>8</sup>, S. Dara<sup>7</sup>, N. Meda**

1.Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, Bamako, Mali

2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain/Université Ouaga1 du Pr Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

3. Institut National de Santé Publique, Bamako, Mali

4. Réseau Africain des Epidémiologistes de Terrains, Bamako, Mali

5. Center of Disease Control in Africa, Bamako, Mali

6. Faculté de Médecine et d'Odonto-stomatologie (FMOS)/Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique (DER-SP)

7. Direction Nationale des Services Vétérinaires, Bamako, Mali

8. Laboratoire central vétérinaire de Bamako

**Auteur correspondant : Soumaïla SAMAKE, Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain/Université Ouaga1 du Pr Joseph Ki-Zerbo/Direction Nationale des Services Vétérinaires de Bamako**

**Email :** [soumi.samake@yahoo.fr](mailto:soumi.samake@yahoo.fr) ; Tel : 00223 76 04 65 57

**Introduction :** La péripleurite contagieuse bovine (PPCB) est une maladie respiratoire très contagieuse provoquant de graves conséquences sur l'économie et le commerce du bétail en Afrique subsaharienne. Son impact sur les moyens de subsistance affecte près de 24 millions d'éleveurs de bétail dans 26 pays africains. L'objectif de notre étude était d'analyser les données de surveillance de la PPCB au Laboratoire Central Vétérinaire de Bamako de 2011 à 2020.

**Méthodes :** Nous avons réalisé une étude transversale descriptive sur les données de surveillance de la PPCB. A travers l'approche de "center of Disease control" nous avons évalué l'acceptabilité, la simplicité, la représentativité, la flexibilité, la stabilité, la ponctualité et l'utilité du système. Un échantillonnage raisonné a conduit au choix de 20 acteurs impliqués dans la surveillance des maladies animales que nous avons interviewer à travers un questionnaire. Les données ainsi collectées ont été extraites sur une fiche et analysées sur Excel 2013 et Epi Info. 7.2.4. Des proportions ont été calculées. Un score d'appréciation a permis de classer les attributs en Faible (<40%), Moyen ((≥40 et <60%), et Bon (≥60%).

**Résultats :** L'acceptabilité était de 56,13%, la simplicité de 39,46%, la représentativité de 43,41%, la flexibilité de 3,94%, stabilité de 46,05% et l'utilité à (24,20%). Le système de surveillance n'était pas utile dans son ensemble, mais ponctuel.

**Conclusion :** Le système de surveillance épidémiologique de la PPCB était acceptable, moyennement représentatif, stable et pas simple, ni flexible pour la majorité des utilisateurs, donc peu utile. Nous recommandons une formation des agents vétérinaires à différents niveaux sur le recueil, la compilation, et l'analyse des données avec diffusion des informations permettant aux responsables de prendre des mesures de contrôle de la maladie.

**Mots clés :** Evaluation, Surveillance, Péripleumonie, Bamako

## STH-2-S2-COL-24

### Epidémiologie de la tuberculose en milieu communautaire à konobougou, Mali.

Coulibaly MB<sup>1</sup>, Niangaly AA<sup>1</sup>, Keita Z<sup>2</sup>, Sylla O<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Centre de santé communautaire et universitaire de Konobougou (Ségou-Mali)

<sup>2</sup>Département d'étude et de recherche en santé publique de la FMOS (Bamako-Mali)

<sup>3</sup>Direction Générale de la santé et de l'Hygiène Publique, Bamako (Mali)

Email : [ousmanesylla019@gmail.com](mailto:ousmanesylla019@gmail.com)

**Introduction :** La tuberculose représente encore un problème majeur de santé publique dans le monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. Objectif: déterminer le profil épidémiologique, diagnostic et évolutif des patients suivis pour tuberculose pharmaco-sensible au centre de diagnostic et de traitement du centre de santé communautaire et universitaire de Konobougou dans le district sanitaire de Barouéli au Mali.

**Méthode :** Il s'agissait d'étude transversale et rétrospective des patients suivis pour tuberculose au centre de diagnostic et de traitement de Konobougou dans le district sanitaire de Barouéli allant du 1<sup>er</sup> janvier 2017 au 30 juin 2019.

**Résultats :** Nous avons retenu dans cette étude 48 tuberculeux toutes formes confondues. Le sexe masculin a été le plus fréquent soit 79,2% avec un sexe ratio de 3,8. La tuberculose

pulmonaire bactériologiquement confirmée représentait 89,6% (n=43) et 10,4% (n=5) était extra pulmonaire. La comorbidité tuberculose - VIH représentait 12,5% des patients. Le succès thérapeutique était à 87,9% (n=42). 8,3% de décès, avec 2,1% cas de perdu de vue et 2,1% cas d'échec thérapeutique.

**Conclusion :** La prise en charge de la tuberculose en milieu communautaire par la stratégie du traitement directement observé serait un élément important dans le succès thérapeutique.

**Mots clés :** Tuberculose, milieu communautaire, Konobougou, Mali

## Sous-thème 2 Session 3

### STH-2-S3-COP-25

#### Correction des données du SNIS après les mouvements d'humeur des agents de santé en 2019 : données de vaccination

André SOME<sup>1,2</sup>, Serge M.A. SOMDA<sup>1,2</sup>, Armelle S. BADO<sup>1,2</sup>, Rachidatou OUEDRAOGO<sup>1,2</sup>, Lucien S. TRAORE<sup>1,2</sup>, Bernard E. A. DABONE<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Centre de Calcul, Centre MURAZ, Institut National de Santé Publique

<sup>2</sup>UFR/Science et Technique, Université Nazi Bonis

**Introduction :** De juin à septembre 2019, le Burkina Faso a connu un mouvement d'humeur des agents de santé. Ceux-ci ont décidé, entre autres actions, de suspendre la transmission des rapports statistiques mettant en cause la qualité des données du Système National d'Information Sanitaire (SNIS).

**Objectif principal de l'étude :** L'objectif de notre étude était de proposer des approches statistiques rigoureuses pour la correction des données des indicateurs clés de la vaccination, notamment la couverture en Bacillus Calmette Guérin (BCG), Diphtérie-Tétanos-Coqueluche, Rougeole Rubéole et Vaccin Anti Tétanique du SNIS après les mouvements d'humeur.

**Méthodes :** Les données de notre étude sont issues de l'entrepôt de données du ministère de santé. Nous avons utilisé les méthodes de la Data Quality review de l'OMS pour évaluer la qualité de nos données en termes d'exhaustivité et de cohérence. Par suite, les méthodes de Holt-Winters (HW) et de l'Imputation Multiple par Équation Chainée (MICE) ont été utilisées pour

respectivement corriger les données par prédiction et par modélisation.

**Résultats :** De janvier à mai 2019, l'exhaustivité au niveau des districts sanitaires était à 100% pour le BCG. Mais, pendant la période de la crise, il a chuté en dessous de 23%. Le test de changement de structure était significatif ( $p = 0.007$ ). La méthode de correction par prédiction proposait des couvertures du BCG allant de 87.71 en juin à 83.35 en octobre. L'approche par modélisation proposait des valeurs corrigées comprises entre 81.60 et 105.90 pour le même indicateur.

**Conclusion :** Ces résultats montrent que la grève a impacté négativement sur les données du SNIS mettant en cause leurs crédibilités. L'utilisation HW et MICE ont permis d'avoir des estimations robustes et fiables des indicateurs. Nous recommandons l'utilisation des approches proposées dans notre étude pour corriger l'ensemble des données du SNIS.

**Mots clés :** SNIS, données, vaccination, correction

## STH-2-S3-COP-26

### Evaluation de la base de données de la tuberculose de 2010 à 2019 en Mauritanie

**Hamet Abderahmane BA,**

E-mail : [hametba18@gmail.com](mailto:hametba18@gmail.com)

#### Introduction

La tuberculose est un problème majeur de santé publique. Malgré la baisse de son incidence, l'avènement du VIH et l'émergence de souches résistantes compliquent le contrôle de la maladie. Malgré les efforts déployés pour contrôler la maladie en Mauritanie, la tuberculose reste un problème majeur de santé publique.

#### Méthodes

Nous avons analysé la base de données du programme national de lutte contre la tuberculose de 2010 et 2019. Nos variables d'intérêt analysées étaient : Sociodémographique, clinique, bactériologique.

#### Résultats

Les hommes représentaient 67,7 % ( $n = 17184$ ) et les femmes 32,3 % (8193). Le sex-ratio était de 2,1. L'âge moyen était de  $43,95 \pm 16,7$  ans avec des extrêmes de 20 et 84 ans. 70 % des patients avaient moins de 45 ans. Il y a eu 18974 (75%) cas de tuberculose pulmonaire et 6333

(25%) cas de tuberculose extra pulmonaire. Les nouveaux cas de tuberculose représentaient 89,6 %, les rechutes 2,8 % et les retraitements 0,5 %. Le taux de réussite du traitement était de 70,3 % (34,6 % de guérison et 35,7 % de traitement terminé), 12,2 % de perte de vue, 3,6 % de létalité et un taux d'échec thérapeutique de 0,4 %. Les patients dont l'issue thérapeutique était inconnue représentaient 25,6% (12,2% perdus de vue, 10,1% transférés). Les taux de complétude étaient respectivement pour les variables « contrôle 2e mois » et « contrôle 5e mois » ; 32 % et 13 %.

#### Conclusion

Selon nos résultats, il convient d'insister sur la qualité des données en renforçant les capacités des acteurs, condition préalable à une meilleure réussite thérapeutique. La mise en place de tests de pharmaco-sensibilité pré-thérapeutiques doit être systématique, pour une détection précoce des résistances et la prévention des échecs thérapeutiques, compte tenu du nombre élevé de patients à issue thérapeutique inconnue (25,6%).

## STH-2-S3-COP-27

### Evaluation de la surveillance électronique des paralysies flasques aiguës dans le district sanitaire de Dori, Burkina Faso, 2021.

**Hamed Sidwaya Ouedraogo<sup>1</sup>,** Seydou Kabore<sup>3</sup>, Noaga Sawadogo<sup>1</sup>, Ma Ouattara<sup>3</sup>, Arnaud Sawadogo<sup>1</sup>, Mathieu Kuiliga Compaore<sup>1</sup>, Larba Yewayan Berenger Kabore<sup>4</sup>, Barthelemy Da<sup>2</sup>, Oula Traore<sup>3</sup>, Pedwinde Hamadou Seogo<sup>4</sup>, Amadou Zongo<sup>2</sup>, Noufou Gansore<sup>1</sup>, Issa Ouedraogo<sup>2</sup>, Denis Yelbeogo<sup>4</sup>, Bernard Sawadogo<sup>4</sup>, Landaogo Sountonogo Lionel Wilfrid Ouedraogo<sup>2</sup>, Charlemagne Marie Ragnang-Newende Ouedraogo<sup>2</sup>.

#### Affiliations :

1. Ministère de la Santé/Direction régionale de la santé par le Sahel, Burkina Faso
2. Ministère de la Santé/Direction de la prévention par les vaccinations, Burkina Faso
3. Organisation mondiale de la santé, Burkina Faso
4. African Field Epidemiology Network (AFENET)

#### Introduction

La poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse spécifiquement humaine causée par le poliovirus bénéficiant de surveillance au Burkina Faso à travers la surveillance des paralysies flasques aiguës

(PFA). Son maintien dans le contexte de crise sécuritaire est un défi. Cette e-surveillance des PFA dénommée « Auto-Visual-AFP-Detection And Reporting » (AVADAR) a été implémentée en utilisant les smartphones dans la région du Sahel. Cette stratégie a-t-elle amélioré la surveillance de la poliomyélite ?

### Objectif principal de l'étude

Evaluer la mise en œuvre de la surveillance électronique de la poliomyélite dans la région du Sahel.

### Méthodes

Nous avons conduit une étude transversale descriptive mixte dans district sanitaire (DS) de Dori situé dans la région du Sahel au Burkina Faso, du 16 au 29 août 2021 en utilisant comme technique, la revue documentaire, des interviews semi structurés auprès des ASBC et des agents des DS.

Pour cette étude, un cas suspect de PFA est tout enfant de moins de 15 ans chez qui un ou plusieurs membres présentent une diminution ou perte totale de mouvement et du tonus musculaire, une absence d'étirement musculaire, de survenue brutale, d'évolution rapide entre 0 – 3 jours.

### Résultats

Cette surveillance a permis de notifier 13 cas contre 03 cas dans le système traditionnel en 2019 et 187 cas contre 08 cas dans le système traditionnel au 2020 avec un maintien de cette surveillance en 2021. Aucun cas positif de poliomyélite détecté dans le DS.

### Conclusion

La surveillance des cas de PFA s'est poursuivie malgré la crise sécuritaire et la pandémie de la COVID-19 avec de meilleures performances et une grande implication de la communauté. C'est une alternative pour le maintien de la surveillance en situation de crise dont la mise en œuvre nécessite une grande communication avec le tissu communautaire.

**Mot clé :** Surveillance épidémiologique, PFA, Poliomyélite, Dori, Région du Sahel.

## STH-2-S3-COP-28

**Profil épidémiologique des animaux mordeurs mise en observation à l'Ecole Nationale d'Elevage et de Santé Animale,**

### Burkina Faso 2016 – 2020

**D.Diakité<sup>1, 2\*</sup>**, LD . Dahourou<sup>2</sup>, D .Barry<sup>2</sup>, PK .Yanogo<sup>2</sup> B. Bicaba<sup>2</sup>, M. Nikiema<sup>2</sup>, T. Nikiema<sup>3</sup>, N. Meda<sup>2</sup>

1. Direction Générale des Services Vétérinaires, Ouagadougou, Burkina Faso ;
2. Département de l'Agriculture et de l'Elevage, Institut du Développement rural, Science de l'Environnement, Université de Dédougou Burkina Faso ;
3. Burkina Field Epidemiology Laboratory Training Program/University Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso;
4. Direction du Centre des Opérations de Réponse aux Urgences Sanitaires, Ouagadougou, Burkina Faso ;
5. Ministère de l'Eau et de l'Assainissement, Ouagadougou, Burkina Faso.

**Enoncé :** La rage est une maladie fatale résultant généralement de la morsure d'un animal infecté. La mise en observation des animaux mordeurs ou griffeurs est une stratégie de choix pour un meilleur suivi des personnes agressées par un animal sensible à la rage. Au Burkina Faso, cette pratique est effectuée dans des établissements vétérinaires, comme celui de l'Ecole Nationale de l'Elevage et de Santé Animale. L'objectif de cette étude était de décrire le profil de des animaux dans la région du Centre du Burkina Faso de 2016 à 2020.

**Méthodologie :** Nous avons conduit une étude transversale descriptive des données secondaires de surveillance incluant tous les cas de mise en observation reçus à l'ENESA. Nous avons élaboré un canevas, épluché les documents pour constituer notre base de données sur le logiciel Excel. Le cadre d'analyse a porté sur l'appréciation de la complétude des données, la description des caractéristiques en temps, lieu, animale de ces animaux, la distribution sociodémographique des cas d'exposition humaine à la rage et la détermination de la proportion de la rage.

**Résultats :** Au total 3 968 mises en observation et les espaces animales rencontrées étaient : chiens, chats, singes et ânes. La majorité de ces animaux étaient des chiens 94,50%. Le statut vaccinal contre la rage n'était pas à jour chez 71,44 % de ces animaux. Sur 181 échantillons transmis au Laboratoire National d'Elevage, 70,71% étaient positifs à la rage. Le taux d'incidence de la rage chez toutes les espèces prise en compte était de 1,4 cas pour 1000 animaux. L'incidence de la rage était plus élevée à Saaba.

**Conclusion :** La rage est surtout retrouvée chez les chiens. Nous recommandons l'abattage des chiens errants et la vaccination.

**Mots clés :** Rage, Mise en observation, Burkina Faso, ENESA.

## STH-2-S3-COP-29

**Mise en place d'une surveillance épidémiologique des méningites bactériennes basée sur les aires de santé au Niger**

**Jean Testa<sup>1,4</sup>**, Hamidou Lazoumar Ramatoulaye<sup>1</sup>, Idé Garba Oumarou<sup>1</sup>, Magali Lago<sup>2</sup>, Ronan Jambou<sup>1,2</sup>, Maman Zaneibou<sup>5</sup>, Judith Muller<sup>2,3</sup>

1 : CERMES, Niamey ; 2: Institut Pasteur Paris ; 3 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes ; 4 Centre Muraz, Bobo-Dioulasso. 5 DSRE, Ministère de la Santé, Niamey.

**Introduction :** Les épidémies de méningite sont toujours un problème de santé publique majeur au Niger. Depuis deux décennies, la surveillance des cas suspects de méningites bactériennes est basée sur l'analyse de données compilées au niveau du district sanitaire. Des travaux antérieurs ont suggéré une meilleure performance d'un système de surveillance au niveau du sous-district permettant une détection précoce des foyers épidémiques ainsi qu'une riposte rapide.

**Objectif :** Évaluer la faisabilité d'une surveillance des épidémies de méningites à partir des aires de santé dans trois régions du Niger.

**Méthodologie :** Nous présentons des résultats d'une étude descriptive prospective pendant les saisons épidémiques de 2018 à 2021 des méningites bactériennes sur l'ensemble des aires de santé des régions de Tillabéry, Dosso et Niamey.

Début 2019, une procédure de surveillance utilisant un tableau de bord réalisé avec Excel a été mise en place. Les données étaient collectées de façon hebdomadaire au niveau aire de santé par le Centre de Santé Intégré (CSI), puis compilées au niveau du district puis de la région. En prenant en compte les seuils de l'OMS, ce tableau de bord a identifié chaque semaine les CSI en alerte et épidémiques et génère une cartographie des aires de santé concernées.

**Résultats :** Les 471 CSI des trois régions ont envoyé un rapport hebdomadaire aux 26

districts concernés avec une complétude de 96% et une promptitude également de 96%.

Le tableau de bord a mis en évidence 40 zones en alerte ou en épidémie de méningite dans 34 districts, détectées seulement au niveau de 2 districts.

**Conclusion :** Les agents de santé des trois régions pilotes se sont appropriés ce nouveau système de surveillance. En l'absence d'épidémie importante de méningite, l'efficacité du système en termes de précocité de riposte n'a pu être encore évalué. Une automatisation de l'alimentation de la data base CERMES par SMS standardisés adressés par les districts est en cours de développement.

**Mots clés :** Surveillance épidémiologique, aire de santé, méningites bactériennes, Niger

## STH-2-S3-COP-30

**Evaluation du système de surveillance de la rage au district de la ville de Tahoua, Niger, 2015 à 2019.**

**M.C. GAMBO<sup>1,2</sup>**, D. BARRY<sup>2</sup>, P. YANOGO<sup>2</sup>, O. BATOURE<sup>3</sup>, A. MOUSTAPHA<sup>2</sup>, N. MEDA<sup>2</sup>

1. Centre Hospitalier Régional de Maradi
2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain : Université Pr Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
3. Organisation Mondiale de la santé Niamey
4. Direction Générale du Ministère de la Santé publique Niger

**Auteur correspondant : Dr GAMBO CHABLA Mariama**, Résident au programme de Formation en Epidémiologie de Terrain à l'université Joseph Ki-Zerbo/ Direction de surveillance et de la riposte aux épidémies, tel :0022796964736 / 0022792270334

**Email :** [nanagamboc2011@gmail.com](mailto:nanagamboc2011@gmail.com)

**Introduction :** la rage est une zoonose d'origine virale, elle fait partie des maladies tropicales négligées et continue à faire des victimes dans le monde alors qu'elle peut être évitée par la vaccination. Le Niger a intégré la rage dans les maladies à déclaration obligatoire en 2015 et l'objectif de notre étude était d'évaluer le système de surveillance à travers son utilité et les attributs :simplicité, sensibilité, représentativité et qualité des données .Nous avons effectué une évaluation du système de surveillance de la rage au district de la ville de Tahoua commune de 2015 à 2019 afin de décrire l'organisation et le fonctionnement du

système, décrire son utilité et ses attributs selon les directives de CDC.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale descriptive qui s'est déroulée du 20 Octobre 2020 au 4 Novembre 2020 et concerne les données du 1er Janvier 2015 au 31 décembre 2019. La population d'étude était constituée des acteurs impliqués dans la surveillance de la rage à tous les niveaux du système du pays. Les données étaient recueillies par entretien, revue documentaire et l'analyse est faite avec le logiciel épi info 7.2.5 et Excel ; des proportions et des taux ont été calculés.

**Résultats :** Le système est bien structuré, utile à 24,92 %, n'est pas simple à 85,66%, sensible (9 cas suspects de rage humaine), la représentativité est faible et la qualité des données est à 94,75% pour la promptitude et la complétude à 88,5%. On note une sensibilité à 100% au niveau de l'élevage communal de Tahoua.

**Conclusion :** le système de surveillance de la rage n'est pas utile, beaucoup reste à faire pour améliorer la simplicité, la sensibilité, la représentativité et la qualité des données. **Mots clés :** Tahoua, évaluation, système, rage, Niger

## STH-2-S3-COP-31

### Rapport d'évaluation du système de surveillance du VIH dans la région de Tillabéri – Niger 2017 – 2019

**GBAGUIDI CLEMENT A. Patrick**<sup>1,2</sup>, Dr Barry<sup>2</sup>, Dr BATOURE Oumarou<sup>3</sup>, Dr ADAMOU Moustapha<sup>4</sup> Dr YANOGO Pauline<sup>2</sup>, Pr MEDA Nicolas<sup>2</sup>

1. Résident au programme de Formation en Epidémiologie de Terrain à l'université Ouaga1 du Pr Joseph Ki-Zerbo/ Direction de la surveillance
2. Programme de formation en épidémiologie de terrain : Université Ouaga1 du Pr Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
3. Organisation mondiale de la santé
4. Direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies

**Auteur correspondant : Gbaguidi Clément A. Patrick**, Résident au programme de Formation en Epidémiologie de Terrain à l'université Ouaga1 du Pr Joseph Ki-Zerbo/ Direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies, Niger, Téléphone : +227 96963091

Email : [gpatrickfr@gmail.com](mailto:gpatrickfr@gmail.com)

**Introduction :** Le VIH reste encore un problème de santé publique. Dans le monde, environ 1,7 millions de nouveaux cas de VIH ont été dépistés en 2018 dont 770 000 décès. Au Niger, en 2018, selon les estimations de l'ONUSIDA, environs 35000 personnes vivent avec le VIH et près de 1300 nouveaux cas. Nous avons évalué le système de surveillance du VIH dans la région de Tillabéry afin de décrire son organisation et son fonctionnement, déterminer son utilité et évaluer ses attributs selon les directives mises à jour du Center for Disease Control and Prevention pour l'évaluation des systèmes de surveillance de la santé publique.

**Méthodes :** Cette étude transversale descriptive a été réalisée du 1 au 31 Octobre 2020, et a concerné les données du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2019. La population d'étude était constituée des acteurs directement impliqués dans la surveillance à tous les niveaux du système de surveillance du pays. Les données ont été collectées par revue documentaire et entretien. L'analyse des données a été faite avec Excel 2016. Des proportions et taux ont été calculés.

**Résultats :** Le système de surveillance est complexe mais utile atteignant partiellement ses objectifs. Il est bien structuré, accepté à 91,43%, réactif à 63,64%, flexible, une représentativité à 7.27% chez les moins de 15 ans contre 92.73% chez les plus de 15 ans, et de qualité de données moyenne avec une stabilité moyenne à 56,90%.

**Conclusion :** Cette évaluation a mis en exergue un système de surveillance utile mais complexe. Il est bien organisé, structuré, acceptable, réactif, flexible, représentatif, de qualité de données moyenne et de stabilité moyenne.

**Mots clés :** Tillabéry, Evaluation, Niger, Surveillance, VIH

## STH-2-S3-COP-32

### Analyse des données de surveillance épidémiologique de la brucellose animale en Guinée de 2018-2020

**Pépé Gbamou**<sup>1, 2</sup>, Pauline Kiswensida Yanogo<sup>2</sup>, Pépé Bilivogui<sup>3</sup>, Jean Kaboré<sup>2</sup>, Djibril Barry<sup>2</sup>, Simon Tiendrebéogo<sup>2</sup>, Tamba Jacques Millimouno<sup>4</sup>

6. Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV), Conakry, Guinée
7. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain/BFELTP, Université Ouga1 du Pr Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

8. Secrétariat permanent de la Plateforme Nationale Une Seule Santé; Conakry, Guinée
9. Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), Conakry, Guinée

**Présentateur :** Mr Pépé GBAMOU, Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV), Conakry, Guinée, **Téléphone :** +224 622 286 994  
**E-mail :** [gbamouezeki@gmail.com](mailto:gbamouezeki@gmail.com)

### Introduction

La brucellose est une maladie contagieuse des animaux d'élevage, elle est transmissible aux humains. C'est une zoonose majeure qui peut engendrer une incapacité au travail chez l'homme. En Guinée, sa prévalence est comprise entre 3,8% et 21%. Une analyse des données de surveillance de la brucellose a été conduite pour décrire les caractéristiques, les moyens de diagnostic, les tendances et la qualité des données. L'analyse des données de surveillance a permis de décrire le profil épidémiologique de cette maladie à l'échelle nationale.

### Objectif de l'étude

Analyser les données de surveillance de la brucellose animale en Guinée de 2018 à 2020.

### Méthode

Nous avons réalisé une étude descriptive transversale des données de surveillance de 2018 à 2020. La population d'étude était l'ensemble des cas suspects et confirmés de brucellose animale enregistrés dans les bases de données des services vétérinaires. Ces cas se rapportaient au cheptel ruminant et porcin. Nous avons utilisé une fiche d'extraction des données des bases. Les logiciels Excel, Epi-Info 7.2 et QGIS ont été utilisés pour les analyses et générer les cartes.

### Résultats

La complétude était 91,12% et la validité 90,19%. Au total, 214 cas suspects de brucellose de toutes espèces confondues ont été enregistrés (dont 72 cas chez les caprins), avec 33 morts. Sur la période, 16 animaux sur 31 ont été testés positifs, soit 51,6 % de positivité. L'année 2020 a enregistré le plus grand nombre de cas, soit 99. Les préfectures de Dabola, N'Zérékoré, Kindia, Macenta et Boké ont enregistré à elles seules 87% des cas suspects notifiés. L'incidence globale a été de 2%.

### Conclusion

L'analyse a fait ressortir que des cas suspects de brucellose ont été notifiés chez toutes les espèces animales sensibles élevées en Guinée. Nous recommandons le renforcement des capacités des agents sur l'identification et la notification des cas de brucellose.

**Mots clés :** analyse, données, surveillance, brucellose, animal

## STH-2-S3-COP-33

### Epidémiologie du choléra au Togo de 2011 à 2019

**SABI M.**<sup>1</sup>, HALATOKO W.<sup>2</sup>, TCHALLA A. E.<sup>3</sup>, ABRANGAO A.<sup>4</sup>, GNENI D.<sup>4</sup>, ASSANE H.<sup>5</sup>, KINDE R.<sup>6</sup>, BARRY D.<sup>7</sup>, YANOGO K. P.<sup>7</sup> NYAMETSO D.<sup>8</sup>

1 Master 2 BFELTP Cohorte 6, Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou (Résident du Togo)

2 Institut National d'Hygiène (Togo); [hjacky78@yahoo.fr](mailto:hjacky78@yahoo.fr)

3 District sanitaire de Haho (Togo); [tehanaldinio@yahoo.fr](mailto:tehanaldinio@yahoo.fr)

4 District Sanitaire de l'Ogou (Togo); [alassaneabrangao@yahoo.fr](mailto:alassaneabrangao@yahoo.fr), [gadjabar@yahoo.fr](mailto:gadjabar@yahoo.fr)

5 Direction de la Lutte contre la Maladie et problèmes de santé publique, Ministère de la Santé (Togo); [simpassane@yahoo.fr](mailto:simpassane@yahoo.fr)

6 Coordination nationale FETP (Togo); [kinderebecca@yahoo.fr](mailto:kinderebecca@yahoo.fr)

7 Université Joseph KIZERBO, BFELTP (Ouagadougou) [yanogo.pauline@yahoo.fr](mailto:yanogo.pauline@yahoo.fr); [djibilirou@yahoo.fr](mailto:djibilirou@yahoo.fr)

8 Direction Régionale de la Santé, Région des plateaux (Togo); [dnyametsso@yahoo.com](mailto:dnyametsso@yahoo.com)  
 Email : [monfayesabi88@yahoo.fr](mailto:monfayesabi88@yahoo.fr); Cel : 0022890855821

### Introduction

Le choléra demeure un problème de santé publique à travers le monde. Au Togo, entre 2006 - 2017, la surveillance épidémiologique a enregistré 2 308 cas avec 46 décès. L'objectif de notre étude était d'analyser les données de surveillance épidémiologique du choléra au Togo entre 2011-2019.

### Méthodes

Nous avons mené une étude transversale descriptive portant sur les données de surveillance du choléra de 2011 à 2019. Nous avons inclus dans notre étude tous les cas inscrits dans la base de données nationale de 2011 - 2019 et pour lesquels les données obligatoires pour notre étude étaient disponibles et ayant répondu à la définition de cas. Les variables étudiées étaient : l'âge, sexe,

profession, lieu de résidence, résultats du laboratoire. Nous avons calculé, les proportions, les médianes, les percentiles et les ratios. Nous avons obtenu l'autorisation du ministère en charge de la santé. Notre protocole a été approuvé par la coordination BFELTP de l'Université Joseph KIZERBO.

### Résultats

Un total de 587 cas de choléra était enregistré de 2011-2019 au Togo. L'année 2014 avait connu une épidémie de 264 cas. Le sexe ratio H/F des cas était de 1,096. L'âge médian était de 27 ans (IIQ= 17-39 ans). Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées étaient les revendeurs/artisans (38%), les élèves/étudiants (15%). Les épidémies de choléra surviennent plus en saison pluvieuse 424 (72,23%). La région Lomé Commune était la plus touchée avec 423 (72,06%) cas. La létalité nationale était de 2,21%, la plus forte létalité était enregistrée en 2012 (6,66%). Sur 401 prélèvements de selles reçus au laboratoire 70,57% était positif au vibrio-cholerae.

### Conclusion

La région Lomé Commune est la plus touchée par les épidémies de choléra, les saisons pluvieuses sont favorables aux épidémies de choléra. Améliorer l'approvisionnement en eau, hygiène et assainissement dans les zones endémiques.

**Mots clés :** Choléra, épidémiologie, Togo, 2020

## STH-2-S3-COL-34

### Investigation d'un cas confirmé de Poliomyélite dans le district sanitaire de Koumassi, Abidjan, Côte d'Ivoire, Octobre 2020

**MZ. TIA**<sup>1,2</sup>, **NL. AKA**<sup>1</sup>, **D.BARRY**<sup>2</sup>, **PK.YANOGO**<sup>2</sup>, **N.MEDA**<sup>2</sup>

1. Service de surveillance Epidémiologique, Direction de Coordination du Programme Elargi de Vaccination, Côte d'Ivoire
2. Burkina Field Epidemiology Laboratory Training Program/University Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

Auteur Correspondant : Marie Zolou TIA, Résidente au Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain, Université Pr Joseph Ki-Zerbo, Tel : +225 07 08 49 28 45

Email : [marytia87@yahoo.fr](mailto:marytia87@yahoo.fr)

**Introduction :** Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de routine, le district sanitaire de Koumassi à Abidjan a notifié un cas de

Paralysie Flasque Aigue (PFA) qui a été confirmé comme une poliomyélite due au poliovirus dérivé de souche vaccinale type 2 (PVDVc2) le 2 Octobre 2020. L'objectif de notre étude était d'investiguer ce cas de poliomyélite confirmé afin de mettre en place des mesures de prévention et de contrôle.

**Matériel et Méthode :** Une étude descriptive a été menée dans le quartier « Grand Campement » de Koumassi du 12 Octobre au 22 Novembre 2020. La définition de cas selon le guide de la Surveillance Intégrée de la Maladie et Riposte (SIMR) a été utilisée. Les caractéristiques sociodémographiques et cliniques, le statut vaccinal et les antécédents de voyage ont été collectés. Une recherche active des cas a été faite dans le centre de santé et dans la communauté. Elle a concerné les enfants de 0 à 59 mois vivant dans un rayon de 5 km autour du cas confirmé. Les données ont été analysées sur Excel avec le calcul Proportions et de fréquences.

**Résultats :** Le cas confirmé était un enfant de sexe féminin, âgé de 21 mois, sans notion de déplacement en dehors de la commune dans les 30 jours précédant la survenue de la paralysie. Le cas vit dans un quartier précaire, dépourvu de système d'assainissement adéquat et situé dans une zone inondable. La paralysie touchait le membre inférieur gauche. Le début des signes a été marqué par une fièvre à 39,6°C. L'enfant a reçu 2 doses de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) et aucune dose de vaccin antipoliomyélitique injectable (VPI). La recherche active des cas de PFA n'a retrouvé aucun cas supplémentaire.

**Conclusion :** Le cas de poliomyélite dû au PVDVc2 est une fillette de 21 mois incomplètement vaccinée contre la poliomyélite, chez qui aucune notion de voyage n'a été retrouvée. Nous recommandons une recherche active et la vaccination de tous les enfants de moins de 5 ans incomplètement vaccinés.

**Mots clés :** PVDVc2, Surveillance, PFA, Côte d'Ivoire

## STH-2-S3-COL-35

### Analyse des Données de La Surveillance de La PPCB, En Mauritanie de 2015 à 2020.

**Navaa.ABD EL Wehab**<sup>1</sup>, **D. BARRY**<sup>2</sup>, **S. Mohamed. HAMA**, **Y.MED ELKORY**<sup>1</sup>, **Y. Barry**<sup>1</sup>, **PK. YANOGO**<sup>2</sup>, **N. MEDA**<sup>2</sup>, **NAH.TOLBA**<sup>2</sup>, **A. Bezeid.ELMAMY**<sup>3</sup>.

1. ONARDEL
  2. Programme de Formation en Epidémiologie et Laboratoire de Terrain du Burkina
  3. mentor
- Auteur Correspondant : *Dr Navaa Abdelwehab, :*  
*ONARDEP, Lexar, Nouakchott Mauritanie*  
*Email : [ssante.al.mr@gmail.com](mailto:ssante.al.mr@gmail.com)*

**Introduction :** La péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) est considérée comme l'une de maladies animales prioritaire du point de vue sanitaire et surtout économique. C'est une maladie des bovins et des Buffles d'eau due à *Mycoplasma mycoides mycoides subsp. (MmmSC)*. L'objectif de notre étude était d'analyse en temps, lieu, Animaux la base de données de l'ONARDEP de 2015 à 2020.

**Méthodes :** Nous avons mené une étude transversale descriptive portant sur la base de données de la PPCB de l'ONARDEP de l'année 2015 à 2020. Les données ont été collectées à l'aide d'une fiche d'extraction des informations du registre de laboratoire ; des bases de données électroniques du laboratoire répertoriées par année individuellement. Les données ont été saisies avec les logiciels Word et Excel 2016, idem pour le calcul des résultats.

**Résultats :** au total ; 15 foyers sur 7 Wilayas (Région) sur ces 06 ans. En dehors de 2020, où aucun foyer n'a été enregistré, chaque année un ou plusieurs foyers sont enregistrés dont Le pic se situe en 2018 avec 7 foyers. Les Wilayas (Régions) de Trarza et Tagant ont enregistré le plus grand nombre de foyers avec respectivement 33,33% et 26,66% du total des foyers (5 foyers et 4 foyers respectivement). Les Wilayas de H.Chargui ; Assaaba ; Brakna ; Guidimagha ont enregistré seulement 7% avec un seul foyer durant toutes ces 6 années ; en dehors du Gorgol qu'a enregistré 27% avec 2 foyers ; les autres Wilayas de la Mauritanie n'ont enregistré aucun foyer.

**Conclusion :** les mesures de contrôle de la PPCB devraient être continues et intensifiées. Les formes subcliniques ou subaiguës de la PPCB peuvent expliquer les écarts entre les nombres de foyers à la base de données et les Enquêtes T1 et T2 PRAPS.

**Mots Clés :** PPCB, Analyse de Données, ONARDEP, Mauritanie.

## STH-2-S3-COL-36

**Investigation d'une épidémie de coqueluche à Sikasso, Mali, 2020**

### **Dr Kampo Oumar Maoudo**

Field Epidemiology Training Program intermediate District Sanitaire de Sikasso, Mali email: [baroukampo@yahoo.fr](mailto:baroukampo@yahoo.fr), tél +22376115190

Co-auteur: Dr Sangho Oumar: Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Biologiques et Médicales (DERSBM), Faculté de Pharmacie (FAPH), Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique (DERSP), Faculté de Médecine et d'Odonto-Stomatologie (FMOS)

Dr Nouhoum Telly : Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique (DERSP), Faculté de Médecine et d'Odonto-Stomatologie (FMOS)

<sup>5</sup>Cellule Sectorielle de Lutte Contre le SIDA la Tuberculose et les Hépatites (CSLS-TB-H).

**Introduction :** début mars, un cas suspect de coqueluche est notifié au centre de santé de référence de Sikasso. L'investigation permet la détection, selon le diagnostic clinique, de 32 cas suspects groupés dans une même concession entre février et mars 2020.

**Objectifs :** étaient de décrire les cas, de rechercher les cas supplémentaires et mettre en œuvre des mesures de contrôle de l'épidémie.

#### **Méthodes :**

Nous avons mené une étude descriptive. Un cas de coqueluche était toute personne, présentant une toux paroxystique, avec ou sans vomissements, fièvre, dyspnée ou éternuement, habitant de Sanoubougoul, de février à mai 2020. Nous avons défini « un cas complètement vacciné » comme toute personne qui a reçu 3 doses du vaccin anticoquelucheux, à la 6ème, 10ème et 14ème semaine ; les moins de 3 doses comme les « cas incomplètement vaccinés » et les « non vaccinés » par l'absence totale de vaccination anticoquelucheuse. La recherche active de cas, permet de recueillir les données en utilisant un questionnaire. Les données furent analysées en temps, lieu et personne. Les fréquences et les taux ont été calculés.

#### **Résultats :**

Nous avons eu 23 cas dont zéro décès, sur 36.093 habitants (taux d'attaque : 6/10.000). L'âge médian était de 3 ans (11 mois-7 ans), et le sexe féminin était de 15 cas (65,22%). Un seul enfant était complètement vacciné ; 16 (69,57%) incomplètement vaccinés. Les malades ont été traités avec de l'Erythromycine. Le vaccin « Penta » a été administré aux non malades. Une sensibilisation sur l'importance de la vaccination été faite dans le District sanitaire.

### Conclusions :

L'épidémie a été brève. Sa survenue chez des enfants majoritairement d'origine étrangère, non vaccinés, malgré une bonne couverture vaccinale de l'aire de santé relance la problématique du monitoring des ménages.

**Mots clé :** Investigation, coqueluche, Sanoubougou, Sikasso, Mali

## Sous-thème 2 Session 4

### STH-2-S4-COP-37

#### Profil épidémiologique du choléra en Guinée 2010-2020.

**Sow MD** ; Barry AM ; Barry D ; Keita S ; Yanogo P ; Kaboré J ; Gbamou N ; Millimono TJ ; Barry M.

#### Introduction

La qualité, le rapportage et la gestion des données de surveillance constituent une problématique notoire malgré la récurrence des flambées en Guinée. Les données de surveillance épidémiologique du choléra, disponibles étaient agrégées et collectées mensuellement dans la base SAP. L'objectif de l'étude était d'analyser la base des données de surveillance du choléra en Guinée de 2010 à 2020.

#### Méthode

Il s'agissait d'une étude transversale descriptive avec collecte rétrospective des données de surveillance épidémiologique du choléra sur une période de 11 ans allant de 2010 à 2020. Nos variables étaient les caractéristiques sociodémographiques, le devenir des patients et les années de survenue des cas. Nous avons calculé la médiane et l'étendue pour l'âge, le sexe ratio, les fréquences et l'incidence annuelle. Les logiciels Excel et QGIS.2.1 ont servi pour la conception des graphiques et cartes.

#### Résultats

Notre étude a révélé que les données collectées lors de l'épidémie de 2012 ont un score de qualité moyen de 98,7% avec une complétude de 97,45 % et une validité à 99,96 %. Une faible proportion des cas ne disposait pas des informations sur des variables importantes dont l'âge, la profession et le sexe, ce qui a rendu difficile l'examen approfondi de certains de ces enregistrements.

De 2010 à 2020, la Guinée a enregistré un cumul de 7 687 cas de choléra dont 176 décès (létalité 2,28%). L'épidémie de 2012 a débuté en février et s'est poursuivie jusqu'en fin novembre. Sa survenue en pleine saison des pluies corrobore les données de la littérature, qui situe les épidémies de choléra pendant la période hivernale ou de fortes précipitations.[11,12]

#### Conclusion

Cette étude fournit une analyse globale des données sur la surveillance du choléra en Guinée. Cependant, nous retenons que le choléra demeure un problème majeur de santé publique et semble négligé ces dernières années avec l'avènement de multiples urgences sanitaires.

**Mots clés :** Profil épidémiologique, Analyse, Base, Choléra, Guinée.

### STH-2-S4-COP-38

#### Système d'information pour la gestion des épidémies au Burkina Faso : Entre théorie et réalité

**Diallo Cheick Omar<sup>1</sup>**, Schioler Karin Linda <sup>2</sup>, Samuelsen Helle<sup>3</sup>, Drabo Koine Maxime <sup>4</sup>

#### Affiliation and qualifications:

1: Université Joseph Ki ZERBO (Burkina Faso). MD, PhD fellow (Epidemiology) [cheick23@gmail.com](mailto:cheick23@gmail.com) .

2: Professeur associé, section Global health, Dept. de Santé publique, Université de Copenhague (Danemark). Ph.D.

3: : Professeur associé, Dept. d'Anthropologie, Université de Copenhague (Danemark). Ph.D.

4: Professeur associé, Directeur de recherche en santé publique, Université Joseph Ki ZERBO/ Institut de Recherche en Sciences de la Santé IRSS, Ouagadougou (Burkina Faso). Ph.D.

**Introduction:** Les systèmes d'information sanitaire (SIS) dans la plupart des pays en voie de développement se heurtent à de nombreuses difficultés. Au regard des faiblesses récurrentes dans l'anticipation et la prise de décision au cours de la gestion des épidémies.

**Objectif:** Nous avons réalisé un état des lieux de l'organisation et du fonctionnement du système d'information sanitaire au Burkina Faso.

**Méthodes:** Il s'est agi d'une étude mixte, transversale menée du 1er Janvier 2019 au 31 Mars 2020 et qui a consisté à une revue des documents de la surveillance épidémiologique au Burkina Faso, à des observations directes et

à l'interview d'acteurs impliqués tels que les agents de santé à base communautaires, les agents de santé, les membres de l'équipe cadre de District et de la région. L'étude a été menée dans les Districts ruraux de Dandé et Tenkodogo, aux centres de santé et de promotion sociale de Bama et Soumagou et leur communauté.

**Résultats :** Bien que les outils et formulaires de rapport utilisés par les formations sanitaires soient standardisés, ils ne sont pas toujours bien compris au niveau communautaire ou au niveau des centres de santé. La transmission des rapports notamment par les agents communautaires connaît très souvent des retards et ne sont pas toujours vérifiés par l'infirmier chef de poste. Les définitions de cas des maladies épidémiques pas bien comprises par certains agents communautaires et agents de première ligne.

**Conclusion :** le système d'information sanitaire au Burkina Faso demeure perfectible. Il y a une nécessité de perpétuer les séances de formations/recyclages à l'endroit des acteurs de la surveillance, de veiller à l'élaboration de définitions simplifiées de cas pour les maladies émergentes ou d'intérêt en santé publique, à l'attention des communautés. En outre, les comités de gestion des épidémies devraient être redynamisés.

**Mots clés :** Système d'information, épidémies, gestion, Burkina Faso

## STH-2-S4-COP-39

### Délais diagnostiques de la tuberculose pulmonaire et facteurs associés à leur allongement dans la région de Boké, Guinée, 2019-2020

Aboubacar Conté<sup>1,2</sup>, Pauline Kiswendsida Yanogo<sup>2,3</sup>, Nicolas Méda<sup>2,3</sup>

#### Affiliations

<sup>1</sup>Ministry of Health, Guinea

<sup>2</sup>Programme de formation en Epidémiologie du Burkina, faculté de Médecine, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

<sup>3</sup>Département de Santé Publique, faculté de Médecine, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

**Auteur correspondant, communicateur :** Pauline Kiswendsida YANOGO, [yanogo.pauline@yahoo.fr](mailto:yanogo.pauline@yahoo.fr)

**Introduction :** Les délais de diagnostic de la tuberculose demeurent au centre de la lutte contre cette maladie. L'objectif de cette étude était de déterminer les délais diagnostiques de la

tuberculose et d'identifier les facteurs associés à son allongement.

**Méthodes :** Une étude transversale analytique de novembre 2019 à janvier 2020, portant sur tous les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire (313 malades) dans les huit Centres de Diagnostic et de Traitement antituberculeux de la Région de Boké a été conduite. Le seuil de 30 jours a été prédéfini entre les délais diagnostiques totaux court et long de la tuberculose. Trente jours ou plus constituaient un délai diagnostique long, et moins de 30 jours constituaient un délai diagnostique court. Ce délai a été divisé en délai patient et délai système. Des OR ont été estimés dans une régression logistique univariée puis multivariée.

**Résultats :** Le délai diagnostique total moyen était de 55±25 jours. Le délai diagnostique moyen patient était de 39±15 jours et le délai diagnostique système était de 17±18 jours. Chez 241(77%) malades le délai diagnostique patient était long. Chez 66 (21%) malades le délai diagnostique système était long et chez 281(89,78%) malades le délai diagnostique total était long. La pauvreté (OR=2,20 ; 95% IC= [1,63-3,59], p=0,002), la non scolarité (OR=2,20 ; 95% IC= [1,85-6,03], p=0,01 et le Centre de Diagnostic et de Traitement (OR=40,72 ; 95% IC= [9,56-217,80], p<0,0001) étaient des facteurs associés à l'allongement de ces délais.

**Conclusion :** Les délais diagnostiques de la tuberculose étaient longs dans la région de Boké et associés de manière significative à la pauvreté, la non scolarité et le Centre de Diagnostic et de Traitement. Des stratégies ciblant ces facteurs modifiables permettront de raccourcir ces délais dans cette région de la Guinée et partant, de limiter la propagation de la tuberculose.

**Mot clés :** Tuberculose, délai diagnostique, allongement, Boké, Guinée

## STH-2-S4-COP-40

### Evaluation du système de surveillance du paludisme dans le district sanitaire de koundara, Guinée, 2021.

F.DOUMBOUYA<sup>1,2</sup>,

D.BARRY<sup>2</sup>, S.SIDIBE<sup>3</sup>, PK .YANOGO<sup>2</sup>, N.ME DA<sup>2</sup>

1. Direction Régionale de la Santé de BOKE

2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain et de Laboratoire, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, Université Pr Joseph Ki- Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

### 3. Programme nationale de lutte contre le paludisme

**Auteur correspondant: Fatoumata DOUMBOUYA**

Tel : +224622643619

Email : [fifidoumbouya24@gmail.com](mailto:fifidoumbouya24@gmail.com)

**Introduction:** La Guinée fait partie des pays visant à réduire l'incidence et ou éliminer le paludisme d'ici 2030. Elle a mis en place un système pour garantir l'accès à la prévention, diagnostic et traitement du paludisme mais aussi faire de la surveillance du paludisme une intervention de base qui a pour objectif de détecter rapidement les épidémies surtout dans les régions à transmission épidémique saisonnière ou ayant une forte proportion de la population à risque. Le but de cette évaluation est de déterminer quel niveau le système a atteint ses objectifs à travers l'appréciation des attributs.

**Méthode:** Une étude transversale descriptive a été menée portant sur la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 juin 2021 Le guide d'évaluation 2001 de CDC a été utilisé. Les données ont été collectées à partir d'un questionnaire administré face à face aux agents impliqués dans la surveillance à Koundara. Les attributs Simplicité, qualité des données, acceptabilité, valeur prédictive positive (VPP) et utilité ont été appréciés selon des scores. Des proportions ont été calculées et les analyses ont été faite avec EPI Info.

**Résultat:** 89% répondants trouvaient la définition de cas de paludisme simple, 84% pouvaient bien définir, 100% déclaraient le remplissage du rapport facile et 100% ont déclaré que la saisie des données dans deux bases de données prenait beaucoup de temps. Acceptabilité: 100% répondants étaient disposés à surveiller le paludisme mais la qualité des données était 95%. VPP était de 59%. Utilité: le système a la capacité de détecter les cas et les traiter d'où la mise en place des sites sentinelles.

**Conclusion:** le système de surveillance est simple, acceptable, les données sont de bonne qualité donc utile. Il est recommandé les supervisions formatives et la dotation des formations sanitaires en kits de prélèvement amélioreraient les performances du système vue le mauvais score de la VPP

**Mots-clés :** Evaluation, système de surveillance, paludisme, Guinée

### STH-2-S4-COP-41

**Evaluation du système de surveillance de la méningite en commune V du district de Bamako, Janvier 2015 - Décembre 2019.**

**T. SIDIBE<sup>1</sup>, D BARRY<sup>1</sup> A. DEMBELE<sup>2</sup>, J. KABORE<sup>3</sup>, P. YANOGO<sup>1</sup>,**

1. <sup>1</sup>Burkina Epidemiology and Laboratory Training Program

2. <sup>2</sup>Direction Générale de la Santé et de l'hygiène Publique, Bamako3

3. <sup>3</sup>Institute for Research in Health Science

Adresse pour correspondance : Toumani SIDIBE, Résident Burkina Epidemiology and Laboratory Training Program, Tel : (00223) 76361968

Email : [sidibetoumani84@yahoo.fr](mailto:sidibetoumani84@yahoo.fr)

**Introduction :** Au Mali d'énormes efforts ont été entrepris dans la prévention contre les méningites bactériennes par l'état et les partenaires. Malgré ces efforts la méningite demeure un problème de santé publique. L'objectif était d'évaluer la performance du système de surveillance de la méningite en Commune V du district de Bamako.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude descriptive transversale réalisée en commune CV du district de Bamako, du 1<sup>er</sup> Octobre 2019 au 31 Octobre 2020 sur les données de la surveillance épidémiologique de la méningite. Des scores d'appréciation des attributs ont été définis : Faible (<50%) ; Moyen ( $\geq 50\%$ <80%) ; Bon (80 %).

**Résultats :** Le système de surveillance épidémiologique de la méningite était fonctionnel et organisé dans toutes les structures visitées. L'existence et l'affichage des définitions des cas dans les structures. Les personnels chargés de cette surveillance étaient majoritairement des médecins suivis des TSS (IDE) soit respectivement à 46,15% et 23,08%. Le système attributs appréciés (Utilité, Simplicité, Acceptabilité, Ponctualité, Représentativité, Flexibilité, Qualité des données) étaient satisfaisants. Néanmoins nous avons constatés qu'aucune structure périphérique évaluée n'a notifié durant 2019. Par rapport à la notification la tranche d'âge de 0 – 11 mois était plus représentés soit 47,25%. Le sexe ratio à 1,02 en faveur du sexe Masculin. Le nombre de jour moyen entre les structures était comprise entre 0.8 à 7 jours. Les données manquantes des différentes variables variaient entre 2,02% à 27,27%.

**Conclusion :** Cette évaluation a mise en évidence un système de surveillance de la méningite bien structuré, utile, simple, acceptable et flexible. Cependant l'absence de notification durant 2019 au niveau des escoms et la mise en disposition tardive des résultats du laboratoire au niveau district ont été identifiés comme insuffisances.

**Mots clés :** Evaluation, Surveillance, Méningite-Commune V, Bamako.

## STH-2-S4-COP-42

### Analyse des données de surveillance de la rougeole, Mali 2016-2020

**T SIDIBE<sup>1</sup>**, A DEMBELE<sup>2</sup>, J KABORE<sup>3</sup>, P YANOGO<sup>1</sup>, D BARRY<sup>1</sup>

4. <sup>1</sup>Burkina Epidemiology and Laboratory Training Program
5. <sup>2</sup>Direction Générale de la Santé et de l'hygiène Publique, Bamako3
6. <sup>3</sup>Institute for Research in Health Science

Adresse pour correspondance : Toumani SIDIBE, Résident Burkina Epidemiology and Laboratory Training Program, Tel : (00223) 76361968  
Email : [sidibetoumani84@yahoo.fr](mailto:sidibetoumani84@yahoo.fr)

**Introduction :** La rougeole est une maladie virale contagieuse due à un virus de la famille des paramyxovirus. Malgré les efforts de l'état et ses partenaire la rougeole reste toujours un problème de santé publique.

**Objectif :** Analyser les données de surveillance épidémiologique de la rougeole de 2016 à 2020.

**Méthodes :** Nous avons conduit une étude transversale descriptive sur les données de la surveillance épidémiologique de la rougeole de 2016 à 2020 à l'aide de la base de données national. Les données ont été extraits sur Excel 2013 et analysées sur épi info 7.4. Nous avons calculé les fréquences, moyennes et proportions.

**Résultats :** Au total sur 1527 cas enregistrés, 1368 étaient confirmé biologiquement (89,59%) et 159 (10,41%) par lien épidémiologique. Le sexe masculin était le représenté avec 52,9%. Les sujets de 1 – 4 ans étaient les plus représentés soit 47,4%. L'incidence de la rougeole variait de 0,15 pour 100 000 habitants en 2016 à 2,16 pour 100 000 habitants en 2020 dont la plus grande incidence a été enregistrée en 2018 soit 2,5 pour 100 000

habitants. Parmi les sujets confirmés, 95,5% étaient non vaccinés. La létalité globale était à 0,4% observée chez les non vaccinés. La couverture vaccinale était insuffisante soit 84% en 2017 et 2020 et supérieur ou égale à 90% en 2016, 2018 et 2019. Le délai de réception des échantillons au laboratoire national de référence variait en 11, 2% à 44,9%. Tous les autres indicateurs de performance de la rougeole étaient satisfaisants ( $\geq 80\%$ ).

**Conclusion :** la rougeole est retrouvée surtout chez les enfants qui n'ont reçues aucune dose. Nous recommandons la promotion des activités de vaccination chez les enfants de moins de 5 ans.

**Mots clés :** Analyse, surveillance Rougeole-Mali

## STH-2-S4-COP-43

### Analyse de la base des données de la rage au Niger de 2015 à 2019

**M C. GAMBO<sup>1,2</sup>**, D. BARRY<sup>2</sup>, P. YANOGO<sup>2</sup>, O. BATOURE<sup>3</sup>, A. MOUSTAPHA<sup>2</sup>, N. MEDA<sup>2</sup>

1. Centre Hospitalier Régional de Maradi
2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain : Université Pr Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
3. Organisation Mondiale de la santé Niamey
4. Direction Générale du Ministère de la Santé publique Niger

**Auteur correspondant : Dr GAMBO CHABLA Mariama**, Résident au programme de Formation en Epidémiologie de Terrain à l'université Joseph Ki-Zerbo/ Direction de surveillance et de la riposte aux épidémies, tel : 0022796964736 / 0022792270334  
Email : [nanagamboc2011@gmail.com](mailto:nanagamboc2011@gmail.com)

**Introduction :** La rage, maladie tropicale négligée constitue un problème de santé publique dans le monde. En 2015, les États Membres de l'OMS et leurs principaux partenaires ont établi un objectif mondial de zéro décès humains dus à la rage à transmission canine à l'horizon 2030. Dans l'optique d'avoir un bref aperçu sur le profil épidémiologique de la rage au Niger et son impact en santé publique nous avons analysé la base des données de la rage humaine et celle de données de la canine au niveau du Labocel du 1<sup>er</sup> Janvier 2015 au 31 décembre 2019 au Niger.

**Méthodologie :** Il s'agit d'une étude transversale descriptive avec collecte des données rétrospective qui s'est déroulée au niveau de la Direction de surveillance et de la Riposte aux épidémies et du laboratoire central de l'élevage : LABOCEL. Notre collecte couvre la période allant du 1<sup>er</sup> Janvier 2015 au 31 Décembre 2019.

**Résultats :** Cette étude a recensé 23 cas suspects de rage humaine avec une prédominance masculine, la tranche d'âge de 15 ans à plus avec 56,53% (13/23) est la plus représentée, le chien est incriminé dans 100% des cas et une létalité de 100%. Dans cette étude 48 cas suspects de rage animale ont été notifiés au Labocel dont 41 ont été confirmés positifs à la coloration de seller au laboratoire soit une proportion de 85,41%.

**Conclusion :** Cette analyse des données de surveillance de la rage au Niger a relevé quelques insuffisances dans la qualité des données MDO et du LABOCEL qu'il faut améliorer afin d'avoir des données fiables et démontrer l'ampleur de la rage en santé publique.

**Mots clés :** rage, analyse, Niger

## STH-2-S4-COP-44

**Analyse de la base de données de la grippe aviaire à influenza aviaire du Niger, de 2009 à 2019.**

**GUERO M.**

**Ousseina<sup>1</sup>** (ousseinaguero@live.fr);

Hamedine. S.<sup>2</sup> (lolidije@yahoo.fr)

Otshudiandjeka J.B.<sup>4</sup> (otshujose@yahoo.fr);

Y. Pauline<sup>1,3</sup> (yanogo.pauline@yahoo.fr),

Fadima Diallo<sup>3</sup> (mi.raina@hotmail.com),

N. Meda<sup>1,3</sup> (nicolas.meda@gmail.com);

1. Burkina Field Epidemiology Training Program University PR Joseph Ki Zerbo Burkina Faso,

2. Ministère de l'environnement et de la lutte contre la désertification du Niger,

3. Faculté de médecine de l'université JKZ Burkina Faso,

4. African Field Epidemiology Network (AFENET),

**Introduction:** La circulation des sous types A (H5, H7N9) dans la volaille est un problème de santé publique. Cette maladie hautement pathogène a un impact imprévisible sur la santé humaine et animale ainsi que sur le commerce à l'échelle globale. La première apparition du

virus H5N1 en Afrique de l'Ouest s'est révélée en 2006 de même qu'au Niger.

L'objectif de cette étude est d'analyser la base de données de la grippe aviaire au Niger de 2009 à 2019 afin de la décrire en temps lieu et espèces.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale descriptive qui a concerné la base de données du LABOCEL de 2009 à 2019. Les données ont été extraites, traitées et analysées par les logiciel Excel et épi info 7.2.2.6. Des proportions et des fréquences ont été calculés.

**Résultats :** Au Niger de 2009 à 2019, il y'a eu 56 suspicions de grippe aviaire dont 10 positifs au sous type virale **H5N1**. Ceci a concerné un effectif de troupeaux total de **248851** toute volaille confondue. Sur cet effectif **117592** ont été malades et **89289** en sont morts. Soit une létalité de **75,93%**. Six sur huit régions étaient touchées. Niamey totalisait 34 suspicions et 6 confirmations. L'élevage familiale a eu plus de suspicions de foyers de grippe avec 30 suspicions que les fermes avec sept (07). **164127** individus toutes volailles confondues sont importés soit 99,50% contre seulement **828** locaux. Les poulets étaient les plus représentés avec 8 foyers confirmés. Les pertes économiques dû aux 10 foyers confirmés de grippe aviaire de 2009 à 2019 étaient estimés **320.140.000** franc CFA.

**Conclusion :** La grippe aviaire est une maladie avec des impacts très lourd sur la population aviaire. Nous recommandons l'application des mesures réglementaires pour minimiser les pertes.

**Mots clés :** grippe aviaire, H5N1 ; Niger.

## STH-2-S4-COL-45

**Analyse des Données de surveillance de la Méningite au Mali de 2010 à 2019.**

**D. Farota<sup>1,2</sup>**, H. Kéita<sup>3</sup>, D. Barry<sup>2</sup>, Y. Koné<sup>1</sup>, B. Traoré<sup>3</sup>, I. Berthé<sup>1</sup>, O. B. Togola<sup>1,2</sup>, Y. K. Pauline<sup>2</sup>, F. Diallo<sup>2</sup>, N. Meda<sup>2</sup>.

1. Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, Bamako, Mali

2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain et de Laboratoire, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, /Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

3. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain, Bamako, Mali

**Auteur correspondant : Dr Dado Farota,**

Email : [dadofatota@gmail.com](mailto:dadofatota@gmail.com) ; Tel : 00223 70 41 89 70

**Introduction :** La Méningite, infection des méninges caractérisée par l'association d'un syndrome infectieux et d'un syndrome méningé, est une urgence médicale responsable d'épidémies, au niveau de la ceinture africaine « de méningite ». Dans le monde, en dehors des périodes d'épidémies on enregistre 1,2 millions de cas de méningites bactériennes chaque année. Le Mali a notifié 127 cas confirmés en 2018 dont 10 décès. La méningite fait l'objet d'une surveillance cas par cas à travers toute la pyramide sanitaire depuis 2015. L'objectif de notre étude est d'analyser les données des méningites afin de contribuer à la réduction de la morbidité et mortalité due à cette maladie au Mali. **Méthodes :** Une étude transversale descriptive a été conduite sur les données secondaires du 01 au 30 octobre 2020 incluant tous les cas enregistrés de méningite dans la base de données de la surveillance de la méningite du Mali de 2010 à 2019. La médiane et ses extrêmes, les proportions ont été calculés avec le logiciel Epi-Info 7.2.

**Résultats :** Au total sur 5064 cas de méningite notifiés, 1027 (20%) ont été confirmés et 4037 (80%) négatifs. La promptitude de la réception des échantillons dans 3 jours était de 71%. Les échantillons reçus au laboratoire étaient adéquats dans 73%. Les régions de Bamako, et Koulikoro avaient enregistré plus de cas en 2016 et 2019 respectivement 360 et 305 cas. L'âge médian était de 3 ans. Le sexe ratio H/F était 1,44. Les prélèvements avaient un aspect clair dans 59,57% des cas.

**Conclusion :** Nous recommandons de renforcer le PEV de routine à travers les centres fixes et mobiles dans tout le pays.

**Mots clés :** Analyse, Données, surveillance, Méningite, Mali.

## STH-2-S4-COP-46

**Evaluation du système de surveillance de la rougeole à Conakry, Guinée du 01 janvier au 31 décembre 2020**

**Naby CAMARA**

**E-mail :** [nabycamarap47@gmail.com](mailto:nabycamarap47@gmail.com)

**Introduction :** Plusieurs flambées de rougeole ont été enregistrées en Guinée durant la dernière décennie. A Conakry, la récurrence d'épidémies, la faible qualité des données de surveillance de routine lors de l'analyse des données nationales de rougeole ont justifié la réalisation de la présente évaluation.

**Méthode :** Une étude descriptive rétrospective a été réalisée sur les données de surveillance (1<sup>er</sup> janvier 2004 au 31 décembre 2020) de la rougeole. La population d'étude a été constituée des cas de rougeole confirmés notifiés pour la période de l'étude. A été inclus tout cas de rougeole confirmé cas confirmé par lien épidémiologique et cas cliniquement compatible, renseigné dans les bases SAP de l'ANSS ou la base du Laboratoire des FHV. Les mesures statistiques descriptives : proportions, taux, ratio ont été calculées et comparées aux cibles de l'OMS.

**Résultats :** Au moins quatre-vingt pourcent des formations sanitaires disposaient d'une définition standard de cas de rougeole affichée. Les prestataires ( $\geq 80\%$ ) trouvaient simple le remplissage de formulaire de notification. Le nombre de cas confirmés de rougeole sur le nombre total de cas suspectés de rougeole était  $\leq 10\%$ . La proportion de cas de rougeole investigués dans les 48 heures suivant la notification dépassait 80%. La simplicité du système a été jugée bonne (86%). La qualité des données du système de surveillance a été moyenne (73%) due par la faible proportion des épidémies (18%) investiguées. La valeur prédictive positive (VPP) avait un score moyen (37%).

**Conclusion :** Les résultats montrent que le système de surveillance de la rougeole est utile, simple, sensible et acceptable. Par contre, il souffre d'une insuffisance de détection rapide des flambées épidémiques.

**Mots clés :** Rougeole, Evaluation, Système, Surveillance, Conakry, Guinée

## STH-2-S4-COP-47

**Evaluation du système de surveillance sentinelle du choléra en Guinée, 2018.**

**Sow MD ; Barry AM ; Barry D ; Keita S ; Yanogo P ; Kaboré J ; Gbamou N ; Millimono TJ ; Barry M.**

### Introduction

Le choléra est apparu pour la première fois en Guinée en 1970 et depuis cette année, des épidémies importantes ont été enregistrées en 1994, 1995, 2005-2007 et 2012. Entre 2003 et 2013, 25 358 cas et 952 décès ont été enregistrés avec une létalité de 3.8%. [5,6] A l'instar des pays membres de l'OMS, la Guinée dispose d'un système de surveillance qui

fonctionne suivant les directives du Guide SIMR.

### Méthode

L'étude s'est déroulée du 22 au 27 juillet 2021 pour la période du 12 juillet au 30 novembre 2018. Nous avons utilisé les lignes directrices de CDC sur l'évaluation du système de surveillance (2001) comme guide pour évaluer le fonctionnement, la performance et les attributs du système de surveillance du choléra en Guinée.

Nous avons examiné les plans d'action contre le choléra pour la préparation et la riposte, effectué une évaluation dans les DPS. Une analyse thématique a été effectuée pour les données qualitatives.

### Résultats

Notre évaluation a montré que le système de surveillance sentinelle du choléra en Guinée est bien structuré avec une organisation simple où les rôles et responsabilités assignés à chaque niveau du système sont décrits. Le flux de l'information est connu de tous les acteurs et les canaux de communication bien identifiés. Le système de surveillance du choléra en Guinée s'est avéré utile pour détecter les cas tout au long de la période considérée à risque par un diagnostic et un traitement gratuit aux patients, mais aussi pour fournir des estimations de l'ampleur de la morbidité et de la mortalité liées au choléra.

### Conclusion

Le système de surveillance sentinelle est utile, simple, bien structurée, accepté de tous les acteurs et réactif. Néanmoins, il est faiblement représentatif, moyennement stable et peu sensible (30,37%) en 2018.

**Mots clés :** *Evaluation, Système de surveillance sentinelle, Choléra, Guinée*

## STH-2-S4-COL-48

### Evaluation du système de surveillance épidémiologique de la rougeole en Communes I et II de Bamako, Mali, 2014-2018

**Oumar Sangho**<sup>1,2\*</sup>, Yéya dit Sadio Sarro<sup>2</sup>, Aboubacar Sangho<sup>3</sup>, Housséini Dolo<sup>2</sup>, Hamadou Coulibaly<sup>4</sup>, Souleymane Coulibaly<sup>5</sup>, Bakary Koniba Traoré<sup>4</sup>, Yaya Ballayira<sup>6</sup>, Ousmane Boua Togola<sup>4</sup>, Oumar Kampo<sup>4</sup>, Yacouba Kouyaté<sup>4</sup>, Mah Sacko<sup>4</sup>, Nouhoum Telly<sup>2,6</sup>, Hanine Kéita<sup>7</sup>, Fatou Diawara<sup>1,5</sup>, Yacouba Koné<sup>7</sup>, Assétou Dembélé<sup>7</sup>, Djibril Barry<sup>5</sup>, Ken Kayembé<sup>10</sup>, Bouyagui Traoré<sup>10</sup>

### Affiliations :

1. Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Biologiques et Médicales (DERSBM), Faculté de Pharmacie (FAPH), Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), Bamako, Mali
2. Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique et Spécialités (DERSP), Faculté de Médecine et d'odontostomatologie (FMOS), Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), Mali
3. Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Pharmaceutiques, FAPH/USTTB, Mali
4. Première cohorte du Diplôme Universitaire en Formation des Epidémiologistes de Terrain, Faculté de Médecine et d'Odonto-Stomatologie (FMOS), USTTB, Bamako, Mali
5. Institut National de Santé Publique (INSP), Bamako, Mali
6. Cellule Sectorielle de Lutte Contre le SIDA la Tuberculose et les hépatites virales (CSLS-TBH), Bamako, Mali
7. Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique (DGSHP), Bamako, Mali
8. Direction Régionale de la Santé de Sikasso, Mali
9. Inspection de la Santé, Bamako, Mali
10. African Field Epidemiology Network (AFENET-Mali), Bamako, Mali

**\*Auteur présentateur : Dr Oumar Sangho**, Maître-Assistant en Epidémiologie au Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Biologiques et Médicales, Faculté de Pharmacie (FAPH), Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), Mali. Tél : +223 76 22 58 77, Email : [osangho75@gmail.com](mailto:osangho75@gmail.com). ORCID ID : 0000-0003-2856-0395

**Introduction :** Les Districts Sanitaires des Communes I (ComI) et II (ComII) de Bamako enregistrent fréquemment des épisodes d'épidémie de rougeole. Les autorités sanitaires, notamment la Direction Générale de la Santé et ses partenaires ont initié cette étude dont l'objectif était d'évaluer le système de surveillance épidémiologique de la rougeole dans ces deux Districts Sanitaires.

**Méthodologie :** Nous avons conduit une étude transversale en août 2019 sur les données du 01<sup>er</sup> janvier 2014 au 31 décembre 2018. L'approche CDC (*Center for Diseases Control and Prevention*) a été utilisée pour la collecte des données. L'organisation, le fonctionnement, la complétude, l'acceptabilité, la simplicité, la représentativité ont été appréciés. Le personnel impliqué dans la surveillance épidémiologique

a été concerné : Direction Régionale, deux Centres de Santé de Référence (CSRéf), 27 Centres de Santé Communautaire, deux cabinets et trois cliniques. Les données ont été saisies et analysées sur Epi-Info 7.2.2.16.

**Résultats :** Nous avons trouvé 61 cas confirmés de rougeole sur 323 cas suspects notifiés (ComI=26/141, ComII=35/182). Les tranches d'âge les plus représentées étaient les 1-4 ans en ComI (OR=11,  $p=0,0001$ ) et les  $\geq 25$  ans en ComII (OR=2,54,  $p=0,05$ ). Concernant l'organisation et le fonctionnement du système : les directives étaient disponibles, l'archivage et la retro-information étaient insuffisants. La complétude des rapports hebdomadaires ComI et II étaient de 46% et 59%. Concernant l'acceptabilité et la représentativité, la notification était de 69% et 64%. Le nombre de cas notifiés a varié de 18 et 12 en 2014 à 74 et 63 en 2018. Les cabinets ont été silencieux. La simplicité a été affirmée par tous enquêtés.

**Conclusion :** Le système a été jugé simple et représentatif. Cependant il existe des insuffisances dans la complétude des données, l'acceptabilité et au niveau des ressources humaines qualifiées formées au niveau aire de santé. Il en résulte la nécessité de la formation.

**Mots clés :** Evaluation, système, surveillance, rougeole, Bamako, Mali.

## **Sous-thème 3 : La communication en période de crise sanitaire**

## Sous-thème 3 Session 1

### STH-3-S1-COP-1

**Connaissance, Attitude et Perception vis-à-vis de la COVID-19 chez les personnes confinées à l'Hôtel Gaweye de Niamey en 2020**

MAMANE BAWA Z, ALKASSOUM S. I.,  
Daou M, Adehossi E

**Introduction :** La gestion de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19 a mis en exergue une discordance entre un Etat en charge de la prévention de la population dont le vécu quotidien ne lui renvoie pas forcément la même lecture de l'évènement et des logiques d'action. L'Objectif de l'étude est d'analyser les connaissances, les attitudes et la perception vis-à-vis de la COVID-19 chez les personnes confinées à l'Hôtel Gaweye de Niamey en 2020.

**Matériels et méthode :** Il s'agit d'une étude transversale sur 11 mois ayant porté sur les personnes confinées au niveau de l'hôtel Gaweye de Niamey, présente au moment de collecte de données et ayant accepté de remplir la fiche d'enquête. Les données ont été recueillies à travers une fiche d'enquête. L'analyse des données a été faite avec SPSS Statistics 20 et Sphinx V5.

**Résultats :** Au total 198 personnes ont été interrogées dont l'âge moyen était de 25,91 ans avec une prédominance féminine à 53,5%. Ils provenaient de l'étranger à 96% et 90% avaient un niveau supérieur. Les étudiants représentaient 79,8% et 36,4% étaient à leur première semaine de confinement. Un sentiment d'isolement a été retrouvé chez 51,5% et 88,4% avaient affirmé s'être ennuyés. Ils ont rencontré des difficultés dans 54% et

celles-ci étaient d'ordre psychologique et alimentaire dans respectivement 26,3% et à 9,6% des cas. Le moyen de contact avec l'extérieur le plus utilisé était le téléphone portable et la connexion internet à 94,9%. Le confinement a été jugé indispensable dans 88,4% et efficace dans 92,4%.

**Conclusion** Il est important de réfléchir au décalage que peut exister entre une connaissance objective d'un phénomène pouvant impacter sur la santé telle que peut être mesuré par les scientifiques et leur perception par la population dans son environnement en situation de pandémie.

**Mots clés :** Connaissance, Attitude, Perception, Covid-19, confinement, Niamey

### STH-3-S1-COP-2

**Covid-19 : observance des mesures barrières dans les officines de pharmacie privées au Mali**

Auteurs : Sorel FANSI<sup>1</sup>, Ousmane TOURE<sup>1</sup>,  
Falaye KEITA<sup>2</sup>, Sékou Bah<sup>1</sup>, Abdoulaye DABO<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculté de Pharmacie, Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB)

<sup>2</sup> Centre d'Excellence pour la Recherche et la Formation sur le Paludisme

<sup>3</sup> Centre National de Recherche Scientifique et Technologique

#### Introduction

Au Mali le premier cas de COVID 19 a été détecté le 24 mars 2020. En l'absence de traitement, le respect des mesures barrières devient le seul moyen d'endiguer la pandémie. Le pharmacien privé doit être à l'avant-garde du respect des mesures de prévention. La présente étude visait à apprécier le niveau de prévention dans les officines privées.

#### Objectif principal

Etudier l'observance des mesures barrières de la covid-19 dans les pharmacies privées de Bamako.

## Méthode

L'étude s'est déroulée, de novembre 2020 à avril 2021, dans les officines privées des six communes du district de Bamako au Mali. 100 Officines sur 226 ont été sélectionnées de façon aléatoire. Etaient incluses les pharmacies dont le gérant est présent durant d'étude.

Les données ont été collectées par un questionnaire après un consentement préalable des responsables des établissements.

## Résultats

Connaissance Covid-19 : 99%

Supports communication : affiche 50%

Dispositif prévention : Kit lavage main 49%, marques au sol 25%, cordon de sécurité 23%, gels 98 %, masques chirurgical 68%, tissu 31%

Formations : lavage des mains 92%, Rôle masques 66%, usage masques 68%

Conditions accès officine : stricte 32%, lavage des mains obligation 31%, port du masque obligation 11%

Respect mesures : port du masque 70%, lavage des mains 83%, désinfection de l'établissement 88%, entretien du kit de lavage des mains 1%

Contrôle application mesures : agent dédié au suivi du kit de lavage 52%, responsable du suivi des mesures Barrières 33%, agent de sécurité veillant au respect des mesure 34%

Gestion des déchets : décharge 75%

Obstacles au respect des mesures : méconnaissance de la maladie 86%, mesures contraignantes 84%, coût équipements 85%, absence de législation 65%.

## Conclusion

Les pharmaciens privés ne jouent pas leur rôle d'avant-garde de la prévention de la pandémie.

**Mots clés :** Officine COVID-19 mesures barrières Bamako

## STH-3-S1-COP-3

**Résultats préliminaires de l'étude sur l'état de stress post-traumatique en population générale au Burkina Faso en 2021**

**Adjaratou OUEDRAOGO** ; Zouma Gisèle M.E. OUEDRAOGO ; Issouf SAMANDOU LGOU ; Albert OUEDRAOGO Thierry RAMDE ; Laurent T. OUEDRAOGO ; André K. SOUBEIGA ; Arouna OUEDRAOGO

**Introduction.** La survenue d'une pathologie psychiatrique à la suite de l'exposition à un événement traumatique est une éventualité très fréquente et rapportée dans la littérature médicale depuis de longues dates. Au Burkina Faso depuis les premiers attentats terroristes dans la capitale en janvier 2015, l'ensemble de la population est de plus en plus exposé à des degrés divers, à des séries d'événements stressants ou potentiellement traumatiques. Une telle situation accroît indéniablement la vulnérabilité de la population burkinabè aux syndromes psycho traumatiques parmi lesquels l'état de stress post-traumatique.

L'objectif de notre étude était de déterminer la prévalence de l'État de Stress Post- traumatique (ESPT) en population générale au Burkina Faso.

**Matériel et méthode.** Nous avons réalisé une enquête transversale descriptive et analytique sur un échantillon représentatif de la population générale âgée d'au moins 18 ans. L'étude a couvert l'ensemble des régions sanitaires du pays. L'échantillonnage en grappe a été utilisé pour la sélection des sujets. Le dépistage de l'ESPT a été réalisé à l'aide du Post-traumatic stress disorder Checklist Scale (PCL-5).

**Résultats.** Au total, 4028 sujets composés de 49,30 % d'hommes et 50,70% de femmes, ont été enquêtés. Sur l'ensemble des répondants, 25,32 % ont déclaré avoir été exposés au moins une fois à un événement traumatique au cours de leur vie et dans 34 % des cas, l'événement en cause était les attaques terroristes. Sur l'ensemble des répondants ayant été exposés à un événement traumatique, 14,66 % présentaient un ESPT. La prévalence de l'ESPT au sein de la population générale était de 3,69 %. Cette prévalence était significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes (65 % versus 35 % ;  $p < 0,001$ ).

**Conclusion :** L'ESPT est une réalité actuelle au sein de la population générale au Burkina Faso. Les attaques terroristes constituent majoritairement l'événement potentiellement

traumatique vécu au sein de la population générale au Burkina Faso. D'où l'urgence d'envisager des stratégies de dépistage systématique et une prise en charge appropriée.  
**Mots clés.** État de Stress Post-Traumatique - PCL-5 - Prévalence - Burkina Faso

### STH-3-S1-COP-4

#### **Covid-19 : observance des mesures barrières dans le commerce de denrées alimentaires dans le district de Bamako**

Sorel FANSI<sup>1</sup>, Ousmane TOURE<sup>1</sup>, Falaye KEITA<sup>2</sup>, Sékou Bah<sup>1</sup>, Abdoulaye DABO<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculté de Pharmacie, Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB)

<sup>2</sup> Centre d'Excellence pour la Recherche et la Formation sur le Paludisme

<sup>3</sup> Centre National de Recherche Scientifique et Technologique

#### **Introduction**

Au Mali le premier cas de COVID 19 a été détecté le 24 mars 2020. En l'absence de traitement, le respect des mesures barrières devient le seul moyen d'endiguer la pandémie. Les marchés sont des lieux à haut risque. La présente étude visait à apprécier le niveau de respect des mesures barrières dans ces lieux.

#### **Objectif principal de l'étude**

Etudier l'observance des mesures barrières de la COVID-19 dans les marchés du District de Bamako.

#### **Méthode**

L'étude s'est déroulée, de novembre 2020 à avril 2021, dans les marchés des six communes du district de Bamako au Mali. 100 magasins de denrées de première nécessité sur plus de 2000 ont été sélectionnés de façon aléatoire. Etaient incluses les magasins dont le gérant est présent durant l'étude.

Les données ont été collectées par un questionnaire après un consentement préalable des responsables des établissements

#### **Résultats**

Connaissance Covid-19 : 0%

Supports communication : affiche 1%

Dispositif prévention : aérosol 3%, cordon de sécurité 1%, gels 46 %, savon 80%, masques chirurgical 16%, tissu 79%

Formations : lavage des mains 72%, usage masques 11%

Respect mesures : port du masque 1%, lavage des mains 1%,

Contrôle application mesures : agent dédié au suivi du kit de lavage 5%, agent de sécurité veillant au respect des mesure 1%

Gestion des déchets : décharge 75%

Obstacles au respect des mesures : méconnaissance de la maladie 66%, mesures contraignantes 73%, coût équipements 73%, absence de législation 53%.

#### **CONCLUSION**

Les mesures barrières sont très peu respectées dans les magasins de denrées alimentaires.

**MOTS CLES :** Marchés COVID-19 mesures barrières Bamako

### STH-3-S1-COP-5

#### **Gestion de la maladie à Corona virus dans la ville de Bobo-Dioulasso : pour une analyse des pratiques de l'autorité en période de crise sanitaire.**

**OUÉDRAOGO Ymba Awa**

Enseignante-Chercheure, Département d'Anthropologie

Université Nazi Boni, Bobo Dioulasso.

[ymbaw@yahoo.fr](mailto:ymbaw@yahoo.fr)

Les thérapies issues de la médecine dite traditionnelle seront utilisées comme des références par une grande partie des communautés dans l'anticipation et la prise en charge de la COVID 19 dans la ville de Bobo. Deux approches de la médecine traditionnelle ressortent à travers cette étude : celle des naturo thérapeutes utilisant les paradigmes et les codes de la médecine moderne dans la thérapie et l'autre plus holistique « traditionnelle » gardienne des valeurs et considérant l'homme comme un tout. L'existence de ces deux tendances, pour le cas de Bobo-Dioulasso, a été favorisée tacitement par l'autorité sanitaire dans le but de contrôler la pratique médicale « traditionnelle » locale qui s'accommode

difficilement avec les mesures édictées durant cette période « Covidienne ». L'objectif de cette étude était de lire la stratégie d'intervention de l'autorité en période d'urgence sanitaire.

Les résultats ont été obtenus à travers une recherche qualitative menée dans sept quartiers de la ville de Bobo-Dioulasso durant une trentaine de jours. Elle s'est appuyée sur un corpus de plus de trente entrevues avec cinq naturo thérapeutes, dix devins-guérisseurs, quatorze patients, et des responsables de la direction régionale de la santé, la direction régionale de la médecine traditionnelle, et des responsables du Comité Régional de lutte contre la COVID 19 dans la région des Hauts Bassins.

Il ressort que la stratégie de « management » de la crise dans la ville de Bobo-Dioulasso va créer des ruptures à plusieurs niveaux.

- Une rupture interne entre membres de l'association des tradi thérapeutes ;
- Une rupture entre l'autorité de la santé et l'association-mère des tradi thérapeutes et
- Une rupture entre autorité et les communautés plus proches de l'association-mère des tradi thérapeutes qui sera « écartée » et mise en marge par l'autorité.

Ces ruptures en chaîne auront pour conséquence une crise de confiance, un doute sur l'existence réelle de la COVID 19 dans la ville. Cela va se manifester par la désobéissance et le non-respect des règles édictées par l'autorité comme moyen de défiance pour la non-considération des pratiques médicales locales.

Cette pandémie fait ressortir, deux choses : d'un côté l'existence dans le milieu des capacités réelles de prise en charge de la maladie à Corona virus et une forte référence des communautés pour cette médecine ; et de l'autre la logique de l'autorité teintée de paradoxe cherchant à éviter la propagation de la maladie en écartant les pratiques médicales de référence des communautés qu'elles trouvent incompatibles avec les procédures sanitaires modernes.

**Mots clés** : Autorité, COVID 19, résilience communautaire, collaboration, mesures barrières.

### STH-3-S1-COL-6

#### WhatsApp et lutte contre la lèpre en milieu rural ivoirien en période de covid-19

- 1- **YOKOLI Amani Charles**, Enseignant-chercheur en Communication à l'Université Felix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody Côte d'Ivoire, [ayokoli@yahoo.fr](mailto:ayokoli@yahoo.fr)
- 2- ASSIE N'da Kouassi Marcellin, Directeur coordonnateur du Programme National d'Élimination de la Lèpre en Côte d'Ivoire, [assiend@yahoo.fr](mailto:assiend@yahoo.fr)
- 3- ZAHIRI Eba Marie-Hélène, Chef de service Suivi et Évaluation au Programme National d'Élimination de la Lèpre en Côte d'Ivoire, [emhzahiri@gmail.com](mailto:emhzahiri@gmail.com)
- 4- KOUADIO Kouakou Jérôme, Enseignant-chercheur en Anthropologie à l'Université Felix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody Côte d'Ivoire, [kouadiojeromek2016@gmail.com](mailto:kouadiojeromek2016@gmail.com)

La prise en charge de la lèpre, depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, semble se réaliser à travers des moyens inhabituels. L'on a parfois recours à des canaux de communication, notamment le whatsapp, pour assurer les prestations de soins envers les patients. L'effet dudit réseau sur la lutte contre la lèpre n'a pas suffisamment été examiné dans la littérature scientifique.

La présente étude se propose d'examiner la prise en charge de la lèpre en considérant un groupe virtuel appelé « *ISL, ICL* ». Elle porte sur les acteurs de la lutte, en l'occurrence les infirmiers spécialistes de la lèpre (ISL), infirmiers contrôleurs de la lèpre (ICL) et la direction de coordination du programme. L'analyse des messages s'est faite au moyen de l'analyse de contenu.

Les résultats montrent que les acteurs de la lutte ont renforcé davantage leurs connaissances en matière de diagnostic de la lèpre par le réseau social WhatsApp. Le réseau

social WhatsApp pourrait être un endroit idéal pour le renforcement de la lutte contre la lèpre en Côte d'Ivoire.

**Mots-clés :** Covid-19 - Lutte contre la lèpre – Milieu rural ivoirien- WhatsApp - Côte d'Ivoire

### STH-3-S1-COP-7

#### Contribution des TIC à la gestion de la Covid-19 au Burkina Faso

**BATCHO D. Lucien**, KONSIMBO Esther Delwendé et KABORE Assita ([lucien.batcho@gmail.com](mailto:lucien.batcho@gmail.com), [estherkonsimbo@yahoo.fr](mailto:estherkonsimbo@yahoo.fr), [assi.kabore@gmail.com](mailto:assi.kabore@gmail.com)) / IPERMIC / Université Joseph Ki-Zerbo/Burkina Faso

La mobilisation contre la Covid-19 n'a pas épargné les acteurs de l'écosystème numérique au Burkina Faso. En réponse à l'urgence sanitaire et l'appel à la solidarité nationale lancés par les pouvoirs publics dès les premières heures de la pandémie, plusieurs initiatives ont vu le jour. Elles ont porté sur la sensibilisation des populations via les réseaux sociaux, médias, etc., le développement d'applications et de plateformes numériques de gestion et de prise en charge des malades. S'appuyant sur « *les potentialités ouvertes par Internet* » (Granjon, 2004), et au vu de la croissance exponentielle de la téléphonie mobile avec un taux de pénétration atteignant des records en Afrique subsaharienne grâce aux smartphones et les réseaux 3G et 4G, des développeurs d'application Burkinabè, à l'instar des autres pays, ont proposé des solutions. Le ministère de la santé a ainsi lancé trois applications mobiles, Corona-Detect, Corona-Contact et Corona-Corus. Elles sont dédiées respectivement au public, aux personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé ou probable de Covid-19 et aux équipes médicales. Cette communication s'intéresse à la contribution des trois applications dans la lutte contre la maladie. Si Corona-Corus a connu une certaine appropriation, telle n'est pas le cas des deux autres, faute de notoriété et de vulgarisation. Nos résultats témoignent d'une faible visibilité de ces applications. Par ailleurs, leur utilité reste prouvée mais avec un besoin de développement d'autres fonctionnalités pour d'autres usages.

**Mots clés:** Covid-19, TIC, application, appropriation, Burkina Faso.

### STH-3-S1-COL-8

#### Acceptabilité de la vaccination contre la Covid-19 par les agents de santé de la région sanitaire de Gbèkè, Côte d'Ivoire, 2021

**Kouassi Damus Paquin (1,2)**, Coulibaly M'Bégnan (1,2), Yao Gnissan Auguste (1,2), Kouadio Arsène Déby (1,2), Soumahoro Sory Ibrahim (1,2), Yéo Salifou (2), Ouaga Jean-Marie (2), Irika Opri (1,2), Tano Mouanta Maryse (1,2), Gbayou Dylane (2), Ouattara Ismael (1,2).

(1) Université Alassane OUATTARA

(2) Antenne régionale d'hygiène publique

#### Contexte

En Côte d'Ivoire, aucune étude sur l'acceptabilité des vaccins contre la Covid-19 n'avait été réalisée avant le début de la campagne de vaccination en avril 2021. Cette étude a donc pour but d'orienter les stratégies vaccinales pour atteindre les agents de santé.

#### Méthode

Nous avons réalisé une étude transversale à visée descriptive et analytique en avril 2021 auprès des agents de santé de la région sanitaire de Gbèkè.

#### Résultats

Parmi les 344 agents de santé interrogés, on comptait 16,9% de médecins, 23,8% d'infirmiers et 20,6% d'aides-soignants. La majorité était de sexe féminin (53,5%), d'âge compris entre 30 et 39 (52%), avec un niveau d'étude supérieur (62,5%). Ils provenaient de structures publiques (96,5%). Leurs sources d'information principales étaient la télévision (74,4%), l'internet (18,6%) et les journaux (3,5%). Parmi eux, 2,9% avaient déjà contracté la maladie et 85% avaient peur de la contracter. L'acceptabilité de la vaccination était de 51,2% et elle était statiquement associée à la peur de mourir de la maladie ( $p=0,046$ ) et la prise en charge des malades ( $p=0,026$ ). Les principales raisons de refus de la vaccination étaient l'absence d'information sur le vaccin (52,1%) et la peur des effets secondaires (22,2%).

**Conclusion:** Les stratégies vaccinales devraient être basées sur le renforcement des capacités des agents de santé au regard de leurs inquiétudes sur le vaccin.

**Mots-clés:** Covid-19, vaccination, agents de santé, Côte d'Ivoire.

### STH-3-S1-COL-9

#### Vécu psychosocial des patients de la Covid-19 lors de leur confinement

**Kouadio Arsène Déby** (1,2), Yéo Salifou (2), Kouassi Damus Paquin (1,2), Soumahoro Sory Ibrahim (1,2), Yao Gnissan Auguste (1,2), Coulibaly M'Bégnan (1,2), Irika Opri (1,2), Ouaga Jean-Marie (2), Tano Mouanta Maryse (1,2), Gbayou Dylane (2), Ouattara Ismael (1,2).

- (1) Université Alassane OUATTARA
- (2) Antenne régionale d'hygiène publique

**Contexte :** Les directives de l'OMS pour la prise en charge des cas de Covid-19 préconisent le confinement des sujets dépistés positifs. Les études antérieures menées sur les patients confinés ont révélé un impact sur leur santé mentale et leurs habitudes. Nous avons mené cette étude dans notre contexte afin de déterminer l'impact du confinement chez nos patients. Cette étude vise à améliorer la prise en charge psycho-sociale.

**Méthodologie :** Une enquête rétrospective à visée descriptive a été menée durant le mois de juillet 2021 portant sur les patients Covid-19 confinés durant la période du 26 mai 2020 au 27 mai 2021.

**Résultats :** 224 personnes sur 511 ont accepté de participer à l'enquête, soit un taux de participation de 43,83%. Parmi eux, 134 (59,82%) avaient été admis dans un centre de confinement et 90 (38,39%) confinés à domicile. Ce qui les avait le plus incommodé lors du confinement était l'état d'isolement (33,48%). Le confinement a provoqué le stress (40,58%), l'anxiété (17,03%) et un trouble du sommeil (2,54%). Au niveau familial, il est né des tensions (3,9%), notamment des violences conjugales (1,73%). Après le confinement, il s'en est suivi la stigmatisation (12,96%) et une réduction du contact social (12,55%).

**Conclusion :** Les résultats de cette étude révèlent l'importance de la prise en charge psychologique des patients confinés et leur réinsertion socioprofessionnelle.

**Mots clés :** Covid-19, confinement, santé mentale, Côte d'Ivoire

### STH-3-S1-COL-10

#### Modèles d'hésitation vaccinale contre la covid-19 : quelle place pour la littératie en santé ?

**Serigne Ndamé DIENG**, Mbathio DIOP, Amadou DIENG, Aïda KANOUTE, Massamba Diouf, Cheikh Mbacké LO, Daouda FAYE.

Service de Santé publique, Institut d'Odontologie Stomatologie – Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odonto-stomatologie - Université Cheikh Anta Diop, Dakar – Sénégal.

**Email du présentateur :**  
[serigneddas@gmail.com](mailto:serigneddas@gmail.com) / [serignedame.dieng@ucad.edu.sn](mailto:serignedame.dieng@ucad.edu.sn)

**Introduction:** Le développement des vaccins contre la covid-19 en un temps record a soulevé des inquiétudes chez les populations. La large diffusion d'informations hostiles à la vaccination a favorisé l'hésitation vaccinale (HV) avec des formes diverses selon les facteurs associés.

La littératie en santé (LS) qui renvoie à des compétences de traitement et d'utilisation de l'information de santé pourrait contribuer à sa réduction.

**L'objectif** de l'étude est d'identifier les modèles d'hésitation vaccinale contre la covid-19 et l'effet de la littératie en santé.

**Méthode:** Une revue de la littérature suivant les principes PRISMA a été menée. Pubmed, ScienceDirect et Google Scholar ont été interrogés avec les mots clés suivants : hésitation vaccinale, vaccination, facteurs associés, connaissances, perceptions, attitudes, littératie en santé, littératie vaccinale. Une analyse narrative des résultats a été faite.

**Résultats:** Huit études ont été sélectionnées et deux modèles d'HV définis. Dans le premier, l'hésitation vaccinale est significativement ( $p < 0,05$ ) influencée par les facteurs socioéconomiques. Elle accroit chez les femmes, jeunes, revenus faibles, moins instruits, personnes en couple, ruraux et noirs. Dans le deuxième modèle, l'HV est

significativement ( $p < 0,05$ ) associée aux connaissances, perceptions et attitudes (CPA). Elle augmente chez les personnes qui ont une méfiance vis-à-vis du système de santé, une faible croyance de l'innocuité des vaccins, de faibles connaissances sur le vaccin et sont stressées. Les résultats montrent que l'HV est associée à la littératie en santé, aux facteurs sociodémographiques et aux connaissances, perceptions et attitudes. La LS jouera un rôle modérateur/médiateur entre les caractéristiques sociodémographiques qui l'influencent, les CPA qu'elle influence et le niveau d'hésitation vaccinale.

**Conclusion:** La littératie en santé est un déterminant de l'hésitation vaccinale contre la Covid-19 à travers les CPA qu'elle modère. L'amélioration de la LS contribuerait à réduire le taux d'hésitation vaccinale et à booster le taux de couverture vaccinale.

**Mots clé :** Covid-19, Hésitation vaccinale, Littératie en santé, facteurs associés.

### STH-3-S1-COL-11

**Acceptabilité des mesures de distanciation sociale : « comment dire à quelqu'un de ne pas te rendre visite ? »**

KADIO Kadidiatou<sup>1,3</sup>, YAYA BOCOUM Fadima<sup>1,2</sup>, OUEDRAOGO Adidjata<sup>1</sup>, DRABO Maxime<sup>1</sup>, KOUANDA Seni<sup>1</sup>

1 : Institut de recherche en sciences de la santé, Ouagadougou, Burkina Faso

2 : African Population Health Research Center, WARO, Dakar, Sénégal

3 : Fellow Pilote African Postdoctoral Academy - PAPA, Goethe University Frankfurt

#### Contexte

Face à la propagation de la COVID-19, le Burkina Faso à l'instar des autres pays a adopté des mesures pour endiguer la maladie. La mise en pratique de ces mesures et plus particulièrement des mesures de distanciation physique, a des impacts sociales, psychologiques et monétaires sur les individus. Ainsi se pose avec acuité la problématique de l'acceptabilité de ces mesures. Cette étude a permis de comprendre la perception des acteurs, sur les facteurs susceptibles de faciliter ou

d'entraver leurs adoptions des mesures de distanciation sociale.

#### Méthode

L'étude s'est déroulée dans cinq arrondissements de la ville de Ouagadougou. Une approche qualitative à travers la conduite d'entretiens individuels a été utilisée. Des répondants issus des catégories sociales : des jeunes (filles et garçons), les adultes (hommes et les femmes), des leaders coutumiers, des leaders religieux et des leaders d'opinion (conseiller municipal, responsable associatif) ont été interrogés. Tous les entretiens ont été transcrits en verbatim. À l'issue d'une relecture des discours, les entretiens ont été importés dans le logiciel QSR NVIVO 12.

#### Résultats

Les facteurs qui favorisent la mise en application des mesures de distanciation sont d'abord le souci de la protection personnelle et familiale. En effet les résultats montrent que les personnes qui croient à la maladie et qui la perçoivent comme un "danger" sont disposées à mettre en application les mesures de distanciation malgré l'incompatibilité avec certaines valeurs, et les contraintes affective, sociale et économique que cela peut impliquer. Les résultats de nos recherches mettent également en exergue des contraintes d'ordre sociales et religieuses dans l'adoption des mesures de distanciation sociale. En effet, les événements sociaux sont des moments pour manifester sa solidarité et pour réaffirmer son lien de fraternité envers les autres. S'absenter peut-être perçu comme un acte de rupture de ces liens. Il y a des personnes qui se retrouvent tirailler entre obligation sociale et respect des mesures de la distanciation sociale.

#### Conclusion

La recherche a généré des informations sur les contraintes à l'application des mesures de distanciation sociale. Elles sont donc utiles pour la prise de décisions concernant les mesures de protection acceptables par les populations.

### STH-3-S1-COL-12

**Perceptions de la COVID-19 des personnels de santé de première ligne de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso**

**Fadima YAYA BOCUM<sup>12</sup>**, Kadidiatou KADIO<sup>1,3</sup>, Télésphore SOME<sup>1</sup>, Adidjata OUEDRAOGO<sup>1</sup>, Maxime DRABO<sup>1</sup>, Seni KOUANDA<sup>1</sup>

1: Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Ouagadougou, Burkina Faso

2: African Population Health Research Center, WARO, Dakar, Sénégal

3: Fellow Pilote African Postdoctorat Academy - PAPA, Goethe University Frankfurt

## Introduction

Au Burkina Faso, les premiers cas de covid-19 ont été notifiés en Mars 2020, ce qui a conduit à la prise de mesures de lutte par le gouvernement. Le personnel de santé est en première ligne de cette lutte et il s'est avéré important de comprendre ses perceptions et connaissances de la maladie. L'objectif était de déterminer les connaissances et les perceptions du personnel de santé de la covid-19 de la ville de Ouagadougou.

## Méthodes

L'étude s'est déroulée dans cinq arrondissements de la ville de Ouagadougou. Au total, vingt agents des centres de santé du public et du privé de la ville de Ouagadougou ont été sélectionnés au cours de mai 2020. Des entretiens individuels approfondis ont été réalisés et une analyse thématique a été faite à l'aide de NVIVO.

## Résultats

Les périodes de prise de connaissance de la maladie par le personnel de santé sont fin 2019, avant mars 2020 et après mars 2020. Les voies de transmission relevées sont la promiscuité, les voies respiratoires et les contacts physiques. Divers symptômes ont été relevés tels que la fièvre, la toux, l'écoulement nasal. Mais ils reconnaissent ces symptômes ne suffisent pas pour poser un diagnostic de la Covid-19. De même, les traitements évoqués sont la combinaison de l'azithromycine et chloroquine, et l'apivirine, un phytomédicament. Les moyens de lutte contre la maladie sont le respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Ainsi, les agents de santé pensent que ces mesures collectives sont efficaces pour freiner la propagation de la covid-19.

## Conclusion

La recherche a généré des informations sur les connaissances et les perceptions des personnels

de santé sur la Covid-19. Elles sont donc utiles pour la prise de décisions concernant les mesures de protection des agents de santé pour la prise en charge de la covid-19.

**Mots-clés :** Connaissances, perceptions, Covid-19, personnel de santé, Burkina Faso

## Sous-thème 3 Session 2

### STH-3-S1-COP-13

**Perception de la communauté sur le positionnement du Ministère de la santé (MS) en réponse à la COVID-19 au Burkina Faso**

**Kagoné M.**, Ouédraogo M., Guissou S., Kouyaté B., Kobiané J.F., Sie A.

*Institut National de Santé Publique/Centre de recherche en santé de Nouna (CRSN)*

*Université Nazi Boni : [Kmoubache@yahoo.fr](mailto:Kmoubache@yahoo.fr)*

## Introduction

Au Burkina Faso, l'épidémie de COVID-19 a été officiellement déclarée par le gouvernement le 10 mars 2020. Le premier cas a été signalé le 09 mars 2020 dans la capitale, Ouagadougou. Le MS, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a élaboré un plan de préparation et d'intervention COVID-19. Ce plan devrait permettre au pays de répondre efficacement à cette pandémie.

## Objectif principal de l'étude

L'objectif principal de cette recherche est de comprendre comment le MS se positionne mieux pour défendre la réponse à la COVID-19 en faveur de systèmes de santé plus solides.

## Méthodes

Il s'agit d'une étude qualitative de type transversale. Les informations ont été collectées à l'aide d'un guide d'entretien semi structuré. L'échantillon de l'étude est composé de 12 groupes de discussion avec les utilisateurs des services de santé, de 40 informateurs clé, choisis de façon raisonnée dans 4 régions et impliqués dans la chaîne de gestion de la pandémie. Les données ont été collectées pendant le mois de Novembre à Décembre 2020. Les interviews ont été enregistrées, transcrites, et analysées à l'aide du logiciel d'analyse qualitative NVivo version 12 Pro. La méthode d'analyse thématique a été utilisée.

## Résultats

Les résultats de l'étude montrent que le MS a influencé les prises de décisions concernant la gestion de la pandémie. Du fait de son rôle de collecte des informations sanitaires et de la maîtrise des situations de pandémie. Les décisions étaient prises en se basant sur les statistiques et les informations fournies par les formations sanitaires. Cependant, malgré les efforts, la lutte demeure un défi pour les autorités sanitaires en ce qui concerne l'application des barrières de prévention dans la population.

## Conclusion

Le respect des mesures de protection a connu un relâchement au sein de la population. Des efforts doivent se poursuivre pour un meilleur contrôle de la maladie.

**Mots clés :** Etude qualitative, Covid-19, Ministère de la santé

## STH-3-S2-COP-14

**Conduites suicidaires chez les populations déplacées internes : résultats préliminaires d'une étude réalisée en 2021 dans trois régions au Burkina Faso**

Issouf SAMANDOULGOU ; Zouma Gisèle M.E. OUEDRAOGO ; Albert OUEDRAOGO ; Thierry RAMDE ; Adjaratou OUEDRAOGO ; Laurent T. OUEDRAOGO ; André K. SOUBEIGA ; Arouna OUEDRAOGO

**Introduction :** Les conduites suicidaires se réfèrent à un ensemble de comportements allant des idées suicidaires à la planification du suicide, la tentative de suicide et le suicide. Elles touchent particulièrement les personnes présentant des facteurs de vulnérabilité.

Depuis janvier 2015, plusieurs régions du Burkina subissent de manière répétée des attaques terroristes entraînant un nombre de plus en plus croissant de personnes déplacées internes. Une telle situation augmente la vulnérabilité des populations déplacées internes aux conduites suicidaires. L'objectif de la présente étude était de déterminer la prévalence du risque suicidaire chez les populations déplacées internes au Burkina Faso.

**Matériel et Méthode :** Nous avons réalisé une étude transversale descriptive et analytique auprès des populations déplacées internes accueillies dans la région de l'Est (Fada N'Gourma), du Nord (Ouahigouya) et de la Boucle du Mouhoun (Nouna). Le choix de ces sites a été fait de façon raisonnée. Au niveau de chaque site, le choix des sujets à inclure a été fait de façon aléatoire. Ont été inclus toutes les personnes âgées d'au moins 18 ans et qui ont donné leur consentement pour participer à l'enquête. Le risque suicidaire a été mesuré à l'aide du module « risque suicidaire » du questionnaire standardisé, « Mini-International Neuropsychiatry Interview » (MINI) de l'OMS.

**Résultats.** Dans les trois sites retenus, 1231 PDI ont été interrogées dont 65,64 % de femmes. L'âge moyen était de  $37,69 \pm 13,90$  ans. La prévalence du risque suicidaire chez les PDI était de 6,82 % dont 4,96 % risque léger, 1,71 % de risque moyen et 0,16 % de risque élevé. Chez les personnes présentant un risque suicidaire 59,52 % était des femmes. Le risque suicidaire était également plus élevé dans la tranche d'âge de 30-39 ans (26,19 %) par rapport aux autres tranches d'âge.

**Conclusion :** Notre étude a révélé une prévalence importante du risque suicidaire chez les PDI interrogée. Ces données suggèrent des recherches complémentaires pour identifier les groupes de populations les plus vulnérables vis-à-vis des conduites suicidaires ainsi que des actions la prévention spécifique du suicide.

**Mots clés :** Risque suicidaire – MINI – Prévalence - Personnes déplacées internes – Burkina Faso

## STH-3-S2-COP-15

**Résultats préliminaires sur la dépression chez la femme en population générale au Burkina Faso en 2021**

Thierry RAMDE ; Zouma Gisèle M.E. OUEDRAOGO ; Issouf SAMANDOULGOU ; Albert OUEDRAOGO ; Adjaratou OUEDRAOGO ; Laurent T. OUEDRAOGO ; André K. SOUBEIGA ; Arouna OUEDRAOGO

**Introduction.** La dépression est une maladie courante dans le monde. Elle serait selon l'Organisation mondiale de la santé, l'une des

principales causes d'incapacité dans le monde. Selon plusieurs études menées, ce trouble mental touche plus les femmes que les hommes. Pour ce qui est de la femme, les aspects spécifiques de la dépression sont la résultante de plusieurs facteurs. La crise sécuritaire et sanitaire que traverse le Burkina Faso est un facteur affectant la santé mentale des populations.

L'objectif de notre étude était de déterminer, à l'aide du « Mini-International Neuropsychiatric Interview » (MINI), la prévalence de la dépression chez la femme dans la population générale au Burkina Faso en 2021.

**Matériel et méthode.** Nous avons procédé par une enquête transversale descriptive et analytique sur un échantillon représentatif de la population générale âgée d'au moins 18 ans. Nous avons procédé à un échantillonnage en grappes à plusieurs degrés qui a couvert l'ensemble des régions sanitaires du pays. L'échantillon, estimé à 2041 sujets, a été réparti en 89 grappes de 10 ménages chacune.

**Résultats.** Le taux de prévalence de la dépression chez la femme était de 16,5% (n=2041). L'épisode dépressif était la forme clinique la plus fréquente 12%. Il existe un lien statistiquement significatif entre la dépression, la situation matrimoniale, l'activité professionnelle et le niveau d'étude. En effet, 70% des femmes mariées ( $p=0,004$ ), 40% des femmes au foyer ( $p=0$ ) et 64% des femmes n'ayant jamais été scolarisé ( $p < 0,001$ ) étaient sujettes à la dépression.

**Conclusion.** La dépression est un problème de santé publique. Au Burkina Faso, la prévalence de la dépression chez la femme en population générale est élevée. Des actions doivent être nécessairement entreprises pour faciliter l'accès aux soins à ces personnes.

**Mots clés : Dépression – Femme - Prévalence - Population générale - Burkina Faso**

### STH-3-S2-COP-16

**Connaissances et attitudes des populations déplacées internes (PDI) sur la covid-19 au Burkina Faso en 2021 : résultats préliminaires**

**Albert OUEDRAOGO** ; Zouma Gisèle M.E. OUEDRAOGO ; Issouf SAMANDOU LGOU ; Thierry RAMDE ; Adjaratou OUEDRAOGO ;

Laurent T. OUEDRAOGO ; André K. SOUBEIGA ; Arouna OUEDRAOGO

**Contexte :** La pandémie à COVID-19 continue d'inquiéter le monde entier. Au Burkina Faso, elle coexiste avec un contexte sécuritaire délétère avec pour conséquence de nombreuses populations déplacées internes (PDI). L'objectif de la présente étude était d'apprécier les connaissances et les attitudes des PDI sur la Covid-19 au Burkina Faso.

**Méthode :** Nous avons réalisé une enquête transversale descriptive et analytique parmi les populations déplacées internes. Comme technique d'échantillonnage, nous avons procédé par un choix raisonné de trois camps d'accueil de ces PDI (un dans la région de l'Est, un dans la région du Nord, un dans la Boucle du Mouhoun). Dans chaque camp choisi, nous avons sélectionné de façon aléatoire un échantillon représentatif de PDI. Les données recueillies à l'aide de fiches d'investigation par entretien individuel en face à face, ont été maintenues anonymes, codées, puis saisies sur un microordinateur équipé d'un logiciel de traitement statistique Epi Info 7.

**Résultats :** Sur un total de 1231 personnes enquêtées, 65,64 % étaient de sexe féminin contre 34,36 % de sexe masculin. L'âge médian était de 35 ans (extrêmes=18 ans et 98 ans).

Pour ce qui est de l'origine de la maladie, 53,81 % pensaient que c'est une maladie venue d'ailleurs. Quant aux symptômes, les plus cités étaient : la toux sèche (60,45%), les maux de tête 50,73 % et la fièvre (48,70%). Seules 6,48 % avaient déjà réalisé un test COVID -19.

Comme mode de transmission, la toux sans protection (63,37 %), la salutation en se serrant les mains (53,16 %), les éternuements (52,03 %), ont été les plus mentionnés. Comme moyens de protection, 89,93 % déclaraient que le port de masque protège contre la maladie. En ce qui concerne la vaccination 47,00 % pensaient qu'elle est très utile pour contrôler l'épidémie et 71,56 % des répondants se déclaraient prêts à se faire vacciner.

**Conclusion :** Les PDI interrogées avaient plutôt une bonne connaissance de la maladie à COVID-19 et ont une bonne attitude face à la maladie. Toutefois, des efforts de sensibilisation restent nécessaires pour l'adoption quotidienne de comportement à moindre risque.

**MOTS CLES :** Connaissances – Attitudes – Covid-19 –PDI - Burkina Faso

## STH-3-S2-COP-17

### Expérience des adolescents avec la COVID-19 en Afrique sub-Saharienne

#### Resultats d'une enquête téléphonique au Burkina Faso, en Éthiopie et au Nigeria

**Millogo Ourohiré<sup>1</sup>**, Sié Ali<sup>1</sup>, Dongqing Wang<sup>2</sup>, Angela Chukwu<sup>3</sup>, Nega Assefa<sup>4</sup>, Christabel James<sup>3</sup>, Tara Young<sup>2</sup>, Bruno Lankoandé<sup>5</sup>, Firehiwot Workneh<sup>6</sup>, Elena C. Hemler<sup>2</sup>, Michelle L. Korte<sup>2</sup>, Josiemer Mattei<sup>7</sup>, Abdramane Bassiahi Soura<sup>5</sup>, Ali Sie<sup>3</sup>, Ayoade Oduola<sup>8</sup>, Yemane Berhane<sup>6</sup>, and Wafaie W. Fawzi<sup>2,7,9</sup>

<sup>1</sup>Nouna Health Research Center, Nouna, Burkina Faso,

<sup>2</sup>Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University, Boston, Massachusetts.

<sup>3</sup>Department of Statistics, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria;

<sup>4</sup>College of Health and Medical Sciences, Haramaya University, Harar, Ethiopia

<sup>5</sup>Institut Supérieur des Sciences de la Population, University of Ouagadougou, Ouagadougou, Burkina Faso;

<sup>6</sup>Addis Continental Institute of Public Health, Addis Ababa, Ethiopia;

<sup>7</sup>Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University, Boston, Massachusetts

<sup>8</sup>University of Ibadan Research Foundation, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria;

<sup>9</sup>Department of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University, Boston, Massachusetts

#### Introduction

La pandémie de la COVID-19 ainsi que les interventions mises en place ont eu des impacts sociaux, économiques et sanitaires directs ou indirects divers sur les populations en Afrique au Sud du Sahara.

#### Objectif principal

L'objectif principal de notre étude était de comprendre les connaissances, les perceptions et les pratiques des adolescents liés au COVID-19 et les impacts de la pandémie sur la vie quotidienne.

#### Méthodes

C'est une enquête transversale multisite conduite sur échantillon aléatoire de 300

adolescents âgés de 10 à 19 ans sélectionnés 3 sites par pays ruraux et 3 sites urbains au Burkina Faso, en Éthiopie et au Nigeria. Les ménages avec des adolescents âgés de 10 à 19 ans ont été échantillonnés à partir des systèmes de surveillance sanitaire et démographique et d'autres enquêtes. Des entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (CATI) ont été menés dans les langues locales de juillet à novembre 2020.

#### Résultats

Au total 1795 adolescents ont été enquêtés dans les 3 pays. Près d'un adolescent sur 5 (18%) ne se sentait pas concerné par la pandémie. Au Burkina Faso, les adolescents avaient une faible connaissance sur la pandémie (50%) en milieu rural (Nouna) contre 16% en milieu urbain (Ouagadougou). Les connaissances des adolescents étaient faibles en milieu rural. Les activités physiques des adolescents ont diminué de 42%. La principale source d'information était la radio et la télévision. Les mesures de prévention les plus respectées étaient le lavage régulier des mains (94%), le port du masque (82%) et la distanciation physique en public (60%). La crise de la COVID-19 a entraîné une anxiété chez 26% des adolescents.

#### Conclusion.

Cette enquête met en exergue la nécessité de renforcer les connaissances des adolescents sur la COVID-19.

**Mots clés :** COVID-19, adolescents, Afrique subsaharienne.

## STH-3-S2-COL-18

### Facteurs associés à l'acceptabilité des mesures gouvernementales face à la COVID-19 au Sénégal

#### Amadou Ibra DIALLO

E-mail : [dialloamadouibra@gmail.com](mailto:dialloamadouibra@gmail.com)

#### Introduction

Trois mois après l'apparition de la nouvelle maladie à coronavirus, le Sénégal enregistre son premier cas, le 02 mars 2020. Face à cette pandémie, l'Etat réagit rapidement par des mesures publiques : couvre-feu, interdiction des déplacements entre les régions, fermeture des commerces et des lieux de culte. Cette

recherche vise à étudier l'acceptabilité de ces mesures non pharmaceutiques par la population sénégalaise.

### Méthode

Il s'agissait d'une enquête transversale et analytique réalisée en juin et juillet 2020 auprès de sénégalais âgés de plus de 18 ans. L'échantillonnage par la méthode des quotas représentatifs a été réparti proportionnellement à l'âge, au sexe et aux régions. Le questionnaire a été construit à partir du cadre théorique d'acceptabilité des interventions de santé. La collecte est réalisée à partir d'un centre d'appel téléphonique synchronisé à un serveur internet concernant : les caractéristiques personnelles, la connaissance de la maladie, la confiance aux sources d'informations, la confiance au gouvernement, l'inquiétude face à l'épidémie et les sept dimensions de l'acceptabilité. L'analyse descriptive et l'équation structurelle ont été réalisées avec le logiciel R version 4.0.2.

### Resultats

L'étude a porté sur un total de 813 individus. L'âge moyen était de 34,7 ans ( $\pm 14,2$ ans). Ils étaient en prédominance masculine (54,6%), sans instruction (42,6%). La bonne connaissance de la maladie était associée à la confiance des sources d'informations des médias nationaux portée par les autorités administratives et sanitaires ( $\beta=0,11^{**}$ ). L'augmentation du niveau de confiance envers le gouvernement dans la riposte contre la COVID-19 était liée positivement à l'acceptabilité du couvre-feu ( $\beta=0,16^{***}$ ), de l'interdiction des déplacements entre les régions ( $\beta=0,11^{***}$ ), de la fermeture des lieux de culte ( $\beta=0,1^{**}$ ) et des marchés ( $\beta=0,09^{**}$ ).

### Conclusion

Au Sénégal, l'acceptabilité des mesures dépendait de la connaissance de la maladie, de la perception du risque liée à la maladie et de la confiance au gouvernement. Il est nécessaire de renforcer la sensibilisation et la communication des risques liés à la COVID-19.

**Mots clés :** Acceptabilité sociale, Mesures gouvernementales, Adhésion, COVID-19, Sénégal.

## STH-3-S2-COL-19

### Covid-19 en Côte d'Ivoire : Impact des rumeurs dans la stratégie gouvernementale de lutte

1. **KOFFI Komenan Simon-Pierre**,  
Docteur en Communication pour le

développement, Université Félix Houphouët-Boigny

[nanmeko@gmail.com](mailto:nanmeko@gmail.com)

2. **EHOUMA Koffi Ludovic**,  
Enseignant-chercheur ISAD,  
Université Félix Houphouët-Boigny
3. **NANGA-ADJAFI Angéline**,  
professeur titulaire, Université Félix Houphouët-Boigny

Le présent article est le résultat d'investigations menées pour l'analyse de l'impact des rumeurs sur la stratégie de lutte mise en place par le gouvernement ivoirien dans la gestion de la pandémie du Covid-19. Cette pandémie, causée par le SARS-CoV-2, met en difficulté les systèmes de santé dans sa propagation en provoquant des perturbations sociales et économiques majeures.

Les dispositifs de contrôle, pour maîtriser et juguler la pandémie, sont contestés par des rumeurs qui sont relayées, tant sur son origine, qu'aux traitements probables ainsi qu'aux mesures préventives. S'appuyant sur le district d'Abidjan, l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire, l'étude a été menée essentiellement à partir de la consultation des données primaires auprès des internautes ainsi que des structures étatiques engagées dans la lutte.

Les données recueillies nous révèlent que, cette épidémie, pour laquelle le vaccin est problématique et le traitement étiologique absent, continue de susciter de très vifs émois et l'émergence de nombreuses rumeurs. La transmission de ces rumeurs sur la covid-19 est une activité très attractive dans laquelle de nombreux acteurs à différents niveaux, avec des rôles précis, trouvent leur compte. La lenteur observée au niveau de la communication officielle comparativement à la vitesse d'accès desdites informations sur internet constitue un facteur explicatif de la naissance et la transmission des rumeurs sur la covid-19 et influence de manière notable les actions gouvernementales dans cette lutte.

En définitive, l'étude sur l'impact des rumeurs dans la stratégie de lutte gouvernementale contre la covid-19 est un fait entièrement social. Les efforts pour juguler ses conséquences ne doivent se limiter à des démentis sporadiques ou des intimidations d'internautes qui ne représentent que le maillon faible de la chaîne de production et de transmission de ces rumeurs.

**Mots clés :** impact, rumeur, gestion, actions gouvernementale, covid-19

### STH-3-S2-COL-20

#### **Communication de santé publique et COVID-19 dans l'espace public télévisuel au Burkina Faso : sous-enjeux et argumentation**

**Lacina KABORE**, Journalisme, Sciences de l'information et de la communication. IPERMIC (UJKZ). E-mail : [lacinakabore@gmail.com](mailto:lacinakabore@gmail.com).

##### **Introduction**

La pandémie actuelle de COVID-19 draine sans son sillage une « infodémie » majeure, une épidémie d'informations fondée sur la diffusion de rumeurs et de fausses nouvelles, mais également basée sur l'inflation de la production et de la consommation des produits médiatiques (Jaubert et Dolbeau-Bandin 2020 : 2). De ce problème découle notre question de recherche : en quoi les défaillances de la communication gouvernementale relative à la COVID-19 et leurs conséquences sur la réponse à la pandémie sont-elles consubstantielles au faible niveau de prise en compte des sous-enjeux du contexte burkinabè ? L'objectif principal du travail découle de cette hypothèse.

##### **Matériel et méthode**

Le travail couvre la période de mars 2020 à février 2021. Le corpus comprend 48 numéros de l'émission *Débat de presse* sur la RTB-Télévision. Les outils de collecte de données sont la recherche documentaire et l'observation. Un guide d'entretien semi-directif a été administré à 30 personnes du monde de la communication, des médias et de la santé.

##### **Résultats**

A l'issue du travail, les liens entre les insuffisances de la communication gouvernementale sur la COVID-19, leurs conséquences sur la réponse à la pandémie et le faible niveau d'intégration des sous-enjeux du contexte seront montrés.

##### **Discussion**

Les résultats de travail montrent que les élections du 22 novembre 2020 ont constitué un important sous-enjeu communicationnel à *Débat de presse*. L'Exécutif est l'autorité la plus référencée dans l'argumentation. Notre hypothèse de travail est confirmée car les insuffisances de la communication stratégique du gouvernement sur la COVID-19 sont en partie liées au faible niveau d'intégration des

sous-enjeux du contexte et des pesanteurs socio-anthropologiques locales.

##### **Conclusion**

En rappel, ce travail visait à démontrer le poids des sous-enjeux du contexte sur l'efficacité de la stratégie de communication de l'Exécutif en matière de COVID-19.

**Mots-clés :** communication gouvernementale, espace public télévisuel, crise

### STH-3-S2-COL-21

#### **Informations et dynamiques comportementales face à la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire : de mars 2020 à aujourd'hui**

**Dr DOFFOU N'Cho François<sup>1</sup>, Dr KOUAKOU Amenan Christiane<sup>2</sup>**

1-Assistant,  
Communication pour le Développement, *Université Virtuelle de Côte d'Ivoire*.

**Email :** [ncho.doffou@uvci.edu.ci](mailto:ncho.doffou@uvci.edu.ci) / [dooffou\\_francois@yahoo.fr](mailto:dooffou_francois@yahoo.fr)

**Contacts :** +225 0101181309 / +225 0173002110 / +225 0505257587

**Adresse postale :** 06 BP 355 Abidjan 06

2-Assistant,  
Sociologie du Politique et de l'Intégration,  
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (UJLoG)  
Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire

**Email :** [christianekouakou@gmail.com](mailto:christianekouakou@gmail.com) / [christiane.kouakou@csrs.ci](mailto:christiane.kouakou@csrs.ci)

**Contacts :** +225 0708304503

**Adresse postale :** BP 150 Daloa

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a été signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine le 31 Décembre 2019 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) occasionnant à ce jour plus de 246 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués pour plus de 212 millions cas de guérison et au moins 6 millions décès à travers le monde aujourd'hui (Wikipédia, 2021). L'Afrique est restée pendant un temps épargnée avant d'être elle aussi envahie par la crise, même si le taux de contamination et le nombre de décès restent très largement en deçà comparé aux autres continents. Depuis lors, les secteurs public et privé sont mis à contribution pour une meilleure gestion de la crise sanitaire. Aussi, les différentes stratégies de lutte afin de réduire la propagation de cette pandémie ne peuvent-elles être efficaces qu'avec la participation

responsable de l'ensemble des chercheurs et singulièrement ceux des sciences sociales en vue de l'amélioration d'un cadre social de riposte à la pandémie. La présente communication a pour objectif principal de montrer comment, en Côte d'Ivoire, les informations consécutives à la covid-19 influent sur les comportements des usagers quant aux mesures de lutte. Il s'agira donc de faire l'état des lieux depuis l'annonce du premier cas confirmé jusqu'à la mise en place des dispositions pour la riposte contre la pandémie. De montrer comment s'est faite la naissance progressive des différentes informations et rumeurs diffusées sur les médias ? Comment ces informations reçues ont influé et identifier les différents changements de comportement et d'habitude des populations ? Enfin, proposer une stratégie de communication d'urgence pour juguler la crise que le pays traverse. Nous avons donc mis l'accent sur la théorie de changement comportemental et sommes aidés d'enquête en ligne à travers des sites, plateformes communautaires et d'entretien avec des administrateurs de groupes.

**Mots clés :** Informations, Dynamiques Comportementales, Lutte, Covid-19, Côte d'Ivoire.

### STH-3-S2-COL-22

#### Connaissances, attitudes et pratiques face à la COVID-19 chez les patients souffrant de maladie cardiovasculaire à Parakou (Bénin) en 2021

Houehanou Yessito Corine Nadège<sup>1\*</sup>, Codjo Léopold<sup>2</sup>, Dohou Hugues<sup>2</sup>, Gbaguidi Ruth<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ecole Nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et surveillance épidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Parakou, Bénin

<sup>2</sup> Service de cardiologie, centre hospitalier départemental universitaire Borgou / Alibori, Parakou, Bénin

\*Adresse : Université de Parakou, BP 123 Parakou (Bénin) ; email : yessito\_fr@yahoo.fr

**Introduction :** Le monde fait face à la pandémie de la maladie due au coronavirus SARS COV2 apparue en 2019 (COVID-19).

**Objectif :** L'objectif de ce travail était d'étudier les connaissances, attitudes et pratiques face à la COVID-19 chez les patients souffrant de maladie

cardiovasculaire au centre hospitalier départemental universitaire Borgou / Alibori (CHUD-B/A), à Parakou, au Bénin, en 2021.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale. La population d'étude était constituée de l'ensemble des patients souffrant de maladie cardiovasculaire, reçus en consultation dans le service de cardiologie du CHUD-B/A d'août à septembre 2021, et ayant donné leur consentement écrit. Un questionnaire électronique a été conçu et rempli lors d'une entrevue individuelle avec l'enquêté. Les connaissances, attitudes et pratiques ont été évaluées par des scores établis grâce à une série de questions notées 0 ou 1 (bonne réponse).

**Résultats :** Un total de 71 patients a été inclus dont 47 femmes (66,2%). Leur âge médian était de 45 ans. Presque tous avaient de bonnes connaissances (91,6%) et des attitudes justes (94,4%) face à la COVID-19. Moins des trois-quarts d'entre eux (70,4%) avaient de bonnes pratiques préventives. Seulement 46,4% ont fait au moins une fois le test de dépistage et 5,6% la vaccination.

**Conclusion :** La connaissance de la COVID-19 est bonne dans cet échantillon et la pratique des mesures préventives acceptable. Les résultats soulignent une réticence pour la vaccination.

**Mots clés :** Connaissances, attitudes et pratiques, COVID-19, Bénin

## **Sous-thème 5 : Communications libres**

## Sous-thème 5 Session 1

### STH-5-S1-COP-1

**Variation temporelle de la distribution des allèles *eba175* chez des enfants atteints de paludisme simple à Banfora, Burkina Faso.**

**Salif Sombié**, Samuel Sindié Sermé, Amidou Diarra, Aïssatou Diawara, Sam Coulibaly, Mame Massar Dieng, Emilie Badoum, Aïssata Barry, Désiré Kargougou, Alfred Tiono, Bienvenu Sodiomon Sirima, Youssef Idaghmour, Issiaka Soulama.

#### Introduction

L'antigène de liaison aux érythrocytes *eba175* joue un rôle important dans l'invasion des érythrocytes par le plasmodium. C'est un candidat vaccin antipaludique. Cependant, il est un gène dimorphique. L'objectif de cette étude était de comparer la distribution des allèles du gène *eba175* pendant deux saisons consécutives de transmission du paludisme chez des enfants infectés par *P.falciparum* vivant dans une zone d'endémie du paludisme au Burkina Faso.

#### Méthodologie

L'étude a été menée pendant la saison de haute transmission du paludisme de 2015 et 2016 à Banfora. Cent cinquante (150) enfants de 2 à 10 ans ont été enrôlés dans une cohorte et suivis pendant la saison de haute transmission des deux années. Des frottis sanguins ont été collectés pour le diagnostic du paludisme au microscope optique. Les allèles EBA-175, ont été typés en utilisant la PCR nichée. L'étude a été approuvée par le comité d'éthique national du Burkina Faso.

#### Résultats

La distribution des allèles *eba175* dans la population étudiée était la suivante : 56,50% fcr3, 16,14% camp et 27,35% mixte. L'analyse de la distribution des allèles *eba175* par année a montré qu'il n'y avait pas de différence statistique ( $p = 0,45$ ) dans la prévalence de l'allèle fcr3 entre 2015 (59,37%) et 2016 (54,33%). Cependant, nous avons constaté que la prévalence de camp en 2015 (21,87%) était statistiquement plus élevée ( $p = 0,04$ ) que la prévalence de l'allèle camp en 2016 (11,8%). De même, la prévalence des porteurs mixtes en 2016 (33,85 %) était statistiquement plus élevée ( $p = 0,01$ ) que la prévalence des porteurs mixtes en 2015 (18,75 %).

#### Conclusion

Cette étude montre que le polymorphisme de *eba175* pourrait varier selon le temps. Ces

résultats pourraient être utiles dans la conception et l'utilisation de vaccin utilisant *eba175*.

**Mots clés :** Paludisme, *eba175*, allèle, fcr3, camp.

### STH-5-S1-COP-2

**Indice de préparation des services de santé relatifs au paludisme et association avec la létalité palustre infantile.**

**Ourohiré Millogo**<sup>1</sup>, Ali Sié<sup>1</sup>, Jean E. O. Doamba<sup>1</sup>, Jürg Utzinger<sup>2,3</sup> and Penelope Vounatsou<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Centre de Recherche en Santé de Nouna, Nouna, Burkina Faso.

<sup>2</sup>Suiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland.

<sup>3</sup>University of Basel, Basel, Switzerland.

#### Introduction :

Les enquêtes sur la disponibilité et les capacités opératoires des services de santé (SARA) génèrent des données importantes sur l'état de préparation des services de santé à prendre en charge les patients.

#### Objectif principal

Notre objectif était de construire un indice synthétique de la performance des services de santé à prendre en charge les cas de paludisme au Burkina Faso et de déterminer l'association entre les effets de cette performance sur et la mortalité due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso.

#### Méthodes :

Des modèles géostatistiques bayésiens avec sélection de variables ont été appliqués sur les données de l'enquête SARA 2014 pour sélectionner les indicateurs les plus importants liés aux services généraux et spécifiques au paludisme sur l'état de préparation des services de santé. L'analyse des correspondances multiples (ACM) a été utilisée pour construire un score composite basé sur plusieurs axes factoriels.

#### Résultats :

Le score composite expliquait respectivement 30 et 53% de la variation de l'ensemble des indicateurs des centres médicaux et les centres de santé périphériques. Le taux de mortalité était inférieur de 59 % (MRR = 0,41, ICB 95 % : 0,19-0,91) dans les centres de santé

périphériques les plus performants, par rapport au groupe à faible niveau de performance. Les régions avec forte proportion de centres de santé performants présentent des taux de mortalité plus faibles.

#### **Conclusion :**

Des services de santé performants au Burkina Faso sont associés à des taux de mortalité due au paludisme plus faible. L'accent devrait être mis sur l'amélioration de la gestion des médicaments essentiels et sur la réduction des délais de transport d'urgence entre les différents niveaux du système de santé.

**Mots-clés :** Enquête SARA, Burkina Faso, Indice composite, Paludisme

### **STH-5-S1-COP-3**

#### **Profil épidémiologique du paludisme en Guinée de 2013 à 2020**

**F.DOUMBOUYA<sup>1,2</sup>,**

D.BARRY<sup>2</sup>, S.SIDIBE<sup>3</sup>, PK .YANOGO<sup>2</sup>, N.ME  
DA<sup>2</sup>

1. Direction Régionale de la Santé de BOKE

2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain et de Laboratoire, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, Université Pr Joseph Ki- Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

3. Programme nationale de lutte contre le paludisme

**Auteur correspondant: Fatoumata**

**DOUMBOUYA,**

Tel : +224622643619

Email : [fifidombouya24@gmail.com](mailto:fifidombouya24@gmail.com)

**Introduction:** En Guinée, le paludisme demeure stable avec une transmission pérenne et toute la population est exposée au risque. Il représente la première cause de morbidité et mortalité dans les formations sanitaires malgré la mise en place des interventions de prévention et de contrôle du paludisme au cours des dernières années avec une vulnérabilité plus élevée chez les enfants de moins de 5 ans (67% de décès) et les femmes enceintes d'où cette analyse pour connaître le profil épidémiologique du paludisme afin de mieux orienter les moyens de lutte déjà mis en place.

**Méthode:** Une étude transversale descriptive portant sur des données de surveillance épidémiologique du paludisme de 2013-2020 a été menée. Etaient inclus dans cette analyse,

tout cas de paludisme enregistré dans la base de données du Programme Nationale de Lutte contre le paludisme répondant à la définition des cas du guide Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte de la Guinée a été utilisée. Les variables sociodémographiques et classification finale des cas ont été considérées. Les données ont été analysées sur Excel. Des proportions et incidence ont été calculés.

**Résultat:** Au total 15.424.439 cas suspect notifiés dont 9.469.029 cas confirmés soit (62,29%) avec 8.636 décès (0,09%). Etaient plus représentés les enfants de plus de 5ans (62,79%) ; Treize (34%) sur 38 districts sanitaires étaient silencieux en 2013. De 2014-2020 la majeure partie des districts avait notifié plus de 10000 cas / 100000 habitants. L'indice de positivité a été beaucoup plus observée en 2013 soit 82,77%.

**Conclusion:** L'incidence du palu et surtout e élevée dans les quatre régions surtout pendant la saison de pluies. Nous recommandons la sensibilisation de la population dans le respect des stratégies de lutte contre le paludisme déjà mise en place (utilisation de MILDA, CPS).

**Mots-clés :** Paludisme, incidence, Guinée, Année

### **STH-5-S1-COP-4**

#### **Analysis of the impact of malaria on the labour productivity of cotton farmers in Burkina Faso.**

**Seydou Yabré<sup>1\*</sup>,** Tito Nestor Tiehi<sup>3</sup>, Fadima Yaya Bocoum<sup>4</sup>, N'Fale Sagnon<sup>1</sup>, Guelbeogo Moussa<sup>1</sup>, Eve Worrall<sup>5</sup>, Pam Zahonogo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme, <sup>2</sup> Université Thomas Sankara

<sup>3</sup> Université de Cocody, <sup>4</sup> Institut de Recherche en Science de la Santé, <sup>5</sup> Liverpool School of Tropical Medicine.

\* [yabreseydou@yahoo.fr](mailto:yabreseydou@yahoo.fr)

#### **Background**

Malaria is both a public health problem and a performance barrier in agricultural countries. Burkina Faso has been facing a gradual decline in cotton productivity since 2014. Cotton, the main agricultural export and source of household income, is a labour-intensive rainfed crop.

The decline would be partly explained by the low labour productivity due to malaria infection. The study aims to analyze the impact

of malaria on the labour productivity of cotton farmers.

### Methods

Panel data techniques and methods were utilized on 25 cotton producing provinces over the period 2014-2018 in the Central, Eastern and Western regions. An augmented growth model of Solow was used to explore the association between malaria and labor productivity. The homogeneity and Hausman test were respectively conducted to identify the possible heterogeneity between provinces and specify the appropriate estimation method depending on whether the individual model effect is fixed or random.

### Results

At 1%, the Fisher test shows the presence of heterogeneity, hence the adoption of an individual effect model. Similarly, the value of the Hausman statistic is 42.02 and the P-value = 0.000 < 5%. The individual fixed-effect model is the best one and the parameters of the model were estimated by the ordinary least squares method. The econometrics results show that an increase in malaria incidence of 1% leads to a decrease in cotton farmer productivity of 0.425%, all other variables being held constant. In addition, education is found to be important variable in labor productivity improvement.

### Conclusions

These results imply further health policies to reduce the incidence of malaria among cotton farmers. In addition, advocate more investment in the education of cotton farmers is need. Because the best educated farmers avoid the misuse of inputs.

## STH-5-S1-COP-5

### Perception de la communauté sur la prévention du paludisme après l'introduction de nouvelles moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) dans les districts sanitaires de Banfora, Gaoua et Orodara.

<sup>1</sup>Kagoné M, <sup>2</sup>Guglielmo F, <sup>1</sup>Ouattara F, <sup>1</sup>Fofana A, <sup>1</sup>Poda S, <sup>3</sup>Tynuv K, <sup>4</sup>Tougri G, <sup>1</sup>Guelbeogo MW, <sup>1</sup>Sagnon N, <sup>3</sup>Gogue C, <sup>3</sup>Robertson M, <sup>1</sup>Gansane A

<sup>1</sup>Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>2</sup> Liverpool School of Tropical Medicines, Liverpool, United Kingdom

<sup>3</sup>PATH, Washington, DC, United States

<sup>4</sup>Programme National de Lutte contre le Paludisme, Ouagadougou, Burkina Faso

Email : [kmoubache@yahoo.fr](mailto:kmoubache@yahoo.fr)

### Introduction

Le paludisme est une infection parasitaire qui est transmise à l'homme par la piqure de moustiques anophèles femelles. Compte tenu de l'émergence et de l'intensification de la résistance aux insecticides chez les moustiques, des moustiquaires imprégnées d'insecticides à double principe actif (MII) contre les moustiques résistants aux insecticides ont été développées. En 2019, des MII standard à base de alpha cyperméthrine, des MII de nouvelle génération de type PBO et des MII de nouvelle génération de type Interceptor® G2 ont été déployés respectivement dans les districts de Gaoua, Orodara et Banfora.

### Objectif principal de l'étude

Evaluer les facteurs qui pourraient influencer l'adoption et l'utilisation des MII.

### Méthodes

Les données anthropologiques ont été collectées dans les trois districts sanitaires de juillet à septembre 2019. Nous avons utilisé une combinaison d'entretiens approfondis (n=146), d'observations participantes (n=469) et de groupes de discussion (n=36). Les participants à l'étude étaient des mères d'enfants, des femmes enceintes, des chefs de famille et des leaders communautaires. Une analyse thématique a été réalisée. Tous les entretiens ont été transcrits et analysés à l'aide du logiciel NVIVO.

### Résultats

Les personnes interrogées pensent que les moustiques transmettent le paludisme. Cependant, des idées comme le soleil, la consommation de mangues, les sorties sous la pluie, la consommation d'aliments gras et la consommation excessive de sucre et d'huile ont également été identifiées comme des facteurs causant le paludisme. La meilleure protection contre les moustiques est la moustiquaire. Cependant, une mauvaise condition d'utilisation de la moustiquaire dans certains endroits limite l'optimisation de la protection contre les moustiques.

### Conclusion

Une sensibilisation à la cause première du paludisme et une meilleure utilisation des

moustiquaires pourraient contribuer à réduire la transmission du paludisme.

**Mots clés :** Perception communautaire, moustiquaire imprégnée, prévention du paludisme, Burkina Faso.

## STH-5-S1-COP-6

### Evaluation de l'efficacité thérapeutique de deux combinaisons à base d'artémisinine pour le traitement du paludisme simple chez les enfants au Burkina Faso

#### Auteurs

Adama Gansané<sup>1\*</sup>, Leah F. Moriarty<sup>2</sup>, Didier Ménard<sup>3</sup>, Isidore Yerbanga<sup>4</sup>, Esperance Ouedraogo<sup>1</sup>, Paul Sondo<sup>4</sup>, Rene Kinda<sup>1</sup>, Casimir Tarama<sup>1</sup>, Edwige Soulama<sup>1</sup>, Madou Tapsoba<sup>1</sup>, David Kangoye<sup>1</sup>, Cheick Said Compaore<sup>5</sup>, Ousmane Badolo<sup>6</sup>, Blami Dao<sup>6</sup>, Samuel Tchwenko<sup>2</sup>, **Siaka Debé<sup>1</sup>**, Halidou Tinto<sup>4</sup> and Innocent Valea<sup>4</sup>

#### Affiliations

<sup>1</sup>Centre National de Recherche Et de Formation Sur Le Paludisme, Ouagadougou, Burkina Faso. <sup>2</sup>Division of Parasitic Diseases and Malaria, Center for Global Health, Centers for Disease Control and Prevention, US President's Malaria Initiative, Atlanta, GA, USA. <sup>3</sup>Malaria Genetics and Resistance Unit, Department of Parasites and Insect Vectors, Institut Pasteur, Paris, France. <sup>4</sup>IRSS / Unité de Recherche Clinique de Nanoro, Nanoro, Burkina Faso. <sup>5</sup>Programme national de lutte contre le paludisme, Ouagadougou, Burkina Faso. <sup>6</sup>JHPIEGO/ Improving Malaria Care, Ouagadougou, Burkina Faso.

**Email du présentateur :** [sk.debe@gmail.com](mailto:sk.debe@gmail.com)

#### Introduction

Au regard des risques d'émergence de souches résistantes aux antipalustres, l'OMS recommande de conduire des études de surveillance de l'efficacité des Combinaisons Thérapeutiques à base d'artémisinine (CTA) couramment utilisées dans les pays d'endémie palustre. Elles servent à fournir des données probantes qui permettront d'alerter les autorités sanitaires sur un éventuel changement de directives de prise en charge du paludisme.

**Objectif principal :** Evaluer l'efficacité clinique et parasitologique de l'Artémether-luméfantrine et la Dihydroartémisinine chez les enfants de 6 à 59 mois au Burkina Faso.

#### Méthodologie

Il s'agit d'un essai clinique ouvert randomisé à deux bras conduit dans les districts sanitaires de Banfora, Nanoro et Gourcy de novembre 2017 à septembre 2018. Les participants ont reçu les traitements de l'étude sous supervision directe pendant 3 jours et ont été suivis pendant 28/42 jours à travers des visites aux sites de recherche. L'efficacité thérapeutique a été évaluée conformément aux dernières directrices de l'OMS. Les taux d'échec ont été calculés en utilisant un niveau de confiance de 95% et comparés au seuil OMS de 10%.

#### Résultats

Au total 720 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été inclus. Le taux d'échec au jour 28 corrigé par la PCR était pour l'artémether/luméfantrine de 9,4%[5,0-17,2], 24,9%[16,8-35,8] et 24,4%[17,0-34,2] respectivement à Niangoloko, Nanoro et Gourcy. Celui pour la Dihydroartémisinine-pipéraquline était de 0,9%[0,1-6,1], 2,7%[0,9-99,1] et 6,1%[3,0-12,4] respectivement à Niangoloko, Nanoro et Gourcy.

#### Discussion/Conclusion

Ces résultats montrent une baisse de l'efficacité de l'artémether/luméfantrine à Nanoro et Gourcy représentant les faciès centre et nord du paludisme au Burkina Faso. Cette tendance reste à être confirmée par des études similaires ultérieures et associant la détection des marqueurs de résistance du plasmodium et le dosage de la luméfantrine à J7.

**Mots clés :** Paludisme, *Plasmodium falciparum*, efficacité, Artémether-Luméfantrine, Dihydroartémisinine-pipéraquline.

## STH-5-S1-COP-7

### Impact des moustiquaires de nouvelle génération sur la prévalence du paludisme, un an après leur introduction au Burkina Faso

**Harouna Sore**<sup>1</sup>, Christelle Gogue<sup>2</sup>, Siaka Debe<sup>1</sup>, René N. Kinda<sup>1</sup>, Adama Ganou<sup>1</sup>, Casimir Tarama<sup>1</sup>, Gauthier Tougri<sup>3</sup>, N'Fale Sagnon<sup>1</sup>, Moussa W. Guelbeogo<sup>1</sup>, Molly Robertson<sup>4</sup>, Adama Gansané<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme, Ouagadougou, Burkina Faso,*

<sup>2</sup>*PATH, Washington, DC, United States,*

<sup>3</sup>*Programme National de Lutte contre le Paludisme, Ouagadougou, Burkina Faso,*

<sup>4</sup>*PATH, Seattle, WA, United States*

## Introduction

En réponse à la résistance au pyréthroïde, principal ingrédient actif d'imprégnation des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MILDA), de nouvelles MILDA à double principes actifs, Interceptor G2® (pyréthroïde+chlofénapyr) et pyréthroïde+PBO ont été déployées sous forme d'étude pilote en 2019 dans quatre pays africains dont le Burkina Faso. Ainsi, au Burkina, les districts sanitaires de Banfora, Orodara et Gaoua ont reçu respectivement les moustiquaires de type IG2, PBO et les moustiquaires standards.

Cette étude vise à évaluer l'efficacité de ces moustiquaires de nouvelle génération un an après leur introduction au Burkina Faso.

## Méthodologie

Il s'agit d'une étude quasi-expérimentale avant-après la distribution des MILDA de nouvelle génération à travers des enquêtes transversales au sein de 190 ménages par district, aléatoirement sélectionnés. La prévalence du paludisme chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, aléatoirement sélectionné, a été évaluée au cours de chaque enquête à l'aide des tests de diagnostic rapide du paludisme.

## Résultats

A l'enquête de base, l'utilisation des moustiquaires par les ménages était de 20,8% (18,6-23,1%), 67,7% (64,9-70,3%) et 78,8% (76,1-81,2%) respectivement à Gaoua, Banfora et Orodara. Ces proportions ont augmenté respectivement à 44,2% (40,9-47,5%), 90,4% (88,5-92,1%) et 84,8% (82,3-87,0%), une année après implémentation de l'étude. La prévalence du paludisme à Gaoua était la plus élevée avec 81,0% en 2019, mais celle-ci a diminué à 49,0% en 2020. De même, des diminutions significatives de la prévalence ont également été observées à Orodara (PBO) et Banfora (IG2) de 28,4% à 3,6% et 39,6% à 18,4%, respectivement.

## Conclusion

Les résultats préliminaires ont montré une amélioration de l'utilisation des MILDA et une

diminution de la prévalence du paludisme chez les enfants un an après la campagne de distribution des moustiquaires dans les trois districts.

**Mots clés :** MILDA, IG2, PBO, Prévalence du paludisme, Burkina Faso

## STH-5-S1-COP-8

### Prévalence du paludisme et couverture des interventions chez les femmes enceintes dans trois districts sanitaires du Burkina Faso : résultats intermédiaires

**Réné Kinda**<sup>1</sup>, Christelle Gogue<sup>2</sup>, Siaka Debe<sup>1</sup>, Adama Ganou<sup>1</sup>, Sonia Ilboudo<sup>1</sup>, Aladari Sagnon<sup>1</sup>, Casimir Tarama<sup>1</sup>, Mafama Siribie<sup>1</sup>, Gauthier Tougri<sup>3</sup>, N'Fale Sagnon<sup>1</sup>, Moussa W. Guelbeogo<sup>1</sup>, Julie R. Gutman<sup>4</sup>, Molly Robertson<sup>5</sup>, Adama Gansané<sup>1</sup>

## Affiliations

<sup>1</sup>*Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme, Ouagadougou (Burkina Faso);*

<sup>2</sup>*PATH (Washington, DC, United States);*

<sup>3</sup>*Programme National de Lutte contre le Paludisme, Ouagadougou (Burkina Faso);*

<sup>4</sup>*Malaria Branch, Division of Parasitic Diseases and Malaria, Center for Global Health, U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Atlanta, GA, United States);*

<sup>5</sup>*PATH (Seattle, WA, United States)*

## Introduction

Les données sur la prévalence du paludisme et la couverture des interventions recueillies lors des visites de soins prénatals peuvent constituer une source facilement accessible, fiable et représentative pour suivre les tendances des indicateurs. L'objectif de l'étude est d'évaluer la possibilité d'utiliser les femmes enceintes comme une population sentinelle pour la collecte des indicateurs du paludisme.

## Méthodologie

Toutes les femmes enceintes reçues pour la première visite de soins prénatals dans 21 centres de santé sélectionnés au hasard dans les districts sanitaires de Banfora, Gaoua et Orodara et qui ont consenti, ont été soumises à un questionnaire standardisé et ont été testées pour l'infection du paludisme à l'aide de tests de diagnostic rapide.

## Résultats

Un total de 4 587 femmes enceintes a été recruté entre septembre 2020 et mars 2021. Parmi ces femmes, 75,6% ont déclaré posséder une moustiquaire. Parmi ces dernières, la proportion de femmes déclarant avoir dormi sous une

moustiquaire la nuit précédente était de 80% (77%-82%) à Banfora, 59% (56%-61%) à Gaoua et 77% (75%-79%) à Orodara. La prévalence globale de l'infection du paludisme à la première visite de soins prénatals était de 28 % (25 %-29 %) à Banfora (25%-29%) à Banfora, 39% (36%-41%) à Gaoua et 19% (17%-21%) à Orodara avec des variabilités mensuelles.

### Conclusion

La prévalence mensuelle du paludisme chez les femmes enceintes semble suivre la tendance saisonnière attendue du paludisme, et est comparable à la prévalence observée chez les enfants de moins de 5 ans pendant des enquêtes transversales contemporaines. Les tendances relatives à la possession et à l'utilisation des moustiquaires sont également similaires à celles des enquêtes transversales. Une analyse plus approfondie est en cours pour déterminer si cette population fournit une estimation représentative des tendances des indicateurs du paludisme.

**Mots clés :** Paludisme, femme enceinte, prévalence, intervention, indicateur

## STH-5-S1-COP-9

### Réponses humores de *Plasmodium falciparum* chez des enfants et adultes semi-immuns vivant à Saponé au Burkina Faso

**Nicolas Ouédraogo**, Guillaume Sylvestre Sanou, Mireille Ouédraogo, Issiaka Soulama et Alfred B. Tiono

Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme, 01 BP 2208, Ouagadougou, Burkina Faso

**Introduction** Les individus vivant dans les zones de transmission du paludisme acquièrent progressivement une immunité contre *Plasmodium falciparum*. Les conditions dans lesquelles cette immunité est acquise ne sont pas bien connues.

**Objectif principal :** l'objectif principal cette étude est d'évaluer l'immunité humorale anti palustre chez des enfants et des adultes burkinabè naturellement exposés à une transmission élevée et saisonnière du paludisme.

**Méthodes :** L'étude a été menée dans la région de Saponé au Burkina Faso dans la période de mai à juin 2013 et a recruté 197 enfants et adultes (dans trois catégories d'âge à savoir 2 à 5 ans, 5 à 15 ans et 15 à 75 ans) avec un paludisme asymptomatique. Des échantillons de sérum ont été collectés pour mesurer les

concentrations d'anticorps contre les antigènes pré-érythrocytaires (CSP et LSA), les antigènes des stades sanguins (AMA1 et MSP1) et l'antigène sexuel (230A) de *P. falciparum* par la technique ELISA.

**Résultats :** 47 volontaires âgés de 2 à 5 ans, 100 volontaires âgés de 5 à 15 ans et 50 volontaires âgés de 15 à 75 ans ont été recrutés dans cette étude. Nous avons comparé les réponses humores aux antigènes de *Plasmodium falciparum* entre ces groupes d'âge. Le niveau d'anticorps diffère selon les groupes d'âge, et augmente progressivement avec l'âge. Pour les cinq antigènes testés, la production d'anticorps contre AMA1 s'est avérée élevée, suivie par les anticorps contre 230A, CSP, LSA1 et MSP1.

**Conclusions :** Des différences notables ont été observées dans les aspects qualitatifs des réponses des anticorps humains contre ces antigènes. Ces données devraient aider à concevoir et à guider d'autres études d'immuno-surveillance de ces antigènes qui sont des candidats vaccins contre le paludisme.

**Mots clés :** *Plasmodium falciparum*, immunité humorale, antigènes, anticorps, Burkina Faso

## STH-5-S1-COP-10

### Évaluation de l'effet de la CPS sur la prévalence du paludisme et la diversité génétique de *Plasmodium falciparum* à Saponé.

**Nikiema seni**, Sermé samuel, Sombié Salif, Soulama Issiaka

**Introduction :** le paludisme est un problème de santé publique majeur au Burkina Faso. La mise en œuvre du CPS au Burkina a commencé avec l'adoption par le pays du CPS en 2013 comme élément clé de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme. Quatre doses mensuelles de la combinaison (SP + AQ) sont administrées aux enfants âgés de 3 à 59 mois de juillet à octobre.

**Objectif :** La présente étude a été initiée pour évaluer la prévalence de l'infection palustre à *Plasmodium falciparum* et la diversité des souches parasitaires dans une population rurale à Saponé au Burkina Faso.

**Méthodologie :** Les échantillons de sang ont été collectés chez les enfants à partir du doigt et conduit au CNRFP pour la confection de gouttes épaisses et frottis sanguin, de spot sanguin respectivement pour la détermination de la parasitemie et l'extraction de l'ADN

parasitaire permettant la détection des espèces plasmodiales et les polymorphismes de *msp-1*, *msp-2*.

**Résultats :** Les résultats de l'étude ont montré que la prévalence de l'infection palustre était en moyenne de 17,43% et une forte diversité génétique a été trouvée.

**Conclusion :** Les résultats de cette étude ont montré une légère augmentation des cas d'infection palustre à *Plasmodium falciparum* au cours de la CPS de juillet à octobre 2020. Cette augmentation malgré l'administration de la CPS indique une diminution de l'efficacité de cette stratégie. Cette baisse de l'efficacité pourrait s'expliquer par la résistance du parasite aux antipaludiques et la diminution de l'immunité chez les enfants soumis à la CPS selon certains travaux antérieurs. Cependant on note une diminution de la prévalence du paludisme chez les enfants cibles par rapports aux données antérieures.

**Mots clés :** CPS, SP AQ, Saponé, *Plasmodium falciparum*, prévalence

## STH-5-S1-COP-11

**Hétérogénéité de la prévalence des marqueurs moléculaires associés à la résistance de *Plasmodium falciparum* aux antipaludiques dans les trois faciès épidémiologiques du paludisme au Burkina Faso**

**Casimire W. Tarama**<sup>1</sup>, Isidore Yerbanga<sup>2</sup>, Madou Tapsoba<sup>1</sup>, Henri S Somé<sup>1</sup>, Espérance Ouedraogo<sup>1</sup>, Adama Ganou<sup>1</sup>, René Kinda<sup>1</sup>, Harouna Sore<sup>1</sup>, Guillaume Sanou<sup>1</sup>, Edwige D. Soulama<sup>1</sup>, Cheick S. Compaore<sup>3</sup>, Moussa Guelbeogo<sup>1</sup>, N'falé Sagnon<sup>1</sup>, Ousmane Badolo<sup>4</sup>, Blami Dao<sup>4</sup>, Halidou Tinto<sup>2</sup>, Didier Menard<sup>5</sup> and Adama Gansané<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Centre National de Recherche et de Formation sur le paludisme, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>2</sup> IRSS / Unité de recherche Clinique de Nanoro, Burkina Faso

<sup>3</sup> Programme National de Lutte contre le Paludisme, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>4</sup> JHPIEGO, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>5</sup> Institut Pasteur de Paris, France

**Introduction :** Les CTA sont utilisées pour le traitement du paludisme simple. Cependant leur efficacité peut être compromise par l'émergence de résistance de *P. falciparum* à l'artémisinine ou aux molécules partenaires. Nous avons

évalué la prévalence de marqueurs moléculaires (*K13*, *Pfmdr1*, *Pfpm2*) impliqués dans la résistance de *P. falciparum* à l'artémisinine, lumefantrine et piperaquine dans trois districts sanitaires situés dans différents faciès de transmission du paludisme au Burkina Faso.

**Méthodologie :** Le prélèvement de sang sur papier WATMAN a été collecté chez les enfants de 6 à 59 mois présentant un paludisme simple. L'extraction de l'ADN parasitaire a été réalisée selon la procédure classique d'extraction du kit Qiagen. L'ADN parasitaire amplifié par PCR a permis détecter la présence de mutations au sein du gène *K13* ou du mutant 86Y sur le gène *pfmdr-1et* de déterminer le nombre de copies des gènes *Pfplamepsin-2* et *Pfmdr-1*.

**Résultats :** Sur un total de 367 échantillons analysés, 95,9% n'ont pas présenté de mutation du gène *K13*. La mutation 86Y sur le gène *Pfmdr-1* était faible (4,8%) et comparable dans les 3 sites. Cependant l'amplification du gène *Pfmdr-1*, a été estimée à 23% (85/364) pour les trois sites variant selon l'axe Sud-Nord du Burkina Faso (Gourcy 30,3% ( $p=0,007$ ), à Niangoloko 15% et de 23,3% à Nanoro). En outre, l'amplification du nombre de copie du gène *Pfpm2* était également très élevée avec 33,2% (121/364) pour les trois sites, variant de 21,5%, 30,3% et 45,2% pour Niangoloko, Gourcy et Nanoro respectivement.

**Conclusion :** Ces résultats montrent une distribution très hétérogène des marqueurs moléculaires de la résistance de *P. falciparum* aux molécules partenaires des ACTs au Burkina Faso selon un axe Sud-Nord. La nécessité d'évaluer l'impact de ces prévalences élevées sur l'efficacité des traitements avec les CTAs dans cette zone du pays dans le futur s'impose.

**Mots clés :** Paludisme- marqueurs moléculaire de résistance

## STH-5-S1-COL-12

**Le paludisme chez les enfants de quatre districts sanitaires du Burkina Faso en contexte de chimio-prévention saisonnière.**

**Mamoudou DIALLO**<sup>1&2</sup>, Désiré Lucien DAHOUROU<sup>3</sup>, Cheick Saïd Ibrahim COMPAORE<sup>4</sup>, Ter Tiero Elias Dah<sup>5</sup>, Boukary Ouédraogo<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Unité de Formation et de Recherche en Sciences De la Santé, Master Santé Publique ; Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.

<sup>2</sup>Terre des hommes - Lausanne, Délégation du Burkina Faso, Programme santé, Burkina Faso.

<sup>3</sup>Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Département de Biomédical/Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso.

<sup>4</sup>Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), Ouagadougou, Burkina Faso.

<sup>5</sup>Université de Ouahigouya, Département de Santé Publique, Ouahigouya, Burkina Faso.

<sup>6</sup>Ministère de la Santé, Direction des Systèmes d'information en santé, Ouagadougou, Burkina Faso.

**Introduction :** Au Burkina Faso où le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité chez les enfants, peu de données existent sur sa prévalence en contexte de chimio-prévention saisonnière (CPS). Notre étude avait pour objectif de documenter l'effet de la campagne CPS 2018 sur le paludisme simple et grave.

**Méthodes :** Une étude transversale a été conduite entre le 1<sup>er</sup> et le 30 novembre 2018 dans les districts sanitaires (DS) de Titao, Yako, Toma et Solenzo. Les enfants ayant un âge compris entre 3 et 59 mois, venus en consultation curative dans l'un des CSPS des quatre DS ont été inclus. Les données sociodémographiques, cliniques et biologiques ont été recueillies à l'aide du registre électronique de consultation (REC). Les facteurs associés au paludisme simple et grave ont été recherchés par une régression logistique multinomiale.

**Résultats :** Au total, 33 822 enfants ont été inclus dans l'étude. L'âge médian était de 24 mois (intervalle interquartile [IIQ] : 14-37 mois). La proportion d'enfants ayant bénéficié de la CPS de la CPS était de 90,5% au premier passage, 90,8% au deuxième passage, 90,8% au troisième passage et 88,3% au quatrième. Les prévalences des paludismes simple et graves étaient de 71,4% et 2,3%. En analyse multivariée, le fait de ne pas avoir bénéficié du quatrième passage de la CPS était significativement associée (Odds ratio ajusté [ORa] : 1,75 ; intervalle de confiance à 95% [IC95%] : 1,56-1,96) au paludisme simple. En outre, il était associé au paludisme grave (ORa 2,5 ; IC95% : 1,81-3,33), de même que la malnutrition (ORa 2,43 ; IC95% : 1,96-3,00).

**Conclusion :** La prévalence du paludisme reste élevée malgré la mise en œuvre de la CPS. La mise en œuvre d'une combinaison d'interventions est nécessaire pour un meilleur contrôle du paludisme au Burkina Faso.

**Mots-clés :** Paludisme, chimio-prévention saisonnier, facteurs associés, Burkina Faso

## Sous-thème 5 Session 2

### STH-5-S2-COP-13

#### Evaluation de l'adhésion du personnel de soins à la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfance (PCIME) dans le contexte de Gratuité des soins au Burkina Faso : Etude PAASME

Hervé B.N. KPODA<sup>1\*</sup>, **Satouro Arsène SOME**<sup>1</sup>, Manituo Aymar Serge SOMDA<sup>1,3</sup>, Mimbouyé YARA<sup>2</sup>, Bernard Eric Agodio DABONE<sup>1</sup>, Patrick ILBOUDO<sup>8</sup>, Richard BAKYONO<sup>2</sup>, Soumeiya OUANGRAOUA<sup>1</sup>, Ali SIE<sup>4</sup>, Elie KABRÉ<sup>5</sup>, Clément MEDA<sup>9</sup>, Emmanuelle SEMPORÉ<sup>1</sup>, Seydou YARO<sup>1\*\*</sup>, Imelda SIMBORO<sup>2</sup>, Leticia SAKANA<sup>1</sup>, Alain HIEN<sup>1</sup>, Herman BAZIE<sup>2</sup>, Hermann BADOLO<sup>2</sup>, Bernard ILBOUDO<sup>1</sup>, Souleymane SANOU<sup>1</sup>, Nicolas MEDA<sup>6</sup>, Hervé HIEN<sup>1,7</sup>

#### Affiliations

<sup>1</sup> Centre MURAZ de Bobo-Dioulasso, Institut National de Santé Publique, Burkina Faso

<sup>2</sup> Observatoire National de la santé de la population, Institut National de Santé Publique, Burkina Faso

<sup>3</sup> UFR Sciences et Technique / Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

<sup>4</sup> Centre de Recherche en Santé de Nouna, Institut National de Santé Publique, Burkina Faso

<sup>5</sup> Laboratoire National de Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>6</sup> UFR Sciences de la santé/Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>7</sup> Institut de recherche en science de la santé (IRSS) /CNRST, Ouagadougou ; Burkina Faso

<sup>8</sup> African Population and Research Center, Nairobi, Kenya

<sup>9</sup> Institut National en Science de la Santé UFR Sciences et Technique / Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

\* Auteurs correspondants :

Hervé B.N. KPODA, BP: 390, Tel: +22670304088, email: [kpodaherve@yahoo.fr](mailto:kpodaherve@yahoo.fr)

Satouro Arsene SOME, BP: 390, Tel: +22670304088,

email: [satourosome2011@gmail.com](mailto:satourosome2011@gmail.com)

\*\*In memorium

**Introduction :** Pour réduire la mortalité infantile, les soins offerts aux enfants de moins de 5 ans sont basés sur les principes de la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfance (PCIME), un instrument qui avait des bonnes perspectives pour améliorer l'offre de soins. Ensuite, depuis 2016, le Burkina Faso a rendu gratuits les soins et les services des enfants de moins de 5 ans. Cette politique qui facilite l'accès aux soins des enfants de moins de 5 ans est documentée sur la manière d'influencer l'adhésion du personnel de santé à la stratégie PCIME.

**Méthodes :** Nous avons conduit une étude transversale de Juillet 2020 à mars 2021 avec une période de collecte des données de 2 mois. L'étude a été réalisée dans 40 CSDS et dans 2 CMA dans la région sanitaire des Hauts-Bassins qui mettaient en œuvre la politique de gratuité. L'étude a concerné 419 enfants de moins de 5 ans recrutés de façon consécutive dans les formations sanitaires inclus dans l'étude. Le recueil des données s'est fait à travers des observations directes des consultations. L'outil utilisé était une checklist avec pour référence la PCIME.

**Résultats :** Le score d'adhésion globale des agents de santé à la PCIME était de 57,8% (42,6% – 73,0%). Le score d'adhésion à la stratégie d'identification de l'ensemble des signes de danger chez les enfants de moins de 5 ans a été de 71,9% (58,7% - 85,1%). Le score moyen de l'adhésion à la PCIME chez les garçons était significativement supérieur à celui obtenu chez les filles ( $p=0.000$ ). Le score moyen de l'adhésion à la PCIME chez les enfants vus par les accoucheuses était significativement supérieur à ceux obtenus chez les enfants consultés par toutes les autres catégories professionnelles ( $p=0,008$ ).

**Conclusion :** Le score d'adhésion globale des agents de santé à la PCIME dans le contexte de la gratuité des soins est acceptable et supérieur aux résultats antérieurs à la politique de gratuité. Cependant, des efforts demeurent dans la sensibilisation, la formation et l'accompagnement du personnel de santé en milieu urbain où le score d'adhésion à la PCIME est faible.

**Mots clés :** Adhésion ; PCIME ; qualité; gratuité de soins; Burkina Faso

## STH-5-S2-COP-14

### Facteurs associés aux abandons ou aux changements de méthodes contraceptives modernes au Burkina Faso.

**Smaïla Ouédraogo<sup>1</sup>**, Adama Ouattara<sup>2</sup>, Maurice Sarigda<sup>3</sup>, Parfaite Gaëlle NZIEFFE BOUANGA<sup>2</sup>, Charlemagne Ouédraogo<sup>2</sup>

**Affiliations :** <sup>1</sup>Département de santé publique, UFR/SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ; <sup>2</sup>Département de gynécologie-obstétricale, UFR/SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ; <sup>3</sup>Département de sociologie, UFR/SH, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso.

**Auteur correspondant :** Dr Smaïla Ouédraogo, [smaïla11@yahoo.fr](mailto:smaïla11@yahoo.fr), Tel. +226 70 20 86 09

**Introduction :** Au Burkina Faso, chaque année, un tiers des grossesses ne sont pas souhaitées témoignent d'un taux élevé des besoins non couverts en planification familiale. Parmi ceux qui utilisent une méthode contraceptive moderne, beaucoup abandonnent ou changent de méthodes. Nous avons déterminé les facteurs associés au changement et/ou abandon de méthode contraceptives au Burkina Faso.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale analytique menée au cours de la période allant du 06 juillet au 28 août 2015 au CSDS de Wemtenga. A cet effet, un questionnaire a été administré aux utilisatrices afin de recueillir leurs points de vue et leur pratique des différentes méthodes contraceptives modernes.

**Résultats :** Au total, 391 clientes ont été incluses. L'âge moyen des femmes qui ont changé ou abandonné une méthode est de  $34,5 \pm 7,9$  ans contre  $31,4 \pm 7,4$  pour celles qui n'ont ni abandonné ni changé leur contraception. La source d'information de ces méthodes est le centre de santé qui couvre également 93,6% des femmes interrogées. Les abandons et les changements de méthodes ont concerné 23,5%. Les utilisatrices ont exprimé leurs inquiétudes quant aux effets secondaires des différentes méthodes contraceptives modernes qui représentent 75%. Les femmes ayant le niveau secondaire et plus avaient 2,4 fois plus de risque d'abandonner ou de changer de méthodes contraceptives par rapport à celles qui n'étaient pas instruites ( $OR=2,4$  ;  $IC95\%$  [1,1-5,2]) ; comparées aux multigestes, les primigestes courraient moins de risque d'abandon ou de changement de méthode ( $OR=0,4$  ;  $IC95\%$  [0,1-0,8]).

**Conclusion :** Le taux d'abandon ou de changement de méthodes contraceptives est élevé. Il faut donc renforcer les activités de counseling en faveur de la contraception, surtout en direction des nouvelles utilisatrices.

**Mots clés :** abandon, changement, méthode contraception moderne, Burkina Faso.

## STH-5-S2-COP-15

### Etude des déterminants des accouchements dans le service d'obstétrique du Centre Hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo.

**Smaïla Ouédraogo**<sup>1</sup>, Adama Ouattara<sup>2</sup>, Maurice Sarigda<sup>3</sup>, Zoéwendtalé Cyrille Compaoré<sup>2</sup>, Charlemagne Ouédraogo<sup>2</sup>

**Affiliations :** <sup>1</sup>Département de santé publique, UFR/SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ; <sup>2</sup>Département de gynécologie-obstétricale, UFR/SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ; <sup>3</sup>Département de sociologie, UFR/SH, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

**Auteur correspondant :** Dr Smaïla Ouédraogo, [smaïla11@yahoo.fr](mailto:smaïla11@yahoo.fr), Tel. +226 70 20 86 09

**Introduction :** Le non-respect de la pyramide pour le recours aux soins est récurrent au Burkina Faso, entraînant une surcharge importante des centres de niveau tertiaire comme le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO). Nous avons étudié les déterminants des admissions directes de patientes dans le service d'obstétrique du CHU-YO pour accouchement.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une enquête transversale analytique réalisée entre le 20 janvier et le 05 avril 2015 sur des clientes reçues pour accouchement à la maternité du CHU-YO. Les paramètres pris en compte étaient le mode d'admission, les données sociodémographiques, les antécédents gynéco-obstétriques, les échanges au cours des consultations prénatales, les connaissances sur la pyramide sanitaire, l'accessibilité géographique et financière des centres de santé périphériques et les motifs du choix direct de la maternité du CHU-YO. Pour identifier les déterminants du recours direct au CHU-YO, nous avons effectué une régression logistique multivariée pas à pas descendante au seuil de significativité de 0.05.

**Résultats :** La proportion des entrées directes était de 38,6% et 71,1% de ces femmes n'avaient pas de motifs pertinents qui justifiaient leur choix direct de la maternité du

CHU-YO. Le lieu de résidence situé à plus de 10 km du CHU-YO (OR = 2,5 ; IC<sub>95%</sub> [1,49-4,18]), le faible niveau d'instruction du conjoint (OR = 0,5 ; IC<sub>95%</sub> [0,23-0,99]) et une absence d'antécédent d'accouchement au CHU-YO (OR = 0,13 ; IC<sub>95%</sub> [0,06-0,31]) sont significativement associés aux entrées directes au CHU-YO.

**Conclusion :** Une grande partie des patientes entre directement dans le service d'obstétrique sans y être référée. Une politique de communication à l'endroit de la population axée sur la pyramide sanitaire et sur les intérêts liés aux recours des centres de santé conformément à l'organisation du système de soins s'avère très importante et permettrait de réduire considérablement le nombre d'entrées directes de la maternité du CHU-YO.

**Mots clés :** entrée directe, accouchement au CHU-YO, déterminants, Burkina Faso.

## STH-5-S2-COP-16

### Déterminants de la prise de décision des césariennes en urgence : cas d'étude à l'hôpital de district de Dafra, à Bobo Dioulasso, Burkina Faso

**Méda ZC**<sup>1,2</sup>, Koinda A<sup>1,3</sup>, Thiombiano SA<sup>3,4</sup>, Ilboudo B<sup>5</sup>, Hien MH<sup>5,6</sup>, Sombié I<sup>2,7</sup>

1 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso.

2 Institut supérieur des sciences de la santé (INSS), Université Nazi Boni (UNB), Bobo Dioulasso, Burkina Faso.

3 Institut de formation et de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation (IFRISSE), Ouagadougou, Burkina Faso

4 Direction régionale de l'Ecole nationale de la santé publique (ENSP) de Bobo Dioulasso, Burkina Faso.

5 Institut national de santé publique (INSP), Burkina Faso.

6 Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS), Ouagadougou, Burkina Faso.

7 Organisation ouest africaine de la santé (OOAS), Bobo Dioulasso, Burkina Faso.

**Introduction :** Devant la morbi-mortalité maternelle et néonatale relative aux césariennes en urgence, la quasi-totalité des études se sont focalisées sur la réduction des délais décision-naissance (DDN) sans s'intéresser aux facteurs influençant la prise de décision de césarienne en urgence (PDCU).

**Objectif :** La présente a déterminé l'influence des prédispositions cognitives des acteurs, des interactions du personnel et de l'environnement de travail sur la PDCU.

**Méthode :** Il s'est agi d'une étude transversale exploratoire sous forme d'étude de cas unique à trois unités d'analyse à l'hôpital du district sanitaire de Dafra, Burkina Faso, avec un échantillon de 15 participants dont 2 gynécologues, 1 médecin et 12 sages-femmes/maïeuticiens.

**Résultats :** la PDCU est négativement influencée par le style décisionnel des décideurs qui est lent, les difficultés dans la communication, l'insuffisance de coopération, les longs quarts de travail, l'insuffisance de coordination des équipes, la faible efficacité des mécanismes de gestion des conflits, les insuffisances dans l'organisation, le cadre physique inadapté et l'inadéquation des ressources. Cette étude a mis en exergue, outre les longs DDN (96,26 minutes), la présence de délais non négligeables imputables à la PDCU (28,49 minutes) qui aggravent le retard à la césarienne.

**Conclusion :** Une amélioration de la PDCU, entraînant une détection précoce des complications obstétricales suivie de décisions de césarienne sans délai, constitue un important facteur de réduction de la morbi-mortalité maternelle et néonatale des césariennes en urgence.

**Mots clés :** décès maternels, gestion, soins obstétricaux.

## STH-5-S2-COP-17

**Urgences dans le service de maternité du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO : mode d'entrée et qualité de la prise en charge.**

**Smaïla Ouédraogo<sup>1</sup>,** Adama Ouattara<sup>2</sup>, Maurice Sarigda<sup>3</sup>, Oumarou Nabi<sup>2</sup>, Jean Lankoandé<sup>2</sup>

**Affiliations :** <sup>1</sup>Département de santé publique, UFR/SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ; <sup>2</sup>Département de gynécologie-obstétricale, UFR/SDS, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ; <sup>3</sup>Département de sociologie, UFR/SH, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso.

**Auteur correspondant :** Dr Smaïla Ouédraogo, [smaïla11@yahoo.fr](mailto:smaïla11@yahoo.fr), Tel. +226 70 20 86 09

**Introduction :** l'une des cibles de la stratégie des trois retards inclut la qualité des références et de la prise en charge de la cliente au niveau du centre de santé d'accueil. A travers une analyse des admissions des patientes reçues en urgence dans le service de gynécologie et d'obstétrique, nous avons apprécié les modes

d'entrée et la qualité de la prise en charge des urgences gynéco-obstétricales dans le service de la maternité du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO).

**Méthodologie :** Il s'est agi d'une étude transversale réalisée entre le 16 janvier et le 15 avril 2014 sur toutes les femmes admises en urgence dans le service de la maternité du CHU-YO. Nous avons analysé les données sur les motifs et les modalités d'admission, les éléments liés à la qualité de la prise en charge et les opinions des patientes sur leur séjour. Les moyennes et les écart-types ont été calculées pour les données quantitatives et des proportions ont été déterminées pour les variables qualitatives.

**Résultats :** Les données de 1025 clientes ont été analysées. La proportion des entrées directes était de 22,2% ; 73,7% de références étaient non pertinentes. La qualité de la prise en charge y est globalement insuffisante. Quarante-cinq virgule un pour cent, 18,7%, 27,4%, 6% et 2,8% des patientes ont été prises en charge respectivement avant dans les 5, entre 5 et 10, entre 10 et 30, entre 30 et 60 et plus de 60 minutes suivant leurs admissions. Les modalités d'attente des patientes étaient souvent inappropriées, 34,5% d'entre elles étaient sur un pagne à même le sol et 18,3% étaient debout dans la salle de consultation. Presqu'une patiente sur 5 (22,4%) a été hospitalisée dans le couloir dont 7,3% sur des nattes et 5,0% sur des pagnes. Plus de la moitié (54,8%) des patientes ont déclaré être insatisfaites de leur prise en charge.

**Conclusion :** L'amélioration de la qualité de la prise en charge dans le service gynéco-obstétricales du CHU-YO passe par la maîtrise du flux des patientes qui y accèdent, le renforcement du plateau technique et de la capacité d'accueil des salles d'urgence et d'hospitalisation. Une politique de communication pour une meilleure connaissance de la pyramide sanitaire peut contribuer à réduire l'engorgement du service d'obstétrique et y améliorer ainsi la qualité de l'offre de service.

**Mots clés :** qualité, admissions, urgences, références, gynéco-obstétricales, CHUYO, BurkinaFaso.

## STH-5-S2-COP-18

**Fréquence et facteurs liés au décès maternels lors des ruptures utérines au département de gynécologie, d'obstétrique et de médecine de**

## la reproduction du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo Dioulasso.

**Yaméogo B**; Somé Der A; Bonkougou H; Dembélé A; Ouattara S; Bambara M.

Mail : [barnayam@yahoo.fr](mailto:barnayam@yahoo.fr)

**Objectif :** étudier les facteurs associés aux décès maternels lors des ruptures utérines dans le département de gynécologie, d'obstétrique et de médecine de la reproduction du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020.

**Méthode :** il s'est agi d'une étude transversale à visée analytique qui s'est déroulée du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. Ont été incluses dans l'étude les gestantes admises dans le service d'obstétrique du département de gynécologie-obstétrique et de médecine de la reproduction (DGOMR) porteuses d'une grossesse au terme de 28 semaines d'aménorrhée ou plus et ayant présenté une rupture utérine. Le test statistique utilisé était celui de de khi carré. Les résultats étaient statistiquement significatifs pour  $p < 0,05$ .

**Résultats :** la fréquence des ruptures utérines était de 0,93%, l'âge moyen des patientes était de 31,47 ans avec les extrêmes de 20 et 45 ans. Le taux de létalité maternel était de 12,73% soit 7 décès sur 55 cas de rupture utérine. Les facteurs associés à la survenue de décès maternel lors de la rupture utérine étaient le mode d'admission par référence ( $p = 0,033$ ), l'antibiothérapie en post opératoire ( $p = 0,001$ ), le geste chirurgical ( $p = 0,005$ ), la distance parcourue ( $p = 0,046$ ) et la transfusion de CGR ( $p = 0,014$ ).

**Conclusion :** la rupture utérine demeure une pathologie fréquente dans le département de Gynécologie-Obstétrique et de médecine de la reproduction du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo Dioulasso avec une létalité non négligeable. La prise en compte des facteurs de risques, dans le cadre d'une réorganisation de la disponibilité de l'offre et de la dispensation des soins contribueront à réduire les décès maternels liés à cette pathologie.

**Mots-clés :** rupture utérine, facteurs associés, décès maternel.

## STH-5-S2-COP-19

### Déclarations et pratiques des mères en matière d'allaitement exclusif en milieu rural au Burkina Faso

**Abdoulaye Hama Diallo**<sup>1,2</sup>, Theodosia Adom<sup>3</sup>, Maimouna Bamouni<sup>1</sup>, Souleymane Ouédraogo<sup>1</sup>, Amariane Ouattara<sup>1</sup>, Simon Cousens<sup>4</sup>, Jenny Cresswell<sup>4</sup>, Sophie Sarrasat<sup>4</sup> et Veronique Filippi<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Centre MURAZ, Ministère de la santé, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso; <sup>2</sup>Dpt de Santé Publique (DSP), UFR-SDS, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso; <sup>3</sup>Nutrition Unit, Ghana Atomic Energy Commission, Ghana; <sup>4</sup>London School of Hygiene and Tropical Medicine, United Kingdom

Email : [hamadial@yahoo.fr](mailto:hamadial@yahoo.fr)

### Introduction :

L'allaitement maternel exclusif (AME) est le principal mode d'alimentation recommandé pour les nourrissons de moins de 6 mois. La mesure du taux d'AME dans les enquêtes nutritionnelles se fait essentiellement à partir des déclarations des mères. Nous avons évalué l'amplitude de la différence entre taux déclarés et pratiqués d'AME en milieu rural au Burkina Faso.

### Objectif principal :

Comparer les taux d'AME obtenus à partir des déclarations de mères à ceux obtenus à partir d'une technique de laboratoire plus objective.

### Méthodes :

Une enquête communautaire transversale a été conduite dans 12 villages de la boucle du Mouhoun, Burkina Faso. Les couples mère-enfants éligibles pour l'étude ont été aléatoirement sélectionnés et suivis pendant 2 semaines avec une collecte de données anthropométriques, cliniques et biologiques. L'enquête nutritionnelle a été répétée à J0 et J14 avec le même questionnaire administré à la mère pour mesurer les taux déclarés d'AME. L'enrichissement au deutérium pour la mesure de l'eau provenant d'autres sources que le lait maternel a été évalué avec un spectrophotomètre de Fourier. Les taux d'AME ont été estimés et comparés suivant les 2 méthodes.

### Résultats :

Au total 153 couples mères-enfants ont été inclus et suivis jusqu'à J14. L'analyse a révélé que le taux déclaré d'AME était de 60,8% (IC à 95% : 43%-76%) dans ce groupe alors que le taux pratiqué (à partir du deutérium) était lui de 32,7% (IC à 95% : 23%-43%),  $p < 0,005$ . De

plus l'enquête ayant été menée dans le contexte d'une intervention, a montré que les taux déclarés d'AME étaient plus élevés dans le bras interventionnel (76%) comparé au bras témoin (45%),  $p=0,02$ .

#### **Conclusion :**

Il y'a une surestimation des taux d'AME déclarés par les mères en milieu rural burkinabè et il faudrait s'interroger sur l'efficacité de ce seul critère.

**Mots-clés :** Allaitement exclusif-taux déclarés-deutérium-milieu rural-Burkina Faso

### **STH-5-S2-COP-20**

#### **Déterminants de l'utilisation des méthodes contraceptives chez les étudiantes de l'Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso**

**Armel Emmanuel SOGO<sup>1</sup>**, Désiré Lucien DAHOUROU<sup>2</sup>, Ter Tiero Elias DAH<sup>3</sup>, Abou COULIBALY<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

<sup>2</sup>Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>3</sup>Université de Ouahigouya, Burkina Faso

Email : [sogoarmel@gmail.com](mailto:sogoarmel@gmail.com)

**Introduction :** L'usage de méthodes contraceptives est un moyen efficace de lutte contre les grossesses non désirées. Cependant au Burkina Faso, peu de données existent sur son utilisation. Nous avons documenté la prévalence et les déterminants de l'utilisation des méthodes contraceptives chez les étudiantes de l'Université Joseph Ki-Zerbo en 2021.

**Méthodes :** Nous avons conduit du 15 mai au 31 juillet 2021 une étude transversale à l'Université Joseph Ki-Zerbo. Les étudiantes âgées de 17-25 ans, rapportant au moins un rapport sexuel vaginal au cours des six derniers mois étaient incluses dans l'étude. Un auto-questionnaire permettant de recueillir les données socio-démographiques et comportementales leur était proposé. Les facteurs associés à l'utilisation de méthodes contraceptives ont été identifiés à l'aide d'une régression logistique.

**Résultats :** Au total, 394 étudiantes ont été incluses dans l'étude. L'âge moyen était de 21 ans (écart-type : 1,7 ans). La prévalence contraceptive moderne était de 47,5%. Les

étudiantes âgées de 18-21 ans utilisaient plus souvent les méthodes contraceptives que celles âgées de moins de 18 ans (Odds ratio ajusté [ORa] : 10,91 ; intervalle de confiance à 95% [IC95%] : 1,12-106,43). En outre, l'utilisation de méthodes contraceptives était significativement associée au fait de s'informer régulièrement sur la contraception par les messages vocaux ou SMS (ORa : 7,26 ; IC95% : 2,11-25,00), les réseaux sociaux (ORa : 3,87 ; IC95% : 1,65-9,11), la télévision (ORa : 2,33 ; IC95% : 1,11-4,90). Les étudiantes résidentes en cité universitaire (ORa : 1,96 ; IC95% : 1,13-3,42), et celles ayant un antécédent de grossesse (ORa : 2,31 ; IC95% : 1,22-4,37) utilisaient également plus souvent les méthodes contraceptives.

**Conclusion :** L'utilisation de méthodes contraceptives est sous-optimale chez les étudiantes au Burkina Faso. Nos résultats sont en faveur d'interventions pour accroître sa demande et son utilisation.

**Mots clés :** prévalence, contraceptifs modernes, facteurs associés, étudiantes, Burkina Faso

### **STH-5-S2-COL-21**

#### **Facteurs explicatifs de la pratique contraceptive moderne des femmes fréquentant les formations sanitaires du district de Youwarou au Mali**

**Sylla O<sup>1</sup>**, Djourdebben FB<sup>2</sup>, Kante S<sup>1</sup>, Dembélé F<sup>3</sup>, Keita Z<sup>4</sup>, Goita S<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Centre de Santé de Référence de Youwarou, Direction Régionale de la Santé de Mopti, Mali

<sup>2</sup>Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD), Université de Yaoundé II, Cameroun

<sup>3</sup>Centre National d'Appui à la Lutte Contre la Maladie, Bamako, Mali

<sup>4</sup>Consultant Indépendant en Santé - Association la Rage en Afrique de l'Ouest, RIWA/REAO, Mali

<sup>5</sup>Consultant en Sciences Sociale, Analyste des Politiques et Programmes de Population et Santé, Bamako, Mali

Email : [ousmanesylla019@gmail.com](mailto:ousmanesylla019@gmail.com)

**Introduction :** Dans les pays en développement, les besoins en planification familiale de plus de 225 millions de femmes demeurent actuellement insatisfaits. Ces femmes qui souhaitent éviter les grossesses, n'utilisent cependant aucun moyen de

contraception moderne. Le taux d'utilisation des méthodes contraceptives modernes est également très faible soit 1,07%. En effet, l'utilisation de la contraception moderne selon la cinquième Enquête Démographique et de Santé du Mali (EDSM-5) est de 9,6% au niveau national et de 2,7% dans la région de Mopti. **Objectif** : Mettre en exergue les déterminants de la pratique contraceptive moderne des femmes fréquentant les centres de santé du district de Youwarou.

**Méthode** : Etude transversale quantitative dont l'enquête fut réalisée du 1<sup>er</sup> mai au 30 juin 2015, et a porté sur 200 femmes âgées de 15-49 ans fréquentant les 07 centres de santé dans le district de Youwarou. Les données collectées par un questionnaire ont été vérifiées, compilées à l'aide du logiciel le Sphinx Plus<sup>2</sup> version 4.5, puis transférées sur le logiciel stata 10 pour l'analyse statistique. Pour l'analyse des données, nous avons eu recours à deux méthodes dans ce travail : la méthode d'analyse descriptive (analyse bivariée) et la méthode d'analyse explicative (analyse multivariée).

**Résultats** : L'étude montrent que la prévalence contraceptive moderne est de 8,8%. Les femmes de centre de Guidio-sare utilisent les contraceptives modernes plus que leurs consœurs du district. Enfin les déterminants de la pratique contraceptive sont notamment l'ethnie, l'âge et le statut matrimonial de la femme.

**Conclusion** : A la lumière de cette étude, nous suggérons qu'un accent particulier doit être mis sur les déterminants révélés afin de promouvoir les méthodes contraceptives modernes.

**Mots-clés**: Contraception Moderne, Rural, Planification Familiale, Youwarou

## STH-5-S2-COL-22

### Facteurs associés aux décès maternels au Centre de Santé de Référence de Koulikoro de 2009 à 2018

**Oumar Sangho**<sup>1,2,3\*</sup>, Hamadou Coulibaly<sup>4</sup>, Seydou Sogodogo<sup>5</sup>, Ken Kayembe<sup>6</sup>, Abdourhamane Dicko<sup>4</sup>, Fanta Sangho<sup>1,2</sup>, Aboubacar Sangho<sup>7</sup>, Yéya dit Sadio Sarro<sup>2</sup>, Housseini Dolo<sup>2</sup>, Mamadou Berthé<sup>8</sup>, Yacouba Koné<sup>9</sup>, Hanine Kéita<sup>6</sup>, Ousmane Boua Togola<sup>9</sup>, Cheick Abou Coulibaly<sup>2,8</sup>, Nouhoum Telly<sup>2</sup>, Boureima Belem<sup>8</sup>, Haoua Dembélé<sup>8</sup>, Mariam Traoré<sup>8</sup>, Kassoum Koné<sup>8</sup>, Bouyagui Traoré<sup>6</sup>

1. Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Biologiques et Médicales, Faculté de Pharmacie (FAPH), Université des Sciences,

des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), Mali

2. Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique et Spécialités, FMOS/USTTB, Mali

3. Agence Nationale de Télésanté et d'Informatique Médicale, Bamako, Mali

4. Direction Régionale de la Santé de Koulikoro, Mali

5. Inspection de la Santé, MSDS, Bamako, Mali

6. Réseau Africain des Epidémiologistes de Terrain, AFENET-Mali, DGSHP, Bamako, Mali

7. Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Pharmaceutiques, FAPH/USTTB, Mali

8. Institut National de Santé Publique (INSP), Bamako, Mali

9. Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique (DGSHP), Bamako, Mali

\***Oumar Sangho**, Maître-Assistant en Epidémiologie au Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Biologiques et Médicales, Faculté de Pharmacie (FAPH), USTTB, Mali. Tél : 76 22 58 77, Email : [osangho75@gmail.com](mailto:osangho75@gmail.com).

**Introduction** : Le décès maternel reste l'un des problèmes majeurs de santé publique et constitue un témoin important de l'aide obstétricale. L'objectif était d'étudier les facteurs associés aux décès maternels au Centre de Santé de Référence de Koulikoro de 2009 à 2018.

**Méthodologie** : Nous avons réalisé une étude transversale analytique en Octobre 2019 sur les données de surveillance épidémiologique de 2009 à 2018. Elles ont été collectées à partir des dossiers obstétricaux et registres de décès. Elles ont été saisies et analysées sur Epi-Info 7.2.2.16. L'analyse bivariée a été faite avec la régression logistique avec présentation des Odds Ratio et leur intervalle de confiance à 95%, et un seuil de significativité de 0,05.

**Résultats** : Nous avons trouvé 77 cas de décès maternels sur un total de 9 765 admissions soit une fréquence de 0,79% dont la maximale en 2010 avec 2,02%. L'âge moyen était de 26,75ans, avec une prédominance des 25-35ans (33,77%) et 15-19ans (28,57%). Les célibataires et les ménagères représentaient respectivement 7,79% et 92,21%. Les évacuées représentaient 84,42% (65/77) dont la plupart (24,68%) venait de l'aire de santé de Koubougou. Environ 16,88% n'avaient réalisé aucune consultation prénatales et 2,60% en avaient réalisé quatre et plus. La gestité et parité moyennes étaient respectivement de 6,5 et 5.

Les causes directes représentaient 71% dont 42,86% d'hémorragie et 23,38% d'éclampsie. Les causes indirectes étaient dominées par l'anémie sévère (14,27%) et le paludisme grave (3,90%). Les <25ans avaient plus de risque de décès par éclampsie (OR[IC95%]=3,78[1,37-10,47]), et moins de risque par hémorragie (OR[IC95%]=0,47[0,26-0,85]) que les ≥25ans. Les ≥7gestités (OR[IC95%]=1,69[1,02-2,79]) avaient plus de risque de décès par hémorragies comparées aux <7gestités.

**Conclusion :** Les évacuées étaient majoritaires. L'hémorragie, l'éclampsie, la multigestité étaient associés aux décès maternels. Ces résultats soutiennent une nécessité d'améliorer le système de référence-évacuation et la disponibilité de sang.

**Mots clés :** Décès maternels, référence-évacuation, Koulikoro, Mali

## STH-5-S2-COL-23

### Facteurs associés aux besoins non satisfaits en contraceptifs modernes chez les jeunes filles au Togo

<sup>1,4</sup>ALIDOU Smaila, <sup>1,2</sup>DAHOUROU Lucien Désiré, <sup>2</sup>DAH Elias Ter Tiero, <sup>4</sup>ASSANE Hamadi Simon Pierre

Adresse Auteurs : [ismoson@gmail.com](mailto:ismoson@gmail.com)

#### Affiliation

<sup>1</sup>Université Joseph Ki-Zerbo

<sup>2</sup>Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>3</sup> Université de Ouahigouya, Ouahigouya, Burkina Faso

<sup>4</sup>Ministère de la Santé, Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins, Togo

**Introduction :** Le concept de besoin non satisfait en contraceptifs modernes met en évidence l'écart entre les intentions reproductives des femmes et leur comportement contraceptif. Chez les jeunes filles du Togo, il s'agit d'un problème de santé publique du fait des conséquences telles que grossesses non désirées, avortements à risque et morbi-mortalité maternelles et néonatales. L'objectif de cette étude était d'identifier leurs facteurs associés, afin de contribuer à l'amélioration de l'utilisation des services de planification familiale au Togo.

**Méthodes :** il s'est agi d'une étude analytique à partir des données portant sur des filles de 15 et 24 ans collectées par l'enquête MICS6-2017 du Togo. Les facteurs associés aux besoins non satisfait en contraceptifs modernes ont été identifiés par régression logistique pas à pas

ascendante. L'analyse a été réalisée avec le logiciel Stata 16 et la significativité statistique était de ( $p \leq 0,05$ ).

**Résultats :** Au total, 1548 jeunes filles ont été incluses. La prévalence des besoins non satisfaits était de 27,02% [IC95% :24,06-30,21]. Les facteurs associés aux besoins non satisfaits en contraceptifs étaient : appartenance à un ménage dont le chef était âgé de moins de 18 ans (ORa=9,05 ; [IC95% :1,21-67,90]), appartenance à un ménage du troisième quintile du bien-être (ORa=1,49 ; [IC95% :1,24-4,31]), du quatrième quintile du bien-être (ORa=2,70 ; [IC95% :1,41-5,15]) et du cinquième quintile du bien-être (ORa=3,55 ; [IC95% :1,80-6,98]), niveau secondaire ou plus (ORa=2,48 ; [IC95% :1,35-4,54]) et être consommation d'alcool (ORa=1,96 ; [IC95% :1,37-2,82]).

**Conclusion :** La prévalence des besoins non satisfaits en contraceptifs est élevée chez les jeunes filles au Togo. La prise en compte de ces différents facteurs dans le développement et la mise en œuvre des interventions sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles pourrait contribuer à améliorer la santé sexuelle de ces dernières.

**Mots clés :** Besoins non satisfaits, jeunes filles, Togo

## STH-5-S2-COL-24

### Gender-Based Violence in Mali: A Hidden Disaster in Schools

F. Dembélé<sup>1</sup>, Z. Keita<sup>2</sup>, S. Goita<sup>3</sup>, **O. Sylla<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Centre National d'Appui à la lutte contre la Maladie, Bamako, Mali

<sup>2</sup>Independent Health Consultant, Rabies Association in West Africa (RIWA-Mali), Bamako, Mali

<sup>3</sup>Social Science Consultant, Policy Analyst and Population and Health Programs, Bamako, Mali

<sup>4</sup>Reference Health Center of Youwarou, Régional Directorate of Health, Mopti, Mali

Email: [ousmanesylla019@gmail.com](mailto:ousmanesylla019@gmail.com)

**Introduction:** Violence against girls has always been considered as a factor of deschooling in French-speaking Sub-Saharan Africa. It is often inadequately reflected in Education for all policies and programs. The objective is to study the frequency and characteristics of gender-based violence at the tertiary vocational training institute (IFP-TER) in Kayes/Mali. **Methodology:** The survey was conducted for four months (September 1 to December 30, 2012). A descriptive cross-sectional study was conducted in the

establishment of IFP-TER Kayes. The study population consists of all the girls in the school. Extensive sampling was done. Individual interviews were conducted and data entered on the Epidata 3.1 software and analyzed on SPSS version 16.0. **Results:** 357 girls were surveyed, of whom 336 experienced at least one form of violence. Of the girls who were abused, 52.4% experienced sexual violence, 77% experienced physical violence, and 47.4% experienced emotional abuse. The vast majority of assaults took place at school (50.9%) and 40% in host families of students. Of the girls surveyed, 77% said they were victims of physical violence, jostling; punches and slaps were frequently cited as types of violence with 69.1%; 40.7% and 36.4%. Girls were victims of sexual violence 52.4% of cases, threats and harassment were the most cited with respectively 75.1% and 74.8%; rape was cited in 41.9% of cases. Blackmail predominated among victims of psychological violence (81.5%). **Conclusion:** The proportion of girls who are abused (94.3%) raises the issue of gender-based violence at the level of IFP-TER. Faced with this situation; it seems advisable to lead an effective fight with the involvement of the various actors in the Kayes region.

Keywords : Violence, Youth, Sex, School Environment, Mali

## Sous-thème 5 Session 3

### STH-5-S3-COP-25

#### **Pneumococcal Carriage and Antibiotic Resistance in Children Younger than 5 Years in Nouna District, Burkina Faso**

Boubacar Coulibaly<sup>1</sup>, Ali Sié<sup>1</sup>, **Dramane Kiemde<sup>1</sup>**, Nestor Dembélé<sup>1</sup>, Adama Compaore<sup>1</sup>, Ousmane Dabo<sup>1</sup>, Clarisse Dah<sup>1</sup>, Lucienne Ouermi<sup>1</sup>, Vicky Cevallos<sup>2</sup>, Elodie Lebas<sup>2</sup>, Jessica M. Brogdon<sup>2</sup>, Jeremy D. Keenan<sup>2,3</sup>, and Catherine E. Oldenburg<sup>2,3,4,\*</sup>

Email : [kiemdedra@gmail.com](mailto:kiemdedra@gmail.com)

<sup>1</sup>Centre de Recherche en Santé de Nouna, Nouna, Burkina Faso ;

<sup>2</sup>Francis I Proctor Foundation, University of California, San Francisco, California ;

<sup>3</sup>Department of Ophthalmology, University of California, San Francisco, California ;

<sup>4</sup>Department of Epidemiology and Biostatistics, University of California, San Francisco, California.

#### **Introduction**

Increasing antibiotic consumption has been shown to lead to increased antibiotic resistance selection. We evaluated the prevalence of antibiotic resistance in *Streptococcus pneumoniae* to commonly used antibiotic classes as well as correlations between resistance and antibiotic consumption at the individual and community levels in children aged 0–59 months in Nouna district, Burkina Faso.

#### **Methods**

This study took place in 18 communities in the Nouna Health and Demographic Surveillance Site (HDSS) in Nouna district, Boucle du Mouhoun Region, Burkina Faso, in July 2017. A population-based sample of 300 children aged 0–59 months was randomly selected from the most recent census in 18 communities in the Nouna Health and Demographic Surveillance Site. Caregivers were interviewed about children's recent antibiotic use, and a nasopharyngeal swab was collected from each child. Nasopharyngeal swabs were processed using standard microbiological methods to determine pneumococcal carriage and resistance. Community-level antibiotic consumption was determined by record review from primary healthcare facilities, which routinely collect prescription data for children aged 0–59 months.

#### **Results**

*Streptococcus pneumoniae* was isolated from 101 (35.7%) nasopharyngeal samples. Among positive isolates, co-trimoxazole (75.6%) and tetracycline (69.3%) resistance was the most common, followed by oxacillin (26.7%) and azithromycin (9.9%). Recent antibiotic use was associated with decreased pneumococcal carriage (odds ratio 0.56, 95% CI : 0.33–0.93) at the individual level. There was no statistically significant relationship between antibiotic use and antibiotic resistance at the individual or community levels, although CIs were generally wide.

#### **Conclusion**

The prevalence of antibiotic resistance to commonly used antibiotics was high in the study area. Expanding antimicrobial resistance surveillance in areas with little population-based data will be important for informing policy related to antibiotic use.

## STH-5-S3-COP-26

### Panorama des pathologies parasitaires dans le service des maladies infectieuses du CHU YO de 2010 à 2019

**Savado Mamoudou**<sup>1</sup>, Diallo Ismaël<sup>2</sup>, Traoré Thérèse<sup>1</sup>, Sondo K Apoline<sup>1</sup>

- 1) Service des maladies infectieuses du CHU Yalgado Ouédraogo
- 2) Service de médecine interne du CHU Yalgado Ouédraogo

**Introduction :** les pathologies parasitaires constituent un problème de santé publique au Burkina Faso.

**Objectif :** déterminer les pathologies parasitaires diagnostiquées dans le service des maladies infectieuses du CHU-YO

**Patients et méthode :** il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive avec collecte rétrospective des données durant la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2010 au 31 Décembre 2019.

**Résultats :** 441 cas de pathologies parasitaires avaient été diagnostiquées dans le service des maladies infectieuses du CHU Yalgado Ouédraogo durant la période d'étude. Le sexe masculin dominait avec un sex ratio à 1,1. L'âge moyen des patients était de 34 ans±11. La majorité des patients (74,7%) provenait de la province du Kadiogo. Les pathologies parasitaires étaient représentées par le paludisme (355 cas dont 78,61% de formes graves), l'isoporoïse (24 cas), la toxoplasmose cérébrale (23 cas), la cryptosporidioïse (13 cas), l'amibiase (13 cas dont 3 à localisation hépatique), la giardiose (9 cas) et la trichomonose intestinale (4 cas). Les plus rarement diagnostiquées étaient l'ankylostomose (1 cas), l'hymenolepiose (1 cas), la cysticercose cérébrale (1 cas), la distomatose (1 cas), la trypanosomose (1 cas) et la filariose lymphatique (1 cas). Sous traitement, l'évolution a été marquée par une létalité de 10,20%.

**Conclusion :** les protozooses étaient les plus fréquemment diagnostiquées. Elles étaient dominées par le paludisme et les parasitoses opportunistes au cours du Sida. Quant aux helminthoses, elles sont rarement diagnostiquées dans le service des maladies infectieuses.

**Mots clés :** pathologies parasitaires, protozooses, helminthoses.

## STH-5-S3-COP-27

### Activité anti-résistance bactérienne de *Securidaca longepedunculata* Fresen (Polygalaceae) : Activité anti-quorum sensing et anti-biofilm

**Issa Karama**<sup>1</sup>, Vincent Ouédraogo<sup>1</sup>, Ablassé Rouamba<sup>1</sup> et Martin Kiendrebeogo<sup>1</sup>  
Laboratoire de Biochimie et Chimie Appliquées, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

[isdok57@gmail.com](mailto:isdok57@gmail.com) ; [vicenteoued@gmail.com](mailto:vicenteoued@gmail.com) ;  
[rouambaablassé@gmail.com](mailto:rouambaablassé@gmail.com) ;  
[martinkindrebeogo@yahoo.co.uk](mailto:martinkindrebeogo@yahoo.co.uk)

**Introduction :** L'émergence de la résistance bactérienne aux antibiotiques est un défi sérieux pour le système de santé mondial. Les biofilms sont des agrégations des microorganismes qui vivent dans une matrice extracellulaire. Les bactéries qui se développent dans le biofilm sont résistantes à la fois à l'antibiothérapie et au système de défense immunitaire de l'hôte. Les bactéries contrôlent la formation du biofilm par un mécanisme de communication appelé le quorum sensing (QS). Le QS agit sur le développement du biofilm et contrôle la production des facteurs de virulence nécessaires à la résistance à la phagocytose. L'inhibition des QS est l'une des approches permettant de lutter contre la résistance aux antibiotiques.

**Objectif :** Evaluer l'effet de l'extrait des feuilles de *S. longepedunculata* sur les facteurs de résistance de *Chromobacterium violaceum* CV026 et *Pseudomonas aeruginosa*.

**Méthode :** Dans cette étude, les activités anti-QS et anti-biofilm de l'extrait méthanolique des feuilles de *S. longepedunculata* (100 à 400 µg/mL) ont été évaluées contre les souches bactériennes *Chromobacterium violaceum* CV026 et *Pseudomonas aeruginosa* PAO1.

**Résultat :** Les résultats ont montré une activité anti-QS et anti-biofilm de l'extrait des feuilles de *S. longepedunculata* qui a réduit la production de violacéine chez *C. violaceum* CV026 de 12 à 59 %. Le facteur de virulence pyocyanine de *P. aeruginosa* PAO1 a été inhibé de 13 à 46%. La formation du biofilm a été significativement inhibée (41 %) à 400 µg/mL. La croissance bactérienne n'a pas été affectée négativement par l'extrait de la plante.

**Conclusion :** L'étude a montré que les feuilles de *S. longepedunculata* ont la capacité d'inhiber significativement les facteurs de résistance bactérienne contrôlés par le QS.

*S. longepedunculata* pourrait être utilisé contre les infections à *P. aeruginosa* et autres bactéries résistantes.

Mots-clés: *Securidaca longepedunculata*, anti-quorum, anti-biofilm

## STH-5-S3-COP-28

### Profil de susceptibilité aux antifongiques des souches cliniques de *Candida albicans* isolées au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso

**Seydou Nakanabo Diallo**<sup>1,2,3</sup>, Isidore W. Yerbanga<sup>1,4,5</sup>, Bassirou Bado<sup>1</sup>, Isidore Mandy<sup>1</sup>, Ahalieyah Anantharajah<sup>3</sup>, Isabel Montesinos<sup>5</sup>, Olivier Denis<sup>7</sup>, Hector Rodriguez-Villalobos<sup>3</sup>, Sanata Bamba<sup>1,7</sup>

<sup>1</sup>Université Nazi-BONI, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso <sup>2</sup>Centre Muraz/ INSP, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso <sup>3</sup>Department of Microbiology, Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL, Brussels, Belgium <sup>4</sup>Service de laboratoire, CHUR, Ouahigouya, Burkina Faso <sup>5</sup>Department of Microbiology, LHUB-ULB, Brussels, Belgium; <sup>6</sup>Microbiology Laboratory, CHU UCL Namur, Yvoir, Belgium; <sup>7</sup>Département des laboratoires, CHUSS, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Email : [seydou.nakanabo@centre-muraz.bf](mailto:seydou.nakanabo@centre-muraz.bf)

#### Introduction

Les candidoses sont des infections fongiques dues aux levures du genre *Candida* parmi lesquelles *C. albicans* demeure l'espèce majoritaire. Ces dernières décennies ont été marquées par une augmentation de l'incidence des candidoses invasives, accompagnée d'une émergence des souches de *Candida* résistantes aux antifongiques à travers le monde.

#### Objectif principal

La présente étude a eu pour objectif d'évaluer le profil de sensibilité aux antifongiques des souches cliniques de *C. albicans* isolées au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso.

#### Méthodes

Trente-trois souches de *C. albicans* ont été isolées de divers échantillons biologiques (écouvillonnages vaginaux, prélèvements d'urine et hémoculture) au laboratoire du CHUSS entre janvier et mai 2021. La spéciation des espèces de levures a été réalisée à la spectrométrie de masse (Malditof). La susceptibilité aux antifongiques a été déterminée grâce à un kit commercial (Sensititre YeastOne YO10<sup>®</sup>) utilisant une technique colorimétrique de microdilution en milieu liquide. Neuf antifongiques ont été testés : anidulafungine, caspofungine, micafungine, 5-fluorocytosine, posaconazole,

voriconazole, itraconazole, fluconazole et amphotéricine B.

#### Résultats

Toutes les souches de *C. albicans* étaient sensibles à l'amphotéricine B avec une concentration minimale inhibitrice (CMI)  $\leq 1$  mg/L. Le taux de résistance à l'anidulafungine était de 2,7%. Nous n'avons observé aucune résistance à la micafungine et à la caspofungine. La résistance aux azolés, notamment le fluconazole était de 5,5% (2/36). La proportion de souches résistantes au posaconazole était de 11,1%. Nous n'avons enregistré aucun cas de résistance au voriconazole ou à l'itraconazole.

#### Conclusion

Nos résultats montrent que les souches de *C. albicans* isolées au CHUSS présentent un faible niveau de résistance aux azolés testés notamment le fluconazole qui est l'antifongique le plus fréquemment utilisé pour le traitement des candidoses dans notre contexte.

**Mots clés :** Candidoses, *Candida albicans*, antifongiques, Bobo-Dioulasso

## STH-5-S3-COP-29

### Caractérisation de la résistance aux antibiotiques, identification des gènes de résistance et des plasmides de souches de *Salmonella* isolées de poulets au Burkina Faso

**Assèta Kagambèga**<sup>a,b,c</sup>, Caroline S. Bouda<sup>b</sup>, Lari M. Hiott<sup>a</sup>, Elizabeth A. McMillan<sup>a</sup>, Hazem Ramadan<sup>a,d</sup>, Daniel K. Soro<sup>b</sup>, Poonam Sharma<sup>a</sup>, Sushim K. Gupta<sup>a</sup>, Nicolas Barro<sup>b</sup>, Charlene R. Jackson<sup>a</sup>, Jonathan G. Frye<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Bacterial Epidemiology and Antimicrobial Resistance Research Unit, U.S. National Poultry Research Center, USDA, ARS, Athens, Georgia, USA

<sup>b</sup>Laboratoire de Biologie Moléculaire, d'épidémiologie et de surveillance des bactéries et virus transmissibles par les aliments (LaBESTA)/Ecole Doctorale Sciences et Technologies (EDST)/Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

<sup>c</sup>Institut des Sciences, Ministère des enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Burkina Faso

<sup>d</sup>Hygiene and Zoonoses Department, Faculty of Veterinary medicine, Mansoura University, Mansoura 35516, Egypt

Email : [kagambega.asseta@gmail.com](mailto:kagambega.asseta@gmail.com)/  
[kagamas2007@yahoo.fr](mailto:kagamas2007@yahoo.fr)

Les bactéries responsables des infections les plus courantes présentent de plus en plus de résistance aux antibiotiques. L'analyse génétique de ces bactéries révèle une fréquence relativement importante de gènes de résistance à plusieurs types d'antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire. Dans la présente étude, la sensibilité phénotypique aux antibiotiques et la détection génotypique des résistances ainsi que la présence de plasmides ont été analysées chez 103 souches de salmonella isolées des fèces de poulets. Pour ce faire, la méthode de séquençage du génome entier (WGS) a été utilisée. Les sérotypes des souches ont été identifiés à travers les données du WGS en utilisant le SeqSero. Les résultats ont montrés un total de vingt-cinq sérotypes à savoir S. Typhimurium, Kentucky, Agona, Virchow, Anatum, Derby, Hato, Chester, Jeddburgh, Schwarzengrund, Tennessee, Albany, Duesseldorf, Poona, Eastbourne, Gaminara, Drac, Alexanderplatz, Brancaster, Bredeney, Amoutive, Telelkebir, Liverpool, Münster, Monschau. Le sérotype le plus répandu était S. Hato avec 28 des 103 isolats (26,66 %). Toutes les 103 souches analysées possédaient au moins un gène de résistance, le plus courant étant le gène *aac(6)-Iaa*. Des multi-résistances ont été trouvées dans 37,14 % des souches analysées avec neuf (09) gènes de résistance identifiés dans la plupart d'entre elles. La résistance a été observée dans différentes classes d'antibiotiques telles que la bêta-lactamase, l'aminoglycoside, la tétracycline, les sulfamides, les phenicols et le trimetoprim. Les résultats ont montrés un manque de concordance entre la résistance génotypique et phénotypique. Le gène de résistance *qacE* conférant une résistance aux antiseptiques a été identifié chez S. Kentucky multirésistant. Cette étude a montré que le poulet est porteur de souches multi-résistantes de Salmonella et ce constat doit être intégré depuis la ferme jusqu'à la fourchette à travers de bonne pratique d'hygiène dans la gestion des fèces et la préparation des carcasses de poulets.

**Mots clés:** Salmonella, génétique, résistance aux antimicrobiens, poulets

### STH-5-S3-COP-30

**Evaluation en milieu naturel de l'efficacité de la pommade MAÏA® contre les moustiques de Goden au Burkina Faso.**

Alphonse Traoré<sup>1</sup>, Gérard Niyondiko<sup>2</sup>, Antoine Sanou<sup>1</sup>, Franck Langevin<sup>2</sup>, Adama

Gansané<sup>1</sup>, N'Falé Sagnon<sup>1</sup>, Moussa Wamdaogo Guelbeogo<sup>1</sup>.

#### Affiliation

<sup>1</sup> Centre national de recherche et de Formation sur le Paludisme 01 BP2208 Ouagadougou 01

<sup>2</sup> Association 100000 vie12 BP 499 Ouagadougou 12

**Email :** [traorealphonse@yahoo.fr](mailto:traorealphonse@yahoo.fr)

#### Introduction

La lutte contre le paludisme repose essentiellement sur l'utilisation des outils antivectoriels. Cependant l'émergence de la résistance aux insecticides et les changements de comportement des vecteurs constituent un facteur limitant pour l'efficacité de ces stratégies de lutte. D'où la nécessité de mettre en œuvre de nouveaux outils de lutte antivectoriel tel que les répulsifs contre les espèces exophages. Cette étude a évalué l'efficacité de la pommade répulsive MAÏA® à Goden au Burkina Faso.

#### Méthodes

Les moustiques ont été collectés à l'aide de la méthode par capture sur homme. 5 binômes de volontaires ont été aléatoirement répartis dans 5 concessions et ont reçu un traitement constitué soit d'un ml d'éthanol (Control négatif), d'un ml d'une solution éthanolique de DEET à 20% (Control positive), soit 2mg/cm<sup>2</sup> de pommade MAÏA®. Les traitements étaient appliqués de façon homogène sur une jambe du volontaire. Avec un aspirateur et une lampe torche le volontaire collectait les moustiques qui tentaient de se poser sur sa jambe.

#### Résultats

Au total 3979 moustiques ont été collectés lors des tests et identifiés. Le taux de piqure a varié significativement entre les traitements, avec une moyenne de 0,68 (95%CI : 0.51 – 0.91) piqures par heure pour MAÏA® contre 1,01 (95%CI : 0.76 – 1.33) pour le DEET et 8.98 (95%CI : 6.56 – 12. 29) pour l'éthanol. Le taux de répulsion a varié entre 90 et 100% pour les traitements MAÏA® et le DEET durant les 6 premières heures après l'application. Les temps moyens de protection contre les piqures de moustiques étaient de 480 minutes pour le DEET et la pommade MAÏA® et de 120 minutes pour l'éthanol.

#### Conclusion

Au vu des résultats la pommade MAÏA®, peut être intégré dans le panier d'outils de lutte antivectorielle au Burkina Faso.

**Mots clés :** MAÏA®, DEET, répulsif, Goden

### STH-5-S3-COP-31

**Distribution, comportement et niveau**

**d'infection des membres du complexe *Anopheles gambiae* en période de transmission du paludisme dans trois districts sanitaires de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso.**

**Nicolas ZANRE**<sup>1</sup>, Aboubacar SOMBIE<sup>1</sup> W. Mathias OUEDRAOGO<sup>1</sup>, Antoine SANON<sup>1</sup>, Athanase BADOLO<sup>1</sup>.

1. Laboratoire d'Entomologie Fondamentale et Appliquée (LEFA), UFR/SVT, Université Joseph Ki-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso  
Adresse du présentateur : ZANRE Nicolas, Tel : 00226 76 25 86 58,  
Email : [nicozanre12@gmail.com](mailto:nicozanre12@gmail.com)

**Introduction** : L'Afrique subsaharienne constitue une zone de forte urbanisation et de démographie galopante. Le paludisme en zone urbaine constitue un fléau dont l'importance croît avec l'immigration croissante vers les zones urbaines. Le paludisme en zone urbaine constitue une préoccupation de santé publique dont le contrôle repose entre autres, sur une meilleure connaissance de la biologie des vecteurs.

**Objectif** : Connaitre la composition spécifique, les préférences trophiques et le niveau d'infection des vecteurs du paludisme dans la ville de Ouagadougou.

**Méthodes** : Des collectes de moustiques à l'état adulte ont été réalisées dans trente quartiers de trois districts sanitaires à l'aide d'un aspirateur en raison de dix quartiers par district. Au laboratoire, les spécimens ont été identifiés morphologiquement bien souvent jusqu'aux espèces. Pour les espèces jumelles, les membres du complexe *Anopheles gambiae* s.l, des PCR ont été réalisées afin de pouvoir les discriminer jusqu'aux espèces de même que l'origine des repas de sang à l'aide d'amorces spécifiques. La méthode ELISA a permis de déterminer l'infection des moustiques.

**Résultats** : Trente-neuf mille sept-cent-vingt-sept (39.727) moustiques dont 1.304 *Anopheles gambiae* s.l femelles ont été collectées. Au total 1261 (96,7%) étaient *Anopheles arabiensis* et 43 (3,3%) de *Anopheles coluzzii*. Cinq hôtes ont été identifiés comme source des repas sanguins, 108 (43,72%) repas sanguins humain, 93 (37,65%) repas sanguins chez les bœufs, 24 (9,72%) sur les porcs, 18 (7,28%) sur les chiens et 04 (1,62%) sur les chèvres. La majorité, soit 66,41% *Anopheles gambiae* s.l ont été collectés à l'extérieur des maisons. Au total 10 moustiques infectés de sporozoïtes de *P. falciparum* ont été identifiés, soit un taux d'infection de 0,7%.

**Conclusion**: Malgré ce taux d'infection relativement bas, le comportement exophile de ces moustiques, associé à une urbanisation galopante mérite une attention spécifique dans le cadre de la lutte contre le paludisme.

Ces données nécessitent d'une part, d'être renforcées pour une vision plus claire de l'écologie de la transmission du paludisme dans la ville de Ouagadougou. Et d'autre part, elles nécessitent d'être prise en compte pour guider les efforts du ministère de la santé dans sa lutte contre les vecteurs du paludisme.

**Mots-clés** : Paludisme, *An. gambiae* s.l, urbanisation, comportement, Ouagadougou, Burkina Faso.

## STH-5-S3-COL-32

### Antibiotic Susceptibility of *Enterobacteriales* and *Cocci* Uropathogens In Patients Attending Regional Hospital in Burkina Faso: Cross-sectional Study.

**René Dembélé**<sup>1,2\*</sup>, Roger Sanou<sup>1</sup>, Oumar Traoré<sup>1,2</sup>, Nafissatou Ouédraogo<sup>1,2</sup>, Wendpoulomdé Aimé Désiré Kaboré<sup>1</sup>, Dramane Sanou<sup>3</sup>, Georgette Djiguemde-Nikiéma<sup>3</sup>, Issiaka Soulama<sup>4</sup>, Alfred Sababenedyo Traoré<sup>1</sup> and Nicolas Barro<sup>1</sup>

#### Author details

1. Laboratory of Molecular Biology, Epidemiology and Surveillance of Bacteria and Viruses Transmitted by Food/ 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso.
2. University of Dedougou, BP 176 Dedougou, Burkina Faso.
3. Regional Hospital of Dedougou, Burkina Faso.
4. National Centre for Research and Training on Malaria, 01 BP 2208 Ouagadougou 01, Burkina Faso.

#### \*Corresponding author:

University of Dedougou, BP 176 Dedougou  
E-mail: [simavedemb@gmail.com](mailto:simavedemb@gmail.com)  
ORCID: 0000-0002-9282-8555

**Introduction**: Making the diagnosis of urinary tract infection (UTI) and deciding when to initiate antimicrobial therapy remains a challenge to healthcare providers.

**Objective**: This study was focused on the identification of bacterial pathogens causing UTI as well the evaluation of related antibiogram.

**Methods**: A cross-sectional study was carried out over a period of one year (March 2018 to February 2019) in the Western part of Burkina Faso. In total, 388 urines samples were collected from individuals with suspected UTIs attending the Regional Hospital of Dedougou.

Samples were inoculated on recommended media and isolation-identification of the bacterial strains were performed using standard microbiological protocols. Antibiotic susceptibility was carried out following European committee on antimicrobial susceptibility testing (EUCAST) recommended guidelines.

**Results:** The overall hospital prevalence of UTIs was 66% with 78.1% for males and 21.9% for females. In addition, half of the patients were under antibiotic treatment. Out of the 388 tested specimens, 132 (34.02%) had significant bacterial growth. *Escherichia coli* (44.7%) was the most frequently isolated specie and 56.8% of the strains were isolated from male patients. *Enterobacterales* were mainly resistant to amoxicillin-clavulanate, amoxicillin, ceftriaxone, ciprofloxacin and trimethoprim-sulfamethoxazole. *Cocci* isolates were resistance to oxacillin, norfloxacin and trimethoprim-sulfamethoxazole. At least, 17 of the *Enterobacterales* and 9 of the *Cocci* were multidrug resistant.

**Conclusions:** The majority of isolates were resistant to commonly prescribed antibiotics. Therefore, the physician should strictly follow the culture report before starting therapy to prevent the emergence of multidrug resistance.

**Keywords:** Urinary tract infections, Uropathogens, Antibiotic susceptibility, Multi-drug resistance, Burkina Faso.

### STH-5-S3-COL-33

#### Connaissances et Pratiques des Étudiants en Pharmacie à l'Université Cheikh Anta Diop sur l'Utilisation et la Résistance aux Antibiotiques (Sénégal)

**Oumar Bassoum**<sup>1,2\*</sup>, Ousmane Djiby Ndiaye<sup>3</sup>, Makhtar Camara<sup>4,5</sup>, Ibrahima Seck<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Service de Médecine Préventive et Santé Publique, Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

<sup>2</sup> Institut de Santé et Développement, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

<sup>3</sup> Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

<sup>4</sup> Laboratoire de Bactériologie-Virologie, Centre hospitalier national universitaire Aristide Le Dantec, Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

<sup>5</sup> Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation, Dakar, Sénégal

Adresse email de l'auteur présentateur et correspondant : [oumar.bassoum@ucad.edu.sn](mailto:oumar.bassoum@ucad.edu.sn)

**Introduction :** Les étudiants en pharmacie devraient jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la résistance bactérienne. Au Sénégal, les données sur ce sujet sont rares.

**Objectif principal de l'étude :** L'objectif était d'étudier les connaissances et pratiques des étudiants en fin d'études de pharmacie sur l'utilisation et la résistance aux antibiotiques.

**Méthodes :** L'étude était transversale et conduite auprès des étudiants de master 2 et doctorat de pharmacie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2019. Les données étaient collectées entre juillet et octobre 2019 au moyen d'un questionnaire électronique dont le lien était partagé à travers le réseau social WhatsApp. Les connaissances étaient évaluées avec une échelle de Likert à cinq niveaux tandis que des questions fermées étaient utilisées pour déterminer les pratiques. Les analyses étaient réalisées avec le logiciel Epi Info™ 7.2.2.16.

**Résultats :** Sur les 559 étudiants éligibles, 278 ont répondu au questionnaire, soit un taux de participation de 60,6%. Parmi eux, 72,3% ont déclaré avoir consommé des antibiotiques durant les 12 mois précédant l'enquête. Concernant les connaissances, 85,6% des étudiants interrogés avaient un niveau suffisant. En outre, 38,2% des étudiants avaient des pratiques inadéquates étaient associées au fait d'avoir un parent ou un ami comme agent de santé (OR = 1,69 ; p-value = 0,04), d'être en doctorat (OR = 0,55 ; p-value = 0,02) et d'avoir des connaissances insuffisantes (OR = 2,21 ; p-value = 0,02).

**Conclusion :** Cette étude a montré que la consommation des antibiotiques est élevée chez les étudiants en pharmacie et que leurs pratiques étaient inadéquates malgré le niveau satisfaisant de leurs connaissances sur les antibiotiques. Il urge de renforcer la sensibilisation des étudiants et de leur entourage sur les bonnes pratiques d'utilisation des antibiotiques.

**Mots clés :** Antibiotiques, Connaissances, Pratiques, Étudiants en Pharmacie, Sénégal

### STH-5-S3-COL-34

#### Prevalence and antibioresistance of *Escherichia coli* and *Salmonella* isolated from lettuce and irrigation water in Ouagadougou, Burkina Faso

**Sibiri Sylvain Rouamba**<sup>1,2</sup>, Namwin Siourimè Somda<sup>2</sup>, François Tapsoba<sup>2</sup>, Asseto Somda<sup>1</sup>, Marie-Laurence Paulette Ouédraogo<sup>1</sup>, Elie Kabré<sup>1,4</sup>, Lassana Sangaré<sup>3,4</sup>, Aly Savadogo<sup>2</sup>

1. Laboratoire National de Santé Publique, 09 B.P : 24, Ouagadougou 09, Burkina Faso.
2. Laboratoire de Biochimie et Immunologie Appliquée, Centre de Recherche en Sciences Biologiques, Alimentaires et Nutritionnelles (LABIA/CRSBAN), Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO BP 7131, Ouagadougou, Burkina Faso.
3. Service de Bactériologie-Virologie, Centre Hospitalier Universitaire Yalagdo Ouédraogo (CHUYO), 03 BP : 7022 Ouagadougou 03, Burkina Faso.
4. Unité de Formation et de Recherche/Sciences De la Santé (UFR/SDS), Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03 Burkina Faso.

**Introduction.** The use of partially or untreated wastewater in the irrigation of vegetable crops constitutes a risk of microbiological contamination of the vegetables produced.

**Aims.** This study had two objectives: (1) to assess the level of contamination of irrigation water and lettuce; and (2) to determine the antibiotic resistance profile of isolated bacteria.

**Methods.** A total of eighty (80) samples of lettuce and ten (10) irrigation waters were collected from the market gardening sites of Boulmiougou, Bissigin, the National School of Public Health (ENSP) and Tanghin. The research of thermotolerant coliforms, *Escherichia coli* and *Salmonella* was done following ISO standard methods. Isolated *Escherichia coli* and *Salmonella* strains were tested for their resistance profile by using the Kirby-Bauer method with a panel of twenty (20) different antibiotics.

**Results.** Out of the eighty lettuce samples, 68.75% (55/80) contained thermotolerant coliforms with an average load of  $8.75 \times 10^5$  CFU g<sup>-1</sup>. The prevalence of *Escherichia coli* was 57.5% (46/80) and *Salmonella* prevalence was 11.25% (9/80) including eight (8) strains of *Salmonella enterica* spp. and one (1) strain of *Salmonella enterica arizonae*. All irrigation waters were contaminated by thermotolerant coliforms at an average concentration of  $3.11 \times 10^4$  CFU g<sup>-1</sup>. The prevalence of *Escherichia coli* was 40% (4/10) in the irrigation waters and *Salmonella enterica* spp. prevalence was 20% (2/10). The highest antibiotic resistance was found in *Escherichia coli* strains with ampicillin 28.26%, amoxicillin+clavulanic acid 26.09% and tetracycline 19.57%.

**Conclusion.** The water used to irrigate vegetable crops in Ouagadougou could be a major source of contamination of vegetables by microorganisms. In addition, the consumption of lettuce would constitute a risk of propagation of salmonellosis among the population.

**Key words:** lettuce, irrigation water, *Salmonella*, *Escherichia coli*, sensitivity to antibiotics

## STH-5-S3-COL-35

### Prévalence et facteurs associés aux infections transmises par la transfusion chez les donneurs de sang dans la ville Burkina-Faso

**Zoma Edwige**<sup>1</sup>, Dahourou Désiré Lucien<sup>2</sup>, Ter Tiero Elias Dah<sup>3</sup>, Sontié Ba-Nébhane Sonia<sup>4</sup>

<sup>1</sup>UFR-SDS, Master Santé Publique ; Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso ;

<sup>2</sup>Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Département de Biomédical/Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso ;

<sup>3</sup>Université de Ouahigouya, Département de Santé Publique, Ouahigouya, Burkina Faso

<sup>5</sup>Ministère de la Santé, Direction Régionale de la Transfusion Sanguine du Centre, Ouagadougou, Burkina Faso

#### Introduction :

La transfusion sanguine est un traitement médical courant, utilisé dans les soins au Burkina Faso. Cependant, peu de données sont disponibles sur les risques de transmission de pathogènes non détectés par les pratiques usuelles. Notre étude avait pour objectif de documenter la transmission résiduelle de pathogènes et les facteurs qui y sont associés.

**Matériels et méthodes :** Nous avons conduit une étude transversale au Centre Régional de transfusion de Ouagadougou. Les données relatives aux dons de sang réalisés entre le 01/07/2018 et 30/09/2018 ont été analysées. Les facteurs associés au portage d'un marqueur transfusionnel ont été identifiés par la régression logistique.

**Résultat :** deux milles deux cent quatre-vingt-trois (2283) poches de sang ont été analysés. L'âge moyen des donneurs était de 22,1 ans (écart-type : 17 ans). La prévalence du virus de l'hépatite B était de 2,6%, celle de la syphilis de 1,1%. Il n'y avait pas de poche de sang contaminée par le virus de l'hépatite C. La présence d'au moins un pathogène était significativement associée au sexe masculin (odds ratio ajusté [ORa] : 2,62 ; intervalle de confiance à 95% [IC95%] : 1,32-5,17), et au fait d'être un nouveau donneur (ORa : 1,22 ; IC95% 1,11-3,06°)

**Conclusion :** La sécurité transfusionnelle reste un défi majeur du fait de la fréquence élevée des marqueurs infectieux dans les dons. Un renforcement de la sensibilisation auprès des donneurs de sang dans le but de les fidéliser, l'amélioration de la qualité de la sélection médicale sont indispensables pour minimiser les risques de transmission de ces marqueurs infectieux par la transfusion sanguine.

Nombre de mots : 272/300

**Mots clés :** transfusion sanguine, donneurs de sang, marqueurs transfusionnels

### STH-5-S3-COL-36

#### Association entre l'anticoagulant lupique et la pré-éclampsie sévère / éclampsie à Ouagadougou au Burkina Faso

**SAWADOGO Salam**<sup>1,2,\*</sup>,  
MINOUGOU/OUATTARA Aminata<sup>3</sup>, NEBIE  
Koumpingnin<sup>1,2</sup>, NIKIEMA/MINOUGOU  
Myriam<sup>4</sup>, KAFANDO Eléonore<sup>1,7</sup>

1 Laboratoire d'hématologie, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

2 Centre national de transfusion sanguine, Ouagadougou, Burkina Faso

3 Centre hospitalier régional de Ziniaré, Burkina Faso.

4 Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, Ouagadougou, Burkina Faso

5 Centre hospitalier régional de Banfora, Burkina Faso.

6 Institut Africain de Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso.

7 Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, Ouagadougou, Burkina Faso.

\* : Auteur correspondant :

[salemserein@hotmail.com](mailto:salemserein@hotmail.com) – Tél : +226 70032776

#### Introduction

La prééclampsie sévère et l'éclampsie dont des complications fréquentes de la grossesse dans notre contexte. Les pronostics fœtal et maternel sont mauvais en l'absence de prise en charge adéquate. Ces complications obstétricales peuvent être associées à des anticorps anti-phospholipides comme l'anticoagulant lupide.

#### Objectifs

Déterminer la prévalence de l'anticoagulant lupique et son association à la pré-éclampsie sévère / éclampsie au Burkina Faso.

#### Méthodologie

Nous avons mené une étude cas-témoins non apparié en milieu hospitalier qui a comparé les femmes avec une prééclampsie ou une éclampsie sévères à celles des témoins (femmes enceintes à terme sans complications obstétricales. Le Temps de venin de vipère de Russel dilué a été utilisé pour

la recherche de l'anticoagulant lupide. L'algorithme utilisé comprenait les tests de dépistage, de mélange et de confirmation. La présence d'un anticoagulant lupique était définie par un ratio temps de dépistage / temps de confirmation > 1,2.

#### Résultats

Au total, 86 cas et 87 témoins ont été inclus dans l'étude. L'âge moyen était respectivement de 25,3 ± 6 ans et 25,4 ± 4,9 ans. On notait des complications obstétricales de types prématurité ou mort fœtal chez 31,4% des cas contre aucune chez les témoins.

La prévalence de l'anticoagulant lupique était de 22,1% chez les cas contre 3,4 % chez les témoins avec un odd ratio de 6,12 ; [1,45 – 25,84], p = 0,014). Parmi les patients possédant un anticoagulant, 68,2 % étaient des primigestes (OR = 2,69 ; [1,04 – 6,97] ; p = 0,042. Le diagnostic de syndrome des anti-phospholipides obstétrical pouvait être évoqué chez 4,6 % des cas.

#### Conclusion

L'anticoagulant lupique est associé à la prééclampsie sévère / éclampsie dans notre contexte. Toutefois, il est nécessaire d'implémenter d'autres techniques complémentaires de diagnostic des anticorps anti-phospholipides afin d'améliorer l'exploration des complications de la grossesse.

**Mots clés :** Anticorps anti-phospholipides –Pré-éclampsie sévère – Eclampsie - Temps de venin de vipère de Russel dilué

## Sous-thème 5 Session 4

### STH-5-S4-COP-37

#### Facteurs pronostiques de la létalité des Accidents Vasculaires Cérébraux au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou du Burkina Faso

**Hervé.B.N.Kpoda**<sup>1</sup>, Léon.G.B.Savadogo<sup>2,3</sup>,  
Délwendé .R.S.Samadoulougou<sup>1,2</sup>,  
Isidore.T.Traoré<sup>1,3</sup>, Serge M.A.Somda<sup>1,3</sup>,  
Daniel Lemogoum<sup>4</sup>, Issiaka Sombié<sup>2,3</sup>,  
Athanase Millogo<sup>2</sup>, Michèle Dramaix<sup>5</sup>,  
Philippe Donnen<sup>5</sup>

#### Institutions

<sup>1</sup> Centre MURAZ research institute /INSP, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

<sup>2</sup>Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

<sup>3</sup> NAZI BONI University (UNB), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

<sup>4</sup> Université Libre de Bruxelles-Erasme Hospital, Bruxelles, Belgium

<sup>5</sup> Université Libre de Bruxelles, School of Public Health, Bruxelles, Belgium

**Présentateur:** Dr Hervé.B.N.Kpoda Centre MURAZ research institute/INSP, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 2054, Mamadou KONATE Road, 01 B.P. 390 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso.

**Introduction :** L'accident vasculaire cérébral (AVC) représente de nos jours un problème majeur de santé publique. Il s'agit d'une pathologie fréquente, dont 80 % est d'origine ischémique. Environ 86% de tous les décès dus à un AVC dans le monde se déroulent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires.

**Objectif:** Notre étude visait à rechercher les facteurs pronostiques de la létalité hospitalière des cas d'AVC admis dans un hôpital universitaire publique du Burkina.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude de cohorte rétrospective portant sur les adultes admis pour un AVC confirmé par un scanner cérébral au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso sur la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2009 au 31 décembre 2013.

**Résultats :** La proportion des cas confirmés par le scanner cérébral était de 32% du nombre total de cas d'AVC hospitalisés au CHUSS. La létalité globale était de 27,6%. Cette létalité était plus marquée chez les patients avec accident vasculaire cérébral hémorragique (AVCH) (35,8%) comparés aux patients avec accident vasculaire cérébral ischémique (AVCI) (22,4%). La médiane de survie était plus élevée chez les AVCI que chez les AVCH (36 et 25 jours respectivement) avec une différence statistiquement significative (p-value= 0.001). En analyse multivariée, un AVCH (HR : 2.25 ; IC95% : 1.41 – 3.61), un état de conscience altéré (HR : 1.90 ; IC95% : 1.20 – 2.99) et la présence d'une paralysie faciale centrale (HR : 1.67; IC95% : 1.04-2.67) augmentaient significativement la létalité.

**Conclusion :** L'étude a permis d'identifier trois facteurs pronostiques de létalité à savoir le type d'AVC, AVCH, l'état de conscience altéré et la paralysie faciale centrale. Compte tenu de la létalité élevée, il est important d'élaborer et de mettre en place des stratégies de prévention et de prise en charge efficaces et adaptées aux ressources en Afrique.

**Keywords :** Accident Vasculaire Cérébral, pronostic, adulte, Burkina Faso.

## STH-5-S4-COP-38

### Prévention des maladies non transmissibles

### et sport selon les fonctionnaires de la ville de Bouaké, Côte d'Ivoire

**Soumahoro Sory Ibrahim**<sup>1,2</sup> ; Kouassi Damus Paquin<sup>1,2</sup> ; Coulibaly M'Begnan<sup>2</sup> ; Irika Opri<sup>2</sup> ; Déby Arsène Kouamé<sup>2</sup> ; Yao Gnissan Henri Auguste<sup>1,2</sup> ; Sekongo Dossonguimon<sup>1</sup>

1-Université Alassane Ouattara de Bouaké

2-Antenne régionale d'hygiène publique de Bouaké

Email présentateur : [ssoryibrahim@yahoo.fr](mailto:ssoryibrahim@yahoo.fr)

**Introduction et objectif:** Le bon fonctionnement du corps humain nécessite plusieurs activités dont la pratique d'activités physiques et/ou sportives. Selon les recommandations de santé publique, un exercice modéré d'une durée de 30 minutes chaque jour de la semaine ou 20 minutes ou plus, d'intensité élevée trois jours par semaine semble nécessaire et suffisante pour garantir des effets bénéfiques sur la santé. Bon nombre d'études ont montré qu'indépendamment de la corpulence et de l'âge, la sédentarité augmente le risque de morbi-mortalité cardiovasculaire, de diabète de type 2, d'obésité, d'hypertension artérielle, d'ostéoporose, de certains cancers. Nous menons cette étude dans le but d'évaluer la pratique du sport chez les fonctionnaires de la ville de Bouaké.

**Méthodes :** Nous avons mené une étude transversale d'avril à mai 2019 auprès des fonctionnaires des différentes directions régionales de la ville de Bouaké. Les fonctionnaires, recrutés de façon exhaustive, ont été soumis à un questionnaire. La saisie et l'analyse des données ont été faites à l'aide du logiciel SPSS.

**Résultats :** Pendant la période de recueil des données, 129 fonctionnaires ont accepté de participer à l'étude. L'âge moyen des fonctionnaires était de 43,77 ans, avec une prédominance masculine (sex-ratio=1,8), un niveau d'instruction supérieur (75,2%). Ils disposaient d'un engin de transport personnel motorisé (50,4%) ; étaient en bonne santé apparente (81,4%), ne consommaient pas d'alcool (60,5%) ni de tabac (83,0%). Ils étaient au moins en surplus pondéral (54,3%). Les fonctionnaires pratiquaient une activité physique et sportive (APS) dans 63,6% des cas pour surtout une bonne santé (43,4%). Les maladies en rapport avec une non pratique évoquées étaient l'hypertension artérielle (28,1%), l'obésité (20,8%) et le diabète sucré (20,1%).

**Conclusion :** La majorité des fonctionnaires pratiquaient une APS. Toutefois, conformément aux recommandations de l'OMS, le niveau de pratique reste encore à améliorer.

**Mots clés :** fonctionnaires-pratique-sport-Bouaké

### STH-5-S4-COP-39

#### **Toxidermies graves au Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU de Bobo-Dioulasso (CHUSS)**

**Ilboudo Dieudonné<sup>1,2</sup>**, Fofana Souleymane<sup>1,2</sup>, Diallo Boukary<sup>1,3</sup>, Awa Wiya<sup>2</sup>, Tioyè Yéri<sup>3</sup>, Konaté Issouf<sup>1,3</sup>, De Vriese Carine<sup>4</sup>, Sombié Issiaka<sup>1</sup>, Sangaré Karim<sup>2</sup>, Andonaba Jean-Baptiste<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), Université Nazi BONI. 01 BP 1091 Bobo-Dioulasso 01

<sup>2</sup>Service de Pharmacovigilance du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou. 01 BP 676 Bobo-Dioulasso 01

<sup>3</sup>Service de Dermatologie – Vénérologie du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou 01 BP 676 Bobo-Dioulasso 01

<sup>4</sup>Service de pharmacologie, pharmacothérapie et suivi pharmaceutique, Faculté de pharmacie, Université Libre de Bruxelles, CP205/07, Boulevard du Triomphe, B-1050 Bruxelles

**Présentateur :** Dr Dieudonné ILBOUDO, Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), Université Nazi BONI. 01 BP 1091 Bobo – Dioulasso 01.

Tél. +226 71 32 13 86.

E-mail : [ddilboudo@gmail.com](mailto:ddilboudo@gmail.com)

**Introduction :** Les toxidermies sont des effets indésirables cutanéomuqueux survenant après l'administration systémique d'un médicament. Au Burkina Faso, les toxidermies pourraient être préoccupantes du fait de l'usage de médicaments les plus à risque dans les programmes de santé et de l'automédication.

**Objectif principal :** Décrire les aspects épidémiocliniques et diagnostiques des toxidermies graves au CHUSS.

**Méthodes :** Entre 2012 et 2021, une étude transversale descriptive et analytique a été menée sur les toxidermies graves confirmées par un dermatologue et notifiées au service de pharmacovigilance. L'imputabilité médicamenteuse a été établie comme décrit par Arimone *et al.* (2011) et l'évaluation du risque lié aux sulfamides par l'estimation du *Reporting Odds Ratio (ROR)*.

**Résultats :** Au total, 105 cas de toxidermies graves ont été colligés. Le délai moyen de survenu d'une toxidermie grave était de  $8,44 \pm 9,47$  jours. L'âge moyen des patients était de  $38,81 \pm 19,87$  ans avec une prédominance féminine (sex-ratio 0,91). L'incidence annuelle a été estimée à 11,62 notification/1.000.000hts/an. Le syndrome de Lyell/SSJ représentait 63,81% des cas. Les sulfamides suivis des bêta-lactamines étaient les médicaments les plus incriminés. Il y avait une association statistiquement significative entre la prise de sulfamides et l'apparition du syndrome de Lyell/SSJ ( $ROR = 2,11$  (IC95% : 1,07 - 4,17)). Le diagnostic des toxidermies était clinique. Le traitement comportait un arrêt systématique du médicament suspect, le traitement curatif et préventif des surinfections et la correction des troubles hydro-électrolytiques.

**Conclusion :** Au CHUSS, les toxidermies graves étaient fréquentes. Les sulfamides étaient les plus incriminés. Au vu de ce contexte, une évaluation de leur usage et la surveillance de leur sécurité sont nécessaires pour minimiser le risque.

**Mots clés :** Toxidermies ; Syndrome de Lyell ; Sulfamides ; CHUSS.

### STH-5-S4-COP-40

#### **Connaissances et pratiques de la prescription des activités physiques et sportives par les médecins**

**Dr Nana Brigitte<sup>1</sup>**, Dabone Moussa<sup>1</sup>, Dr Cissé Abdoul Rahamane<sup>1</sup>, Dr Sawadogo Amidou<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain/ Université Joseph Ki-Zerbo

Email : [nanabrigitte@ymail.com](mailto:nanabrigitte@ymail.com)

**Introduction :** La promotion de l'activité physique est devenue un véritable enjeu dans le contexte général de sédentarisation des populations. Les bienfaits de l'activité physique (AP) dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques ont conduit certains pays à l'inscription de la prescription de l'AP dans le code de santé publique. Au Burkina Faso, les documents de santé publique ne mentionnent pas d'informations concernant la prescription de l'AP.

**Objectif principal de l'étude :** Etudier les connaissances et les pratiques des médecins sur la prescription des APS en vue de susciter un plaidoyer pour la prescription de l'AP dans les pratiques quotidiennes des médecins.

**Méthode :** Etude transversale de type qualitatif, l'enquête a été réalisée auprès de 23 médecins dans 03 districts sanitaires dans la ville de Ouagadougou. L'instrument de collecte des données utilisé a été le guide d'entretien. L'analyse de contenu a servi à analyser les données.

**Résultats :** L'analyse des résultats a permis de noter que la grande majorité des médecins interviewés n'ont pas assez d'informations requises pour la prescription d'une APS. Ils conseillent la pratique des APS à leurs patients atteints de maladies chroniques. Ces résultats indiquent que les médecins ne disposent pas d'assez de connaissances sur la prescription des APS. Leurs actes se résument à de la sensibilisation.

**Conclusion :** Il apparaît judicieux d'intégrer des modules de cours des normes de prescription des AP adaptées aux pathologies chez les médecins en formation.

**Mots-clés :** connaissances-pratiques-prescription-APS-médecins

## STH-5-S4-COP-41

**Facteurs associés à la non observance thérapeutique chez les drépanocytaires au Centre national de référence de la drépanocytose (CNRD) Niamey- Niger, 2021.**

**Moussa MAMADOU**

E-mail : [mamadoumoussa2000@yahoo.fr](mailto:mamadoumoussa2000@yahoo.fr)

### Introduction

La drépanocytose constitue un véritable problème de santé publique. Plus de 330 000 nourrissons naissent chaque année avec des troubles (83% avec une drépanocytose, 17% avec une thalassémie) et près de 500.000 personnes décèdent chaque année de cette maladie dans le monde dont 3,4% concerne les enfants de moins de 5ans. Au Niger la prévalence du gène S est estimée à 25% et celle des formes homozygotes à 1-2%. Notre étude a pour objectif d'étudier les facteurs associés à la non observance thérapeutique chez les drépanocytaires suivis au centre national de référence de la drépanocytose du Niger en 2021.

### Méthodes

Il s'agit d'une étude transversale descriptive analytique des cas de drépanocytaires suivis au centre national de référence de la

drépanocytose du Niger. La population était constituée de tous les patients drépanocytaires homozygotes suivis au centre national de référence de la drépanocytose en 2021. Les techniques de collecte de données étaient l'entretien individuel et la revue documentaire. Les analyses ont été effectuées à l'aide des logiciels Epi-info version 7.

### Résultats

Au total 368 Patients ont été enrôlés dont 98 (26,63%) sont observants et 270 (73,37%) étaient non observants.

En analyse multivariée les facteurs indépendamment liés à la non observance thérapeutique étaient la scolarisation [OR= 0,17 ; IC95= (0,10-0,30)] ;  $p < 0,0001$  ; l'arrêt du traitement [OR=0,15 ; IC95 (0,05-0,43)] ;  $p < 0,0004$  ; la connaissance de la maladie [OR=7,68 ; IC95= (2,20-26,72)] ;  $p \leq 0,0014$  ; et la distance par rapport au centre [OR=0,58 ; IC95= (0,33-0,99)]  $P \leq 0,0489$ .

### Conclusion

Les facteurs influençant l'observance thérapeutique trouvés dans cette étude sont tous corrigeables et pour cela il suffit de lutter contre l'ignorance, et rendre accessible les services de prise en charge de la drépanocytose, rendre la prise en charge gratuite.

Mots clés : Facteurs associés, drépanocytose, Non observance thérapeutique, Niamey-Niger

## STH-5-S4-COP-42

**Mesures hygienodietetiques appliquées par les diabétiques suivis à Bouake, Côte d'Ivoire.**

**Soumahoro Sory Ibrahim**<sup>1,2</sup> ; Kouassi Damus Paquin<sup>1,2</sup> ; Tuo Wako-Tianwa Alice<sup>1</sup> ; Coulibaly M'Begnan<sup>2</sup> ; Déby Arsène Kouamé<sup>2</sup> ; Irika Opri<sup>2</sup> ; Yao Gnissan Henri Auguste<sup>1,2</sup> ;

1-Université Alassane Ouattara de Bouaké

2-Antenne régionale d'hygiène publique de Bouaké

Email présentateur : [ssoryibrahim@yahoo.fr](mailto:ssoryibrahim@yahoo.fr)

**Introduction et objectif :** L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), depuis ces deux dernières décennies, a tiré la sonnette d'alarme en attirant l'attention de la communauté sur le caractère « épidémique » du diabète. Cette véritable épidémie constitue un enjeu majeur de santé publique. La prévalence devrait passer de 1,1% en 1995 pour la population africaine subsaharienne à 1,3% en 2025. Les règles hygiéno-diététiques font partie intégrante de la prise en charge thérapeutique du patient diabétique et ont démontré leur efficacité. Il nous est paru opportun d'évaluer l'observance

des mesures hygiéno-diététiques chez les diabétiques de type 2 suivis à Bouaké afin de mieux les promouvoir.

**Méthodes :** Nous avons mené une étude transversale qui s'est déroulée dans les deux structures publiques de prise en charge des diabétiques de la ville de Bouaké, de septembre 2019 à novembre 2019, soit une période de 03 mois. Le recueil des données s'est fait à l'aide d'un questionnaire auto-administré. Les données ont été analysées par le logiciel SPSS.

**Résultats :** Pendant les trois mois du recueil des données, 398 personnes/484 ont correctement répondu aux questions. L'âge moyen était de 57,1 ans avec une prédominance féminine (sex-ratio=0,5 H/F), aucun niveau d'instruction scolaire (82,8%), un revenu mensuel moyen de 58860FCFA. Les dépenses mensuelles pour la santé s'élèvent à 21965FCFA. Les sujets étaient exclusivement sous régime (5,8%), sous ADO (50,3%), sous traitement traditionnel (10,8%). Les sujets ne consommaient pas d'alcool (93,0%). Ils avaient reçu des informations sur l'alimentation (97,0%) et la nécessité de pratiquer une activité physique (88,4%) et l'importance des soins des pieds (85,0%). Ils avaient conservé les mêmes habitudes alimentaires (50,2%), pratiquaient une activité physique (68,1%) et faisaient des bains de pieds (72,4%).

**Conclusion :** Le niveau d'observance des mesures hygiéno-diététiques chez les patients diabétiques suivis à Bouaké était insuffisant.

**Mots-clés :** observance-diabète-alimentation-sport-Bouaké

## STH-5-S4-COP-43

**Connaissance, attitude et pratique du personnel paramédical des districts sanitaires de Diourbel et de Bambey de la Région Médicale de Diourbel vis-à-vis du diabète : période du 10 juillet au 10 octobre 2020**

**Ousseynou Ka<sup>1</sup>**, Ndeye Fatou Ngom Gueye<sup>2</sup>, Ndeye Fatou Fall<sup>3</sup>, Anta Agne Djigo<sup>1</sup>, Fulgence Abdou Faye<sup>2</sup>, Mountaga Elimane Dia<sup>1</sup>, Cheikh Tacko Diop<sup>1</sup>, Boubacar Gueye<sup>1</sup>, Abdoul Aziz Ndiaye<sup>1</sup>, Papa Gallo Sow<sup>1</sup>.

**Affiliations :**

<sup>1</sup>Département Santé Communautaire de l'UFR Santé et Développement Durable UAD de Bambey,

<sup>2</sup>Département Médecine de l'UFR Santé et Développement Durable, UAD de Bambey,

<sup>3</sup>Faculté de Médecine, Pharmacie, Odontostomatologie de Dakar, UCAD de Dakar

**Auteur correspondant :** Ousseynou Ka –

**Email :** [ousseynou.ka@uadb.edu.sn](mailto:ousseynou.ka@uadb.edu.sn) ou

[siboryka@gmail.com](mailto:siboryka@gmail.com) – Tél : 00 221 77 616 49 98 – BP : 7568 Dakar Médina Sénégal.

**Introduction :** Le diabète constitue un problème de santé publique et la lutte contre celle-ci nécessite sa bonne connaissance par le personnel soignant en particulier paramédical. L'objectif de cette étude était d'évaluer le niveau de connaissances, d'attitudes et de pratiques de ce personnel vis à vis du diabète sucré.

**Méthodologie.** Il s'agissait d'une étude transversale descriptive, réalisée du 10 juillet au 10 octobre 2020 auprès du personnel paramédical des districts sanitaires de Diourbel et de Bambey de la Région Médicale de Diourbel.

**Résultats :** La population d'étude était constituée de 82 agents dont 31 infirmiers et 51 sages-femmes. L'âge moyen était de 36 ans et le niveau moyen d'expérience de 7,7ans. La majorité des agents (95%) affirmait pouvoir définir le diabète mais seulement 58,5% avaient donné une bonne définition. Le niveau de connaissance de l'examen paraclinique de diagnostic était de 79%, des symptômes de 67%, des complications de 44%, des facteurs de risque de 56%, des médicaments antidiabétiques de 43%, des moyens de prévention de 72%, de l'existence d'un programme national de lutte contre le diabète de 60%. La pratique du dépistage systématique du diabète était de 65%, de la référence en cas de glycémie élevée de 85%, du suivi médical de 60%, du contrôle de l'HTA de 98% et du bilan lipidique de 56%. La majorité des agents (89%) n'avait pas confiance à la médecine traditionnelle et le désir de formation avait concerné presque tous les agents (98%). Les sages-femmes avaient une meilleure connaissance des facteurs de risque et de l'examen paraclinique de diagnostic du diabète que les infirmiers.

**Conclusion :** Le niveau de connaissance du personnel paramédical de ces districts vis-à-vis du diabète sucré était insuffisant et des recommandations ont été émises pour pallier à ces insuffisances.

**Mots clés :** Diabète, personnel paramédical, connaissances, région médicale de Diourbel.

STH-5-S4-COL-44

Performance d'une communication pour le changement de comportement chez les personnes à risque du diabète de type 2 au Bénin

**Metonnou Clémence Germaine\***, Azandjèmé Colette Sylvie, Sossa Charles, Paraïso Noël Moussiliou

Département de la promotion de la santé, **Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi**, Ouidah, **Bénin**.

**\*Auteur correspondant :** Metonnou Clémence Germaine, BP 384 Ouidah.

Tel : +229 95863091

Email: [metonnouc@yahoo.fr](mailto:metonnouc@yahoo.fr)

**Introduction.** Les interventions pour retarder ou empêcher la survenue du diabète en Afrique sont très peu nombreuses. Cette étude vise à évaluer la mise en œuvre d'un plan de communication pour réduire les facteurs de risque du diabète de type 2 chez les personnes à risque.

**Méthode.** L'étude transversale évaluative a porté sur les ressources utilisées, les activités et les bénéficiaires de l'intervention. La méthode non probabiliste a été utilisée pour le choix de toutes les populations cibles avec des techniques d'échantillonnage appropriées. La performance de la mise en œuvre du plan de communication pour le changement de comportement a été évaluée à travers le cadre d'évaluation des interventions de santé de Donabedian : la structure, le processus et les résultats. L'appréciation des composantes a été faite selon l'échelle d'évaluation de Varkevisser.

**Résultats.** La performance de la mise en œuvre du plan de communication pour le changement de comportement était satisfaisante dans tous les villages d'intervention à 89%. Les scores obtenus pour la performance de la structure, la performance du processus et la performance des résultats étaient respectivement de 100%, 95% et 83,8%. L'implication de toute l'équipe de

recherche, l'engagement des autorités locales et la motivation des cibles étaient déterminants.

**Conclusion** La présente étude montre qu'une activité de communication préventive du DT2 efficace est possible au niveau communautaire au Bénin et probablement en Afrique.

**Mots-clés :** Performance ; plan de communication ; personne à risque ; diabète de type 2 ; Bénin.

## STH-5-S4-COL-45

### Etude de la connaissance et de la prévalence du diabète en milieu rural sénégalais en 2020

**Amadou Ibra Diallo**<sup>1,2</sup>, Khadija Sandembou Diop Mbacké<sup>1</sup>, Oumar Bassoum<sup>1,2</sup>, Mayssine Diongue<sup>1,2</sup>, Adama Faye<sup>1,2</sup>

#### Institutions d'origine

<sup>1</sup>Institut Santé et Développement, Université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD, Sénégal

<sup>2</sup>Service de Médecine Préventive et de Santé Publique, UCAD, Sénégal

#### **Introduction**

Le diabète une maladie chronique à lourd fardeau économique dans les pays à revenus faibles particulièrement en milieu rural confronté aux changements du mode de vie. L'objectif de ce travail était d'étudier la connaissance, la prévalence, les facteurs de risque associés dans la ville de Niakhène en milieu rural sénégalais.

#### **Méthodologie**

Il s'agissait d'une enquête transversale, descriptive et analytique chez les sujets âgés d'au moins 18ans et résidant dans la commune de Niakhène, réalisée en octobre 2020. Un sondage aléatoire systématique, stratifié suivant le sexe et les tranches a été réalisé. Le questionnaire a été construit à partir du cadre de l'outil STEPS 2015 de l'organisation mondiale de la santé. Les données collectées portaient sur les caractéristiques personnelles, la connaissance du diabète, les antécédents familiaux et personnels, les mesures anthropométriques et les prises de la glycémie et de l'hypertension artérielle. L'analyse a été réalisée avec le logiciel R et le test de Chi2 a été utilisé pour effectuer les comparaisons de fréquences avec un seuil de 0,05.

#### **Résultats**

Un total de 300 individus a été enquêté. Ils avaient un âge moyen de 35,3 ans (+/-16,9), de sexe féminin (52,3%), mariés (65,7%) et sans instruction (67,7%). Un tiers des enquêtés, disait que le diabète est une maladie non

transmissible, parmi les signés cités : une perte de poids (83%), une augmentation de la fréquence des urines (70%). Les complications fréquemment citées étaient les atteints cardiaques (47,3%), rénales (43,7%), oculaires (52,3%) et les amputations (86,6%). La communauté (95,7%), le personnel de santé (36,0%), la télévision (28,7%) et la radio (26,7%) constituaient les principales sources d'information. La prévalence du diabète était de 3,7 % dont 0,7% ont été nouvellement diagnostiqués. Seul une relation significative avait été retrouvée avec l'âge ( $P<0,001$ ). Un antécédent familial de diabète a été retrouvé dans 9% des cas et la surcharge pondérale dans 14,2%.

### Conclusion

Cette étude a permis de montrer que prévalence du diabète (connu et nouvellement diagnostiqué) en milieu rural au Sénégal est encore faible. L'âge avance étant le principal facteur associé, il est nécessaire de renforcer les politiques préventives pour cette cible.

**Mots clés :** Diabète, prévalence, facteurs de risque, milieu rural, Sénégal

## STH-5-S4-COL-46

### Profil épidémiologique des dermatoses professionnelles chez les garagistes automobiles de la ville de Parakou

**Gounongbé A.C. Fabien<sup>1</sup>**, Mama Cissé Ibrahim<sup>1</sup>, Owona Manga L. Jules<sup>2</sup>, Mikponhoué Rose<sup>3</sup>, Agblonon J. L. Valère<sup>1</sup>.

1. Faculté de médecine, Université de Parakou, Bénin

2. Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques, Université de Douala, Cameroun

3. Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

**Communicateur :** Dr Fabien Christophe A. GOUNONGBÉ, Maître de Conférences Agrégé en Médecin du Travail, Faculté de Médecine ; Université de Parakou ; Bénin  
Email : [gcfabien@yahoo.ca](mailto:gcfabien@yahoo.ca)

**Introduction :** Très fréquentes sont en milieu de travail, les dermatoses restent un sujet toujours d'actualité.

**Objectif :** Déterminer la prévalence et les facteurs associés aux dermatoses chez les garagistes automobiles de la ville Parakou.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale, descriptive qui a porté sur les garagistes automobiles de Parakou. L'échantillonnage était non probabiliste par recensement exhaustif. Les données ont été

collectées au moyen d'un questionnaire puis analysées avec le logiciel Epi info version 7.2.2.

**Résultats :** La moyenne d'âge des 358 enquêtés tous de sexe masculin, était  $25,80 \pm 10,22$  ans avec les extrêmes de 10 et 61ans. La tranches d'âge 14-25 ans était la plus représentée. Ils étaient 158(44,13% qui avaient le niveau secondaire. Les garagistes ayant une ancienneté de 1 à 5 an exclue représentaient 46,01% de la population d'étude. Les mécaniciens (65,64%) étaient les plus représentés des différents corps de métiers retrouvés dans les garages. La presque totalité (95,81%) manipulaient avec contact cutané fréquent du carburant. La fréquence des dermatoses était 73,46%. Mains et le poignet étaient les sièges les plus fréquents.

**Conclusion :** La prévalence des dermatoses au sein des garages automobiles de Parakou est élevée et la quasi-totalité des facteurs associés sont d'origine professionnelle.

**Mots clés :** Dermatoses professionnelles, fréquence, facteurs associés, garagistes automobiles, Parakou.

## STH-5-S4-COL-47

### Prévalences des facteurs de risque comportementaux de maladies non transmissibles chez les étudiants de l'Université de Parakou (Bénin) en 2021

**Houehanou Yessito Corine Nadège<sup>1\*</sup>**,

Toffohossou Evelyne<sup>1</sup>, Tchibozo Maria-Conchéta<sup>2</sup>, Houinato Dismand<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ecole Nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et surveillance épidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Parakou, Bénin

<sup>2</sup> Laboratoire d'épidémiologie des maladies chroniques et neurologiques (LEMACEN), Faculté des sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

\*Adresse : Université de Parakou, BP 123 Parakou (Bénin) ; email : [yessito\\_fr@yahoo.fr](mailto:yessito_fr@yahoo.fr)

**Introduction :** Les maladies non transmissibles (MNT) peuvent être évitées grâce à l'adoption d'un mode de vie équilibré.

**Objectif :** L'objectif de cette étude était de déterminer les prévalences des facteurs de risque comportementaux de MNT chez les étudiants de l'Université de Parakou au Bénin en 2021.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale. Elle a inclus les étudiants inscrits à l'Université de Parakou en 2021 et ayant donné leur consentement écrit. Les étudiants sous un régime spécifique pour des raisons médicales et

les femmes enceintes ont été exclus. Un échantillonnage de convenance a été réalisé ; tous les étudiants rencontrés dans les entités ciblées durant la période du 27 Mai au 30 Juillet 2021 ont été sélectionnés. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire imprimé et auto-rempli. Les données sur la consommation d'alcool, de tabac, de fruits et légumes et la pratique d'activité physique ont été renseignées et définies suivant les normes de l'OMS.

**Résultats :** Un total de 717 étudiants a été inclus dont 49,8% de femmes. L'âge moyen était de 21,2±2,4 ans. Les prévalences étaient estimées à : 0,7% pour la consommation abusive d'alcool ; 1,1% pour la consommation de tabac ; 47,2% pour la consommation insuffisante de fruits et légumes et 60,1% pour l'inactivité physique. La résidence ( $p=0,001$ ) était significativement associée à la consommation nocive d'alcool ; l'âge ( $p=0,03$ ), la religion ( $p=0,02$ ) et le sexe ( $p=0,004$ ) à la consommation de tabac ; l'âge ( $p=0,02$ ), l'entité ( $p=0,01$ ) et la sensibilisation sur les MNT ( $p=0,001$ ) à l'inactivité physique.

**Conclusion :** Les prévalences de certains facteurs comportementaux de risque de MNT sont élevées dans cet échantillon. Des actions pour la promotion d'un mode de vie équilibré chez les étudiants ciblés sont à encourager.

**Mots clés :** Prévalences ; facteurs de risque comportementaux ; Maladies non transmissibles ; Bénin

## Sous-thème 5 Session 5

### STH-5-S5-COP-49

#### Santé bucco-dentaire et grossesse : Connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de périnatalité dans les centres hospitaliers universitaires de Ouagadougou

Garé JVW <sup>1,2</sup>, **Bougsery F<sup>2</sup>**, Kaboré A<sup>1</sup>, Diarra AA<sup>2</sup>, Kanouté A<sup>3</sup>, MEDA N<sup>1</sup>

1. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Département de santé publique, Université Joseph Ki Zerbo 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso
2. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), section de chirurgie dentaire, Université Joseph Ki Zerbo 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso
3. Service de Santé Publique et Médecine Préventive, Faculté de Médecine, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

**Présentateur :** Dr Fatao BOUGSERY

**E-mail :** [bougseryf@gmail.com](mailto:bougseryf@gmail.com) ; **Téléphone :** 00226 72 97 36 55 / 55 51 42 10

**Introduction :** Les variations hormonales au cours de la grossesse sont responsables de manifestations pathologiques bucco-dentaires fréquentes mais non spécifiques. Malgré ces risques, peu de femmes semblent rendre visite à une dentiste pendant leur grossesse, même lorsqu'elles ont des problèmes dentaires. Parmi les raisons avancées, il ressort le manque de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire pendant la grossesse.

**Objectif :** Étudier les connaissances, les attitudes et les pratiques des professionnels de périnatalité sur la relation santé bucco-dentaire et grossesse dans les CHU de Ouagadougou.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale à visé descriptive. Les données ont été recueillies par interview à l'aide d'un questionnaire conçu et implémenté dans un système Android. Des scores ont été générés à partir des réponses aux questions et des niveaux de connaissances, d'attitudes et de pratiques ont été définis.

**Résultats :** Sur les 139 répondants ; 81,3 % étaient de sexe féminin et 43,2% exerçaient depuis plus de 10 ans. Ils avaient majoritairement de bonnes connaissances concernant la santé bucco-dentaire et la grossesse, de bonnes attitudes face aux pathologies bucco-dentaires et de mauvaises pratiques face aux parturientes présentant des pathologies bucco-dentaires. L'ancienneté était significativement associée à la connaissance globale ; de même que la formation reçue était associée à l'attitude globale. La pratique des praticiens de périnatalité était significativement meilleure avec l'existence d'un protocole de prise en charge de la femme enceinte incluant le volet buccodentaire ( $p<0,05$ ).

**Conclusion :** Les professionnels de périnatalité sont conscients de l'importance de la santé bucco-dentaire, cependant ils ne l'abordent pas toujours dans le cadre de leurs prestations de soins. Des sensibilisations de rappel permettront à l'ensemble de ces acteurs de prendre les meilleures décisions face à des parturientes présentant ou pas des pathologies bucco-dentaires.

**Mots clés :** Santé bucco-dentaire, grossesse, connaissances, attitudes, pratiques, professionnels de périnatalité, Ouagadougou.

## STH-5-S5-COP-50

### La carie dentaire et ses complications chez l'enfant : étude au Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire de Ouagadougou

**Ouédraogo CNT<sup>1\*</sup>**, Kaboré WAD<sup>1</sup>, Koné K<sup>2</sup>, Kouakou KF<sup>2</sup>, Garé JV<sup>1</sup>, Héma F<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso

<sup>2</sup>Unité de Formation et de Recherche en Odonto-Stomatologie, Université Félix Houphouët Boigny, 22 BP : 612 Abidjan 22, Côte d'Ivoire.

**Introduction :** La population infantile et adolescente constitue une tranche d'âge très vulnérable à la carie dentaire. Ce travail avait pour

**objectif** d'étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de la carie dentaire et ses complications chez l'enfant et l'adolescent au Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire de Ouagadougou.

**Méthodologie :** Il s'est agi d'une étude transversale descriptive à collecte rétrospective. Elle s'est déroulée du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2018. Les données collectées étaient en rapport avec les variables sociodémographiques, cliniques et l'attitude thérapeutique.

**Résultats :** Durant la période d'étude, 6861 nouvelles consultations ont été répertoriées dont 805 cas d'enfants et adolescents, soit une fréquence globale de 11,7 % de consultation. Le motif de consultation le plus fréquent était représenté par la douleur avec 555 cas soit 68,9 %. La carie dentaire et/ou ses complications soit au total 578 cas (71,8 %) étaient la pathologie la plus rencontrée. Un traitement conservateur a concerné 293 cas (44,9 %) et la pulpectomie a été la plus pratiquée (78,8 %).

**Conclusion :** Cette étude a montré une prévalence élevée de la carie dentaire et de ses complications chez l'enfant et l'adolescent. Il faudrait en plus des soins classiques de prophylaxie orale se résumant en l'enseignement à l'hygiène, mettre l'accent sur le scellement préventif des sillons anfractueux.

**MOTS CLÉS :** Carie dentaire, Complications, Epidémiologie, Clinique, Thérapeutique, Enfants

#### \*Correspondance:

Dr Carole Nathalie Ténin Ouédraogo  
Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé  
Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021  
Ouagadougou, Burkina Faso  
Adresse email: catenao@yahoo.fr

Téléphone : 70249646

WhatsApp : 70249646

## STH-5-S5-COP-51

### Periodontal Conditions and Pathogens Associated with Pre-Eclampsia: A Scoping Review

**Gare J<sup>1,2</sup>**, Kanoute A<sup>3</sup>, Meda N<sup>2</sup>, Viennot S<sup>1</sup>, Bourgeois D<sup>1</sup>, Carrouel F<sup>1</sup>

1- Laboratory P2S (Health Systemic Process), UR4129, University Claude Bernard of Lyon 1, University of Lyon, Lyon, France;

2- Public Health Laboratory (LASAP), ED2S Doctoral School of Sciences and Health, University Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou 7021, Burkina Faso  
3- Public Health Service, Department of Dentistry, Faculty of Medicine, Pharmacy and Dentistry ; University Cheikh Anta Diop, Dakar 10700, Senegal

**Background :** Pre-eclampsia, the second most frequent direct source of maternal mortality, is a multisystem gestational disorder characterized by proteinuria and maternal hypertension after the 20th gestational week. Although the causes of pre-eclampsia are still discussed, research has suggested that the placenta has a central place in the pathogenesis of this disease. Moreover, current surveys indicated that periodontal disorders observed during the pregnancy and more particularly, periodontal pathogens could be link to the risk of pre-eclampsia.

**Objectives:** This study aims to review recent studies focusing on periodontal conditions and pathogens associated with pre-eclampsia.

**Methods:** Electronic research was organized in Pubmed, Embase and Web of science. The following search terms were used: ("pregnant" OR "pregnancy" OR "gravid" OR "expectant") AND ("hormone" OR "estrogen" OR "progesterone" OR "immunity" OR "microbiota" OR "periodontal" OR "pathogen") AND ("pre-eclampsia" OR "pregnancy disorder"). The inclusion criteria were: (i) publications written in English language; (ii) publications published between 2010 and April 2021; (iii) publications presenting human studies; (iv) publications focusing on preg- nant woman; (v) publications focusing on periodontal disease or periodontal microbiota; (vii) publications focusing on pre-eclampsia. The GRADE process was applied to evaluate the quality of the studies.

**Results:** Metabolic conditions, immunological changes, fluctuating progesterone and estrogen levels of the pregnant woman induce a dysbiosis of the oral microbiota and contribute to increase

inflammation of periodontal tissues. Periodontal pathogens could diffuse through the bloodstream inducing a placenta inflammatory response as well as inflammatory molecules produced in response to periodontopathogens could migrate through the bloodstream leading to a placenta inflammatory response. Also, periodontopathogens can colonize the vaginal microbiota through the gastrointestinal tract or during oro-genital contacts.

**Conclusion:** A cumulative bi-directional relationship between periodontal conditions, pathogens and the pre-eclampsia exists.

**Keywords:** periodontal disease; oral microbiota; periodontal pathogens; pre-eclampsia;; dysbiosis; placenta.

## STH-5-S5-COP-52

### Prévalence des affections bucco-dentaires et besoins en soins des personnes handicapées mentales dans les centres spécialisés de Ouagadougou, Burkina Faso

Garé JVW <sup>1,2</sup>, **Kientega FD**<sup>2</sup>, Ouédraogo CNT<sup>2</sup>, Ouattara S<sup>1,2</sup>, Kaboré WAD<sup>2</sup>, MEDA N<sup>1</sup>

1. *Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Département de santé publique, Université Joseph Ki Zerbo 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso*
2. *Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), section de chirurgie dentaire, Université Joseph Ki Zerbo 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso*

**Présentateur :** Dr Filwendé Dan KIENTEGA  
**E-mail :** [dkientega@gmail.com](mailto:dkientega@gmail.com) ; **Téléphone :** 00226 61055552

**Introduction :** Le terme 'handicap mental' couvre un grand groupe de troubles aux nombreuses causes possibles dans lesquelles la fonction intellectuelle est dans une certaine mesure insuffisante. De ce fait, les personnes handicapées mentales ont deux fois plus de problèmes de santé buccodentaire que la population générale.

**Objectifs :** Décrire les principales affections bucco-dentaires et identifier les besoins en soins des personnes handicapées mentales dans les centres spécialisés de Ouagadougou.

**Méthodes :** Une enquête transversale descriptive a été conduite dans les centres d'accueil de personnes handicapées mentales bénéficiant de la subvention du Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire. Un questionnaire adapté pour les enquêtes en santé bucco-dentaire de l'Organisation mondiale de la santé

a été utilisé pour la collecte des données qui ont été analysées avec le logiciel STATA MP 16.0 (College station, Texas 77845, USA).

**Résultats :** Ont été incluses dans l'étude 193 personnes handicapées mentales dont l'âge moyen était de 12,4 ans  $\pm$  7,9. La prévalence globale de la carie était de 58,6 % avec IC 95% [51,2 - 65,8]. Les fréquences des saignements gingivaux et du tartre étaient de 63,8 % et 63,4 % respectivement. Les autres pathologies se répartissaient en 25,5% de sialorrhées ; 15,0% d'usures dentaires ; 39,1% de malocclusions ; 19,2% d'anomalies dentaires et 13,4% de traumatismes dentaires. Les sujets qui avaient besoin de soins rapides et urgents étaient de 51,6 %.

**Conclusion :** Cette étude a permis de rapporter les principales affections bucco-dentaires rencontrées chez les personnes handicapées mentales et les besoins en soins. Des stratégies de promotion de la santé axées sur des interventions simples tels que des soins bucco-dentaires adaptés permettraient d'améliorer le bien-être général de ces personnes vulnérables.

**Mots clés :** affections bucco-dentaires, handicap mental, déficience intellectuelle, besoins de soins bucco-dentaires.

## STH-5-S5-COP-53

### Epidemiological aspects of cervicofacial cellulitis due to dental origin in the city of Ouagadougou (Burkina Faso)

**Wendpouiré Patrice Laurent Guiguimdé**<sup>1</sup>,  
Valérie Wendkouni Garé<sup>1</sup>, Yamsoulougri C.  
Laeticia Ouédraogo<sup>2</sup>, Tarcissus Konsem<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Department of Odontostomatology and Maxillofacial Surgery, Yalgado Ouédraogo University Hospital, 03 PO Box 7022 Ouagadougou 03, Burkina Faso*

<sup>2</sup>*Department of Odontostomatology and Maxillofacial Surgery, Bogodogo University Hospital Center, 14 PO Box 371 Ouagadougou 14, Burkina Faso*

**Email:** [guiguimdew@yahoo.fr](mailto:guiguimdew@yahoo.fr)

### Background:

Head and neck cellulitis of dental origin are polymicrobial bacterial infections involving the cellulo-adipose spaces of the face and neck.

### Objective

The objective of this work was to describe the epidemiological and clinical profile of patients with head and neck cellulitis.

## Methods:

This was a cross-sectional study conducted from 1 January to 30 June 2020. All patients consulting for cervico-facial cellulitis of dental origin in 2 university hospitals in Ouagadougou were included in the study. The usual parameters of descriptive statistics were estimated for each variable.

## Results:

Two hundred and ninety-two cases (184 men and 108 women), aged 3 to 85 years were collected. The 25-35 years old were the most affected (33%). Decay was the leading dental cause (95,6%). The delay in consultation was included within 7 days in 74.66% of cases. Ninety-one-point forty-four percent of patients had poor oral hygiene. Diffuse cellulitis were the most common (64.04%) and peri-mandibular regions the most invaded (42.81%).

## Conclusion:

The frequencies observed in our study allow us to conclude that cervicofacial cellulitis of dental origin is still frequent and affects a young and disadvantaged population.

## Keywords

cervicofacial cellulitis, odontogenic infection, epidemiological and clinical profile, Ouagadougou.

## STH-5-S5-COP-54

### Prévalence de la carie dentaire et les facteurs associés chez les personnes handicapées mentales dans les centres spécialisés de Ouagadougou

**Garé J<sup>1</sup>**, Kientga FD, Ouédraogo CNT<sup>2</sup>, Ouattara S<sup>1</sup>, Kaboré WAD<sup>2</sup>, Meda N

1. *Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Département de santé publique, Université Joseph Ki Zerbo 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso*
2. *Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), section de chirurgie dentaire, Université Joseph Ki Zerbo 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso*
3. *Service de Santé Publique et Médecine Préventive, Faculté de Médecine, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal.*

**Présentatrice :** Dr Jocelyne Valérie Wendkouni GARE

E-mail : [jvgare@yahoo.fr](mailto:jvgare@yahoo.fr) ; 00226 70 33 69 10

**Introduction :** Plusieurs études ont rapporté une grande prévalence de caries dentaires chez les personnes handicapées mentales. En effet, les psychotropes, indispensables à la stabilisation des troubles mentaux, ont des

effets secondaires sur la santé générale des patients particulièrement sur la sphère orale ; les plus connus étant entre autres l'augmentation de risque de la maladie carieuse.

**Objectifs :** Cette étude avait pour objectifs de déterminer la prévalence de la carie dentaire et d'identifier les facteurs y associés chez les personnes handicapées mentales dans les centres spécialisés de Ouagadougou.

**Méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale descriptive et analytique. L'enquête s'est déroulée du 02 Novembre 2020 au 22 Janvier 2021 auprès des personnes handicapées mentales des centres d'accueil bénéficiant de la subvention du Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire. Le support de collecte utilisé était un questionnaire adapté de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la carie dentaire a été enregistrée selon les critères de l'OMS. Une régression logistique binaire a été réalisé pour étudier l'association entre la carie dentaire et les facteurs associés.

**Résultats :** Cette étude a porté sur 193 personnes handicapées mentales dont l'âge moyen était de 12,4 ans  $\pm$  7,9. La prévalence globale de la carie mesurée avec l'indice CAO était de 58,6 % IC 95% [51,2 - 65,8]. Elle variait de manière significative avec le genre, l'épilepsie, la trisomie, l'autonomie motrice et l'utilisation de pâte dentifrice.

**Conclusion :** Les personnes handicapées mentales constituent un groupe de population vulnérable qui n'a souvent pas accès aux soins bucco-dentaires. Il existe un énorme besoin d'éducation et de formation ciblées pour ces personnes ainsi que pour toutes celles qui les accompagnent dans les structures spécialisées.

**Mots clés :** carie dentaire, handicap mental, déficience intellectuelle, facteurs associés, Ouagadougou.

## STH-5-S5-COP-55

### Stratégie intégrée de détection précoce et de prise en charge des cas de noma dans la région du sahel au Burkina-Faso

**BOUGOUM S<sup>1</sup>**, TAPSOBA H<sup>2</sup>; GUIGUIMDE W. P.L<sup>3</sup> ; KONSEM T<sup>3</sup> ;

<sup>1</sup>UFR/SDS Université Joseph Ki-Zerbo, Département d'Odonto-Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale CHU Yalgado Ouédraogo; PSRCN/BF. Courriel : [bougoums@yahoo.fr](mailto:bougoums@yahoo.fr)

<sup>2</sup>PSRCPN/BF (Projet de Sensibilisation et de Renforcement des Capacités pour la Prévention du Noma au Burkina Faso), 10 BP 133 13 Ouagadougou 10 Burkina Faso

<sup>3</sup>UFR/SDS Université Joseph Ki-Zerbo, Département d'Odonto-Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale CHU Yalgado Ouédraogo

**Introduction :** le noma sévit toujours dans la région du sahel au Burkina-Faso, où la prévalence de la malnutrition reste élevée. La forte mortalité et les séquelles de cette maladie sont essentiellement liées au diagnostic tardif et à la prise en charge inappropriée. Pour lutter contre le noma dans le sahel, une stratégie de détection précoce et de prise en charge a été mise en place en 2019 par le projet PSRCPN/BF en collaboration avec les structures sanitaires.

**Objectifs :** l'objectif de ce travail est de faire le bilan du dépistage des cas, de la prise en charge médico-chirurgicale et d'évaluer l'impact de la stratégie sur le pronostic et l'évolution des cas traités.

**Méthodologie :** il s'agit d'une étude rétrospective portant sur la période de juillet 2019 à juillet 2021. Le dépistage était assuré par une recherche active au niveau communautaire. La prise en charge a été réalisée au niveau CSPS, CMA et/ou CHU. Les données ont été collectées grâce aux fiches d'investigation, fiches de notification, fiches de référence ainsi que les dossiers patients et fiches de suivi pour le CHU.

**Résultats :** 31 cas de noma ont été détectés soit quatre fois plus que la moyenne annuelle habituelle. 16 d'entre eux ont été évacués au CHUYO (15 enfants et un adulte). On dénombrait 12 cas associés à la malnutrition aiguë et un cas associé au VIH. La prise en charge a permis la survie de tous les patients (contre 30% de mortalité hospitalière habituelle) et la limitation des séquelles (3 guérisons sans séquelles, 3 avec des séquelles mineures et 6 séquelles graves ayant bénéficié de chirurgie réparatrice).

**Conclusion :** un dépistage dès le niveau communautaire suivi d'une prise en charge appropriée permet de réduire la mortalité et les séquelles du noma. Une démarche à prendre en compte dans les stratégies de lutte.

**STH-5-S5-COL-56**

**Inégalités sociales de carie dentaire des enfants sénégalais de Pikine, Sénégal : Faut-**

**il incriminer les déterminants familiaux ?**

**Serigne Ndamé DIENG,** Mbathio DIOP, Amadou DIENG, Aïda KANOUTE, Massamba Diouf, Cheikh Mbacké LO, Daouda FAYE.

Santé Publique - Institut d'Odontologie et de Stomatologie – Faculté de Médecine, Pharmacie et d'Odontologie - Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.

Email

présentateur :

[serigneddas@gmail.com](mailto:serigneddas@gmail.com)/[serignedame.dieng@ucad.edu.sn](mailto:serignedame.dieng@ucad.edu.sn)

**Introduction :** La problématique des inégalités sociales de carie dentaire demeure une préoccupation de santé publique notamment en Afrique où la précarité sociale sévit. Chez les enfants l'environnement social familial de vie discrimine les états de santé dentaire. Au Sénégal, la carie dentaire des enfants est inégalement distribuée selon un déterminisme social.

**Objectif :** Ce travail cherche à identifier les déterminants sociaux familiaux des inégalités sociales de carie dentaire des enfants de Pikine.

**Méthode :** Une étude transversale a été menée sur 315 enfants de 3 à 9 ans et leurs mères du département de Pikine, Sénégal. Un examen clinique a servi à collecter les données de la carie dentaire des enfants ; un questionnaire pour les données socioéconomiques familiales. Les tests de chi-2 de Person et de tendance ont été utilisés dans les analyses et un modèle de régression logistique a été construit.

**Résultats :** La prévalence de la carie dentaire des enfants était de 64,8%. Le test de tendance a montré des inégalités significatives de carie dentaire selon le niveau de richesse ( $p < 0,001$ ) et la structure ( $p < 0,005$ ) des familles. Le modèle de régression logistique a établi une association significative entre le niveau de richesse familiale et la prévalence de carie dentaire des enfants avec une relation protectrice contre la carie de la modalité « famille riche » ([OR (IC95%) = 0,23(0,08-0,64)]) vis-à-vis de la modalité « famille pauvre ».

**Conclusion :** L'étude a identifié le niveau de richesse familiale et le niveau de peuplement des ménages comme étant des déterminants des inégalités sociales de la carie dentaire des enfants de Pikine. Dans les politiques locales ou nationales de réduction de la pauvreté, ces déterminants doivent être pris en compte dans une approche d'universalisme proportionné.

**Mots clé :** Déterminants sociaux, Carie dentaire, Famille, Enfant

### STH-5-S5-COL-57

**Facteurs limitant la prévention de la carie dentaire chez la femme enceinte dans le district sanitaire de Koupéla, Burkina Faso**

**Kaboré WAD<sup>1\*</sup>**, Garé JV<sup>1</sup>, Kouakou KF<sup>2</sup>, Ouédraogo CNT<sup>1</sup>, Zombo N<sup>3</sup>, Konsem T<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso

<sup>2</sup>Département d'Odontologie Conservatrice-Endodontie, UFROS/Université Félix Houphouët Boigny, 08 BP 3569 Abidjan 08, Côte d'Ivoire

<sup>3</sup>Ecole Nationale de Santé Publique, 01 BP 7002 Ouagadougou 01, Burkina Faso

**Introduction :** Ce travail avait pour objectif d'étudier les facteurs limitant la prévention de la maladie carieuse chez la femme enceinte dans le district sanitaire de Koupéla afin d'apporter une contribution à l'amélioration de sa santé orale.

**Méthodologie :** Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive qui a concerné les centres de santé et de promotion sociale de même que les prestataires de soins prénataux du district sanitaire de Koupéla durant la période du 15 au 29 février 2018. Les variables collectées étaient relatives à l'organisation du service en matière de prévention de la maladie carieuse et aux connaissances des agents sur la prévention de la carie dentaire chez la femme enceinte

**Résultats :** Au cours de la période d'enquête, 30 prestataires de soins dont 13 (43,3%) étaient des sages-femmes et maïeuticiens d'Etat et 17 (56,7%) des accoucheuses auxiliaires ont participé à l'étude. Il n'y avait ni de description de poste ni de répartition des tâches prenant en compte la prévention de la carie dentaire chez la femme enceinte. Les connaissances des agents en matière de santé bucco-dentaire et grossesse étaient insuffisantes.

**Conclusion :** Il est important que les professionnels de santé travaillant au contact des femmes enceintes puissent être attentifs à la santé orale de leurs patientes et qu'ils pensent à les orienter très précocement auprès du chirurgien-dentiste.

**Mots clés :** Carie dentaire, Prévention, Femme enceinte, District sanitaire

**\*Correspondance:**

Dr Wendpoulomé Aimé Désiré Kaboré

Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé

Université Joseph KI-ZERBO - 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso

Adresse email: dr\_kabore@yahoo.fr

Téléphone : +22670211283

WhatsApp : +22676417878

### STH-5-S5-COL-58

**La carie dentaire et ses complications : principaux motifs d'indication d'avulsion au centre municipal de santé bucco-dentaire de Ouagadougou, Burkina Faso**

**Kaboré WAD<sup>1\*</sup>**, Guiguimé WPL<sup>1</sup>, Seck A<sup>2</sup>, Bougoum S<sup>1</sup>, Nikiéma KR<sup>3</sup>, Bane K<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso

<sup>2</sup>Service d'Odontologie Conservatrice-Endodontie, Université Cheikh Anta Diop-Dakar BP 5005 Dakar-Liberté, Sénégal

<sup>3</sup>Ecole Nationale de Santé Publique, 01 BP 7002 Ouagadougou 01, Burkina Faso

**Introduction :** Ce travail a pour objectif d'étudier les déterminants de la fréquence élevée des complications carieuses nécessitant une avulsion dentaire afin de contribuer à l'amélioration de la santé orale de la population.

**Matériel et méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive, qui a concerné les patients ayant fréquenté l'UOCE du CMSBD durant la période du 12 au 26 février 2018. La population d'étude est constituée des patients chez qui des avulsions doivent être pratiquées pour cause de carie dentaire.

**Résultats :** Au cours de la période d'enquête, 108 patients dont 67,6 % de sexe féminin ont participé à l'étude. Les complications de la carie dentaire étaient dominées par l'abcès phœnix (58,4 %). Les molaires inférieures représentaient 87 % des dents présentant une complication carieuse nécessitant une avulsion. Soixante-dix-neuf patients ont utilisé l'automédication et/ou la pharmacopée traditionnelle comme premier recours thérapeutique face à la carie dentaire.

**Conclusion :** Dans la présente étude, la carie dentaire et ses pathologies pulpaire se sont avérées être les raisons les plus courantes d'extraction, avec les molaires inférieures comme étant les dents les plus fréquemment affectées. Ces résultats interpellent sur la mise en place d'un programme éducatif notamment en ce qui concerne les enfants.

**MOTS CLÉS :** Carie dentaire, Complications, Avulsion dentaire

### \*Correspondance:

Dr Wendpoulomdé Aimé Désiré Kaboré  
Unité de Formation et de Recherche en Sciences  
de la Santé  
Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021  
Ouagadougou, Burkina Faso  
Adresse email: dr\_kabore@yahoo.fr  
Téléphone : +22670211283  
WhatsApp : +22676417878

## STH-5-S5-COL-59

### Cancers de la cavité orale et facteurs associés en Afrique subsaharienne : revue systématique de la littérature

**Amadou Dieng**<sup>1,\*</sup> Ababacar Diegane Faye<sup>2</sup>,  
Mouhamadou Makhtar Ndiaye<sup>3</sup>, Gora Diop<sup>4</sup>,  
Serigne Ndamé Dieng<sup>1</sup>, Mbathio Diop<sup>1</sup>, Aida  
Kanouté<sup>1</sup>, Massamba Diouf<sup>1</sup>, Cheikh  
Mouhamadou M Lô<sup>1</sup> et Daouda Faye<sup>1</sup>

1 : Service de Santé Publique, Institut  
Odontostomatologie, Faculté de médecine, de  
Pharmacie et d'Odontostomatologie, UCAD, Dakar,  
Sénégal

2 : Service de Stomatologie et Chirurgie maxillo-  
faciale, UFRSS, UIDT, Thiès, Sénégal

3 : Service de Stomatologie et Chirurgie maxillo-  
faciale, Faculté de médecine, de Pharmacie et  
d'Odontostomatologie, UCAD, Dakar, Sénégal

4 : Département de Biologie Animale, FST, UCAD,  
Dakar, Sénégal.

\* : Auteur correspondant : Dr Amadou Dieng,  
Maître de conférences Assimilé en Santé Publique,  
Service de Santé Publique, Institut  
Odontostomatologie, Faculté de médecine, de  
Pharmacie et d'Odontostomatologie, UCAD, Dakar,  
Sénégal. 00221 773769006 / 766331143.  
[adieng00@gmail.com](mailto:adieng00@gmail.com)  
[amadou7.dieng@ucad.edu.sn](mailto:amadou7.dieng@ucad.edu.sn)

### Introduction

Les cancers de la cavité orale constituent  
aujourd'hui un problème de santé publique  
selon les données épidémiologiques de l'OMS.  
Il existe plusieurs facteurs associés aux cancers  
de la cavité orale mais ils sont variables selon  
les régions géographiques.

### Objectif

L'objectif de ce travail était d'identifier les  
facteurs associés aux cancers de la cavité orale  
chez les populations d'Afrique subsaharienne à  
travers une revue systématique de la littérature

### Méthode

A travers les données disponibles de la période  
de janvier 1980 à décembre 2019, une synthèse  
de la littérature a été réalisée. La stratégie de  
localisation des écrits comportait une recherche  
électronique dans les bases de données

MEDLINE, EMBASE et GOOGLE  
SCHOLAR de 1980 à 2019 et une recherche  
manuelle dans la liste des références des articles  
identifiés par effet boule de neige. Les données  
ont été extraites de façon indépendante par deux  
lecteurs sur un tableur Excel. Les paramètres  
recueillis de chaque étude étaient l'auteur, le  
pays, le type d'étude, la période d'étude,  
l'effectif, l'âge, le sexe et les facteurs étudiés.

### Résultats

Sur 1318 articles retrouvés, 24 ont été  
sélectionnés. Les données contenaient 17290  
patients dont 8229 hommes soit un sex-ratio  
0,91. Les facteurs étudiés étaient le tabac,  
l'alcool, l'alimentation, l'infection, la génétique  
et les facteurs sociaux.

### Conclusion

Les résultats rapportés montraient que plusieurs  
facteurs sont associés à la survenue des cancers  
de la cavité orale en Afrique subsaharienne.  
Leur identification et leur contrôle  
permettraient de réduire la morbidité et  
mortalité de cette pathologie.

**Mots clés :** Cancer, cavité orale, Afrique  
subsaharienne, Facteurs associés, Revue  
systématique.

## STH-5-S5-COL-60

### Prévalence des malocclusions dentaires et besoin en traitement orthodontique des élèves de la ville de Boromo.

**OUÉDRAOGO Y1**, LAMIEN Y1,  
SAWADOGO A2, OUÉDRAOGO CNT2,  
TOURÉ K3, SANGARÉ AD4,  
OUÉDRAOGO D2, BEUGRÉ JB 4.

- 1- Centre Hospitalier Universitaire Yalgado  
Ouédraogo-Université Joseph KI-ZERBO ;  
Burkina Faso.
- 2- Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo-  
Université Joseph KI-ZERBO ; Burkina Faso.
- 3- Département d'orthodontie-Centre Hospitalier  
Universitaire d'Odontostomatologie de Bamako  
; Mali.
- 4- Unité de Formation et de Recherche en  
Odontostomatologie-Université Félix Houphouët  
Boigny, Côte d'Ivoire.

Correspondance : Dr Youssouf OUEDRAOGO, e-  
mail : ouedraogoy@yahoo.fr

**Introduction\_ :** L'objectif de cette étude était  
d'estimer la prévalence des malocclusions et le  
besoin en soins orthodontiques chez les élèves  
de la ville de Boromo en utilisant l'index de  
besoin en traitement orthodontique.

**Méthodes\_ :** Il s'est agi d'une étude descriptive  
transversale effectuée du 25 mai au 7 juin 2018  
dans le Lycée Provincial de Boromo dans la

province des Balés. La collecte des informations a été faite avec la fiche d'enquête, la série de photographie de la composante esthétique et la réglette de la composante de santé dentaire de l'Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) par examen clinique.

**Résultats :** Au total 360 élèves âgés de 12 à 16 ans dont 176 garçons (49%) et 184 filles (51%) ont été examinés. Selon la perception de l'examineur 40,3% des élèves avaient un score de la composante esthétique compris entre 5-10 contre seulement 10,6% selon la perception des élèves avec un score entre 5-10. Pour la composante de santé dentaire 22,8% des élèves présentaient un surplomb positif exagéré et 42,7% des élèves avaient un besoin de traitement orthodontique.

**Conclusion :** La présente étude a permis de noter la méconnaissance des anomalies orthodontiques au niveau des élèves. Le besoin en soin orthodontique était présent chez deux élèves sur cinq. Ce besoin répond à la nécessité de correction des anomalies comme le surplomb, les encombrements dentaires, la supraclusion ou la béance dentaire.

**Mots clés :** malocclusions dentaires, IOTN, Burkina Faso.

## Sous-thème 5 Session 6

### STH-5-S6-COP-61

**Facteurs associés à l'administration tardive du BCG en milieu rural au Burkina Faso**

**M BOUNTOGO<sup>1</sup>**, M KAGONE<sup>1</sup>, O MILOGO<sup>1</sup>, Z C MEDA<sup>2</sup>, M YE<sup>1</sup>, A SIE<sup>1</sup>, T YAMEOGO<sup>2</sup>, E BIRBA<sup>2</sup>, M OUEDRAOGO<sup>2</sup>.

1 Centre de recherche en santé de Nouna

2 Université Nazi-Boni

Auteur correspondant : Bountogo Mamadou, [drbountogo@yahoo.fr](mailto:drbountogo@yahoo.fr)

**Introduction :** Plusieurs études démontrent l'efficacité de l'administration du vaccin *Bacille*

*Calmette-Guérin* (BCG) en période néonatale dans l'acquisition de l'immunité spécifique et non spécifique. Cette étude explore les facteurs explicatifs de l'administration tardive du BCG qui est très fréquent dans les pays en développement.

**Objectif :** l'objectifs de cette étude était d'identifier les facteurs associés à

l'administration tardive du BCG en milieu rural au Burkina Faso.

**Méthodologie :** Il s'est agi d'une étude transversale analytique et a concerné 184 enfants âgés de 6 mois à 36 mois dans 8 villages de l'aire du Système de surveillance démographique et de santé de Nouna (SSDSN), Burkina Faso. La force de l'association était calculée par des OR au seuil de 5%.

**Résultat :** Deux variables ont été retenues dans le modèle final avec une p-value de 0,0015.

Le niveau d'instruction était significativement associé au retard d'administration du BCG (OR=2,28 et IC<sub>95%</sub> : 1,00-5,47). Le deuxième facteur était l'accès à un poste téléviseur qui était statistiquement associé au retard à l'administration du BCG (OR=2,88 et IC<sub>95%</sub> : ,22-5,45).

**Conclusion :** Cette étude a permis de mettre en évidence des facteurs explicatifs de l'administration tardive du BCG qui se résument à une insuffisance dans l'accès à l'information.

**Mots clés :** BCG, Facteurs associés, Burkina, administration tardive

### STH-5-S6-COP-62

**Motifs et délai avant la ré-hospitalisation chez les nourrissons de 2 à 23 mois dans le service de pédiatrie du Centre Hospitalier Régional de Banfora, Burkina Faso.**

**Auteurs et affiliations**

**Abdoulaye Hama Diallo<sup>1,2</sup>**, Issaka Ouédraogo<sup>3,4</sup>, Hassane Cissé<sup>3,4</sup>, Roseline Maïmouna Bamouni<sup>3</sup> et Blaise Gnomou<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Département de Santé Publique, Centre MURAZ, 01 BP 390 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ;

<sup>2</sup>Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso ;

<sup>3</sup>Projet CHAIN-Burkina Faso, 01 BP 09 Banfora, Burkina Faso ;

<sup>4</sup>Centre Hospitalier Régional de Banfora, Burkina Faso.

### Introduction

Les 1000 premiers jours constituent une période critique dans la survie de l'enfant à cause d'un risque élevé de morbidité conduisant parfois à des ré-hospitalisations. La fréquence, les motifs et le délai moyen avant la ré-hospitalisation chez les nourrissons de 2 à 23 mois a été peu décrite au Burkina Faso.

### Objectif de l'étude

Décrire l'incidence, les motifs et le délai avant la ré-hospitalisation chez des nourrissons de 2 à

23 mois admis au Centre hospitalier régional de Banfora (CHR) de Banfora, Burkina Faso.

#### **Patients/méthodes**

Une étude de cohorte prospective a été conduite de Janvier 2018 à Janvier 2019 dans le service de pédiatrie du CHR de Banfora dans le cadre du Projet CHAIN-Burkina Faso. Les nourrissons de 2 à 23 mois éligibles à l'étude principale CHAIN-Burkina Faso ont été inclus, hospitalisés et suivis en post-hospitalisation pendant 6 mois. Les données sociodémographiques et cliniques ont été collectées à l'admission, à la sortie et lors des ré-hospitalisations pendant le suivi.

#### **Résultats**

Au total, 431 nourrissons de 2-23 mois ont été inclus durant la période d'étude. L'âge moyen des enfants à l'inclusion était de 12,5 mois  $\pm$  0,3. L'incidence cumulée des ré-hospitalisations était de 7,1% avec un IC à 95% de : 5,0%-10,0%. Les trois principaux motifs de ré-hospitalisation étaient respectivement l'anémie (55%), le paludisme grave (48%) et la malnutrition aiguë sévère avec complications (32%).

Le délai médian entre la sortie d'hôpital et la 1<sup>ère</sup> ré-hospitalisation était de 77 jours avec un intervalle interquartile de 51. La durée médiane du séjour lors de la 1<sup>ère</sup> ré-hospitalisation a été de 5,8 jours avec une issue favorable chez 90% des enfants.

#### **Conclusion**

L'incidence des ré-hospitalisations reste importante chez les nourrissons de 2-23 mois au Burkina Faso suggérant une sortie d'hôpital sans rémission complète ou un contexte de forte charge morbide sur malnutrition.

**Mots clés :** rehospitalisation, nourrisson, Burkina Faso

### **STH-5-S6-COP-63**

#### **Prévalence et facteurs associés à la mise au sein précoce en milieu rural au Burkina Faso**

**Auteurs et affiliations:** DIALLO Abdoulaye Hama<sup>1,2</sup>, BAMOUNI Roseline Maimouna<sup>1</sup>, OUATTARA Seydou<sup>1,2</sup>, OUEDRAOGO Souleymane<sup>1</sup>, SARRASSAT Sophie<sup>3</sup>, CRESSWELL Jenny A<sup>3</sup>, COUSENS Simon<sup>3</sup> et FILIPPI Véronique<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Département de santé publique, Centre MURAZ, Ministère de la Santé, 01 BP 390 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

<sup>2</sup>Département de santé publique, UFR-SDS, Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso

<sup>3</sup>Centre for Maternal, Adolescent, Reproductive & Child Health, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom

#### **Introduction :**

L'OMS recommande la mise au sein précoce comme une pratique essentielle pour la survie des nourrissons. Nous avons évalué la prévalence et les facteurs associés à la mise au sein précoce dans une région du Burkina Faso dans le contexte d'une intervention de promotion des bonnes pratiques nutritionnelles du nourrisson en milieu rural.

#### **Méthodes :**

Une enquête transversale prospective a été conduite en 2016 dans 12 villages sélectionnés aléatoirement. Les couples mères-enfants dont les bébés avaient moins de 6 mois ont été sélectionnés aléatoirement à partir des registres de maternités locales. Un questionnaire semi-structuré avec 3 volets (sociodémographique, nutritionnel et anthropométrique) a été administré aux mères consentantes lors d'une visite à domicile. Les données ont été saisies sur Epidata et analysées sur le logiciel Stata. Une analyse descriptive et une régression logistique ont été utilisées.

#### **Résultats :**

Au total, 157 couples mères-enfants ont été inclus. La prévalence de la mise au sein précoce était de 17,8% (IC à 95% : 9,4-31,2). L'on a noté que 65,6% des mères ont rapporté avoir mis le bébé au sein entre 1-12h après l'accouchement. Le seul facteur significativement associé à cette pratique était le bras interventionnel (OR=8,64 ; IC à 95 : 2,67-279) dans l'analyse multivariée. Ni l'âge, ni le niveau socioéconomique, ni la profession de la mère n'étaient associés à cette pratique.

**Conclusion :** Le taux de mise au sein précoce est très faible en milieu rural au Burkina Faso et la promotion du recours à cette pratique en milieu communautaire et au CSDS est une urgence.

**Mots clés :** Prévalence-Mise au sein précoce-Burkina Faso.

### **STH-5-S6-COP-64**

#### **L'obésité des adolescents : un problème émergent en milieu scolaire au Burkina Faso**

**Dahourou Désiré Lucien<sup>1</sup>**, Kiendrebéogo Rahiesse Philippe<sup>2</sup>, Comboigo O Narcisse<sup>3</sup>, Kiendrebéogo Joël Arthur<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut de Recherche en Sciences de la Santé,  
Département Santé

Publique/Biomédical, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>2</sup>Master santé Publique, Université Joseph Ki-Zerbo,  
Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>3</sup>Unité de formation et de recherche en Sciences de  
la Santé, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou,  
Burkina Faso

<sup>3</sup>Département de santé Publique, Université Joseph  
Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

**Introduction :** Peu de données existent sur  
l'état nutritionnel des adolescents au Burkina  
Faso. Nous avons décrit le profil nutritionnel et  
identifier les facteurs associés au  
surpoids/obésité des adolescents dans la ville de  
Ouagadougou.

**Méthode :** Nous avons mené une étude  
transversale en juin 2019, incluant des  
adolescents scolarisés âgés de 11 à 19 ans dans  
la ville de Ouagadougou. Les facteurs associés  
au surpoids/obésité ont été étudiés par une  
régression logistique.

**Résultats :** Au total, 535 adolescents (58% de  
filles) ont été inclus, à un âge médian de 16 ans  
(intervalle interquartile (IIQ) : 14-18 ans). Deux  
tiers des adolescents pratiquaient une activité  
sportive en dehors des heures de classe (68%),  
d'une durée hebdomadaire de 45 minutes en  
médiane, et se rendaient à l'école à pieds ou à  
bicyclette (65%). L'indice de masse corporelle  
médian était de 20,7 kg/m<sup>2</sup> (IIQ : 18,59-23,04).  
Un adolescent sur cinq (19%) était en surpoids  
ou obèse, tandis que 12% avait un retard de  
croissance staturale. En analyse multivariable,  
l'utilisation d'un moyen de déplacement non  
motorisé pour se rendre à l'école (Odds ratio  
ajusté [ORa] : 0,44, Intervalle de confiance à  
95% [IC95%] : 0,27-0,74), et pour les courses  
(ORa : 0,33, IC95% : 0,20-0,55) protégeait du  
surpoids/obésité.

**Conclusions :** Le surpoids/obésité des  
adolescents est un problème émergent au  
Burkina Faso. La promotion d'une activité  
physique régulière et la mise en œuvre  
d'interventions de prévention de l'obésité  
devrait permettre de prévenir la survenue des  
comorbidités associées à l'obésité.

**Mots clés :** Etat nutritionnel, obésité, surpoids,  
adolescents scolarisés, Burkina Faso.

## STH-5-S6-COP-65

Connaissances, attitudes et pratiques du

## personnel paramédical féminin du district sanitaire de Tivaouane de la Région Médicale de Thiés vis-à-vis du cancer du col de l'utérus en 2020

**Ousseynou Ka<sup>1</sup>**, Aïssatou Diop Dia<sup>2</sup>, Cheikh  
Tacko<sup>1</sup> Diop, Boubacar Gueye<sup>1</sup>, Fatou Oumar  
Sy Sylla<sup>1</sup>, Mountaga Elimane Dia<sup>1</sup>, Abdoul  
Aziz Ndiaye<sup>1</sup>, Papa Gallo Sow<sup>1</sup>.

**Affiliations :**

<sup>1</sup>Département Santé Communautaire de l'UFR  
Santé et Développement Durable UAD de  
Bambey, <sup>2</sup>UFR des Sciences de la Santé de  
l'UIDT de Thiés,

**Auteur correspondant :** Ousseynou Ka – Email :  
[ousseynou.ka@uadb.edu.sn](mailto:ousseynou.ka@uadb.edu.sn) ou  
[siboryka@gmail.com](mailto:siboryka@gmail.com) – Tél : 00 221 77 616 49 98 –  
BP : 7568 Dakar Médina Sénégal.

**Introduction :** Le cancer du col de l'utérus  
constitue un problème de santé publique et la  
lutte contre celle-ci nécessite sa bonne  
connaissance par le personnel paramédical.  
L'objectif de cette étude était d'évaluer le  
niveau de connaissances, d'attitudes et de  
pratiques de ce personnel vis à vis de cette  
affection.

**Méthodologie.** Il s'agissait d'une étude  
transversale descriptive, réalisée de Juin à  
Octobre 2020 auprès du personnel paramédical  
féminin du district sanitaire de Tivaouane de la  
Région Médicale de Thiés du Sénégal.

**Résultats :** La population d'étude était  
constituée de 114 agents paramédicaux avec un  
taux de scolarisation de 95,6%. Presque tous les  
agents (99,1%) avaient entendu parler du cancer  
du col utérin, 77,2% estimaient pouvoir le  
définir mais seulement 47,7% l'ont bien défini.  
Le niveau de connaissances était de 29,8%  
pour la population à risque, de 4,4% pour la  
notion héréditaire dans la survenue du cancer,  
de 7,9% pour les facteurs de risque, de 43,9%  
pour les symptômes et de 66,3% pour la  
prévention vaccinale. Parmi les agents de santé  
84,2% avaient affirmé que le cancer du col  
n'était pas curable, 4,4% faisaient confiance à la  
médecine traditionnelle, 55,3% avaient déjà  
conseillé à des femmes de faire le dépistage  
systématique, 65,8% avaient effectué un test  
dépistage du cancer du col, 29,8% avaient  
bénéficié d'une formation sur le cancer du col  
et 98,2% avaient exprimé le besoin de  
formation. Le niveau de connaissance du cancer  
était corrélé à la profession sage-femme et le

niveau d'instruction alors que celui de la vaccination à la profession infirmières.

**Conclusion :** Le niveau de connaissance du personnel paramédical du district était insuffisant d'où l'intérêt de mettre en place une formation continue sur cette affection pour ce personnel afin de renforcer leurs connaissances et compétences vis-à-vis de cette affection.

**Mots clé :** cancer du col utérin, personnel paramédical féminin, connaissances, région médicale de Thiés

## STH-5-S6-COP-66

**Impacts possibles de la COVID-19 sur la santé de la mère et de l'enfant. État des lieux en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso.**

**Hien Hervé<sup>1,3</sup>**, Ilboudo Bernard<sup>1,3</sup>, Sakana leticia<sup>1</sup>, kpoda Hervé<sup>1</sup>, Mien Awa<sup>1</sup>, Badolo Hermann<sup>1</sup>, Bazié Herman<sup>1</sup>, Somé Arsène<sup>1</sup>, Nana W. Félicité<sup>2</sup>, Bocom Fadima<sup>2</sup>, Kadio Kadidia<sup>2</sup>, Meda Clement<sup>1,3</sup>, Drabo K. Maxime<sup>2</sup>

**Affiliations :** 1 : programme de recherche système de santé et capitalisation/INSP, 2 : Unité de recherche politique et système de santé/CNRST, 3 : INSSA/UNB

Au 18 juillet 2021, le monde comptait 190 169 833 COVID-19 cas confirmés et 4 086 000 décès . En Afrique la situation est marquée par une tendance à la hausse du nombre de cas hebdomadaires (+ de 20 % d'augmentation/Semaine) faisant craindre une autre vague. La covid-19 au-delà des conséquences sur les populations a eu des impacts négatifs sur les indicateurs importants des systèmes de santé notamment les progrès que commençaient à enregistrer la santé maternelle et infantile. L'objectif de cette étude était de faire une revue de littérature relative à un état de lieux épidémiologique de la covid-19 au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest et de présenter les impacts possibles sur la santé maternelle et infantile. Au cours des 5 prochaines années la covid-19 et ses prédictions vont impacter négativement l'offre des services et des soins en faveurs des femmes et des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les expériences actuelles nous enseignent que la promotion de la santé par la vaccination est une bonne arme pour stopper la maladie et espérer

une relance des indicateurs de la santé maternelle et infantile.

**Mots clés :** COVID-19, santé maternelle, infantile, vaccination

## STH-5-S6-COP-67

**Effets de la politique de gratuité des soins sur la fréquentation des services de santé par les enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso : analyse en séries chronologiques interrompues**

**Siaka Debe<sup>1</sup>**, Patrick G Ilboudo<sup>2</sup>, Lassane Kabore<sup>3</sup>, Noellie Zoungrana<sup>4</sup>, Adama Gansane<sup>1</sup>, Valery Ridde<sup>5</sup>, Vincent De Brouwere<sup>6</sup>, Fati Kirakoya Samandoulougou<sup>7</sup>

### Affiliations

<sup>1</sup>National Center for Research and Training on Malaria Ouagadougou, Burkina Faso, <sup>2</sup>African Population and Health Research Center, Nairobi, Kenya, <sup>3</sup>Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva, Geneva, <sup>4</sup>Hospital Tengandogo, Ouagadougou, Burkina Faso, <sup>5</sup>School of Public Health, University of Montreal, Montreal, Canada, <sup>6</sup>Institute of Tropical Medicine Antwerp, Brussels, Belgium, <sup>7</sup>University libre of Brussels, Brussels, Belgium

### Introduction

Les frais de santé sont largement reconnus comme le principal obstacle à la fréquentation des services de soins dans de nombreux pays en développement. Le Burkina Faso a mis en place, en avril 2016, une politique de gratuité des soins à l'échelle nationale au profit des enfants de moins de cinq ans. Cette étude vise à analyser l'effet de cette politique sur le recours aux soins des enfants dans les services de santé publiques du pays.

### Méthodes

Les données du SNIS ont été utilisées. La variable de résultat était le nombre de visites des centres de santé effectuées pour les enfants de moins de cinq ans. Une analyse de séries chronologiques interrompues a été réalisée pour comparer les données dans les 70 districts sanitaires du pays. Une régression binomiale négative multivariée a été utilisée pour modéliser le nombre de visites dans les centres de santé.

### Résultats

L'étude montre une augmentation des visites dans les centres de santé de 57% (IRR= 1,57 ; 95% IC=1,214-2,040) dans le mois suivant immédiatement la mise en œuvre de la politique. Pendant la période d'intervention, il y a une augmentation mensuelle à long terme de 1% (IRR=1.01 ; 95% IC=1.005-1.016) par rapport à la tendance sous-jacente.

#### **Discussion/Conclusion**

L'efficacité de la volonté politique, la mobilisation sociale et des campagnes médiatiques mises en place pour informer les communautés cibles de la politique de gratuité des soins pendant le mois précédant sa mise en œuvre pourrait expliquer l'effet positif rapide de ladite politique. Cependant, l'effet à long terme était faible, soulevant ainsi des inquiétudes quant aux défis que représente le maintien d'une telle politique dans un contexte d'insécurité et de limitations financières.

**Mots-clés :** Soins de santé ; Enfant de moins de 5 ans ; Politique de gratuité des soins  
Services de santé ; Burkina Faso

### **STH-5-S6-COL-68**

#### **Evaluation qualitative du projet pilote des sage-femmes itinérantes (SAFI) dans le district de Thilogne au Sénégal**

**Papa Gallo sow<sup>1</sup>**, Martial Coly Bop<sup>1</sup>, Ndéye Fatou N'diaye Sy<sup>1</sup>, Touba Gueye<sup>1</sup>

1. Université de Bambey/Sénégal/ Email: papagallosow@uadb.edu.sn

#### **Introduction**

Au Sénégal, les taux élevés de mortalité maternelle (392 pour 100000), infantile (33 pour 1000) sont dus en grande partie à un accès inadéquat à des services de santé de qualité, une insuffisance du personnel de santé qualifié. La région de Matam est l'une des régions pilotes de la stratégie SAFI grâce à ses indicateurs élevés allant jusqu'à 741 pour 1000 concernant la mortalité maternelle, 39 pour 1000 pour la mortalité néonatale.

#### **Objectif**

Cette étude vise à documenter le projet pilote de sages-femmes itinérantes dans le district de Thilogne, évaluer la mise en œuvre des activités d'itinérance, apprécier la perception des parties prenantes.

#### **Méthodologie**

Le cadre d'étude est constitué du district de Thilogne dont la population de l'étude est composée des SAFI, des informateurs clés

(autorités sanitaires, collectivités locales, chefs de poste), des ACS, des communautés et des partenaires. L'étude est du type descriptif transversal.

#### **Résultats**

La stratégie a été très bénéfique car elle a permis de réduire la mortalité maternelle et infantile dans la région de Matam, de prendre en charge de façon précoce les femmes présentant des signes de gravité lors de la grossesse et des complications pendant l'accouchement

Elle a aussi entraîné l'augmentation de la fréquentation en termes d'utilisation des services, la hausse du taux de prévalence contraceptive mais aussi le renforcement de la prise en charge des enfants de 0-5 ans.

#### **Conclusion**

La stratégie des Sages-femmes itinérantes financée par la fondation Bill et Melinda Gates est très bien accueillie dans la région de Matam particulièrement dans le district de Thilogne car elle a permis aux populations des zones défavorisées d'accéder aux soins et services de santé. Elle a contribué à l'amélioration des indicateurs de santé de la reproduction et réduit les accouchements à risque.

**Mots clés :** Mortalité, Stratégie SAFI, Région pilote

### **STH-5-S6-COL-69**

#### **Contribution des écoles des maris (EDM) du District Sanitaire (DS) de Matamèye dans la promotion de la santé maternelle au Niger en 2018**

**<sup>1</sup>Goni A. M. Bachir,** <sup>2,3</sup>Haggar ELI Kadela, <sup>1</sup>Mahamane Moumouni, <sup>1</sup>Magagi Ali, <sup>4</sup>Ibrahim Alkassoum

<sup>1</sup> Direction de la Surveillance et de la Riposte aux Epidémies (DSRE) du Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AP);

<sup>2,3</sup> Direction Régionale de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales de Diffa (MSP/P/AP); Institut de Santé Pratique de Niamey ;

<sup>4</sup> Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey, Hôpital Général de Référence (HGR) de Niamey.

**Présentateur :** GONI DIT ALASSAN Maman Bachir, email : gonialassan@yahoo.fr

**Introduction :** La santé maternelle (SM) est l'un des principaux indicateurs poursuivis par les autorités sanitaires. Pour améliorer la situation, l'Etat et ses partenaires ont mis en œuvre plusieurs stratégies dont l'« EDM ».

**Objectif principal :** est d'étudier la contribution des EDM dans la promotion de santé de la reproduction (SR).

**Méthodologie :** C'était une étude transversale dans six 1<sup>ers</sup> centres (villages) des EDM du DS de Matamèye région de Zinder. Tous les 60 membres des douze EDM ont été enrôlé et de façon aléatoire 120 chefs de ménages (CM) de ces six villages ont été interviewé. Une grille d'analyse documentaire et l'observation lors d'animation des douze membres des EDM ont aidé pour la collecte. Les données étaient présentées sous forme d'effectifs et pourcentages et sous forme des moyennes avec écart type.

**Résultats :** Dans cette étude aucun membre d'EDM n'a été supervisé en 2017. Il n'a reçu aucune formation sur les thématiques recommandées et ne dispose d'aucun support de collecte et de transmission des données de même qu'il n'a établi aucun plan d'action. Les CM qui accompagnaient leurs femmes au centre de santé étaient les plus représentés 82%. Ceux qui dialoguaient avec leurs épouses sur la SR étaient les plus nombreux 58% et ceux qui discutaient sur la CPNR représentaient 78,57%. Les CM affirmaient avoir rencontré des difficultés en utilisant les services 69% parmi lesquels 94% avaient eu de problème dès l'accueil.

**Conclusion :** Cette initiative a pris sa source des résultats de l'enquête menée par le LASDEL et l'UNFPA sur la problématique de la SR. Les résultats de cette étude montrent que l'implication des hommes dans les questions de la SM s'avère très nécessaire d'où importance de sa mise à l'échelle au niveau national et sous régional.

**Mots clés :** Ecoles des maris, districts sanitaires, Niger

## STH-5-S6-COL-70

**Violences basées sur le genre : Evolution et perspectives de lutte contre les mutilations génitales féminines au Bénin**

**Pacôme Evènakpon ACOTCHEOU**<sup>1,2</sup>, Jacques Zinsou SAIZONOU<sup>1,2\*</sup>, Alphonse Mingnimon AFFO<sup>2,3</sup>, Justin DANSOU<sup>2,4</sup>

<sup>1</sup>Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRS/CAQ), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

<sup>2</sup>Groupe de Recherche en Population Santé et Développement (GRPSD)

<sup>3</sup>Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFORP), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

<sup>4</sup>Ecole Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie (ENSPD), Université de Parakou, Bénin.

\*Auteur correspondant : Pacôme Evènakpon ACOTCHEOU, Doctorant, 04 BP 109 Cotonou Bénin, Tel : 229 97 32 97 36, E-mail : [pacomeacotcheou@yahoo.fr](mailto:pacomeacotcheou@yahoo.fr)

**Contexte :** Bien que reconnu comme une pratique néfaste à la santé les mutilations génitales féminine (MGF), demeurent une réalité au Bénin. La présente étude vise à analyser le phénomène au cours des vingt dernières années et à dégager les perspectives de lutte.

**Objectif :** La présente étude vise à analyser la pratique des mutilations génitales féminines chez les adolescentes au Bénin en identifiant les sources des changements intervenus tout en mettant en exergue les déterminants temporels du phénomène, les mécanismes d'action ainsi que les perspectives.

**Méthodologie :** L'étude recourt aux données des EDSB de 2001 et 2011 ainsi qu'à l'enquête de 2020 sur la persistance des MGF. Elle porte sur 1223 adolescentes de 15-19 ans en 2001, 2922 en 2011 et 1439 en 2020. L'analyse de décomposition, l'AFCM et la régression logistique ont été effectuées.

**Résultats :** Les changements proviennent essentiellement de l'effet de comportement. Les déterminants sont : le département, religion, ethnie, l'activité économique, le statut matrimonial et les caractéristiques des parents. Les adolescentes favorables au maintien des MGF vivent en milieu rural dans l'extrême Nord, sans instruction, ignorantes des droits des enfants, de la législation interdisant les MGF, et des actions de lutte.

**Conclusion :** Orienter les actions à court terme sur la base des facteurs socioculturels et les perceptions et attitudes des parents alors que les perspectives à long terme doivent prendre en compte le profil des adolescentes favorables au maintien des MGF.

**Mots clés :** Mutilation génitale féminine, évolution, perspective, Bénin.

## STH-5-S6-COL-71

**Épidémiologie de l'insuffisance pondérale chez les nourrissons dans les zones rurales du Burkina Faso**

Ali Sié<sup>1</sup>, **Mamadou Ouattara**<sup>1</sup>, Mamadou Bountogo<sup>1</sup>, Clarisse Dah<sup>1</sup>, Guillaume Compaore<sup>1</sup>, Elodie Lebas<sup>2</sup>, Jessica M. Brogdon<sup>2</sup>,

Ying Lin<sup>2</sup>, William W. Godwin<sup>2</sup>, Kieran S. O'Brien<sup>2,3</sup>, Benjamin F. Arnold<sup>2,4</sup>, Thomas M. Lietman<sup>2,4,5</sup>, Catherine E. Oldenburg<sup>2,4,5</sup>

Présentateur : Mamadou Ouattara

Email : [md.ouattara@yahoo.fr](mailto:md.ouattara@yahoo.fr)

1 Centre de Recherche en Santé de Nouna, Burkina Faso;

2 Francis I Proctor Foundation, University of California, San Francisco, California ;

3 Division of Epidemiology and Biostatistics, University of California, Berkeley, California; 4 Department of Ophthalmology, University of California, San Francisco, California;

5 Department of Epidemiology and Biostatistics, University of California, San Francisco, California

### Introduction :

On pense que la dénutrition infantile contribue à l'échec de la croissance et à la mortalité. Nous avons évalué les tendances de l'insuffisance pondérale dans un échantillon basé sur la population d'enfants âgés de 1 à 11 mois dans les zones rurales du nord-ouest du Burkina Faso.

### Objectif principal :

Décrire l'épidémiologie de l'insuffisance pondérale chez les nourrissons âgés de 1 à 11 mois dans un échantillon basé sur la population dans les zones rurales du Burkina Faso et évaluer les déterminants potentiels de la dénutrition

### Méthodologie :

Les données ont été recueillies lors de l'évaluation de base d'un essai randomisé communautaire évaluant la distribution massive d'azithromycine dans le district de Nouna, au Burkina Faso. Un recensement porte-à-porte a été entrepris pour tous les ménages de toutes les collectivités. Les nourrissons âgés de 1 à 11 mois ont été pesés et leurs poids ont été utilisés pour calculer les rapport poids/âge (RPA). L'insuffisance pondérale a été définie comme un  $RPA \leq 2$ . Nous avons évalué les tendances d'âge dans le RPA et l'insuffisance pondérale en fonction des caractéristiques démographiques, saisonnières et géographiques.

### Résultats :

Sur 7 109 nourrissons, 6 077 avaient un poids précis et des données de coordonnées du système de positionnement global (GPS) (85,5 %). Les nourrissons étaient âgés d'une médiane de 6 mois (intervalle interquartile [IQR] 3-8) et 48,4% étaient des femmes. Le rapport poids/âge (RPA) moyen était de 0,68 (ET 1,6) et 19,0 % étaient dénutris. Le RPA a diminué avec l'âge, et la prévalence de l'insuffisance pondérale est

passée de 2,5 % chez les enfants de 1 mois à 27,6 % chez les enfants de 11 mois. L'insuffisance pondérale était plus fréquente chez les garçons que chez les filles (22,1 % chez les garçons contre 15,6 % chez les filles). L'amélioration de l'utilisation des latrines par le ménage était associée à une augmentation du RPA, et cet effet était plus fort chez les garçons que chez les nourrissons de sexe féminin.

### Mots clés :

Insuffisance pondérale, nourrissons, milieu rural, Burkina Faso

## STH-5-S6-COL-72

### Facteurs associés à la mise en œuvre des recommandations des audits de décès maternels dans deux zones sanitaires au Bénin

SAIZONOU Jacques<sup>1</sup>, ZANNOU Robert Franck<sup>2</sup>, AGOSSOU Beniel<sup>3</sup>, DENAKPO Justin<sup>4</sup>

1 Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenum de Ouidah

2. Direction de la Santé Mère-Enfant du Ministère de la santé du Bénin

3 Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie de Cotonou

4 Faculté des sciences de la santé de Cotonou

**Introduction :** La mise en œuvre des recommandations issues des audits de décès maternels est une des clés de succès de la SDMR. Aucune étude n'a été retrouvée sur les facteurs associés à la mise en œuvre des recommandations depuis l'avènement de la SDMR au Bénin et dans les pays en développement. L'objectif est d'étudier les facteurs associés à la mise en œuvre des recommandations issues des audits de décès maternels dans la zone sanitaire Cotonou 5, et celle de Pobè\_Adja-Ouère\_Kétou (PAK) au Bénin.

**Méthode d'étude :** Il s'est agi d'une étude transversale analytique qui a porté sur toutes les recommandations formulées dans ces deux zones sanitaires du Janvier 2016 à juin 2019. Des entretiens semi structurés individuels ont été réalisés ainsi que l'exploitation documentaire. Une analyse bivariée a été effectué pour identifier les facteurs associés à la mise en œuvre des recommandations issues des audits de ces décès maternels.

**Résultats :** 523 recommandations ont été retrouvées dans les rapports d'audits et 38,0% des recommandations formulées ont été mises

en œuvre. Les cibles visées ( $p=0,002$ ), la responsabilisation d'une personne ( $p=0,001$ ), la revue des recommandations à l'audit suivant ( $p=0,011$ ), la présence du gynécologue ( $p=0,013$ ) étaient significativement associées à la mise en œuvre des recommandations de ces audits ainsi que la présence de la maîtresse sage-femme. Les facteurs contextuels comme l'organisation du comité d'audit, son fonctionnement, le profil des membres, le leadership et la formation à la SDMR de ses membres influencent la mise en œuvre.

**Conclusion :** Le niveau de mise en œuvre des recommandations issues des audits de décès maternels est très faible. Les actions doivent être focalisées sur les facteurs identifiés pour améliorer la SDMR au Bénin.

**Mots clés :** recommandations, audits, décès maternels, mise en œuvre, Bénin.

## Sous-thème 5 Session 7

### STH-5-S7-COP-73

**Etude de l'activité hépatoprotectrice de l'extrait aqueux de *Celosia trigyna* linn chez le rat de souches wistar**

**SAWADOGO Touwindséda Aimée**<sup>1</sup>,  
OUEDRAOGO Youssoufou<sup>1</sup>,

Da Filkpière Léonard<sup>2</sup> et Balé Bayala<sup>1</sup>

1. Université Joseph KI-ZERBO/ Ecole Doctorale  
Sciences et Technologies/ Laboratoire de  
Physiologie Animale (LAPA), 03 BP 7021  
Ouagadougou 03, BURKINA FASO  
E-mail : wendja258@yahoo.fr

2. Université Norbert Zongo de Koudougou, BP :  
376, Burkina Faso.

**Introduction :** Les plantes hépatoprotectrices sont utilisées dans le traitement des hépatites.

**Objectif :** le but de cette étude était de déterminer les propriétés hépatoprotectrices de l'extrait aqueux de *Celosia trigyna* Linn (Amaranthaceae) sur des rats Wistar femelles.

**Méthodologie :** l'extraction des principes actifs a été réalisée par macération des parties aériennes de la plante.

Les rats ont été répartis en six lots de cinq rats. L'administration de l'extrait et des autres produits a été faite par gavage à dose unique. Le lot contrôle neutre a été traité au NaCl 0,9 %. Les lots contrôles négatifs, positifs, tests ont été traités au paracétamol 1 g/kg pc et ont reçu

respectivement du NaCl 0,9 %, du légalon 70 mg / kg et l'extrait aqueux de *Celosia trigyna* aux doses de 50, 100 et 250 mg / kg pc. L'induction de l'hépatotoxicité au paracétamol a été faite deux fois par semaine. Les traitements à l'extrait et à la molécule de référence ont été faits tous les trois jours pendant trois semaines.

Le logiciel GraphPad Prism 5.03 a été utilisé pour les tests statistiques et les représentations graphiques. Le Seuil de significativité à 5 % a été fixé pour la comparaison des moyennes

**Résultats :** le taux des transaminases, de bilirubines directe et totale, de la phosphatase alcaline a varié significativement chez les rats traités par rapport aux rats contrôle neutre. L'augmentation sérique des marqueurs de la fonction hépatique dans le lot contrôle négatif indique l'hépatotoxicité du paracétamol. Dans les lots tests, la réduction sérique des enzymes du foie prouve un effet hépatoprotecteur de *Celosia trigyna*.

**Conclusion :** les données biochimiques confirment les propriétés hépatoprotectrices de l'extrait aqueux de *Celosia trigyna* comparable à celles de légalon.

**Mots clés :** *Celosia trigyna*, hépatoprotection, paracétamol, rats, Légalon.

### STH-5-S7-COP-74

**Audit de gestion et pratiques de prescription en consultation de médecine dans les hôpitaux de district, région des Hauts-Bassins, Burkina-Faso**

**Méda ZC**<sup>1,2</sup>, Ilboudo DGP<sup>1</sup>, Konaté I<sup>6</sup>, Hien L<sup>5</sup>,  
Ilboudo B<sup>3,4</sup>, Sombié I<sup>1,7</sup>, Ouédraogo SM<sup>1,2</sup>

1 Institut supérieur des sciences de la santé,  
Université Nazi Boni, Burkina Faso

2 Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou,  
Burkina Faso

3 Institut national de santé publique, Burkina Faso

4 Centre MURAZ/Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

5 Ministère de la santé, Burkina Faso

6 Direction régionale de la santé des Hauts Bassins,  
Burkina Faso

7 Organisation Ouest Africaine de la santé (OOAS)

**Introduction :** La prescription médicale engage la responsabilité du médecin ; elle doit être aisément exploitable, afin d'aboutir à la gestion rationnelle des médicaments.

**Objectif :** Etudier les déterminants liés aux pratiques de prescription médicale en consultation de médecine générale.

**Méthode :** Il s'est agi d'une étude transversale descriptive, à recueil prospectif. Ont été inclus dans notre étude, tous les patients reçus en consultation de médecine générale et les responsables des centres médicaux avec antenne chirurgicale de la région des Hauts-bassins.

**Résultats :** Au total 151 patients ont été inclus dans notre étude. La consultation de suivi représentait 52,3%. La durée moyenne de la consultation médicale était de 19,5 minutes ; [3 à 50] minutes. La lisibilité était bonne dans 53,6 % ; le nom de l'établissement sanitaire et la date de prescription étaient présents dans 89,9% et 98,7% respectivement. Le nom du prescripteur et sa qualification étaient présents dans 94,7% et 46,4% respectivement. Le score moyen de la qualité rédactionnelle d'une ordonnance médicale était à 10,1 +/- 0,1. Le nombre moyen de médicaments prescrits par patient était de 1,78. Les antalgiques étaient les plus prescrites avec 15,9%. Les spécialités pharmaceutiques représentaient 84,1%. Le coût moyen d'une ordonnance s'élevait à 7 613 F CFA. L'audit organisationnel révélait que l'ensemble des structures évaluées ne répondait pas aux normes de bonne gestion des médicaments.

**Conclusion :** Dans notre étude, relève une faiblesse de la prescription rationnelle dans nos structures de santé, ainsi que des dysfonctionnements dans la gestion des médicaments dans les hôpitaux de district.

**Mots clés :** usage rationnel, gestion des médicaments, qualité

## STH-5-S7-COP-75

### Evolution des dépenses de santé des ménages dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso de 2010 à 2019

**Edouard A. AKOTIONGA**<sup>1</sup>, Simon NASSA<sup>2</sup>, Vincent BATIENÉ<sup>2</sup>, Théophile Sanou<sup>2</sup>, Abdoulaye P. NITIEMA<sup>3</sup>, Ali Ouattara<sup>4</sup>, Léodégal BAZIRA<sup>5</sup>, Saidou YONABA<sup>6</sup>, Fidèle BAKIONO<sup>6</sup>

1. Consultant indépendant Ouagadougou, Burkina Faso ;

2. Ministère de la santé Ouagadougou, Burkina Faso ;

3. Institut national de santé publique (INSP) Ouagadougou, Burkina Faso ;

4. Programme d'appui aux Programmes de santé de l'Union Européenne (PAPS/UE) Ouagadougou, Burkina Faso ;

5. Faculté de Médecine de Bujumbura Université du Burundi ;

6. Service de santé des armées Ouagadougou, Burkina Faso.

*Auteur principal :* Edouard A. AKOTIONGA

email: [eakotionga@yahoo.fr](mailto:eakotionga@yahoo.fr);

[aedouardako@gmail.com](mailto:aedouardako@gmail.com)

### Introduction :

Le paludisme demeure un problème de santé publique dans le monde et en Afrique. Au Burkina Faso (BF), 41,5% des consultations et de 36,3% % des décès sont liés au paludisme. Ceci constitue un lourd fardeau pour les ménages tant sur le plan sanitaire, qu'économique malgré les efforts de l'Etat et ses partenaires dans la mobilisation et l'utilisation des ressources financières pour les interventions de lutte contre le paludisme.

L'objectif de cette étude est d'évaluer le poids des dépenses réalisées par les ménages dans la prise en charge du paludisme au Burkina Faso entre 2010 et 2019.

### Méthodologie :

Nous avons réalisé une analyse des données issues des comptes de santé et des annuaires statistiques du Ministère de la santé du Burkina Faso couvrant la période de 2010 à 2019. Les données ont été analysées à l'aide des logiciels Excel 2019 et Stata 14. Les comparaisons de proportions ont été faites à l'aide du test Khi2 avec un seuil de signification fixé à 5%.

### Résultats :

Les dépenses des ménages dans la lutte contre le paludisme ont connu une tendance à la baisse entre 2010 et 2019. Ces dépenses sont passées de 30,191 en 2010 à 23,315 milliards de FCFA en 2019. La part des dépenses des ménages dans les dépenses totales de lutte contre le paludisme est passée de 40,3 % en 2010 à 31,0% en 2019 avec une moyenne annuelle de 37,2% et une réduction non significative de 9,3 points en dix ans ( $p=0,23$ ). Ces dépenses ont principalement servi à l'achat des médicaments (48%), aux soins ambulatoires (32%), et aux soins curatifs hospitaliers (17%).

### Conclusion :

La part des ménages dans les dépenses totales de lutte contre le paludisme reste élevée. Ceci interpelle les décideurs à accélérer la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle comme alternative au financement de la santé des populations.

**Mots clés :** Paludisme - Dépenses de santé – Ménage

## STH-5-S7-COP-76

### Evaluation des déterminants de l'utilisation des mutuelles de santé par la population de la région de Ziguinchor

**Dr Martial Coly BOP**  
**Enseignant/Chercheur**  
**Maitre de Conférences Titulaire**

**BOP Martial Coly<sup>1</sup>**, AKOETHEY Kossivi<sup>2</sup>,  
 GUEYE Boubacar<sup>1</sup>, DIOP Cheikh Tacko<sup>1</sup>,  
 SOW Papa Gallo<sup>1</sup>, KA Ouseynou<sup>1</sup>, DIOP<sup>4</sup>  
 Abdoulaye, SOW Fatou SARR<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Université Alioune DIOP de Bambey

<sup>2</sup>Ecole d'Economie, Université Clermont  
 Auvergne

<sup>3</sup>Université Cheikh Anta DIOP

<sup>4</sup>Université Assane SECK de Ziguinchor

Auteur correspondant : Dr Martial Coly BOP,  
 Université Alioune DIOP de Bambey/Sénégal.  
 Email : [martialcoly.bop@uadb.edu.sn](mailto:martialcoly.bop@uadb.edu.sn)

L'accès aux soins et aux services de santé constitue une préoccupation dans le monde. Malgré le développement de différentes stratégies, le constat n'est pas encourageant et l'Afrique reste le continent où le taux d'accès est le plus faible (8,2%) [1]. Pour contribuer à l'accès aux soins de la population, l'objectif de cet article est d'évaluer les déterminants de l'utilisation des Mutuelles de Santé (MS) par la population de la région de Ziguinchor au Sénégal.

**Méthodologie :** L'étude effectuée est transversale à visée descriptive. Elle a été réalisée sur la période de juillet à août 2018. La méthode des quotas a été utilisée pour définir le nombre de patients à interroger selon les départements administratifs de la région et selon les différents services des hôpitaux. Sur cette base, nous avons fait, dans un premier temps, une stratification géographique selon les départements. En second lieu, une stratification au deuxième degré en tenant compte des effectifs des différents services des hôpitaux. L'échantillon était constitué de 392 patients sélectionnés. Les données ont été traitées et analysées par les logiciels sphinx et stata.

**Résultats :** Sur 392 patients sélectionnés, 73% ont été enquêtés au Centre Hospitalier Régional et 27% à l'Hôpital de la Paix. Nous avons obtenu un taux de réponse de 97%. Les femmes représentent 60% de l'échantillon et les hommes 40%. Le taux d'adhésion chez les femmes (24%) est légèrement supérieur à celui des hommes (21%).

**Les facteurs socio-économiques :** Selon le niveau d'étude, les patients d'un niveau universitaire ont présenté le taux d'adhésion le plus élevé (31%), suivi du niveau secondaire (24%). En ce qui concerne les revenus, les

patients ayant déclaré avoir un revenu mensuel compris entre 200 000 et 500 000 FCFA, présentent le taux d'adhésion le plus élevé (33%), suivi de 28% pour les patients disposant d'un revenu mensuel compris entre 100 000 et 200 000 FCFA. Quant aux facteurs liés à l'utilisation des mutuelles de santé : le taux d'adhésion retrouvé dans l'étude (23%) est inférieur à celui indiqué par les responsables (40%) et 53% parmi les patients qui ne disposent d'aucune couverture déclarent n'avoir jamais entendu parler de la couverture maladie universelle ou communautaire).

**Les facteurs liés à la prestation de soins :** le taux d'adhésion aux MS suit les distances par rapport aux domiciles des patients (27% pour les patients disposant d'un centre de santé à moins de 2 km, 19 % entre 2 et 10 km, et pas d'adhésion pour ceux qui se trouvent au-delà de 10 km). Le taux d'adhésion ne présente pas de différences significatives par rapport à la satisfaction (23% pour les patients satisfaits et 21% pour les non-satisfaits). Les principaux déterminants sont l'éducation, la distance par rapport aux structures de santé et l'information.

**Recommandations :** pour l'Etat les actions sur l'éducation et la distance étaient la mise en place de politiques publiques dans le moyen et long terme. Pour les MS, les actions à mener étaient la sensibilisation des populations. Pour les Prestataires de soins, les actions à mener étaient la sensibilisation sur les procédures à suivre pour recevoir les soins.

**Mots Clés :** Facteurs d'adhésion, mutuelles de santé, Sénégal.

## STH-5-S7-COL-77

### Impact des normes et protocoles de prise en charge sur la qualité des soins dans les hôpitaux de zone Bénin

**SAIZONOU Jacques<sup>1</sup>**, MAKOUTODE Patrick<sup>1</sup>, AISSI Florel<sup>2</sup>, MONGBO Virginie<sup>1</sup>, OUENDO Edgard-Marius<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenum de Ouidah

<sup>2</sup> Faculté des sciences de la santé de Cotonou

**Introduction :** Pour la garantir la qualité des soins, il est important que les normes et protocoles de prise en charge soient respectées. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'utilisation de ces normes et son impact sur la qualité des soins.

**Méthode d'étude :** Il s'agissait d'une étude transversale et évaluative dont la collecte a été effectuée en 2019 dans douze hôpitaux du

Bénin. La population d'étude était constituée des infrastructures, équipements, prestataires, bénéficiaires de soins et services. Les critères définis ont été établis sur la base des documents normatifs validés par le Bénin. Des scores ont été calculés pour apprécier l'utilisation des normes et procédures et son impact sur la qualité des soins.

**Résultats :** Dans les hôpitaux évalués, les normes de constructions des infrastructures n'étaient pas respectées (34,22%). Le matériel et l'équipement était insuffisant (33,86%) et les ressources humaines étaient insuffisantes (32,14%). Les documents normatifs étaient peu connus (21,82%). Les soins de santé n'étaient accessibles qu'à 25,11% quoiqu'ils étaient facilités à l'intérieur des hôpitaux (84,38%). La sous composante de l'état de santé et des besoins des patients n'était pas bonne (36,35%). Peu de prestataires de soins se lavaient les mains à l'eau et au savon à toutes les étapes de la prise en charge (14,17%). Les patients étaient satisfaits de la relation avec leurs soignants (81,42%) mais n'étaient pas satisfaits du niveau de leur implication dans les soins reçus (21,02%). Ils n'étaient pas non plus satisfaits du confort dans les salles d'hospitalisation et des repas (50,30%).

**Conclusion :** Nous retenons des insuffisances importantes en matière de respect des normes et procédures de soins. Des interventions devront se focaliser sur les gaps identifiés en matière d'adéquation de l'infrastructure, des équipements et des ressources humaines et de mieux former le personnel au respect des normes et procédures de soins.

**Mots clés :** Qualité, structure, procédure, prise en charge, satisfaction, Bénin

## STH-5-S7-COP-78

### Evaluation de la performance d'un service de chirurgie du CNHU-HKM, Bénin, dans le contexte de la COVID-19 en 2021

**Sopoh Ghislain Emmanuel**<sup>1</sup>, Contayon Esther<sup>2</sup>, Hans Moevi A. Aristote<sup>2,3</sup>

#### Affiliations

<sup>1</sup> Département Santé et Environnement, Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenum de Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>2</sup> Clinique universitaire de traumatologie, d'orthopédie et de chirurgie réparatrice, Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Ministère de la Santé, Bénin

<sup>3</sup> Département de Chirurgie et spécialités chirurgicales, Faculté des sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

#### Adresses

SGE : [ghislainsop@yahoo.fr](mailto:ghislainsop@yahoo.fr), CE: [estheracontayon@gmail.com](mailto:estheracontayon@gmail.com), HMAA : [aristotehmma@gmail.com](mailto:aristotehmma@gmail.com)

**Introduction :** L'évaluation de la performance des systèmes de santé est rarement mise en œuvre dans les pays en développement, et pour les établissements hospitaliers en particulier.

**Objectif :** Evaluer la performance de la clinique universitaire de traumatologie, d'orthopédie et de chirurgie réparatrice (CUTO-CR), du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, dans le contexte de la COVID-19.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude évaluative normative, ayant inclus tout le personnel soignant de la CUTO-CR du CNHU-HKM de Cotonou, les stagiaires internes présents dans le service au cours de la période d'étude le personnel administratif et les patients reçus dans les différentes unités, dans la période allant du 1er juillet 2018 au 30 Juin 2021. La composante évaluée est la performance de la clinique. Les composantes explicatives étudiées sont : l'adaptation des buts, l'adaptation à l'environnement externe et interne, le maintien des valeurs aussi bien internes qu'externes et la productivité en termes de qualité et de quantité. Elles ont été appréciées sur la base des fréquences et scores calculées, et jugées selon les critères de Varkevisser et al.

**Résultats :** L'adaptation des buts a été jugée faible, avec une compliance de 40% des scores attendus. Les adaptations à l'environnement externe et interne ont été jugées (compliances) respectivement faible (33,33%) et moyenne (79,25%). L'adaptation globale à l'environnement est moyenne ainsi que maintien des valeurs et la productivité (79,12%, 73,73% et 78,09% respectivement). La performance globale de la CUTO-CR dans le contexte de la COVID-19 est moyenne, avec une compliance de 77,97% par rapport au score attendu.

**Conclusion :** Cette étude met en relief les insuffisances de résilience des systèmes de santé en général, et des systèmes de prestation de soins et services en particulier, dans les situations d'urgences en santé publique.

**Mots clés :** Performance, Résilience, Système de soins, Chirurgie, COVID-19

## STH-5-S7-COL-79

### Distance des formations sanitaires primaires et utilisation des services de santé par les enfants d'âge préscolaire

Catherine E. Oldenburg<sup>1,2,3</sup>, Ali Sié<sup>4</sup>, Mamadou Ouattara<sup>4</sup>, Mamadou Bountogo<sup>4</sup>, Valentin Boudo<sup>4</sup>, Idrissa Kouanda<sup>4</sup>, Elodie Lebas<sup>1</sup>, Jessica M. Brogdon<sup>1</sup>, Ying Lin<sup>1</sup>, Fanice Nyatigo<sup>1</sup>, Benjamin F. Arnold<sup>1,2</sup>, Thomas M. Lietman<sup>1,2,3</sup>

Présentateur : Mamadou Ouattara

Email : [md.ouattara@yahoo.fr](mailto:md.ouattara@yahoo.fr)

1. Francis I Proctor Foundation, University of California, 513 Parnassus Ave, Box 0412, San Francisco, CA, 94143, USA
2. Department of Ophthalmology, University of California, San Francisco, USA
3. Department of Epidemiology & Biostatistics, University of California, San Francisco, USA
4. Centre de Recherche en Santé de Nouna, Nouna, Burkina Faso

### Introduction :

Les retards dans la recherche de soins pour une maladie infantile peuvent entraîner des résultats plus graves.

### Objectif principal :

Nous avons évalué si la distance entre la communauté et la formation sanitaire baisse l'utilisation des soins de santé dans le district sanitaire de Nouna.

### Méthodologie :

Nous avons effectué une surveillance passive des formations sanitaires primaires publiques du district de Nouna, au Burkina Faso, du 1<sup>er</sup> mars au 31 mai 2020. Toutes les visites de soins des enfants de moins de 5 ans ont été enregistrées sur un formulaire électronique. Nous avons enregistré l'âge, le sexe, la communauté de résidence et les diagnostics et traitements administrés. Nous avons calculé l'utilisation des soins de santé par 100 enfants mois en reliant le nombre total de visites au niveau communautaire à la population d'enfants de moins de 5 ans selon un recensement effectué d'août 2019 à février 2020. Nous avons calculé la distance entre chaque communauté et le centre de santé correspondant et évalué la relation entre la distance et le taux d'utilisation des soins de santé.

### Résultats :

Dans 226 communautés, 12 676 visites en soins de santé primaires ont été enregistrées au cours de la période de trois mois. La distance médiane entre la communauté et l'établissement de santé était de 5,0 km (IQR 2,6 à 6,9 km), et le nombre médian de visites pour 100 enfants-mois au niveau communautaire était de 6,7 (IQR 3,7 à 12,3). Le taux de visites en soins de santé

primaires a diminué avec l'augmentation de la distance (rho de Spearman = -0,42, IC à 95 % = -0,54 à -0,31,  $P < 0,0001$ ). Cette relation était similaire pour les visites spécifiques à une cause (y compris la pneumonie, le paludisme et la diarrhée) et pour les prescriptions d'antibiotiques.

### Mots clés :

Soins de santé primaires, enfants de moins de 5 ans, distance formation sanitaire communauté, Burkina Faso

## STH-5-S7-COL-80

### Management de la qualité du soin : enquête à l'unité d'Odontologie Conservatrice-Endodontie du Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire de Ouagadougou

Kaboré WAD<sup>1\*</sup>, Sangaré AD<sup>2</sup>, Seck A<sup>3</sup>, Garé JV<sup>1</sup>, Ouédraogo CNT<sup>1</sup>, Leye-Benoist F<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso

<sup>2</sup>Département de Santé Publique, UFROS/Université Félix Houphouët Boigny, 08 BP 3569 Abidjan 08, Côte d'Ivoire

<sup>3</sup>Service d'Odontologie Conservatrice-Endodontie, Université Cheikh Anta Diop-Dakar. BP 5005 Dakar-Liberté, Sénégal

**Introduction :** L'objectif général de cette étude est d'évaluer la perception des patients de la qualité du service à l'Unité d'Odontologie Conservatrice-Endodontie (UOCE) du Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire (CMSBD) de Ouagadougou.

**Matériel et méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale et descriptive, qui a concerné les patients fréquentant l'UOCE du CMSBD. Les données ont été collectées à l'aide d'un guide d'entretien individuel semi-structuré. Les principales variables étudiées étaient l'accueil, la qualité de l'information et des soins, la qualité de la prise en charge de la douleur, les conditions d'hygiène et de propreté des salles de soins et la satisfaction globale des enquêtés.

**Résultats :** Cent quarante-trois patients dont 51 % de sexe féminin ont participé à l'étude. La tranche d'âge 16-30 ans était la plus représentée (41,3 %) et la majorité des patients (97,9 %) résidaient à Ouagadougou. La qualité de l'accueil était globalement satisfaisante pour 95,8 % des patients. La qualité de l'écoute du personnel était satisfaisante pour 142 (99,3 %) patients. La qualité des soins était perçue comme satisfaisante par 137 enquêtés soit 95,8 %. L'état du mobilier était jugé satisfaisant pour

90,2 % et la propreté des salles pour 95,8 %. L'appréciation générale de leur passage à l'UOCE du CMSBD était satisfaisante pour 135 (94,4 %) patients.

**Conclusion:** Le fort taux de satisfaction des patients dénote de l'existence dans l'établissement d'une politique qualité. Cependant, le plus urgent reste à implémenter les changements souhaités par les patients et à évaluer leur mise en œuvre.

**MOTS CLES :** Satisfaction, Qualité, Soins, Patient, Odontologie Conservatrice-Endodontie

**\*Correspondance:**

Dr Wendpoulomé Aimé Désiré Kaboré  
Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé  
Université Joseph KI-ZERBO - 03 BP 7021  
Ouagadougou 03, Burkina Faso  
Adresse email: [dr\\_kabore@yahoo.fr](mailto:dr_kabore@yahoo.fr)  
Téléphone : +22670211283  
WhatsApp : +22676417878

## STH-5-S7-COL-81

### Indication de la prescription d'antibiotiques chez les enfants dans les formations sanitaires primaires dans les zones rurales du Burkina Faso

Ali Sié,<sup>1</sup> Mamadou Ouattara,<sup>1</sup> Mamadou Bountogo,<sup>1</sup> Clarisse Dah,<sup>1</sup> Guillaume Compaoré,<sup>1</sup> Valentin Boudo,<sup>1</sup> Elodie Lebas,<sup>2</sup> Jessica Brogdon,<sup>2</sup> Fanice Nyatigo,<sup>2</sup> Benjamin F. Arnold,<sup>2,3</sup> Thomas M. Lietman,<sup>2,3,4</sup> Catherine E. Oldenburg<sup>2,3,4</sup>

Présentateur : Mamadou Ouattara

Email : [md.ouattara@yahoo.fr](mailto:md.ouattara@yahoo.fr)

1. Centre de Recherche en Santé de Nouna, Nouna, Burkina Faso
2. Francis I Proctor Foundation, University of California, 513 Parnassus Ave, Box 0412, San Francisco, CA, 94143, USA
3. Department of Ophthalmology, University of California, San Francisco, USA
4. Department of Epidemiology & Biostatistics, University of California, San Francisco, USA

### Introduction :

La consommation d'antibiotiques peut sélectionner des organismes résistants aux niveaux individuel et communautaire [1, 2]. Réduire l'utilisation inutile d'antibiotiques peut réduire la consommation d'antibiotiques sans compromettre l'utilisation nécessaire d'antibiotiques.

### Objectif principal

Nous avons utilisé des données recueillies régulièrement auprès d'établissements de soins de santé primaires dans les zones rurales du Burkina Faso pour évaluer la prescription d'antibiotiques chez les enfants de <5 ans atteints de maladies infantiles courantes diagnostiquées et identifier les diagnostics les plus susceptibles de réduire l'utilisation inutile d'antibiotiques.

### Méthodologie :

Cette étude a eu lieu dans 48 centres de santé primaire (CSPS) du district de Nouna, au Burkina Faso. Nous avons extrait les données de toutes les visites d'enfants malades de mars à novembre 2020 dans chaque établissement, pour tous les enfants de <5 ans. Les données étaient limitées aux premières visites, et nous avons exclu les visites de suivi dans notre analyse. Nous avons inclus des informations sur la date de la visite, l'âge et le sexe de l'enfant, le diagnostic et le traitement. Nous avons concentré l'analyse sur les infections et les symptômes infectieux les plus fréquemment diagnostiqués, notamment la pneumonie, le paludisme, la diarrhée, la fièvre et la toux.

### Résultats :

Sur 61 355 visites, 30 975 (50,5 %) ont reçu une ordonnance d'antibiotiques. Les prescriptions d'antibiotiques étaient plus fréquentes pendant la saison sèche que pendant la saison des pluies (dans 57,1 % vs 42,9 % des visites). De toutes les prescriptions d'antibiotiques, 23 554 (76 %) étaient associées à une pneumonie, au paludisme, à la diarrhée, à la dysenterie, à la fièvre ou à la toux. La majorité des ordonnances d'antibiotiques restantes étaient principalement pour des affections cutanées.

**Mots clés :** Antibiotiques, pneumonie, paludisme, diarrhée, gestion des antibiotiques

## STH-5-S7-COP-82

### The financial architecture of vector borne diseases in Burkina Faso: Trends and allocations patterns

**Fadima YAYA BOCOUM**, IRSS,

APHRC/WARO, +226 76 50 34 37,

[fadimabocoum@yahoo.fr](mailto:fadimabocoum@yahoo.fr)

**Auteurs :** Fadima YAYA BOCOUM<sup>1 2</sup>, Corneille Traore<sup>3</sup>, Eve Worall<sup>4</sup>

1 Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS), Département BIOMED/SP, Ouagadougou, Burkina Faso

2 African Population Health Research Center (APHRC), WARO, Dakar, Sénégal

3 CNRFP, Ouagadougou, Burkina Faso

4 LSTMED, Liverpool, United Kingdom

## Introduction

Vector-borne diseases (VBD) are responsible for over 17% of all the infectious diseases globally causing more than 700,000 deaths annually. But there is little published information about the domestic and international financial resources allocated to VBD. Thus, there is a need for empirical assessments to determine current resource allocations. The specific objectives of this study were to map main funders of VBD in Burkina Faso, and to explore how investment decisions on VBD by the funders who reported data from 2015-2018 have been allocated among diseases and particular activities.

## Method

Our research framework was grounded in political economy analysis and different frameworks in public policy analysis. Budget allocation and expenditures data from 2015 to 2018 were collected from the NTD program and from a fund management institution of the Ministry of Health. The database included variables such as Budget mobilized and allocated, expenditures, source of funding and type of activity. Analysis explored levels, trends and allocation of domestic and donor funds for VBD.

## Results

Most of sources were from external donors (7/8). Government has funded only 4% of activities. The trend of sources of financing were discontinued. Over time some sources disappeared and some appeared. In terms of activities, 28% of activities were related to prevention followed by surveillance and monitoring and evaluation from 2015 to 2018. There were few variations between mobilized, allocated and expenditures over the time. In terms of expenditures more than 85% of allocated resources were spent. Activities were mainly concentrated in Lymphatic filariasis, onchocerciasis and schistosomiasis.

## Conclusion

The findings highlighted the persistent dependence of health financing to donors funds. This situation questions the sustainability of activities for vector-borne diseases control and the achievement of elimination of vector-borne diseases in low incomes countries.

## STH-5-S7-COL-83

### Facteurs associés à l'utilisation irrationnelle des médicaments dans les ménages de la zone sanitaire Abomey-Calavi/So-Ava, au Bénin, en 2021

**Sopoh Ghislain Emmanuel<sup>1</sup>**, Degbey C. Cyriaque<sup>1,2</sup>, Sossa-Jérôme Charles<sup>3</sup>, Gbaguidi Caleb<sup>4</sup>

#### Affiliations

<sup>1</sup> Département Santé et Environnement, Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenum de Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>2</sup> Service d'Hygiène Hospitalière, Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Ministère de la Santé, Bénin

<sup>3</sup> Département Promotion de la santé, Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenum de Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>4</sup> Ecole de Pharmacie, Faculté des sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

#### Adresses

SGE : [ghislainsop@yahoo.fr](mailto:ghislainsop@yahoo.fr), DCC: [comlancy@yahoo.fr](mailto:comlancy@yahoo.fr), SJC: [sossajero@yahoo.com](mailto:sossajero@yahoo.com), GC: [calebgbaguidi7@gmail.com](mailto:calebgbaguidi7@gmail.com)

**Introduction :** Les normes d'utilisation des médicaments sont peu respectées dans les pays en développement.

**Objectif :** Déterminer les facteurs associés à l'utilisation irrationnelle des médicaments par les ménages d'une aire de santé périurbaine au Bénin, en 2021

**Méthode :** Il s'agit d'une étude transversale analytique, ayant impliqué 610 chefs de ménage (ou représentants), échantillonnés par grappes, et 15 agents de santé choisis par commodité dans les formations sanitaires. Les facteurs individuels, comportementaux, environnementaux et ceux liés au système de santé, ont été analysés, par régression logistique pas à pas descendante. Les forces d'associations sont appréciées par les rapports de cote ajustés (ORa)

**Résultats :** La majorité des chefs de ménage sont des hommes (53,6%), mariés (69,2%), de moins de 45 ans (58,8%), et d'un niveau socioéconomique moyen (60,7%). Pour ceux qui disposaient de médicaments à la maison, 56,7% n'ont pas consulté un professionnel de la santé, 51,3% les utilisent pour des indications incorrectes, 0,8% par une mauvaise voie d'administration, 47,9% pour une durée inadéquate. Le coût était jugé non abordables par 23,8%. L'utilisation des médicaments était irrationnelle dans 80% des ménages enquêtés.

Le lieu d'achat des médicaments (Rue) [ORa, IC95% ; p = 2,32, 1,14-4,68 ; 0,019] ainsi que la non Disponibilité médicaments pharmacies (rupture de stock) [ 1,64, 1,08-2,49 ; 0,020] étaient associés à un risque élevé d'utilisation irrationnelle, tandis que les cibles n'exerçant pas des activités physiques régulières [0,55, 0,35-0,86 ; 0,046] et ceux disposant d'une assurance maladie ou couverture sociale [0,27, 0,13-0,57 ; 0,001], étaient protégés contre l'utilisation irrationnelle des médicaments.

**Conclusion :** L'utilisation irrationnelle des médicaments est plurifactorielle, dépendant, non seulement des individus, mais aussi du système de santé. L'instauration d'une couverture maladie universelle, ainsi qu'une amélioration de la disponibilité des médicaments aux endroits appropriés, permettra d'en réduire la prévalence.

**Mots clés :** Médicaments, utilisation, facteurs associés, Bénin

## STH-5-S7-COL-84

### Rôle du pharmacien dans la mise en œuvre de la politique de l'Assurance Maladie Obligatoire au Mali.

**Aboubacar Sangho**<sup>1\*</sup>, Rabiétou Kouboura Teguer<sup>5</sup>, Oumar Sangho<sup>2,3</sup>, Alaye Diah<sup>1</sup>, Assitan Kaloga<sup>1</sup>, Fanta Sangho<sup>3,4</sup>

#### Affiliations :

1. Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Pharmaceutiques, Faculté de Pharmacie (FAPH)– Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), Mali
2. Agence Nationale de Télésanté et d'Informatique Médicale (ANTIM), Hamdallaye ACI, Bamako, Mali
3. Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique (DERSP), Faculté de Médecine et D'odontostomatologie (FMOS), Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB), Mali
4. Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM), Bamako, Mali
5. Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique (ANRP), Ouagadougou, Burkina Faso

**\*Auteur présentateur :** Dr Aboubacar Sangho, Assistant au Département d'Enseignement et de Recherche des Sciences Pharmaceutiques, FAPH/USTTB, Mali.

Tél. : +223 76 08 04 15/+226 74 46 74 04,

Email : [sanboucar@gmail.com](mailto:sanboucar@gmail.com)

**Introduction :** La maîtrise des dépenses de santé est un impératif pour tout système de santé. C'est ainsi que l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) a été instauré au Mali en 2009 pour améliorer l'accès permanent, facile et solidaire aux soins de santé ainsi qu'aux médicaments essentiels génériques ou en Dénomination Commune Internationale (DCI) de qualité.

**Objectif principal :** Étudier le rôle du pharmacien dans la mise en œuvre de la politique de l'AMO au Mali.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une étude transversale descriptive qui s'est déroulée à Bamako du 1<sup>er</sup> octobre 2016 au 31 décembre 2017. Nous avons réalisé une analyse documentaire et des entrevues avec 36 pharmaciens, 400 assurés, 90 prescripteurs et 04 personnes ressources des organismes délégués de gestion. L'analyse des données a été faite par le logiciel SPSS 20.

**Résultats :** Au total 2 lois et 6 décrets consacrent les dispositions législatives et réglementaires de l'AMO au Mali. La majorité des assurés (90%) pensait que le pharmacien est un spécialiste du médicament. Plus de 80% des médicaments figurant sur les feuilles de soins étaient intégralement disponibles. Parmi leurs missions dans le cadre de la mise en œuvre de l'AMO, 38,9% des pharmaciens ont cité la disponibilité continue des médicaments, 27,70% l'application des bonnes pratiques de dispensation et 16,7% le droit à la substitution. Outre les pharmaciens, les personnes ressources des organismes délégués de gestion ont également tous reconnu, que la substitution pouvait permettre une dispensation pérenne de tous les médicaments prescrits sur les feuilles de soins de l'AMO.

**Conclusion :** La substitution des médicaments non disponibles est un facteur pouvant contribuer à la réduction des dépenses de santé pour les patients et à leur satisfaction.

**Mots clés :** assurance maladie obligatoire, pharmacien, rôle, substitution.

## Sous-thème 5 Session 8

### STH-5-S8-COP-85

#### Impact de l'initiation rapide du traitement antiretroviral sur la réponse thérapeutique chez les HSH en Afrique de l'Ouest

**Ter Tiero Elias Dah**<sup>1,2,3</sup>, Issifou Yaya<sup>2</sup>, Ephrem Mensah<sup>4</sup>, Alou Coulibaly<sup>5</sup>, Jean-Baptiste Malan<sup>6</sup>, Kader Maiga<sup>5</sup>, Issa Traoré<sup>3</sup>,

Rachelle Kotchi<sup>6</sup>, Camille Rajaonarivelo<sup>1</sup>, Marion Mora<sup>7</sup>, Pamela Palvadeau<sup>8</sup>, Lucas Riegel<sup>8</sup>, Fodié Diallo<sup>5</sup>, Camille Anoma<sup>6</sup>, Bintou Dembélé Keita<sup>5</sup>, Bruno Spire<sup>7</sup>, Christian Laurent<sup>2</sup>, on behalf of the CohMSM Study Group.

<sup>1</sup> Université de Ouahigouya, Département de Santé Publique, Ouahigouya, Burkina Faso

<sup>2</sup> IRD, Inserm, Univ Montpellier, TransVIHMI, Montpellier, France

<sup>3</sup> Association African Solidarité, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>4</sup> Espoir Vie Togo, Lomé, Togo

<sup>5</sup> ARCAD Santé PLUS, Bamako, Mali

<sup>6</sup> Espace Confiance, Abidjan, Côte d'Ivoire

<sup>7</sup> Aix Marseille Univ, Inserm, IRD, SESSTIM, Marseille, France

<sup>8</sup> Coalition Internationale Sida, Pantin, France

## Introduction

En Afrique de l'Ouest où les HSH sont une population stratégique dans la lutte contre le VIH, nous avons évalué auprès d'eux le délai d'initiation du traitement antirétroviral (ARV) et son impact sur la réponse thérapeutique.

## Méthodes

Nous avons conduit une étude de cohorte prospective entre 2015 et 2020 chez des HSH suivis dans quatre cliniques associatives (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Togo). Les HSH âgés d'au moins 18 ans, rapportant au moins un rapport sexuel anal avec un autre homme au cours des 3 derniers mois, et découvrant leur séropositivité au VIH ont été inclus. L'initiation du traitement ARV indépendamment du stade clinique et du nombre de CD4 leur était proposée. Les participants bénéficiaient d'un suivi trimestriel. Le nombre de CD4 et la charge virale du VIH étaient réalisés tous les six mois. Les facteurs associés à l'initiation rapide du traitement ARV (0-7 jours après le diagnostic d'infection par le VIH) et son impact sur la réponse thérapeutique étaient recherchés par des analyses multivariées.

## Résultats

350 HSH séropositifs au VIH étaient inclus. Parmi eux, 335 (95,7%) initiaient le traitement ARV dans un délai médian de 5 jours (intervalle interquartile 1-13). 216 (64,5%) participants initiaient rapidement le traitement. 111 (33,1%) participants n'étaient pas retenus dans les soins. L'initiation rapide du traitement ARV était basse chez les participants avec un nombre bas de CD4 (odds ratio ajusté [ORa] 0,37, intervalle de confiance [IC] à 95% 0,15-0,88,  $p=0,025$ ). L'initiation rapide du traitement ARV était positivement associée au succès virologique

(ORa 6,96, IC95% 1,98-24,5,  $p=0,003$ ). En revanche, elle n'avait d'impact ni sur l'attrition (ORa 0,87, IC95% 0,57-1,33,  $p=0,525$ ), ni sur le gain en CD4 (coefficient ajusté 28,2, IC95% -17,0; 73,4,  $p=0,221$ ).

## Conclusion

Nos résultats sont en faveur des recommandations de l'OMS pour l'initiation **rapide du traitement ARV**.

## STH-5-S8-COP-86

### Adhésion au traitement des travailleuses du sexe PVVIH de la ville de Ouagadougou : analyse des déterminants selon les acteurs clés

**Ahmed KABORE<sup>1</sup>**, Stéphanie Dominique Amida NAMA<sup>1</sup>, Nicolas MEDA<sup>1,2</sup>

1 Université Ouaga 1 Joseph Ki Zerbo

2 Institut National de Santé Publique

Email : [ahmedkaboreza@gmail.com](mailto:ahmedkaboreza@gmail.com)

## RESUME :

**Introduction :** Le taux d'adhésion au traitement antirétroviral des travailleuses du sexe au Burkina Faso est très inférieur à celui de la population générale : 44% contre 86,86%. Ce manque d'adhésion au traitement représente un frein dans la lutte acharnée contre l'infection à VIH qui constitue une préoccupation majeure de santé publique.

**Méthode :** Il s'est agi d'une étude qualitative à visée exploratoire qui s'est déroulée entre mars 2020 et septembre 2021. La population d'étude était constituée d'une part, de six travailleuses du sexe exerçant à Ouagadougou, et d'autre part, de parties prenantes impliquées dans la lutte contre le VIH dans cette communauté (six paires éducatrices, un agent de santé et une sociologue). Elle a consisté à identifier et analyser les déterminants de l'adhésion au traitement antirétroviral des travailleuses du sexe selon le modèle socio écologique à travers des focus group et des entretiens individuels semi dirigés.

**Résultats :** Les facteurs favorisant l'adhésion au traitement antirétroviral des travailleuses du sexe étaient : au niveau personnel un niveau de littératie élevé, un self efficacy élevé, les bénéfices perçus du traitement, et l'autonomie financière ; au niveau interpersonnel, un réseau social sensibilisé ; au niveau communautaire, la disponibilité de centres d'accueil et d'écoute et la sensibilisation ; au niveau organisationnel la présence de dispositions particulières pour cette communauté et l'opérationnalité des services de santé ; au niveau politique la gratuité du traitement et l'engagement politique.

**Conclusion :** Les résultats de notre étude nous apprennent que l'adhésion au TARV des TS de Ouagadougou résulte d'une interaction entre des dispositions psychologiques intrinsèques et des conditions environnementales.

**Mots clés :** Travailleuses du sexe ; Adhésion ; Traitement antirétroviral ; Barrières ; Facteurs favorisant ; Stigmatisation

## STH-5-S8-COP-87

**Profil des travailleuses de sexe utilisant internet pour la recherche de clients au Burkina Faso : Implication pour la prévention du VIH/IST**

**Harouna. N Bado**<sup>1,2</sup>, *Isidore T. Traoré*<sup>1,2</sup>, *Salifou C.A Zerbo*<sup>1,2</sup>, *Ajani O. Taofiki*<sup>1</sup>, *Wilfried W Bazié*<sup>1</sup>, *Anselme Sanon*<sup>1</sup>, *Wilfried Bazié*<sup>1</sup>, *Adjara Millogo*<sup>1,2</sup>, *Souleymane Tassembedo*<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> Programme des maladies infectieuses, Centre MURAZ, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, <sup>2</sup> Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso

### Contexte et Objectifs

Durant les dix dernières années, l'accès et l'utilisation d'internet ont connu une forte évolution en Afrique. Les travailleuses de sexe (TS) utilisent internet pour rechercher des clients afin de réduire leur sortie dans la rue. La présente étude vise à examiner l'utilisation d'internet par les TS, les facteurs associés à son utilisation et d'explorer la faisabilité d'une intervention internet contre le VIH/IST dans cette population clé au Burkina Faso.

### Matériel et Méthodes

Nous avons utilisé les données de l'enquête bio comportementale nationale réalisée au Burkina en 2017. Au total 4780 TS ont participé à cette étude. Une analyse descriptive a été faite pour observer la répartition des TS en fonction de l'usage d'internet. Une régression logistique a été également réalisée pour identifier les facteurs associés à l'utilisation d'internet.

### Résultats

L'âge médian des TS était de 24 ans (IQR 21-29). Environ 10% des TS utilisaient internet pour obtenir des clients. Parmi les TS qui utilisent l'internet dans un but professionnel 54% avaient un niveau d'éducation secondaire et 65% avaient un partenaire sexuel régulier. L'utilisation d'internet était significativement associée à l'âge, au niveau d'instruction, à la durée dans la profession du sexe, à la catégorie de TS, à la consommation d'alcool et du tabac, à la pratique sexuelle anale, au lieu de résidence, aux déplacements, aux attitudes discriminatoires envers les PVVIH, à l'affiliation à une association de profession de

sexe et à la couverture par les services de prévention VIH/IST. Des analyses multivariées ont montré que l'affiliation à une association de profession de sexe, la couverture par les services de prévention VIH/IST, le jeune âge (20-24ans), le niveau d'éducation supérieur et le déplacement étaient significativement associées à une utilisation accrue d'internet avec des odds ratio respectifs de 2,12 [1,59 ; 2,82], 1,12[0,90; 1,40], 1,55[1,09; 2,21], 3,97[2,17 ; 7,24] et 1,66[1,33 ; 2,08] au seuil de 5%.

### Conclusion

Nos données montrent que l'internet pourrait offrir une stratégie prometteuse pour donner de programmes de prévention du VIH/IST à faibles coûts au Burkina Faso.

**Mots clés :** Travailleuses de sexe, Internet, Prévention, VIH, IST

## STH-5-S8-COP-88

**Facteurs associés à la mortalité et à la perte de vue après initiation antirétrovirale au district sanitaire de Boromo**

**I. Yameogo**<sup>1</sup>, *M. Tassembedo*<sup>2</sup>, *N.F. Kaboré*<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>Université Joseph KI-ZERBO - Ouagadougou (Burkina Faso), <sup>2</sup> Ministère de la santé - Ouagadougou (Burkina Faso), <sup>3</sup> Centre Muraz - Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Adresse email : [dryamis@yahoo.fr](mailto:dryamis@yahoo.fr) (I. Yameogo)

**Introduction :** L'infection par le Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) demeure un problème de santé publique. L'accès au traitement antirétroviral (TAR) s'est amélioré ces dernières années. Cependant, la perte de vue (PDV) et le décès sous TAR constitue le défi du moment.

**Objectif principal de l'étude :** Déterminer les facteurs associés à la mortalité et à la perte de vue à l'initiation du TAR chez les personnes vivant avec le VIH suivies au district de Boromo entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019.

**Méthodes :** Nous avons conduit une étude de cohorte rétrospective chez les PVVIH âgés d'au moins 15 ans ayant initié un TAR et suivies à l'hôpital de district de Boromo entre le 1<sup>er</sup> janvier 2015 et le 31 décembre 2019. Le modèle de régression à risque compétitif de Fine et Gray a été utilisé pour rechercher les facteurs associés à la mortalité et à la la perte de vue.

**Résultats :** L'étude a concerné 550 patients. Le taux de mortalité était de 34,5 [intervalle de confiance à 95% (IC<sub>95%</sub>) :24,4-48,8] pour 1000 PA et le taux de PDV de 220 (IC<sub>95%</sub> :191,8-

252,4) pour 1000 PA. Le stade OMS III et IV (SHRa=2,76 ; IC<sub>95%</sub>:1,25-6,09) et l'absence de prophylaxie au cotrimoxazole (SHRa=2,65 ; IC<sub>95%</sub>:1,17-5,97) étaient associés à la mortalité. Le jeune âge à l'initiation du TAR [(15-29 ans, SHR=2,23 ; IC<sub>95%</sub>:1,44-3,45) et (30-44 ans, SHR=1,54 ; IC<sub>95%</sub>:1,01-2,36)] et l'infection par le VIH2 [SRH=2,22 ; IC<sub>95%</sub>: (1,38-3,72)] étaient associés à la PDV.

**Conclusion :** Les taux de mortalité et de PDV après initiation au TAR demeurent élevés. Il y'a nécessité de renforcer les stratégies de lutte ciblant les facteurs identifiés.

**Mots-clés :** VIH, Mortalité, Perte de vue, Antirétroviral, Boromo

### STH-5-S8-COP-89

**Facteurs associés à la couverture par les services de prévention du VIH parmi travailleuses du sexe séronégatives au Burkina Faso**

**Salifou CA Zerbo**<sup>12</sup>, Isidore T Traoré<sup>13</sup>, Harouna N Bado<sup>12</sup>, Bakary Cisse<sup>1</sup>, Ajani O. Taofiki<sup>1</sup>, Souleymane Tassebeddo<sup>1</sup>, Anselme Sanon<sup>1</sup>, Adjara Millogo<sup>1</sup>, Wilfried W Bazié<sup>1</sup>, Issouf Konate<sup>1</sup>, Bea Vuylsteke<sup>4</sup>, Leon Sawadogo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Centre MURAZ, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

<sup>2</sup> Université Nazi Boni, Ecole Supérieure d'Informatique, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

<sup>3</sup> Université Nazi Boni, Institut Supérieur des Sciences de la Santé, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

<sup>4</sup> Department of Public health, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium

#### Introduction

Notre objectif était d'estimer la couverture des TS séronégatives par les services de prévention du VIH et ses facteurs associés parmi les TS au Burkina Faso.

#### Méthodes

Nous avons utilisé les données de l'enquête bio comportementale réalisée en 2017 au Burkina Faso. La couverture par services de prévention du VIH a été définie comme suit : avoir reçu des préservatifs gratuits durant les 12 mois précédant l'étude ; avoir bénéficié de campagnes de sensibilisation ou de conseils durant les 12 mois précédant l'enquête ; avoir été infecté par une IST et reçu un traitement durant les 12 mois précédant l'étude. Nous avons utilisé la régression logistique pour identifier les facteurs associés à cette couverture.

#### Résultats

La prévalence du VIH était de 5,4 % parmi les 4784 TS incluses dans l'étude. Parmi les 4526 TS séronégatives, 62,2% (IC<sub>95%</sub> 60,8-63,6) étaient couvertes par les services de prévention. Cette couverture était faible parmi les TS adolescentes (OR=0,6 [0,5;0,7], p=0,001). Elle était également faible parmi les TS ayant commencé le commerce du sexe dans les 12 derniers mois (OR=0,5 [0,4-0,7], p=0,001) et aussi parmi celles déclarant avoir des attitudes discriminatoires envers les PVVIH (OR=0,7 [0,6;0,8], p=0,001). Cependant, les TS qui se déplaçaient vers d'autres localités pour leur activité étaient mieux couvertes par les services de prévention (aOR=1,6 [1,4-1,8], p=0,001). Avoir au moins un partenaire non payant augmentait la couverture par les services de prévention (aOR=1,2 [1,0;1,3], p=0,03). Les TS qui étaient affiliées à une association de TS étaient également mieux couvertes par ces services (aOR=1,7 [1,4;2,2], p=0,001).

#### Conclusion

Les jeunes TS et celles qui ont débuté le commerce du sexe dans la dernière année devraient être prioritaires dans les programmes de prévention. Aussi, le soutien apporté par les organisations communautaires permet une plus grande couverture des TS par les services de prévention.

**Mots clés :** VIH, Travailleuses du sexe, Prévention

### STH-5-S8-COP-90

**Suivi préventif trimestriel et incidence du VIH chez des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes en Afrique de l'Ouest**

**Ter Tiero Elias Dah**<sup>1</sup>, Issifou Yaya<sup>2</sup>, Luis Sagaon Teyssier<sup>6</sup>, Alou Coulibaly<sup>3</sup>, Malan Jean-Baptiste Kouamé<sup>4</sup>, Mawuényégan Kouamivi Agboyibor<sup>5</sup>, Kader Maiga<sup>3</sup>, Issa Traoré<sup>8</sup>, Marion Mora<sup>6</sup>, Pamela Palvadeau<sup>7</sup>, Fodié Diallo<sup>3</sup>, Ephrem Mensah<sup>5</sup>, Camille Anoma<sup>4</sup>, Bintou Dembélé Keita<sup>3</sup>, Bruno Spire<sup>6</sup>, Christian Laurent<sup>2</sup>, pour le groupe de l'étude CohMSM.

<sup>1</sup>Université de Ouahigouya, Département de Santé Publique, Ouahigouya, Burkina Faso, <sup>2</sup>IRD, Inserm, Univ Montpellier, TransVIHMI, Montpellier, France, <sup>3</sup>ARCAD-SIDA, Bamako, Mali, <sup>4</sup>Espace Confiance, Abidjan, Côte d'Ivoire, <sup>5</sup>Espoir Vie Togo, Lomé, Togo, <sup>6</sup>INSERM, IRD, Univ Aix-Marseille, SESSTIM, Marseille, France, <sup>7</sup>Coalition Internationale Sida, Pantin, France, <sup>8</sup>Association African Solidarité, Ouagadougou, Burkina Faso

#### Objectif

En Afrique, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) ont un accès limité à des services de prévention du VIH adaptés à leurs besoins. Nous avons évalué l'acceptabilité d'un suivi préventif trimestriel et son effet sur l'incidence du VIH chez des HSH en Afrique de l'Ouest.

### Méthodes

Une étude de cohorte prospective a été conduite entre 2015 et 2018 chez des HSH suivis dans des cliniques associatives d'Abidjan, de Bamako, de Lomé et de Ouagadougou. Les HSH inclus étaient âgés d'au moins 18 ans, rapportaient au moins un rapport sexuel anal avec un autre homme au cours des 3 derniers mois et étaient séronégatifs pour le VIH. Les visites de suivi trimestrielles comprenaient un examen clinique, le dépistage du VIH, la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, un accompagnement communautaire et la fourniture de préservatifs et de lubrifiants. L'effet du suivi préventif sur la survenue d'une séroconversion pour le VIH a été étudié à l'aide d'un modèle de Cox multivarié.

### Résultats

618 HSH ont été suivis pour une durée médiane de 20 mois. L'observance au suivi trimestriel était globalement de 76,5% (intervalle de confiance à 95% [IC95%] 75,1-77,8), allant de 66,8% à Abidjan à 87,3% à Lomé. 51 (8,3%) HSH n'ont réalisé aucune visite de suivi trimestriel, 206 (33,3%) ont réalisé entre 10% et 90%, et 361 (58,4%) les ont toutes réalisées. 78 séroconversions pour le VIH ont été enregistrées au cours du suivi (780,8 personne-années), soit une incidence de 10,0 pour 100 personne-années (IC95% 8,0-12,5). L'observance au suivi trimestriel n'était pas associée à la séroconversion (risque relatif ajusté 0,9 ; IC95% 0,5-1,6).

### Conclusion

L'incidence du VIH reste élevée chez ces HSH malgré le suivi trimestriel. L'ajout de la PrEP semble indispensable pour maîtriser l'épidémie chez les HSH et, au-delà, dans la population générale.

### Conflits d'intérêts

Aucun

### Mots clés

Afrique ; HSH ; incidence ; prévention ; VIH

## STH-5-S8-COP-91

**Facteurs de la demande régulière d'examen de dépistage de l'hépatite virale B (VHB) chez les femmes enceintes selon les sages-**

## **femmes(SFE)/ maïeuticiens(ME) dans la région des Hauts Bassins, Burkina Faso**

**Meda ZC** <sup>1, 2</sup>, Sankara CPM <sup>2</sup>, Kamboulé BE <sup>1</sup>, Koura M <sup>1, 2</sup>, Sawadogo A <sup>1, 3</sup>

1 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou

2 Institut supérieur des sciences de la santé

3 Université Joseph Ki-Zerbo

**Introduction :** La transmission mère-enfant (TME) de l'hépatite virale B est un problème de santé publique.

**Objectif :** Etudier les facteurs influençant la demande régulière d'examen pour le dépistage du VHB chez les femmes enceintes par les SFE/ME du CHUSS et des DS de Do et Dafra.

**Méthode :** Il s'est agi d'une étude transversale à visée analytique conduite d'Octobre 2020 à Mai 2021, à l'aide d'un questionnaire auto-administré et sous supervision. L'échantillon attendu était de 162 SFE/ME. Les variables étudiées étaient relatives aux données sociodémographiques, connaissances, attitudes, pratiques, perceptions, et facteurs liés au système de santé. Les facteurs influençant la demande régulière d'examen ont été identifiés par régression logistique.

**Résultats :** Un total de 134 SFE/ME enquêtés soit un taux de participation de 82,7 %. L'âge moyen était de 41,5 ans avec 73,9 % de femmes (sex-ratio = 0,3 H/F). Les facteurs influençant la demande régulière d'examen identifiés étaient : le dépistage systématique de HVB des femmes reçues en consultation prénatale (CPN) et en dehors des CPN, la référence d'une femme enceinte dépistée positive à un spécialiste, l'entretien avec les femmes sur la TME du VHB pendant les CPN, la connaissance de l'infectiosité du VHB par rapport au VIH, et le lieu de travail.

**Conclusion :** Il existait une relation entre les bonnes pratiques en milieu de soins et la demande d'examen pour le dépistage de HVB chez les femmes enceintes. Une gestion adéquate de l'infection au VHB et la mise en place d'une bonne stratégie de prévention de la TME, pourraient contribuer à un meilleur contrôle de HBV.

**Mots clés :** Connaissances, attitudes, pratiques.

## STH-5-S8-COP-92

**Modélisation mathématique de la transmission du virus de l'hépatite B**

**Adama KIEMTORE**

Doctorant Spécialité : Modélisation mathématique et simulation numérique.

Domaine : Mathématiques appliquées Ecole  
doctorale : Sciences et Technologie

### Introduction

L'Hépatite B est un problème majeur de santé publique dans le monde et surtout au Burkina Faso. Elle est causée par le VHB qui est le deuxième agent cancérigène connu pour l'Homme. L'Hépatite B se présente sous deux formes : aiguë (6 mois) et chronique (au-delà de 6 mois) dont les complications sont la cirrhose et/ou le CHC. Plus de 90% des infectés aigus guériront sans traitement mais le risque de passage à la chronicité est inversement proportionnel à l'âge auquel le sujet a été infecté. La transmission verticale étant le mode le plus fréquent de contamination du VHB au Burkina Faso, le vaccin anti-VHB demeure le meilleur moyen pour prévenir la survenue d'une Hépatite B chronique.

### Objectif principale de l'étude

Formuler un modèle mathématique de la transmission du virus de l'hépatite B au Burkina Faso.

**Méthodes :** - Analyse compartimentale,  
- Méthode de P. Van Den Driessche et J. Watmough.

**Résultats :** Modèle de la transmission du VHB, détermination du nombre de reproduction de base  $R_0$  qui caractérise le potentiel infectieux des maladies infectieuses.

### Conclusion

Après avoir présenter quelques modèles de la transmission du VHB et formulé un modèle pour le Burkina Faso, nous l'avons étudié mathématiquement puis déterminer le nombre reproduction de base  $R_0$ .

**Mots clés :** *hépatite B, VHB, modélisation, dynamique, épidémie.*

## STH-5-S8-COP-93

### Prévalence de l'hépatite virale B chez les travailleurs d'une entreprise agro-alimentaire à Bobo-Dioulasso

**TRAORE I**<sup>1,2</sup>, **SANON/LOMPO MS**<sup>3,4</sup>, **KABORE M**<sup>2</sup>, **KAFANDO WJB**<sup>5</sup>, **OUEDRAOGO AF**<sup>2</sup>, **ZOUNDI/IDO CN**<sup>2</sup>, **BAYANE/ZOUNGRANA B**<sup>2</sup>, **SAWADOGO A**<sup>3,6</sup>, **SAWADOGO GLB**<sup>1,6</sup>

1. Université Nazi Boni/Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA)
2. Office de santé des travailleurs
3. Université Joseph KI ZERBO/UFR-SDS
4. Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo

5. Service de santé au travail Essakane
6. Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou

Présentateur : TRAORE Issa ; Téléphone : 0022670293210 ; Email : [placitra@yahoo.fr](mailto:placitra@yahoo.fr)

**Introduction :** Le Burkina Faso fait partie des zones de forte endémie du virus de l'hépatite B où la prévalence est supérieure ou égale à 8%. En effet, l'hépatite virale B constitue un véritable problème de santé publique dans le monde.

**Objectif :** L'objectif de cette étude était de déterminer la prévalence de l'hépatite virale B chez les travailleurs d'une entreprise agro-alimentaire à Bobo-Dioulasso.

**Matériels et Méthodes :** il s'est agi d'étude transversale descriptive qui s'est déroulée du 1<sup>er</sup> mai 2018 au 30 avril 2019. Les travailleurs ont été interrogés à l'aide d'un questionnaire.

**Résultats :** Sur un effectif total de 115 travailleurs que compte l'entreprise, 111 ont participé à l'étude, soit un taux de participation de 96,52%. L'âge moyen des participants était de 40,96 ans avec des extrêmes de 26 et 58 ans. Ils étaient en majorité des hommes, sex ratio = 4,84 hommes pour une femme. Les mariés représentaient 80,18%. Les agents de la production étaient les plus représentés (46,85%) suivis du personnel administratif (21,62%). Les travailleurs ayant une ancienneté au poste de 6 à 10 ans étaient les plus nombreux (32,71%). La prévalence de l'hépatite virale B était de 12,61%. Les travailleurs ayant un AgHBs positif étaient en majorité des hommes (78,57%) sans lien statistique. Parmi ces travailleurs, la tranche d'âge de 40 à 50 ans représentait 42,86%. Les ouvriers qualifiés étaient majoritaires (42,86%) par rapport aux agents de maîtrise et aux cadres  $p = 0,13$ .

**Conclusion :** La prévalence de l'hépatite virale B est élevée dans cette entreprise Il est alors important de sensibiliser les travailleurs sur les voies de contamination et les mesures de prévention de cette maladie.

**Mots-clés :** Hépatite virale B ; Prévalence ; Travailleurs ; Entreprise agro-alimentaire.

## STH-5-S8-COP-94

### Prévalence et facteurs associés à l'intention de consommer du tabac chez les étudiants de première année de l'université Joseph KI-ZERBO

**Mahamadou BARRO**<sup>1</sup> ; Ahmed KABORE<sup>2</sup> ; Issa KABORE<sup>2</sup> ; Moumini NIAONE<sup>3,4</sup> ; Noled

MUGISHA<sup>4</sup>, Harriet NAMATA<sup>4</sup>; Jim ARINAITWE<sup>4</sup>; Nicolas MEDA<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Bobo Dioulasso, Burkina Faso ([levieuxbarro@gmail.com](mailto:levieuxbarro@gmail.com))

<sup>2</sup>UFR-SDS, Université de Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>3</sup>Ministère de la santé, Burkina Faso

<sup>4</sup>Centre for Tobacco Control in Africa, Uganda

**Introduction** : La consommation du tabac constitue un problème de santé publique particulièrement en Afrique. En effet le tabac tue une personne toutes les huit secondes.

**Objectif principal** : L'objectif de l'étude est de déterminer la prévalence de l'intention tabagique et les facteurs de la Théorie Sociale Cognitive (TSC) qui y sont associés chez les étudiants.

**Méthodes** : Nous avons mené une étude transversale à visée descriptive et analytique auprès d'étudiants régulièrement inscrits en première année à l'université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) en 2021. Les données ont été saisies avec le logiciel EPI data 3.5.1 et analysées par le logiciel STATA version 16. Une pondération proportionnellement aux poids des UFR a été faite. Un modèle logistique a été utilisé pour identifier les déterminants de l'intention tabagique.

**Résultats** : Au total 1074 étudiants soit un effectif pondéré de 8592 étudiants ont été inclus dont 63,18 % de sexe masculin. L'âge moyen des étudiants était de 22,18 ans ( $\pm 6,59$ ). La prévalence de l'intention tabagique est de 20,23% (IC95% = [19,38 – 21,11]). Les facteurs de la TSC associés à l'intention tabagique sont : le sexe (OR<sub>masculin</sub> = [1,97-2,73]), attentes pour ne pas fumer (OR<sub>positive</sub> = [0,56-0,82]), conditions environnementales face au tabagisme (OR<sub>favorable</sub> = [0,11-0,19]), auto-efficacité pour surmonter les barrières sans fumer (OR<sub>sûr</sub> = [0,09-0,19]) et gestion émotionnelle pour ne pas fumer (OR<sub>sûr</sub> = [5,16-10,46]).

**Conclusion** : La lutte contre le tabagisme demeure une priorité. Une démarche participative des jeunes intégrant des modèles comportementaux et cognitivistes contribuerait à réduire du fléau.

**Mots clés** : Théorie sociale Cognitive, Tabac, Intention, Etudiant, Université Joseph KI-ZERBO.

## STH-5-S8-COL-95

**Prévalence et facteurs associés de la consommation du cannabis chez les adolescents scolarisés au Bénin**

**Klikpo TEE<sup>1</sup>**, Kpozehouen A<sup>2</sup>, Kpozehouen D<sup>2</sup>, Anagonou L<sup>3</sup>, Fiossi Kpadonou E<sup>3</sup>, Houinato D<sup>4</sup>, Ezin Houngbe J<sup>1</sup>, Salamon R<sup>5</sup>

1- Unité de psychiatrie d'adultes, Département de santé mentale, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi, Bénin.

2- Département d'épidémiologie, Institut régional de santé publique (IRSP), Université d'Abomey Calavi, Bénin.

3- Unité de pédopsychiatrie, Département de santé mentale, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi, Bénin.

4- Laboratoire épidémiologique des maladies chroniques et neurologiques (LEMACEN), Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi, Bénin.

5- Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement (ISPED), Université de Bordeaux, France.

**Présentateur** : KLIKPO T.E. Elvyre; [eklikpo@gmail.com](mailto:eklikpo@gmail.com)

**Introduction** : Le début (12-14 ans) et la fin (15-17 ans) de l'adolescence sont des périodes critiques pour l'initiation à la consommation de substances psychoactives. La consommation de substances psychoactives est souvent associée aux troubles mentaux. En effet, le risque de souffrir de la schizophrénie est augmenté chez les consommateurs de cannabis.

**Objectif principal de l'étude** : Evaluer la consommation du cannabis en milieu scolaire était l'objectif de l'étude.

**Méthode** : Il s'est agi de faire une analyse secondaire des données existantes de l'enquête mondiale sur la santé en milieu scolaire (Global School-based student Health Survey (GSHS)) au Bénin en 2016. La variable dépendante étudiée était la "consommation du cannabis dans les trente derniers jours précédents l'enquête".

**Résultats** : Cinq adolescents sur 7 étaient de sexe masculin (72%), âgés de 15 ans et plus (86%) et fréquentaient des établissements publics (69%). Au cours des trente derniers jours précédents l'enquête, 1,97% des participants ont déclaré avoir fait usage du cannabis. Les participants ayant tenté de se suicider (ORa = 3,62 IC95% = [1,63 ; 8,03]) et ceux qui estimaient ne pas bénéficier d'un suivi rapproché de leurs parents (ORa = 3,93 IC95% = [1,46 ; 10,59]) avaient respectivement trois et quatre fois plus de risque d'avoir consommé le cannabis. Le fait de fumer des cigarettes (ORa = 18,26 IC95% = [8,67 ; 38,45]) multipliait 18 fois ce risque par rapport aux non-fumeurs.

**Conclusion** : Il découle de l'identification de ces facteurs de risque qu'il est nécessaire de faire des interventions sur la santé mentale des

élèves et la guidance parentale pour réduire la consommation du cannabis dans le milieu scolaire au Bénin

**Mots clés :** Prévalence, Consommation, Cannabis, Elèves, Benin

### STH-5-S8-COP-96

#### Evaluation de la qualité des services offerts aux consommateurs d'héroïne par le Centre des Addictions de Dakar

**Diop** Cheikh Tacko<sup>1\*</sup>, **Gomis** Alexandre<sup>2</sup>, **Ka** Ousseynou<sup>1</sup>, **Gueye** Boubacar<sup>1</sup>, **Sow** Djibril<sup>1</sup>, **Sow** P G<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculté de Santé Communautaire, Université Alioune DIOP, Bambey, Sénégal

<sup>2</sup>Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontologie, Université Cheikh Anta DIOP, Dakar, Sénégal

**Introduction :** La dépendance aux drogues constitue un problème majeur de santé publique au Sénégal. Une des réponses a été la mise en place d'un Centre de Prise en Charge Intégrée des Addictions de Dakar (CEPIAD). L'objectif de cette étude est d'évaluer la qualité des services offerts aux consommateurs d'héroïne bénéficiant d'un traitement de substitution par la méthadone.

**Méthodologie :** Il s'agit d'une étude transversale descriptive faite à partir d'un échantillonnage systématique de cent (100) héroïnomanes sous traitement de substitution par la méthadone et ayant donné leur consentement. Des entretiens individuels ont été réalisés avec les patients suivis régulièrement au centre dans la période du 16 décembre 2016 au 17 février 2017. Les données ont été saisies et analysées à l'aide du logiciel Epi-info et Excel.

**Résultats :** Une prédominance masculine a été retrouvé avec 92 hommes vs 8 femmes (sex ratio de 11,5). La moyenne d'âge était de 48,8 ans avec un écart type de 9,7. La presque majorité des enquêtés étaient de nationalité sénégalaise (99%), dont les 78% habitaient en ville et 22% en banlieue de Dakar. La grande majorité était des solitaires et était divorcés, célibataires ou veufs (61%). Le niveau d'étude était relativement élevé avec 11% ayant le niveau universitaire, 47% le niveau secondaire, 31% le niveau élémentaire et seulement 1 personne n'était pas scolarisé. On comptait parmi les enquêtés : 39 chômeurs, 1 ménagère, 5 retraités. Les 55 autres exerçaient une activité génératrice de revenus dont 42 dans le secteur informel. La totalité des enquêtés était satisfaite

et avait accès au matériel de Réduction Des Risques aux Infections sexuellement transmissibles (RDR). Parmi les enquêtés, 80 participaient régulièrement aux activités de convivialité dont les causeries, les repas communautaires... Les 20 autres n'avaient pas le temps d'y participer.

La méthadone était délivrée de 9h à 13 h les jours ouvrables. Seuls 57 enquêtés étaient satisfaits de l'horaire, 70 demandaient la possibilité d'emport et bénéficier d'une dotation d'une semaine.

**Conclusion :** Les héroïnomanes étaient globalement satisfaits mais il est nécessaire d'insister sur la sensibilisation, l'information et le sevrage. Il est important d'étendre les activités du CEPIAD aux autres régions et surtout aider les héroïnomanes à se réinsérer sur le plan socioprofessionnel.

**Mots clés :** Héroïne, Méthadone, Qualité, Sénégal

## Sous-thème 5 Session 9

### STH-5-S9-COP-97

#### Conditions de travail des salariés au poste de décorticage d'anacardes à Bobo-Dioulasso

**TRAORE I**<sup>1,2</sup>, **AKA INA**<sup>3</sup>, **IDO/ZOUNDI** CN<sup>2</sup>, **GUIEGUI CP**<sup>3</sup>, **SANON/LOMPO MS**<sup>4,5</sup>, **KABORE M**<sup>2</sup>, **KABORE SG**<sup>5</sup>, **ZOUNGRANA B**<sup>2</sup>, **ANDONABA JB**<sup>4,6</sup>, **KOUASSI YM**<sup>3</sup>.

1. Université NAZI BONI/Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA)
2. Office de Santé des Travailleurs (OST)
3. Service de Médecine du Travail et pathologies professionnelles, CHU Yopougon, Abidjan Côte d'Ivoire
4. Université Joseph KI ZERBO/UFR/SDS
5. Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO)
6. Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou (CHUSS)

**Présentateur :** TRAORE Issa ; Téléphone : 0022670293210 ; Email : [placitra@yahoo.fr](mailto:placitra@yahoo.fr)

**Introduction :** Le décorticage est une étape indispensable dans le processus de transformation de la noix de cajou.

**Objectif :** L'objectif de cette étude était de déterminer les conditions de travail des salariés au poste de décorticage dans une usine de transformation d'anacarde à Bobo-Dioulasso.

**Matériels et méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale descriptive qui s'est déroulée du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre 2020. Elle a porté sur les conditions de travail des décortiqueuses dans une entreprise de transformation d'anacardes à Bobo-Dioulasso.

**Résultats :** Notre étude a porté sur 249 travailleurs exclusivement de sexe féminin. L'âge moyen était de 35,83 ans  $\pm$  8,87ans, généralement non scolarisée (74 %) et avec une ancienneté professionnelle moyenne de 4,14 ans. Les nuisances auxquelles étaient exposées ces travailleuses étaient essentiellement le contact avec le CNSL, l'adoption de postures contraignantes, les gestes répétitifs et les risques d'accidents. Cent quarante-deux (57 %) avaient été victimes au moins une fois d'un accident de travail siégeant majoritairement au niveau de l'index gauche (61,6%) et ces accidents survenaient lors du concassage (96%). Les dermatoses étaient observées chez 162 décortiqueuses (65,06%) et elles étaient dominées par les dermites de contact d'irritation (58,2%) ; celles-ci siégeaient principalement sur les mains (68,2%). Les troubles musculosquelettiques étaient retrouvés chez 91 femmes (36,6%) avec l'épaule comme la principale localisation (30,9%). En termes de mesures de prévention, les décortiqueuses ont toutes bénéficié d'une visite médicale d'embauche et les EPI fournis n'étaient pas adaptés.

**Conclusion :** Le décorticage des noix de cajou expose les travailleurs à de nombreuses nuisances notamment chimiques, ergonomiques et physiques. Il est donc nécessaire d'améliorer les conditions de travail des décortiqueuses en leur fournissant des EPI adaptés et en les formant aux gestes et postures.

**Mots clés :** conditions de travail - décortiqueuse - noix de cajou - Bobo-Dioulasso

## STH-5-S9-COP-98

**Analyse de la Base de Données du Dénombrement Annuel des Girafes dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W, Partie Nigérienne « Zone Girafe » de 2010 à**

**Issaka A idrissa**<sup>1,2</sup>, Hamedine Saley <sup>2</sup>, A.Moustapha<sup>3</sup>, D. Barry <sup>1,4</sup>, Fadima.Diallo <sup>1,4</sup>, Pauline K.Yanogo<sup>1,4</sup>, Nicalas Méda <sup>1,4</sup>,

<sup>1</sup>Burkina Field Epidemiology and Laboratory Training Program, Burkina Faso

<sup>2</sup> Direction de la Faune de la Chasse et des Parcs et Réserves du Niger (DFC/PR)

<sup>3</sup> Direction Générale de la Santé Publique au Ministère de la santé Publique

<sup>4</sup>Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo, Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Burkina Faso

**Auteur correspondant :** Issaka Abdou Idrissa, Résident au programme de formation en Epidémiologie de Terrain de l'Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo /Direction de la Faune de la Chasse et des Parcs et Réserves à la Direction Générale des Eaux et Forêts du Niger.

Tél : +227 96101116 Adresse mail : [issakadriss@gmail.com](mailto:issakadriss@gmail.com)

**Introduction :** Les girafes du Niger, sont considérées comme les dernières représentantes de la sous espèce « peralta » d'Afrique de l'Ouest. Cette sous espèce est actuellement classée sur la liste rouge de l'UICN en 2010 dans la catégorie « En Danger ». Ainsi, pour améliorer son statut de conservation, nous avons analysé de base de données des girafes pour une meilleure conservation de l'espèce.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale analytique réalisée à la DFC/PR<sup>2</sup>. Elle a porté sur la sous-espèce de girafe de l'Afrique de l'Ouest. Deux types d'informations ont été collectés dans la base de données : (i) sur les girafes, (ii) sur l'habitat et les éventuelles menaces notifiées.

**Résultats :** il ressort de cette analyse que le nombre de girafes s'est considérablement accru en passant de 203 individus en 2010 à 664 individus en 2019 avec un taux de croissant annuel moyen de 11.4 % par an. La proportion moyenne des femelles observées est de 58.7% contre 41.3 % des mâles. Les femelles en âge de se reproduire représentent en moyenne 26.2 % de l'effectif moyen avec un taux de natalité moyen de 25.2 %. Le taux de mortalité moyen des girafes est de 1,2 % et semble être le plus faible. Le coefficient de vulnérabilité calculé montre que les adultes (R=1,16) sont très vulnérables comparés aux girafons (R=0,91), aux jeunes (R=0,83) et aux subadultes (R=0,47). Le sexe mâle (I= 1,08) quant à lui est relativement plus touché à la survenue des morts contrairement aux femelles (I=0.93)

**Conclusion :** L'absence d'un protocole de suivi sanitaire des girafes explique le fait que les causes de mortalités sont inconnues et qu'elles sont basées uniquement sur des observations visuelles.

**Mots clés :** Reserve de Biosphère transfrontalière, Zone girafe, Niger

## STH-5-S9-COP-99

**Abondance et diversité des moustiques vecteurs de pathogènes en milieu hospitalier : cas de l'hôpital de district de**

## Nouna, Burkina Faso

**Moustapha NIKIEMA**<sup>1, 2</sup>, Awa GNEME<sup>2</sup>,  
Athanasie BADOLO<sup>2</sup>, Boubacar  
COULIBALY<sup>1</sup>, Ali SIE<sup>1</sup>, Gustave B KABRE<sup>2</sup>

(1) Centre de Recherche en Santé de Nouna  
(CRSN) : 02 BP Nouna Burkina Faso, Rue Namory  
Keita

(2) Université Joseph Ki-zerbo (UJKZ) : 03 BP 7021  
Ouagadougou Rue Charles De Gaulle

Des espèces de moustiques appartenant au genre *Anopheles*, *Aedes* et *Culex* sont des vecteurs de maladies infectieuses dans le monde, particulièrement en Afrique tropicale. Ces insectes prolifèrent à la faveur de facteurs climatiques et anthropiques tels la pluviométrie, le manque d'aménagement et d'hygiène. L'objectif de ce travail est de déterminer la diversité et l'abondance de moustiques, vecteurs potentiels de maladies dans l'environnement de l'hôpital de district de Nouna.

Durant la période d'Aout à Novembre 2019, des moustiques adultes ont été collectés deux fois par semaine dans les salles d'hospitalisations et de soins de l'hôpital de district de Nouna. Entre 16 h et 18 h, une collecte à l'aide d'aspirateurs de type prockopact a été faite, ensuite les pièges lumineux CDC ont été installés de 18 h et 6 h du matin dans les mêmes locaux. Les moustiques collectés ont été identifiés morphologiquement à l'aide d'une loupe binoculaire en utilisant des clés d'identifications, pour d'abord distinguer les différents genres puis les espèces. Pour les espèces qui ne peuvent être distinguées par l'identification morphologique, l'outil moléculaire en occurrence la PCR a été utilisée sur la base de protocoles adaptés à chaque complexe ou groupe d'espèces.

Sur un total de 3178 culicidés collectés, (2345)73,8% étaient représentés par *Culex quinquefasciatus*, (578)18,2% d'*Anopheles arabiensis* et (255) 08% par *Aedes aegypti aegypti*. Les moustiques étaient beaucoup plus abondants dans les salles d'hospitalisations notamment dans les services de pédiatrie (63%) et de maternité (13%). Aussi 17% de moustiques ont été collectés les salles de consultations et 7% dans les salles de garde du personnel soignant.

Notre étude a révélé la présence d'une importante diversité de culicidés dans l'environnement de l'hôpital du district de Nouna. Cette présence de vecteurs potentiels est

un risque de transmission de maladies nosocomiales et dénote de l'absence d'hygiène et de politiques d'assainissement.

**Mots clés** : Moustiques, Abondance, diversité, hôpital, Nouna

## STH-5-S9-COP-100

### Evaluation du Système de Surveillance Ecologique dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W, Partie Nigérienne : Cas de la « Zone Girafe » de 2015 à 2019

**Issaka A idrissa**<sup>1,2</sup>, Hamedine Saley<sup>2</sup>, A. Moustapha<sup>3</sup>, D. Barry<sup>1,4</sup>, Fadima Diallo<sup>1,4</sup>, Pauline K. Yanogo<sup>1,4</sup>, Nicolas Méda<sup>1,4</sup>

<sup>1</sup>Burkina Field Epidemiology and Laboratory Training Program, Burkina Faso

<sup>2</sup> Direction de la Faune de la Chasse et des Parcs et Réserves du Niger (DFC/PR)

<sup>3</sup> Direction Générale de la Santé Publique au Ministère de la Santé Publique

<sup>4</sup> Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo, Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Burkina Faso

**Auteur correspondant** : Issaka Abdou Idrissa, Résident au programme de formation en Epidémiologie de Terrain de l'Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo /Direction de la Faune de la Chasse et des Parcs et Réserves à la Direction Générale des Eaux et Forêts du Niger.

Tél : +227 96101116 Adresse mail : [issakadriss@gmail.com](mailto:issakadriss@gmail.com)

**Introduction** : Après plusieurs années de fonctionnement du système de surveillance écologique dans la zone girafe, il convient de s'assurer que les objectifs initialement assignés sont atteints par le biais d'une évaluation. L'objet de ce travail est d'évaluer l'efficacité du système de surveillance à travers l'appréciation de son utilité et ses attributs.

**Méthodes** : Une étude transversale descriptive a été conduite en incluant les acteurs clés (public, privé, associatif et communautés locales) dans la gestion et la conservation des girafes selon un choix raisonné. L'analyse a été faite avec Excel et Epi info. Des fréquences, proportions.

**Résultats** : Au total nous avons interviewé 31 acteurs clés sur 40 initialement identifiés soit 77.5 % de notre cible. Les activités du système sont dominées par la collecte de données sur le conflit homme-girafe (83,9 %), le suivi des girafes (80,6%), les suivis de l'habitat (74,2%), le Suivi des points d'eau (48,4%) et le suivi météo (22,6%). Près de 58,1%, affirment que la retro-information déclenche des actions contre 32.3% de cas. Les actions les plus engagées sont

la sensibilisation (64,5), la lutte anti-braconnage (22,6%) et le suivi de la girafe ainsi que son habitat (12,9%). En termes de concordances entre les supports, 22(64.5%) des acteurs, pensent qu'il y'a une discordance contre 11(35.5%). Sur un total de 42 cas de mortalité notifiés, 31%(13/42) des individus ont un sexe connu, 16,6% (7/42) d'individus ont classe d'âge connue et 28,5% (12/42) des individus ont un lieu de mort connu. La proportion des données manquantes calculée sur la période est de 11,1%.

**Conclusion :** Le système de surveillance a été jugé utile, simple et acceptable avec une qualité des données appréciable mais non réactif entre 2015 à 2019.

**Mots clés :** Niger, Surveillance Ecologique, Réserve de Biosphère Transfrontalière du W, Zone Girafe

## STH-5-S9-COP-101

**Situation nationale de la résistance aux insecticides chez *Aedes aegypti* principal vecteur de la transmission des arboviroses au Burkina-Faso**

**Soumanaba ZONGO<sup>1</sup>**, Hyacinthe K. TOE<sup>2</sup>, Prosper THIAO<sup>3</sup>, Seydou A. YARO<sup>4</sup>, Brice BICABA<sup>3</sup>, Adama GANSANE<sup>1</sup>, N'Falé SAGNON<sup>1</sup>, Moussa W. GUELBEOGO<sup>2</sup>.

1 : Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme

2 : Université Joseph Ki-Zerbo

3 : Centre des Operations de Réponses aux Urgences Sanitaire

4 : Université des Sciences des Techniques et des Technologiques de Bamako, Mali

Email : [zongosoumanaba@gmail.com](mailto:zongosoumanaba@gmail.com)

### Introduction

Le Burkina-Faso a enregistré des flambées successives de dengue dont le vecteur est *Aedes aegypti*. La mise à jour des données bioécologique et la sensibilité du vecteur aux insecticides est primordial avant toute lutte anti-vectorielle. Le niveau de résistance des *Aedes* a été suivi sur l'ensembles du pays pour informer les décideurs.

### Méthodes

Des moustiques adultes de 3 à 5 jours provenant des œufs collectés en 2019 et 2020 à l'aide de pondeurs dans les chefs-lieux de région ont été exposés à des papiers imprégnés d'insecticide selon le protocole de l'OMS. Les taux de mortalités ont été évalués après 24 heures d'exposition et la détection des gènes de résistance par la qPCR a été effectuée.

### Résultats

Les populations de *Ae. aegypti* des 13 régions ont montré une forte résistance aux insecticides de la classe des pyréthrinoides avec des taux qui variaient de 13,4% à 29,1% pour l'alphacyperméthrine 0,03% et de 2 % à 68,7 % pour la deltaméthrine 0,03%. Cependant pour les insecticides de la classe des carbamates (Bendiocarb 0,1%) et organophosphates (malathion 0.8% et Pirimiphos-méthyl 0.21%) une résistance modérée a été observée avec des taux de mortalité de 20 à 98% pour le Bendiocarb 0,1%, de 80% à 100% pour le Malathion 0,8% et de 57% à 100% pour Pirimiphos-méthyl 0.21%. 655 moustiques ont été génotypé pour la détection des mutations Kdr Phe1534Csy, Val1016Iso et Val410Leu et les fréquences alléliques moyennes respectives étaient de 0,89, 0,38 et 0,35 suggérant leur implication dans la résistance aux pyréthrinoides.

### Conclusion

Notre étude a révélé que les *Ae. Aegypti* du Burkina-Faso sont résistants à plusieurs classes d'insecticides. Ainsi une stratégie nationale de monitoring et de surveillance continue de la résistance de *Ae. Aegypti* pour un meilleur contrôle des maladies à arbovirus s'impose.

**Mots-clés :** dengue, *Ae. Aegypti*, résistance, insecticides, gènes KDR

## STH-5-S9-COP-102

**Étude de la gestion des déchets biomédicaux dans le district sanitaire de Goudiry au Sénégal**

**Dr Martial Coly BOP**

**Enseignant/Chercheur**

**Maitre de Conférences Titulaire**

**Bop MC<sup>1</sup>**, Sow-PG<sup>2\*</sup>, Gueye B, Tall AB<sup>1</sup>, Ka O<sup>1</sup>, Diop EM<sup>1</sup> <sup>1</sup>Université Alioune Diop de Bambey

Auteur correspondant: Dr Papa gallo sow, BP : 5856 Dakar- Fann /Sénégal Email: [papagallosow@uadb.edu.sn](mailto:papagallosow@uadb.edu.sn)

Il s'agissait d'explorer, au niveau du district sanitaire de Goudiry, la pratique de la gestion des déchets biomédicaux et d'en analyser les conséquences.

**Matériels et Méthodes :** L'échantillon était constitué de sept Postes de Santé tirés sur 11 postes par un sondage aléatoire simple et d'un Centre de Santé dont toutes les unités fonctionnelles ont été incluses dans l'étude. Les données ont été recueillies au travers des entretiens structurés avec l'ensemble du

personnel, des observations participantes et de la recherche documentaire.

**Résultats :** Le District, en sept jours, avait produit 111,9 Kg (soit 16,0 kg/j). La gestion des déchets était inadéquate à tous les niveaux.

**Conclusion :** A cet effet, pour améliorer la gestion des déchets, les actions à mener étaient la sensibilisation et la formation des acteurs, l'implication de toutes les parties prenantes (collectivités locales, population, personnel sanitaire), et le plaidoyer auprès des décideurs.

**Mots clés :** Gestion, déchets biomédicaux, district sanitaire

## STH-5-S9-COP-103

**Intoxication alimentaire mortelle dans une famille au Burkina Faso: apport des analyses toxicologiques dans la recherche des causes de décès.**

**N. -S. Dimitri MEDA\***, Cheick. PALM, Elie. KABRE

Laboratoire National de Santé Publique, 09 BP 24, Ouagadougou, Burkina Faso

### Introduction

En septembre 2017, il est survenu dans un village du Burkina Faso (BF), un cas inhabituel de décès de cinq membres d'une famille, quelques heures après à la prise d'un repas commun. Ainsi, l'hypothèse d'une intoxication alimentaire (IA) a été formulée.

L'analytique toxicologique a été mise à contribution pour détermination des causes de décès.

### Objectif principal:

Confirmer l'intoxication alimentaire par la mise en évidence de substances toxiques dans les échantillons suspects.

### Méthodes:

Après une inspection des lieux, des échantillons alimentaires et biologiques ont été collectés et analysés.

La recherche de pesticides et le screening chimique par GC/MS, ont été les principales analyses réalisées.

Une approche estimative a été appliquée pour évaluer le risque toxique.

### Résultats:

Vingt-un échantillons ont été analysés, dont quatre étaient les restes de repas consommés par les victimes.

Du Fipronil et Cyhalothrine ont été identifiées dans le reste de «tô consommé», avec des teneurs respectives de **21,14** et **226,15** mg/kg.

L'estimation du risque a montré que les doses supposées ingérées correspondent respectivement à **3** et **45** fois la dose de

référence aigue du Fipronil et de la Cyhalothrine.

Aucune substance d'intérêt toxicologique n'a été détectée dans les échantillons biologiques.

### Conclusion

On a notifié une IA collective due à la consommation d'un repas contaminé par du Fipronil et de la Cyhalothrine, avec 100% de létalité. Or, Fipronil et Cyhalothrine sont deux pesticides à toxicité modérée selon l'Échelle de Hodge et Sterner. Mais avec les teneurs déterminées, l'estimation du risque montre que les doses ingérées sont suffisantes pour causer des dommages pour l'homme en une seule exposition pour chacun des pesticides.

Par ailleurs, la cause de décès n'a pu être imputée à ces pesticides, car ils n'ont été détectés dans aucun échantillon biologique.

Toutefois, cet événement indique le niveau du risque d'exposition aux pesticides au BF.

**Mots clés:** Intoxication alimentaire, Pesticides, Fipronil, Cyhalothrine, risque toxique

## STH-5-S9-COP-104

**Prévalence et facteurs associés à l'hygiène des mains chez les adolescents scolarisés au Bénin**

**Alphonse Kpozèhouen<sup>1\*</sup>**, Yolaine Glèlè Ahanhanzo<sup>1</sup>, Elvyre Klikpo<sup>2</sup>, Cyriaque Degbey<sup>1</sup>, Agbohoui-Houinato Olga<sup>3</sup>, Dismand Houinato<sup>3</sup>, Roger Salamon<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>2</sup>Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>3</sup>Laboratoire d'Epidémiologie des Maladies Chroniques Et Neurologiques (LEMACEN), Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Benin

<sup>4</sup>Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement, Université Victor Segalen, France

\*Email: Alphonse Kpozèhouen – [Alphonse.Kpozehouen@gmail.com](mailto:Alphonse.Kpozehouen@gmail.com)

**Introduction :** Une bonne hygiène des mains (HM) avec du savon peut éviter 0,5 à 1,4 million de décès chaque année. Malgré l'impact positif d'une bonne HM, la prévalence des bonnes pratiques d'HM chez les adolescents demeure encore faible. Dans cette étude, nous avons estimé la prévalence et les potentiels facteurs qui pourraient influencer l'hygiène des mains chez les adolescents scolarisés au Bénin.

**Méthodes :** Il s'agit d'une étude transversale qui a utilisé des données chez les adolescents scolarisés provenant de l'Enquête Mondiale sur la Santé en Milieu Scolaire de 2016. Pour

analyser les données, nous avons utilisé le logiciel Stata version 12, des statistiques descriptives et inférentielles. Toutes les analyses statistiques ont été considérées comme significatives à une valeur  $p < 0,05$ .

**Résultats :** Nous avons au total travaillé sur 3968 élèves (27,08% de filles et 72,92% de garçons). La prévalence d'une bonne hygiène des mains était de 33,43% IC95%=[31,33 – 35,53]. Plus les adolescents étaient âgés et plus ils étaient susceptibles d'avoir une bonne HM (OR=1,09 ; IC95%[1,01 – 1,18]). Les adolescents victimes d'intimidation à l'école avaient moins de chances de pratiquer une bonne HM (OR=0,77 ; IC95%[0,61 – 0,97]). Les adolescents impliqués dans les bagarres étaient moins susceptibles d'avoir de bonnes pratiques en ce qui concerne une bonne HM (OR=0,73 ; IC95%[0,56 – 0,96]). Les adolescents dont les parents vérifiaient si leurs devoirs étaient faits, étaient 1,98 fois plus susceptibles de pratiquer une bonne HM (OR=1,97 ; IC95%[1,57 – 2,48]). Les adolescents allant à l'école en milieu urbain étaient plus susceptibles de pratiquer une bonne HM (OR=1,53 ; IC95%[1,21 – 1,95]).

**Conclusion :** Les bonnes habitudes d'hygiène restent une stratégie clé pour diminuer la propagation des maladies transmissibles. Le résultat de l'étude actuelle (prévalence de 33,43%) sur la bonne hygiène des mains, reflète l'incapacité du pays à fournir un accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Pour atteindre l'ODD 6.2, qui stipulait que toutes les personnes aient un accès adéquat et équitable à l'assainissement et à l'hygiène d'ici 2030, de nouvelles initiatives visant à promouvoir les comportements d'hygiène chez les adolescents, ainsi que l'extension des interventions existantes comme l'initiative WASH (Eau, Assainissement et Éducation à l'Hygiène) dans les écoles, sont nécessaires.

**Mots clés :** hygiène des mains ; adolescents scolarisés ; Enquête Mondiale sur la Santé en Milieu Scolaire ; Bénin.

## STH-5-S9-COP-105

**Accès aux ressources d'hygiène des mains dans les ménages béninois : Une analyse de l'Enquête Démographique et Sanitaire de 2018**

**Alphonse Kpozèhouen<sup>1\*</sup>**, Yolaine Glèlè Ahanhanzo<sup>1</sup>, Elvyre Klikpo<sup>2</sup>, Cyriaque Degbey<sup>1</sup>, Moussiliou Noël Paraiso<sup>1</sup>, Edgard-Marius Ouendo<sup>1</sup>, Roger Salamon<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>2</sup>Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

<sup>3</sup>Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement, Université Victor Segalen, France

\*Email: Alphonse Kpozèhouen –

[Alphonse.Kpozehouen@gmail.com](mailto:Alphonse.Kpozehouen@gmail.com)

**Introduction :** Le lavage des mains à l'eau et au savon reste la mesure de santé publique la plus efficace pour réduire le risque de maladies infectieuses. L'absence de ressources pour l'hygiène des mains dans les foyers expose de nombreuses personnes au risque de ces maladies infectieuses. À la suite de l'apparition de la pandémie de COVID-19, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les gouvernements du monde entier ont souligné l'importance du lavage régulier des mains pour prévenir la propagation du virus. Cela suggère que la recherche sur les questions d'eau, d'assainissement et d'hygiène mérite une attention particulière de la part des chercheurs. Cette étude a estimé la prévalence de ménages béninois ayant accès aux ressources d'hygiène des mains et les potentiels facteurs associés en utilisant les données d'une enquête nationale récente.

### Méthodes

L'étude a utilisé les données de l'Enquête Démographique et de Santé du Bénin de 2018. Le logiciel STATA-12 a servi pour l'analyse des données. Toutes les analyses (descriptives, univariées et multivariées) ont été pondérées. Nous avons utilisé une régression logistique pour déterminer les forces d'association (Odds Ratio (OR)) et leur intervalle de confiance à 95%. Le seuil de significativité était fixé à 5% pour toutes les analyses.

### Résultats

Nous avons travaillé sur 7001 ménages ; la prévalence des ménages qui avait accès à des ressources pour l'hygiène des mains était de 15,15% (IC95%=[13,34 – 17,15]), soit environ 1 ménage sur 7. Les ménages dont les chefs de ménage avaient un niveau d'instruction secondaire (OR=1,80 ; IC95%=[1,31 – 2,48]) ou supérieur (OR=2,71 ; IC95%=[1,73 – 3,91]) étaient plus susceptibles d'avoir accès aux ressources d'hygiène des mains. Disposer d'une radio (OR=1,49 ; IC95%=[1,10 – 2,00]), posséder une source d'eau potable (OR=1,42 ; IC95%=[1,10 – 2,01]) augmenterait les probabilités d'avoir accès aux ressources d'hygiène des mains. Les ménages les plus riches étaient plus susceptibles d'avoir un endroit pour se laver les mains au savons que

leurs homologues, les plus pauvres (OR=2,46 ; IC95%=[1,42 - 4,28]).

### Conclusion

Le gouvernement et les partenaires au développement pourraient fournir des ressources d'hygiène des mains aux ménages ayant un accès limité ou nul. À long terme, nous recommandons aux autorités de mettre en œuvre des mesures et des politiques qui faciliteraient l'indépendance économique des citoyens et leur accès à l'éducation.

**Mots-clés** : Hygiène des mains, savon, eau, assainissement, enquête démographique et de santé, Bénin.

## STH-5-S9-COP-106

**Investigation de cas suspect de toxi-infection alimentaire dans le village de Mignoré, District sanitaire de Vavoua, Côte d'Ivoire, 2021.**

**WOGNIN .A S<sup>1</sup>**, D .BARRY<sup>2</sup> ,PK.YANOGO<sup>2</sup> , KEITA .Y<sup>3</sup>, YAPO. Ossey B <sup>4</sup>,

Email : [yapossey@yahoo.fr](mailto:yapossey@yahoo.fr)

1. Université Pelefero Gon Coulibaly/Centre Ivoirien Antipollution ; Cohorte 6 BFELTP

2. Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain et de Laboratoire, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé, Université Pr Joseph Ki- Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ;

3. Institut National d'Hygiène Publique ;

4. Université Nangui Abrogoua/Centre Ivoirien Antipollution

**Auteur correspondant** : WOGNIN Affou Séraphin

**Tel** : +225 0707850875

Email : [seraphinwn@gmail.com](mailto:seraphinwn@gmail.com) ;

**Introduction** : L'Organisation Mondiale de Santé a indiqué que 310 000 à 600 000 personnes décèdent des maladies d'origine alimentaire dans le monde. L'Afrique fait partie des continents dont la charge de morbidité imputable à ces maladies est la plus élevée (Rapport OMS, 2015). La Côte d'Ivoire a rapporté plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives. Cette étude était d'investiguer les cas de toxi-infection alimentaire suite à la notification par le district sanitaire de Vavoua, en septembre 2021.

**Méthodes** : Une étude de cohorte a été réalisée. Les données sociodémographiques cliniques ont été collectées à travers un questionnaire. Des échantillons de farine de maïs et eau de boisson ont été collectés puis analysés. L'analyse des données a été réalisée à l'aide du logiciel Epi Info 7.2 et Excel 2016. Le risque relatif (RR) pour chaque repas a été calculé.

**Résultats** : Les taux d'attaque (TA) et de létalité (TL) obtenus sont respectivement de 63% et 90%. Les proportions élevées de signes cliniques sont le coma (40%), les troubles de la conscience (40%), les vomissements (40%). Le risque relatif (RR) calculé pour le "*Tô à base de maïs et la sauce feuille*" est de 4. Une charge 1020 UFC/100mL d'*Escherichia coli* a été dénombré dans l'eau de boisson. Une teneur moyenne d'aflatoxine totale de 21,73±1,03 µg/kg (supérieure à la norme de 4µg/kg) a été obtenue dans la farine de maïs prélevée.

### Conclusion

L'enquête épidémiologique et les analyses de laboratoire effectués indiquent que le "*Tô à base de maïs et la sauce feuille*" consommé est fortement suspecté d'être à l'origine de l'intoxication alimentaire survenu dans le village de Mignoré.

### Recommandations :

- Consommer les aliments bien protégés ;
- Se rendre à l'hôpital en cas signes similaires.

**Mot clés** : Intoxication alimentaire, village de Mignoré, district sanitaire de Vavoua, Côte d'Ivoire

## STH-5-S9-COL-107

**Évaluation des risques professionnels du brulage du plastiques chez les soudeurs à Parakou**

**Gounongbé A. C. Fabien<sup>1</sup>**, Mama Cissé Ibrahim<sup>1</sup>, Hinson Antoine V<sup>2</sup>. Owona L. Jules<sup>3</sup>

1. Faculté de médecine, Université de Parakou, Bénin

2. Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

3. Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques, Université de Douala, Cameroun

**Communicateur** : Dr Fabien Christophe A. GOUNONGBÉ, Maître de Conférences Agrégé en Médecin du Travail, Faculté de Médecine ; Université de Parakou ; Bénin

Email : [gcfabien@yahoo.ca](mailto:gcfabien@yahoo.ca)

**Introduction** : L'utilisation à grande échelle du plastique particulièrement dans la fabrication des moyens de transport a conduit au métier de soudage de cette matière en Afrique subsaharienne.

**Objectif** : Évaluer les risques professionnels du brulage du plastiques chez les soudeurs à Parakou

**Méthode d'étude :** Il s'est agi d'une étude transversale descriptive et à visée analytique déroulée du 1er mai au 30 juillet 2019. Avec un questionnaire et une grille d'observationnelle les données ont été recueillies. Elle a concerné les soudeurs de matière plastique de Parakou. Étaient inclus tous les soudeurs qui ont donné leur libre consentement. La saisie et l'analyse des données ont été faites par le logiciel Epi info version 7.2.1.0. Le seuil de signification a été fixé à une valeur de  $p < 0,05$ .

**Résultats :** La fréquence des accidents du travail était de 99,27%. Tous s'étaient brûlés quatre fois au moins par mois. Étaient plus exprimées les manifestations respiratoires (86,76%), oculaires (97,81%), dermatologiques (66,42%), neurologiques (96,24%). Une très faible proportion des soudeurs portait les équipements de protection individuelle pendant le travail. Les facteurs associés à la brûlure étaient les troubles musculosquelettiques, l'âge, la perception personnelle du travail, l'exposition à la chaleur et la mauvaise organisation du milieu de travail.

**Conclusion :** Le soudage de plastique est une activité à risque sanitaire important. Il urge de prendre des mesures pour limiter l'exposition.

**Mots clés :** Brûlage, plastique, risqué, santé, soudeur, Parakou.

## STH-5-S9-COL-108

**Prévalence et facteurs associés à la surcharge pondérale chez les adolescents scolarisés de 10 à 19 ans, Conakry, Guinée, 2020**

**Enogo KOIVOGUI<sup>1</sup>**, Niouma N LENO<sup>2</sup>, Jean KABORE<sup>3</sup>, Sakoba KEITA<sup>4</sup>, Pauline YONOGO<sup>5</sup>, Nicolas MEDA<sup>6</sup>

(1) Département Surveillance, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Conakry, Guinée.

(2) Programme National de Lutte Contre le Sida, Direction Nationale de Grande Endémie, Conakry, Guinée.

(3) Institut de recherche en science de la santé (IRSS),

(4) Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Ministère de la Santé, Conakry, Guinée. Ouagadougou, Burkina Faso.

(5) Coordinatrice du programme BFELTP, Ouagadougou, Burkina Faso.

(6) Directeur du programme BFELTP, Ouagadougou, Burkina Faso.

**Objectif :** L'objectif de ce travail était d'étudier la prévalence et les facteurs associés à la surcharge pondérale chez adolescents scolarisés de la ville de Conakry.

**Méthodes :** Il s'agissait d'une enquête transversale analytique réalisée en mars 2020 sur un échantillon représentatif d'élèves 720 adolescents recrutés dans les élémentaires et secondaires, primaires et publiques. Des informations concernant les caractéristiques sociodémographiques et les habitudes alimentaires pour chaque adolescent ont été précisées au moyen d'un questionnaire.

**Résultats :** Nous avons enquêté 697 adolescents, âgés entre 10 et 19 ans et se répartissant en 316 garçons (45%) et 381 filles (55%). La prévalence de la surcharge pondérale était de 12,91 %. La surcharge pondérale était significativement associée au sexe féminin de l'adolescent,  $p=0,001$  et à la faible pratique d'activités physique,  $p=0,048$ .

**Conclusion :** L'identification des facteurs associés à la surcharge pondérale permettrait de dépister les adolescents à risques afin de leur proposer des mesures de prévention adaptées. Elles devraient inclure non seulement des approches individuelles, mais aussi l'environnement social et physique de l'adolescent.

**Mots clés :** Prévalence, facteurs associés, surcharge pondérale, adolescents, milieu scolaire.

## Sous-thème 5 Session 10

### STH-5-S10-COP-109

**Effet du portage céphalique sur les paramètres cinématiques de la marche chez les enfants de 8 à 11 ans**

**Auteurs :** 1<sup>er</sup> **Kabore André**, 2<sup>ème</sup> Hounmenou Mahoutin Alain, 3<sup>ème</sup> Tiama Adama, 4<sup>ème</sup> Falola Jean-Marie.

Le port de charge céphalique est une technique de portage très courant chez les enfants et les femmes en Afrique de l'ouest et consiste à garder sur soi un objet sur la tête au cours d'un déplacement surtout dans le domaine commercial et autour des travaux domestiques. Il n'est pas sans conséquence sur la santé des enfants porteurs. Le but de cette étude expérimentale est d'évaluer les effets induits par le portage céphalique sur les paramètres cinématiques de la marche chez des enfants au Bénin.

**Méthode :** 36 enfants âgés de 8 à 11 ans ayant au moins 3 ans d'expérience dans la pratique du portage céphalique ont pris part à l'étude. Les données obtenues ont été traitées avec le

logiciel statistique R 3.1.0. Le Test t de Student pour échantillons indépendants a permis de déterminer les différences significatives entre la condition de portage sans charge et celle avec charge. Le niveau de significativité des tests statistiques est fixé à  $p < 0,05$ .

**Résultat :** Après analyse de plusieurs charges échelonnées 0% MC, 10% MC, 15% MC, 20% MC, 25% MC, 30% MC, 35% MC et 40% MC, nous avons observé une perturbation de la durée de mise en charge lors de la phase d'oscillation à partir de 35% MC avec  $p = 0,0124 < 0,05$  par rapport à la condition de portage sans charge (0%).

**Conclusion :** Les enfants de 8 à 11 ans de notre échantillon peuvent porter sur la tête, une charge correspondant à 30% de leur masse corporelle sans aucune perturbation des paramètres cinématiques

Mots clés : Enfants, charge céphalique, paramètres cinématiques

## STH-5-S10-COP-110

### Évaluation de l'âge osseux par l'IRM

**H.BOUZOU Souleymane**, SOUNA SEYNI Badio, ALKASSOUM Ibrahim, Guidah Seidou, Moumouni Hassan, Ali Ada Omid, B.Hima Mahamadou Bello

Hôpital National Amirou Boubacar Diallo de Niamey

[leymane5@gmail.com](mailto:leymane5@gmail.com)

**Introduction :** L'évaluation de l'âge osseux correspond au besoin de disposer d'une méthode d'estimation du degré du développement de l'enfant et de sa maturation, indépendamment du poids, de la taille et de l'âge civil, qui était basé sur des examens radiologiques osseux.

**Objectif général :** Contribuer à l'évaluation de l'âge osseux par l'imagerie par résonnancemagnétique nucléaire.

**Patients et Méthode :** il s'agissait d'une étude IRM descriptive et rétrospective du poignet gauche de 2 équipes d'adolescents footballeurs de sexe masculin réalisée de janvier 2015 à septembre 2017 dans le cadre des compétitions de football CAN U17.

**Résultats :** Tous les joueurs étaient de sexe masculin. L'analyse du degré de fusion de la physe radiale a montré la distribution suivante pour les équipes 1 et 2 respectivement : grade I : 0% et 3,12% ; grade II : 11% et 15,62% ; grade III : 4% et 25% ; grade IV : 5 % et 31,25% ; grade V : 20% et 3,12% ; grade VI : 6% et 21,89%. L'âge IRM était supérieur à l'âge civil dans 68%

des cas dans l'équipe 1 et 65,63% des cas dans l'équipe 2 ; il était inférieur dans 17% et 15,62% des cas ; concordant dans 15% et 18,75% des cas. Le nombre de footballeurs qui avaient un âge  $\leq 17$  ans était de 20 sur 46 (43%) dans le premier groupe et 24 sur 32 (75%) dans le second groupe.

**Conclusion :** l'IRM est une technique d'imagerie médicale non irradiante qui malgré son cout élevé par rapport à la radiographie standard fourni une bonne corrélation entre l'âge civil (âge chronologique) et l'âge osseux.

Mots clés : IRM, Niger

## STH-5-S10-COP-111

### Fractures de la Jambe à l'hôpital Général de Référence (HGR) de Niamey : aspects épidémiologiques et lésionnels

**H.BOUZOU Souleymane**, SOUNA SEYNI Badio, ALKASSOUM Ibrahim, ABDOULWAHAB Mohamed, Idé GARBA, MAYAKI ALZOUMA Harouna IDI WADA Abdoul Wahabou

Hôpital National Amirou Boubacar Diallo de Niamey

Hôpital Général de Référence de Niamey

Hôpital National de Niamey

[leymane5@gmail.com](mailto:leymane5@gmail.com)

**Introduction :** Les fractures de jambe sont très fréquentes et représentent 15 à 20 % de l'ensemble des fractures. Beaucoup d'études ont concerné ces fractures, d'où notre intérêt pour les aspects épidémiologiques et lésionnels.

**Objectif général :** contribuer à l'amélioration de la prise en charge des fractures traumatiques de la jambe.

**Patients et méthode :** il s'agissait d'une étude rétrospective et prospective mono centrique qui a concerné 90 patients colligés dans le service de chirurgie traumatologique et orthopédique de l'HGR.

**Résultats :** L'âge moyen des patients était de 34,58 ans et le sexe masculin (85,6%) prédominait le genre. Les étiologies étaient dominées par les AVP (65,6%). Dans 83% des cas les deux roues (motos) étaient impliquées dans la survenue des fractures de la jambe. Le délai d'admission des patients était inférieur à 12H. Les signes fonctionnels étaient présents chez la quasi-totalité des patients. Seulement 7,8% ne présentaient pas de déformation du membre atteint à leur admission. Le côté droit était le plus atteint avec 56,7% (n=51), a sont tiers moyen (34,45%) le plus souvent. Les fractures ouvertes (24,4%) étaient moins

représentées que les fractures fermées (75,6%) et parmi les fractures ouvertes, 54,6% étaient classées type II selon la classification de Gustilo-Anderson. Le type de déplacement le plus fréquent était le chevauchement et selon la classification de l'association d'ostéosynthèse (AO) le type 42A3 était le plus représenté avec 32,22% (n=29). Les lésions du fémur avaient la plus grande représentation des lésions associées.

**Conclusion :** les fractures de la jambe étaient plus fréquentes chez le sujet jeune de sexe masculin et victime d'AVP. Les fractures ouvertes étaient moins représentées et le déplacement le plus souvent mis en avant était le chevauchement

**Mots clés :** *Epidémiologie-Fracture-Jambe – NIGER.*

### STH-5-S10-COP-112

#### Représentations et pratiques relationnelles en milieu de soins dans le contexte de gratuité au Burkina Faso

**Maurice SARIGDA**, doctorant en sociologie de la santé, laboratoire société, migration et environnement : Université Joseph KI-Zerbo : [maursarigda@yahoo.fr](mailto:maursarigda@yahoo.fr); numéro de téléphone : 70282775

Au Burkina Faso, le taux de mortalité infanto-juvénile demeure élevé. Cette situation est attribuable à la non utilisation optimum des services de santé par les populations à faibles revenus. Des politiques de gratuité notamment l'exemption totale de paiement des soins au profit des enfants de moins de 5 ans est mise en œuvre comme une panacée depuis avril 2016. Sa logique d'action est de promouvoir le recours précoce aux centres de santé par les bénéficiaires en supprimant la barrière financière. Visant la réduction la mortalité infanto-juvénile, cet objectif n'est possible que si les soins sont de qualité technique et relationnelle. La politique de gratuité dans sa mise en œuvre améliore-t-elle les relations en milieu de soins?

Partant du postulat que les représentations structurent les pensées et conditionnent les pratiques des acteurs, cette recherche a été menée dans trois structures dans trois centres de santé et de promotion sociale appartenant à des milieux sociaux différents du Centre (Ouagadougou) que sont : Bang-poore, Sakoula et Yamba.

La posture épistémologique adoptée est celle de l'empowerment. L'approche méthodologique

mixte a consisté en une enquête par distanciation sociale. Ainsi, une observation multi située non participante a permis de collecter des données lors des consultations curatives à l'aide d'une grille. Au total, 137 consultations réalisées ont été observées. De plus 33 entretiens individuels avec les usagers et 1 focus groupe avec les soignants ont réalisés.

Les principaux résultats montrent une insuffisance relationnelle des pratiques de soins se traduisant par une faible écoute corporelle et prise en compte de la dimension sociale de la maladie et une prescription des décisions thérapeutiques. La pression sociale attribuable à la gratuité est mobilisée par les soignants comme justificatifs. Mais, en réalité, la posture paternaliste des soignants facilitée par la recherche du consensus social par les soignés explique ces insuffisances relationnelles.

**Mots clés:** représentations ; pratiques ; gratuité ; relation ; soins

### STH-5-S10-COP-113

#### « Humour et pratiques enseignante : quel enjeu pour l'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires du secondaire »

**Missa BARRO**

E-mail : [barromissa@gmail.com](mailto:barromissa@gmail.com)

Considéré dans son rôle éducatif, l'humour tient une place si minime dans l'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires du secondaire au Burkina Faso en dépit des vertus pédagogiques qu'il pourrait receler. Pourquoi un tel mépris pédagogique pour l'humour quand on sait le rôle qu'il pourrait jouer, tant dans la relation pédagogique et le climat de la classe que dans la facilitation de la construction des savoirs dans ces disciplines ? Quels sont les enjeux pédagogiques du recours à l'humour en classe ? Ces préoccupations et interrogations fondent notre travail réflexif sur la place et les enjeux pédagogiques du recours à l'humour comme approche pour un enseignement et apprentissage des disciplines et spécifiquement des disciplines littéraires.

A ce sujet, nous retenons deux hypothèses, à savoir que l'humour dans les disciplines littéraires facilite l'enseignement-apprentissage. La méconnaissance des enjeux pédagogiques de l'humour aux enseignants ne favorise pas le recours à cette technique d'apprentissage dans leurs pratiques pédagogiques.

Cette étude s'inscrit dans une méthodologie de

recherche mixte. Les résultats des données de l'enquête montrent qu'en matière d'enseignement-apprentissage des disciplines littéraires, l'humour a une fonction cognitive. Distillé avec tact et précaution, il produit des effets positifs sur le climat de classe, sur la relation pédagogique, sur l'apprentissage et contribue à créer une atmosphère agréable de travail en classe. Il réduit la distance psychologique entre l'enseignant et les élèves en induisant joie et plaisir voire un meilleur enseignement-apprentissage de ces disciplines.

#### Mots-clés

Humour, pratiques pédagogiques, enseignement-apprentissage, matières littéraires, jeux.

### STH-5-S10-COP-114

**Des enfants handicapés mentaux en famille : problématique de la prise en charge et de l'accompagnement psycho-éducatif des parents.**

Coulibaly Yasnoga Félicité, épouse Barro,  
École Normale Supérieure/Burkina Faso, 01 BP  
2237 Ouagadougou 01, [byasnog@gmail.com](mailto:byasnog@gmail.com)

La survenue du handicap mental, sa découverte ou son annonce par les spécialistes créent beaucoup de difficultés existentielles au sein de la cellule familiale. L'enfant handicapé mental dans la famille pose problème parce qu'il "n'est pas comme les autres" enfants. Alors, comment la famille vit-elle avec le handicap ? Quels types de souffrances rencontrent-elles ? Comment y faire face ? Comment répondre aux besoins de l'enfant ? Quelles stratégies développer pour une meilleure prise en charge ?

Ce thème vise à comprendre le handicap mental de l'enfant, son vécu au niveau familial ainsi que les ressources dont disposent les parents pour une prise en charge holistique.

L'étude a été réalisée dans la ville de Ouagadougou auprès de 39 professionnels et 37 familles d'enfants handicapés de la Communauté de l'Arche Nongr-Maasem de Ouagadougou et de l'Association des Parents et Amis d'Enfants Encéphalopathes. Les professionnels ont été soumis à un questionnaire et les familles à un entretien semi-directif.

Les résultats révèlent qu'en dépit des difficultés multiformes rencontrées par les familles, des

ajustements et réajustements intrafamiliaux et extrafamiliaux s'opèrent grâce aux potentialités et ressources existantes et à l'accompagnement des parents à domicile par les spécialistes.

Malgré toutes les compétences et ressources mises en place pour affronter la problématique du handicap mental, des besoins et des attentes sont formulés pour une meilleure prise en charge et un accompagnement plus structurant pour l'enfant handicapé et sa famille.

**Mots clés :** handicap mental, famille, parentalité, prise en charge, accompagnement, domicile.

### STH-5-S10-COP-115

**Douleurs lombaires chez les joueurs seniors de handball de la ville de Ouagadougou**

SAWADOGO Amidou <sup>(1\*)</sup>, ZONGO  
Delwendé Mireille<sup>(1)</sup>, NANA Brigitte<sup>(1)</sup>

(1) Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain (ISSDH) / Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.

\*Auteur présentateur, email : [sawa.amidou@gmail.com](mailto:sawa.amidou@gmail.com)

**Introduction :** Les lombalgies sont des maux extrêmement fréquents et touchent environ 60% de la population générale. En milieu sportif, la prévalence des lombalgies est supérieure à celle de la population générale.

**Objectif:** L'objectif de cette étude est d'étudier les douleurs lombaires chez les joueurs seniors de handball de la ville de Ouagadougou.

**Méthode :** Cette étude descriptive s'est déroulée à Ouagadougou et a concerné 180 joueurs actifs d'au moins 21 ans et titulaires de licences issues des différents clubs de handball de la ville. Le questionnaire nordique adapté a permis de collecter des données sur les troubles musculosquelettiques et l'Echelle Visuelle Analogique (EVA) a permis de mesurer l'intensité des douleurs. Les données ont été traitées à l'aide du logiciel SPSS V22.

**Résultats :** L'analyse des résultats a montré une prévalence de douleurs lombaires de 50% chez les handballeurs au cours des douze (12) derniers mois. Ces résultats ont indiqué que ces douleurs sont très fréquentes pendant les périodes de compétition. Une régression logistique binaire a établi une relation significative ( $P < 0,05$ ) entre les postes de jeux occupés et la douleur lombaire.

**Conclusion :** les problèmes lombaires figurent parmi les pathologies au premier rang qui

peuvent freiner la carrière du handballeur burkinabè. Il y a nécessité de prendre en compte ces risques dans les réflexions futures sur la performance en handball au Burkina Faso.

#### Mots clés :

Prévalence, douleurs lombaires, traumatismes, handball, Burkina Faso

### STH-5-S10-COL-116

#### Risk factors for post-traumatic stress disorder in survivors of a road crash cohort: Results at 12 months of prospective follow-up

**Donatien Daddah**, Yolaine Glèlè Ahanhanzo, Alphonse Kpozehouen, Bella Hounkpe Dos Santos, Edgard-Marius Ouendo, Alain Leveque

1-Donatien: Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin and

Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique

(email : daddahdonatien@gmail.com)

2-Yolaine Glèlè Ahanhanzo: Institut régional de Santé Publique (IRSP), Ouidah-Bénin

(email : nyglele@yahoo.fr)

3-Alphonse Kpozehouen: Institut régional de Santé Publique (IRSP), Ouidah-Bénin

(email : alphonse.kpozehouen@gmail.com)

4-Bella Hounkpe Dos Santos: Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin and

Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique

(email : belle.h.2012@gmail.com)

5-Edgard-Marius Ouendo: Institut régional de Santé Publique (IRSP), Ouidah-Bénin

(email : ouendo@yahoo.fr)

6-Alain Leveque: Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique

(email : alain.leveque@ulb.be)

#### Background

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is the most common and severe mental health complication in road crash survivors. The present study aimed to determine the prevalence and factors associated with PTSD in survivors of the "TraumAR" cohort of road crash victims in Benin.

#### Methods

This was a prospective cohort study using survivors of a road crash cohort set up in Benin in 2020. Patients were recruited from five high-use referral hospitals for road crash injuries. They then received two follow-ups, including a 12-month face-to-face follow-up. All consenting patients aged at least 18 years living in localities near one of the three examination sites were eligible for this follow-up during

which they received a physical examination and completed pre-tested questionnaires. These questionnaires included the Post Traumatic Stress Disorder (PCL) checklist and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Modelling was used to investigate factors associated with PTSD.

#### Results

Of a total of 865 eligible patients, 734 (85%) responded to the 12-month follow-up. In this study the prevalence of PTSD in the study was 26.4% CI95% (23.4-29.7). The associated factors were female gender (RR: 2.9; 95% CI: 1.9-4.5), hospitalisation (RR: 2.1; 95% CI: 1.4-3.3), negative impact of the accident on income (RR: 5.7; 95% CI: 3.7-8.8) and initial severity of injury (RR: 1.7; 95% CI: 1.1-3.1).

The comorbidities associated with post-traumatic stress disorder were disability (RR: 3.3; 95% CI: 1.9-5.7), anxiety (RR: 9.4; 95% CI: 5.1-17) and depression (RR: 4.9; 95% CI: 3.3-7.3).

#### Conclusion

Early detection of anxiety and depression should be systematic, especially in hospitalized patients with severe injuries, in order to prevent PTSD. These results deserve to be taken into account in road safety policies in order to accelerate the achievement of the targets of the 2021-2030 road safety action decade in Benin.

**Keywords:** Road crash, PTSD, cohort, follow-up

### STH-5-S10-COL-117

#### Traumatisés graves par accidents de la route au Bénin : conditions de référence, caractéristiques des sujets et mortalité hospitalière

Yolaine GLELE AHANHANZO<sup>2</sup>, **Bella HOUNKPE DOS SANTOS**<sup>1,2</sup>, Alphonse KPOZEHOUE<sup>2</sup>, Donatien DADDAH<sup>1,2</sup>, Edgard-Marius OUENDO<sup>2</sup>, Yves COPPIETERS<sup>1</sup>, Alain LEVEQUE<sup>1</sup>

#### Affiliations :

<sup>1</sup>Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique.

<sup>2</sup>Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin

**Présentateur :** Dr Bella HOUNKPE DOS SANTOS  
Email : [neemamarie@yahoo.fr](mailto:neemamarie@yahoo.fr)

#### Introduction

Les retards aux premiers soins dus entre autres au délai allongé pour le transfert à l'hôpital et à l'absence de soins d'urgence pré hospitaliers contribuent à l'augmentation de la mortalité hospitalière.

## Objectif principal

L'étude vise à décrire les caractéristiques des traumatisés graves par accidents de la route et leurs conditions de référence au Bénin.

## Méthodes :

Il s'agit d'une étude d'observation décrivant les conditions de référence et les caractéristiques de 357 traumatisés graves d'une cohorte prospective d'accidentés de la route. Le retard de référence, variable d'intérêt a été défini au seuil d'une heure. L'analyse des données a été faite par régression logistique binaire simple.

## Résultats :

Les sujets référés dans la première heure après la survenue de l'accident représentaient 38,1% de l'ensemble. Le retard de référence n'était associé ni à l'âge ni au sexe. Les traumatisés graves référés tardivement à l'hôpital étaient ceux transportés par ambulance (RR= 4,9 IC [2,4 – 9,8]) ou par les témoins ou connaissances (RR= 2,4 IC [1,5 – 4,0]), ceux reçus dans les hôpitaux de Cotonou (RR= 2,4 IC [1,7 – 4,8]) ou venus à l'hôpital accompagnés d'un garde malade ou d'un répondant (RR= 3,1 IC [1,7 – 5,5]). Les sujets étaient référés tardivement lorsque les accidents étaient survenus sur des pistes rurales ou ruelles (RR= 2,4 IC [1,2 – 4,6]).

Les sujets référés en retard et ceux transportés par ambulance avaient plus de risque de mourir à l'hôpital des suites de leur accident avec des risques respectifs de 3,0 [1,2 – 7,5] et 3,2 IC [1,2 – 8,6].

## Conclusion :

La mauvaise organisation du système de référence, l'inaccessibilité des voies, l'insuffisance de moyens financiers des populations et l'insuffisance de subvention des soins aux traumatisés pourraient expliquer ces résultats. Il est important de mettre en place un système de référence fonctionnel et efficace des traumatisés graves au Bénin.

**Mots clés :** Référence, accident de la route, traumatisés graves, Bénin

## STH-5-S10-COL-118

### Enquête de satisfaction des utilisateurs de produits sanguins du Centre national de transfusion sanguine selon le modèle tétraclasse de Llosa

**Sawadogo Abdoul-Guaniyi**<sup>1,2\*</sup>, Drabo Bia Emile<sup>1,3</sup>, Sawadogo Salam<sup>1,4</sup>, Nèbié Kompingnin<sup>1,4</sup>, Koanda Jean-Etienne<sup>1</sup>, Konseybo Alain<sup>1</sup>, Sanou T. Thomas<sup>1</sup>, Boro Mariam<sup>1</sup>, Koné Geoffroy Kader<sup>1</sup>, Yooda Arzouma Paul<sup>1,5</sup>, Kafando Eléonore<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Centre national de transfusion sanguine, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>2</sup>ONG Terre des hommes Lausanne, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>3</sup>Croix-Rouge Burkinabè, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>4</sup>Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

<sup>5</sup>Programme national de lutte contre la tuberculose, Ministère de la santé, Ouagadougou, Burkina Faso

**\*Auteur correspondant :** Tel : +226

70131693 ; E-mail : [lesage2004bk@yahoo.fr](mailto:lesage2004bk@yahoo.fr)

**Introduction :** La satisfaction du client est un impératif pour tout organisme engagé dans un processus d'amélioration continue de la performance de ses prestations. Le Centre national de transfusion sanguine, opérateur unique du sang au Burkina Faso, offre plusieurs produits et services aux formations sanitaires habilitées à transfuser.

**Objectif principal :** Cette étude avait pour objectif d'évaluer la satisfaction globale des utilisateurs des produits sanguins labiles (PSL) du CNTS sur la performance perçue des PSL servis, leurs supports de commande, l'hémovigilance, la prescription et le transport des PSL et la communication.

**Méthodes :** Nous avons mené une étude transversale descriptive de novembre 2017 à mai 2018 à l'aide de questionnaires auto-administrés. L'échelle de Likert et le modèle tétraclasse de Llosa ont été utilisés pour apprécier la satisfaction des enquêtés.

**Résultats :** Notre étude a inclus 283 professionnels de santé issus de 24 formations sanitaires, dont 63,60% d'hommes et 25,09% de médecins. Au total, 52,30% des enquêtés avaient plus de 5 ans d'ancienneté dans leur service. Les enquêtés étaient globalement satisfaits des PSL servis, des supports de commandes, de l'hémovigilance, de la prescription, du transport des PSL et de la communication (coefficient gamma variant entre 0,5 et 0,7 ;  $p < 0,0001$ ). Cette satisfaction globale n'était pas statistiquement liée à la zone de couverture des CRTS ( $p=0,44$ ), au sexe ( $p=0,14$ ), au profil professionnel ( $p=0,22$ ) et à l'ancienneté dans le service ( $p=0,76$ ).

**Conclusion :** Globalement, les enquêtés étaient satisfaits des prestations du CNTS. Mais l'accent devrait être mis sur l'amélioration de la communication entre le CNTS et les services cliniques, les règles de distribution, la gestion des urgences vitales immédiates et de maintenir un excellent service sur le délai d'obtention des

PSL prescrits, la communication sur les PSL disponibles.

**Mots clés :** *Satisfaction client, produits sanguins labiles, modèle tétraclasse.*

## STH-5-S10-COL-119

**Dévoilement d'abus sexuels sur mineurs à Cotonou : circonstances, attitudes et vécu des parents d'enfants**

**ANAGONOU L<sup>1</sup>**, KLIKPO E<sup>2</sup>, DEGNON R<sup>3</sup>, TOUDONOU G<sup>1</sup>, GOGAN M<sup>1</sup>, FIOSSI KPADONOU E<sup>1</sup>

1. Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, Département de santé mentale, CHU-MEL, Cotonou, Bénin
2. Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, Département de santé mentale, CNHUPC, Cotonou, Bénin
3. Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, Ecole Supérieure des Assistants sociaux, Cotonou, Bénin

**Auteur correspondant :** ANAGONOU Lucrèce  
Tél : +229 66263585

Email : [luccea2@gmail.com](mailto:luccea2@gmail.com)

Les abus sexuels sur mineurs apparaissent de nos jours comme des problèmes public et politique majeurs. Dans notre contexte culturel, les tabous sociaux constituent un frein considérable à leur révélation.

Cette étude a eu pour objectif de déterminer les attitudes et ressentis des parents lorsqu'ils apprennent que l'un de leurs enfants a été victime d'abus sexuel ainsi que les circonstances du dévoilement.

Il s'agit d'une étude transversale descriptive et analytique utilisant une méthode à la fois qualitative et quantitative. Elle a été réalisée sur une période de six (06) semaines, du 17 août au 26 septembre 2020, dans un centre de prise en charge des victimes à Cotonou.

Elle a concerné quarante-un (41) parents d'enfants victimes d'abus sexuel dont vingt-un (21) de sexe féminin et vingt (20) de sexe masculin. L'âge moyen des enfants était compris entre 10 et 15 ans (56,1%). L'abus sexuel dont a été victime l'enfant a été découvert par le parent lui-même dans 24,4% des cas. Plus de la moitié des agressions sexuelles (51,2%) a été découverte plus d'un mois après leur survenue. Le dépôt de plainte s'est fait dans un délai d'une semaine à 1 mois

dans 39% des cas ; 56,1% des parents n'avaient pas initialement pensé à le faire.

La colère (53,7%) et la tristesse (34,1%) sont les émotions les plus ressenties par la majorité des parents. Ils rapportent une détérioration de la relation à leur enfant dans 21,9% des cas.

Le dévoilement des faits d'abus sexuels sur un enfant bouleverse le système familial.

**Mots clés :** *abus sexuel, mineur, attitude, vécu, parents, Cotonou.*

## STH-5-S10-COL-120

**Usage des appareils électroniques audiovisuels par les adolescents de 10 à 19 ans dans la commune d'Abomey Calavi en 2021 : connaissances, attitudes et pratiques, et conséquences socio sanitaires associées**

**Azandjeme Colette Sylvie<sup>1\*</sup>**, LEGBA S. Rosine<sup>2</sup>, AGUEMON Badirou<sup>2</sup>, Sopoh Ghislain<sup>3</sup>, Sossa Charles<sup>1</sup>, Ouendo Edgard-Marius<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Département de la Promotion de la Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

<sup>2</sup>Département de Santé Publique Santé et Epidémiologie, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

<sup>3</sup>Département Environnement et Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

<sup>4</sup>Département Politique et Système de Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

**Auteur correspondant:** Azandjeme Colette Sylvie, BP 384 Ouidah. Tel : +229 61784478 Email : [colsyaz@yahoo.fr](mailto:colsyaz@yahoo.fr)

**Introduction :** L'usage des appareils audiovisuels chez les enfants comme chez les adultes dans le monde pose un véritable problème de santé Publique. Cependant force est de remarquer que des données sont quasi inexistantes en Afrique et surtout au Bénin. L'objectif de notre étude est d'étudier les connaissances, attitudes et pratiques des adolescents sur l'usage des appareils audiovisuels et les conséquences socio-sanitaires associés dans la commune d'Abomey-Calavi en 2021.

**Méthode:** Il s'agit d'une étude transversale descriptive et analytique qui s'est déroulée du 17 Mai au 25 Mai 2021. La population d'étude était constituée d'adolescents scolarisés dans les collèges publics et privés de la commune d'Abomey-Calavi sélectionnés suivant une

méthode probabiliste par technique d'échantillonnage stratifié. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire auto-administré.

**Résultats :** Parmi les 346 élèves adolescents enquêtés, 98,8% avaient une connaissance insuffisante sur l'usage des appareils audiovisuels. La télévision était l'appareil audiovisuel le plus utilisé surtout pour regarder un film. Les conséquences étaient essentiellement à type de troubles visuels (54,3%) et de dépendance (62,4%). Après une analyse multi variée, les variables telles que les troubles musculo squelettiques (OR= 6,557 ; p=0,002), la sécheresse oculaire (OR= 10,824 ; p=0,005) et les troubles auditifs (OR= 1,795 ; p=0,050) étaient significativement associées à la dépendance.

**Conclusion :** La moitié des élèves adolescents de notre étude avait dans leur quotidien la présence d'appareils audiovisuels surtout l'usage de la télévision et du smartphone.

L'effet d'une certaine forme de dépendance ainsi que l'observance de troubles socio-sanitaires ajoutés à l'insuffisance de connaissances des adolescents et l'usage excessif et inappropriés, nous amènent à tirer la sonnette d'alarme. Des mesures doivent être également prises par tous les acteurs responsables du bien-être des enfants afin de leur assurer une meilleure protection.

**Mots clés :** Appareils Audiovisuels, Adolescents, Connaissances-Attitudes-Pratiques, Conséquences.

## Sous-thème 5 Session 11

### STH-5-S11-COL-121

**Evaluation de l'efficacité du projet « stratégie de réduction de la consommation du sel dans la commune de Porto-Novo »**

**Azandjeme Colette Sylvie**<sup>1\*</sup>, Danmadou Oceane<sup>1</sup>, Metonnou Clemence<sup>1</sup>, Sossa Charles<sup>1</sup>, Kpozehouen Alphonse<sup>2</sup>, Paraiso Moussiliou<sup>1</sup>, Ouendo Edgard-Marius<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Département de la Promotion de la Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

<sup>2</sup>Département d'Epidémiologie, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

<sup>3</sup>Département Politique et Système de Santé, Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin.

**Auteur correspondant:** Azandjeme Colette

Sylvie, BP 384 Ouidah. Tel : +229 61784478 Email :

[colsyaz@yahoo.fr](mailto:colsyaz@yahoo.fr)

**Introduction :** La consommation du sel constitue un défi notamment pour les pays africains où les prévalences de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires sont en hausse. Le but de l'étude était d'évaluer l'efficacité d'une intervention de réduction de la consommation du sel au sud du Bénin.

**Méthode :** Il s'agissait d'une étude évaluative qui s'est déroulée du 22 Mars au 16 Avril 2021 dans la ville de Porto-Novo. Elle a pris en compte les intrants en termes de ressources humaines, matérielles et financières. Le processus a porté sur les ateliers de sensibilisation des restaurateurs, pâtisseries, boulangers et hôteliers ainsi que les communications radio et télévision. Les résultats concernent les extraits, les effets et l'impact apprécié auprès de 62 boulangers et pâtisseries et 30 cuisiniers. Chaque composante a été appréciée selon une échelle adaptée de "Varkevisser et al."

**Résultats :** La composante « performance de la structure » a été jugée bonne à 85,71% avec une défaillance pour les ressources financières. La composante « performance du processus » a été jugée bonne avec un niveau de 100%. Les bénéficiaires du projet dans leur majorité (88,2%) ont une bonne connaissance des recommandations journalières de sel (p<10<sup>3</sup>). En comparant aux personnes non sensibilisées, les sensibilisées ont reconnu l'effet néfaste d'une consommation élevée du sel sur les maladies cardiovasculaires (82,4%). Toutefois elles estiment qu'il est impossible de cuisiner sans ajout de sel (p=0,002) mais n'ajoutent pas de bouillon aux repas (p=0,036). Cette réduction du sel a amélioré la fréquentation des clients chez la moitié des acteurs, mais a entraîné une perte de clients chez le tiers.

**Conclusion :** Ces résultats montrent que la stratégie de réduction du sel a été efficace. Un suivi plus régulier devra se faire pour renforcer les connaissances et les pratiques tout en maintenant la rétention des clients.

**Mots Clés :** Evaluation, Efficacité, Réduction, Sel

### STH-5-S11-COL-122

**Évaluation de la qualité de l'eau de boisson et facteurs associés en milieu professionnel dans la ville de Parakou en 2018**

**Gounongbé AC Fabien**, Mama Cissé Ibrahim, Azandjè Colette, Hinson Antoine V.

1. Faculté de médecine, Université de Parakou, Bénin.

2. Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin.

3. Département de promotion de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

**Communicateur** : Dr Fabien Christophe A. GOUNONGBÉ, Maître de Conférences Agrégé en Médecin du Travail, Faculté de Médecine ; Université de Parakou ; Bénin

Email : [gcfabien@yahoo.ca](mailto:gcfabien@yahoo.ca)

**Introduction** : La qualité de l'eau de boisson apparaît partout dans le monde comme une question préoccupante.

**Objectif** : Évaluer la qualité de l'eau de boisson et les facteurs associés en milieu professionnel dans la ville de Parakou 2018.

**Méthodes** : Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive à visé analytique menée du 26 septembre au 02 décembre 2018. Elle a porté sur les personnels des directions et entreprises de Parakou. À l'aide d'un questionnaire, d'une grille d'observation et d'analyses de laboratoires, les données ont été collectées. Elles ont été traitées et analysées par le logiciel Epi Info 7.

**Résultats** : Au total, 302 des 551 personnes de 42 structures investiguées ont participé à l'enquête soit 53,83% de taux de participation. La sex-ratio (Hommes/Femmes) est égale à 1,25. 216 (71,60%) ne réservaient pas de l'eau pour la consommation et 71 (23,51%) traitaient l'eau avant de la boire. L'eau de boisson provenait de quatre sources. 65,56% buvaient l'eau d'adduction d'eau public. La quasi-totalité des enquêtés (92,38%) ont affirmé qu'une eau de mauvaise qualité est nuisible à la santé. Des échantillons d'eau analysés ne respectent pas les normes bactériologiques. 4(50%) des échantillons prélevés respectent le PH normale.

**Conclusion** : Il existe encore des entreprises où l'eau de boisson est impropre à la consommation.

**Mots clés** : qualité d'eau, consommation, facteur, milieu de travail, de risque, Parakou.

## STH-5-S11-COP-123

**Etude de la disponibilité des produits à base de plantes médicinales dans les établissements de vente de produits**

**alimentaires**

**Aminata P. NACOULMA**<sup>1\*</sup> ; Sakinatou WANGRAWA<sup>1</sup> ; Cheick Armand Noukami PALM<sup>2</sup> ; Romaric MEDA<sup>1,2</sup> ; Issa SOME<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Université Joseph KI-ZERBO, Unité de Formation et de Recherche en Sciences de Santé (UFR-SDS), Département des Sciences pharmaceutiques, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso.

<sup>2</sup> Laboratoire National de Santé Publique

\* Contact de l'auteur : [natanac5@gmail.com](mailto:natanac5@gmail.com)

RÉSUMÉ (max 300 mots)

**Introduction** : Les plantes sont utilisées dans la vie quotidienne pour l'alimentation, l'usage thérapeutique, etc. Cependant, certaines espèces peuvent être toxique de par leur composition chimique [1]. Aussi, leur préparation et leur conservation peuvent altérer la qualité du produit final [2]. De nos jours diverses préparations à base de plantes sont en vente libre dans les établissements de vente de produits alimentaires. L'objectif de notre étude est de répertorier ces produits mis en libre consommation.

**Méthodologie** : Collecte de données dans les établissements et analyse statistique descriptive [3].

**Résultats** : Au total 70 établissements de vente de produits alimentaires de la ville de Ouagadougou ont été contactés. 42.8 % ont participé à l'étude et 1020 produits à base de plante ont été recensés, principalement sous forme de tisane (81.37 %) et sous forme d'organes végétaux (18.63 %). Les infusettes étaient rencontrées dans 49.76 % des cas et les feuilles étaient l'organe le plus exploité (49.47 %). Le nom scientifique de la plante était utilisé dans 30.90 % des cas. Sur la base des noms botaniques, on a dénombré 55 espèces issues de 28 familles dont les Lamiaceae, les Astéraceae et les Rosaceae étaient les plus représentées. 27.07 % des produits proviennent de la France, 12.78 % du Burkina et 10.53 % de la Chine. Enfin, 07 plantes sont retrouvées dans 86 % des produits recensés et seules *Combretum micrantum*, *Hibiscus sabdarifa* et *Moringa oleifera* sont rencontrées au Burkina Faso.

**Conclusion** : Les produits à base de plante rencontrés dans les établissements ciblés sont de type mixte alimentaire et médicinale. Aucune espèce recensée ne présente une toxicité intrinsèque. Toutefois l'étude des caractéristiques botaniques et de pharmacognosie, permettront d'évaluer la qualité des matières premières utilisées.

Mots clés : produits à base de plante ; plantes alimentaires et médicinales

## STH-5-S11-COP-124

**Activités anti-inflammatoires in vivo et in vitro d'extraits de *Pandiaka Angustifolia* (Vahl.) Hepper (Amaranthacées) utilisés en médecine traditionnelle au Burkina Faso**

**Emmanuel A.M. THIOMBIANO<sup>a</sup>,**

Mindiédiba Jean BANGOU<sup>1,2</sup>, YOUNGBARÉ-ZIÉBROU Mouhibatou<sup>3</sup>, Martin

KIENDREBEOGO<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Laboratoire de Biochimie et de Chimie Appliquées (LABIOCA), U.F.R.-S.V.T., Université de Ouagadougou, 09 BP 848 Ouagadougou 09, Burkina Faso

<sup>2</sup>Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques. Université Nazi Boni I, 01 BP 1091 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso.

<sup>3</sup>Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, 03 BP 7192 Ouagadougou 03, Burkina Faso.

Email : [esterfils@gmail.com](mailto:esterfils@gmail.com)

Des études antérieures ont révélé que *Pandiaka Angustifolia* (Vahl.) Hepper (Amaranthacées) est une plante à potentiel antioxydant, des activités inhibitrices de la xanthine oxydase et de la lipoxigénase, mais, ses activités anti-inflammatoires n'ont pas été rapportées à notre connaissance; par conséquent, cette étude a été initiée dans le but d'évaluer l'activité anti-inflammatoire et analgésique des extraits hexanique et aqueux de *P. angustifolia* en utilisant des méthodes *in vitro*, des méthodes *in vivo* et rechercher le meilleur extrait analgésique par comparaison de leur action sur les canaux potassique ( $K^+$ ).

La phospholipase et les cyclooxygénases étaient des enzymes pro-inflammatoires utilisées pour évaluer les effets anti-inflammatoires *in vitro* des extraits de plantes, tandis que la méthode de l'œdème induit par la carraghénine a été utilisée pour évaluer l'activité anti-œdémateuse et la méthode de contorsion induit par l'acide acétique pour évaluer l'effet analgésique non morphinique des extraits de la plante. La sensibilité des canaux  $K^+$  sensibles à l'ATP a été réalisé *in vivo* en utilisant le glibenclamide comme bloqueur des canaux potassiques sensibles à l'ATP ( $K^+_{ATP}$ ).

Les tests d'inhibition enzymatique ont révélé que les extraits hexanique et aqueux de *P. angustifolia* étaient de bons inhibiteurs de l'activité de la sPLA2 avec des  $CI_{50}$  de  $14,23 \pm$

$0,72 \mu\text{g/mL}$  et  $11,56 \pm 0,11 \mu\text{g/mL}$ , respectivement. L'extrait aqueux a été meilleure inhibitrice de la COX-1 et la COX-2. Comparativement, l'extrait aqueux est plus réducteur de l'œdème induit par la carraghénine que l'extrait hexanique. L'évaluation de l'activité analgésique non-morphinique a révélé que l'extrait aqueux était plus efficace sur la réduction des contorsions que l'extrait à l'hexane.

Les résultats indiquent que le potentiel anti-inflammatoire de *P. angustifolia* peut être dû à ses phytoconstituants polaires et son effet nociceptif serait lié à ses effets sur les canaux potassiques sensibles à l'ATP.

Mots clés : *Pandiaka angustifolia*, activité enzymatique, activité anti-inflammatoire, activité analgésique.

## STH-5-S11-COP-125

**Santé bucco-dentaire des enfants et jeunes du centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou**

Garé JVV<sup>1,2</sup>, **Sanogo O<sup>2</sup>**, Ouattara S<sup>1,2</sup>, Ouédraogo CNT<sup>2</sup>, Kaboré WAD<sup>2</sup>, Konsem T<sup>2</sup>, Faye D<sup>3</sup>

4. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Département de santé publique, Université Joseph Ki Zerbo 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso
5. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), section de chirurgie dentaire, Université Joseph Ki Zerbo 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso
6. Service de Santé Publique et Médecine Préventive, Faculté de Médecine, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal.

**Présentatrice : Dr Oroky SANOGO**

**E-mail :** [sorokia7@gmail.com](mailto:sorokia7@gmail.com) ;

**Téléphone :** 00226 74991330

**Introduction :** La santé bucco-dentaire est fortement liée aux conditions sociales et constitue un des domaines où les inégalités sociales de santé sont les plus marquées. Disposer d'informations actualisées sur les niveaux de santé bucco-dentaire des différentes catégories de la population est fondamental pour formuler une réponse adéquate en matière de prévention et de prise en charge.

**Objectifs :** Décrire l'état de santé bucco-dentaire des enfants et jeunes retirés de la rue et accueillis au centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou.

**Matériel et méthodes :** Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive qui s'est déroulée en mai 2019 chez les enfants et les jeunes recrutés lors d'une opération de retrait des enfants de la rue initiée par le ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire. Les données ont été collectées avec une fiche d'enquête préconisée par l'organisation mondiale de la santé et l'analyse a été réalisée avec le logiciel SPSS (Statistical Package for Social Science version 20).

**Résultats :** Au total, 103 sujets de sexe masculin avec une moyenne d'âge de 14,3ans  $\pm 3,4$  ont été inclus. La prévalence globale de la carie était de 40,8% IC 95% [32,1-51,9]. Le saignement gingival était retrouvé chez 49,5 % IC 95% [39,2-60,3] des sujets. Les traumatismes dentaires, les fluoroses et les érosions avaient des prévalences respectives de 7,8 % ; 3,9 % ; et 5,8 %. La moitié des enquêtés (46,60%) avait besoin d'un traitement rapide.

**Conclusion :** Les résultats de cette étude montrent une prévalence élevée des pathologies bucco-dentaires notamment la carie dentaire. Cependant le recours aux soins reste très limité. Aussi un programme de santé bucco-dentaire prenant en compte leurs spécificités permettrait de résorber ses inégalités.

**Mots clés :** santé bucco-dentaire, carie dentaire, enfants en situation de rue, Ouagadougou.

## STH-5-SS-COP-Y1

### Facteurs associés au faible poids de naissance dans la ville de Ouagadougou : étude cas-témoins

**Jean Kaboré<sup>1\*</sup>**, Seraphin D. Nikiéma<sup>2</sup>, Jerome W. Somé<sup>1</sup>, Jeoffray Diendéré<sup>3</sup>, Augustin N. Zeba<sup>3</sup>, Herman Lanou<sup>1</sup>, Séni Kouanda<sup>1</sup>, Nicola Meda<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut recherche en Sciences de la Santé, (IRSS), Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), 03 BP 7192 Ouaga 03, Ouagadougou, Burkina Faso ;

<sup>2</sup> UFR Sciences de la Santé, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso ;

<sup>3</sup> Institut recherche en Sciences de la Santé, (IRSS), Direction régionale de l'ouest, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

\* **Auteur correspondant :** Jean Kaboré, 01 BP 5054 Ouaga 01 ; e-mail : [jck6238@gmail.com](mailto:jck6238@gmail.com); [jkabore@irss.bf](mailto:jkabore@irss.bf), tél.: 70 71 46 23

**Introduction :** Le faible poids de naissance (FPN) est un problème de santé publique dans les pays en voie de développement comme le Burkina Faso. La lutte contre ce problème de santé passe par la connaissance des facteurs associés à sa survenue.

### Objectif principal

Identifier les facteurs associés à la survenue du FPN dans la ville de Ouagadougou en 2021.

**Méthodes :** Nous avons conduit une étude cas-témoin appariée sur l'âge et le centre de santé, du 1<sup>er</sup> Mai au 31 Juin 2021. Elle a concerné les couple mère et, nouveau-nés de poids < 2500g(cas) et ceux avec un poids > 2500g (témoins) dans les formations sanitaires retenues de la ville de Ouagadougou. Le lien entre le score de diversité alimentaire et FPN indépendamment des autres caractéristiques a été analysé par une régression logistique conditionnelle avec faite par le logiciel SAS® 9.4.

**Résultats :** Le poids médian des nouveau-nés était 2250 g pour les cas, contre 3100 g pour les témoins. Le sexe ratio pour l'ensemble de l'échantillon était de 0,97 : plus exactement de 0,80 pour les cas et de 1,19 pour les témoins. L'âge médian des mères était de 25 ans. Les facteurs qui étaient significativement associés au FPN étaient : la prise de moins de 3 repas par jour, ORajusté[ICà95%](2,84[1,64-4,89]), l'âge <20ans de la mère(3,37[1,36 -8,33]), l'absence de prophylaxie anti palustre(2,06[1,10-3,87]), la réalisation de moins de 4 CPN(2,24[1,29-3,85]), et le sexe féminin du nouveau-né(1,56[1,06-2,29]).

**Conclusion :** Une éducation nutritionnelle sur les fréquences alimentaires, la sensibilisation sur la santé de la reproduction et le renforcement des consultation prénatales pourront contribuer à prévenir le faible poids de naissance dans la ville de Ouagadougou.

**Mots clés :** faible poids de naissance, facteurs associés, Ouagadougou.

## STH-5-SS-COP-Y2

### Hypertension artérielle incidente et facteurs associés dans les établissements pénitentiaires au Burkina Faso

**Jean Kaboré<sup>1\*</sup>**, Innocent Bassékoa Nama<sup>2</sup>, Jeoffray Diendéré<sup>3</sup>, Augustin N. Zeba<sup>3</sup>, Herman Lanou<sup>1</sup>, Séni Kouanda<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut recherche en Sciences de la Santé, (IRSS), Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), 03 BP 7192 Ouaga 03, Ouagadougou, Burkina Faso ;

<sup>2</sup> Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement (ISPED), Université de Bordeaux, Bordeaux, France ;

<sup>3</sup> Institut recherche en Sciences de la Santé, (IRSS), Direction régionale de l'ouest, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

**\*Auteur correspondant :** Jean Kaboré, 01 BP 5054 Ouaga 01 ; e-mail : [jck6238@gmail.com](mailto:jck6238@gmail.com); [jkabore@irss.bf](mailto:jkabore@irss.bf), tél.: 70 71 46 23

#### **Introduction :**

L'organisation mondiale de la santé estime qu'un tiers des adultes sont porteurs d'une hypertension artérielle (HTA). Bien que présentant un environnement hostile, aucune étude sérieuse n'a été diligentée sur l'HTA en milieu carcéral au Burkina Faso.

#### **Objectif principal**

Etudier le lien entre détresse psychologique et HTA incidente dans les établissements pénitentiaires du Burkina Faso.

#### **Méthodes :**

Nous avons mené une étude cas témoins appariée sur 276 participants, du 26 mai au 27 juillet 2021. L'échantillon d'étude calculé avec le logiciel EpiInfo<sup>®</sup> était de 276 participants repartis en 138 cas et 138 témoins. La régression logistique conditionnelle à l'aide de

RStudio<sup>®</sup> a été utilisée pour identifier les facteurs associés à l'HTA incidente.

#### **Résultats :**

En tenant compte de la durée de l'incarcération, de la présence d'antécédents familiaux d'hypertension artérielle, et de l'indice de masse corporelle, les détenus en état de détresse psychologique [RC= 11,76 ; IC95%= 3,09 ; 44,79 ; p=0,000303] avaient un risque plus important de développer une HTA par rapport à leurs homologues qui n'avaient une détresse psychologique. La présence d'antécédents familiaux d'HTA [RC=22,78 ; IC95%= 6,44-80,67 ; p=1,26.10<sup>-06</sup>] et l'augmentation de la durée de l'incarcération [RC= 1,0011 ; IC95%= 1,0005 ; p=1,0017] étaient significativement et indépendamment associés à un risque élevé de survenue d'une HTA en prison. A l'inverse, les détenus avec une autonomisation financière [RC=0,36 ; IC95%=0,14-0,91] avaient un risque significatif moins important de développer une HTA pendant l'incarcération comparativement à ceux qui n'en avaient pas.

#### **Conclusion :**

Les résultats de cette étude semblent confirmer l'influence des troubles psychosociaux dans la survenue de l'hypertension artérielle dans l'environnement carcéral. Les stratégies de prévention et de prise en charge de cette affection dans cet environnement hostile doivent accorder une place de choix sur la dimension la prise en charge et l'accompagnement psychosocial des détenus.

#### **Mots-clés :**

Hypertension artérielle, détresse psychologique, établissements pénitentiaires



## RESUMES DES COMMUNICATIONS AFFICHEES

# ***RESUMES DES COMMUNICATIONS AFFICHÉES (POSTERS)***

## P-01

### Le syndrome de prune Belly, quand une malformation supplée à une thérapeutique !

**SAWADOGO Wendmetta Hubert<sup>1</sup>**, SAWADOGO Harouna<sup>1</sup>, KONE Massara<sup>2</sup>, TRAORE O Honorine<sup>1</sup>, DAO saydou<sup>1</sup>, BADO Bertille<sup>1</sup>, PARE Armelle<sup>1</sup>, KERE Laila<sup>1</sup>, KONFE Ismael<sup>1</sup>, NAMOANO Romaric<sup>3</sup>, CISSE Hama<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Service de pédiatrie, Centre hospitalier régional de Dori, Burkina Faso

<sup>2</sup> Service d'imagerie médicale, Centre hospitalier régional de Dori, Burkina Faso

<sup>3</sup> Service de médecine interne, Centre hospitalier régional de Dori, Burkina Faso

**Introduction :** Le Syndrome de Prune Belly (PBS) est un syndrome anatomo-radiologique extrêmement rare, formant la triade classique qui associe une aplasie des muscles de la paroi antérieure de l'abdomen, des dilatations des voies urinaires et des malformations testiculaires.

**Cas clinique :** Nous rapportons le cas d'un nouveau-né de sexe masculin, né à domicile et âgé d'un jour de vie, issue d'une grossesse menée à terme suivie par une CPN, VAT et bilan TORSCH non faits. Il n'y avait pas notion de pathologie ni de prise médicamenteuse chez la mère pendant la grossesse. Il a été admis sur évacuation pour incapacité de s'alimenter et écoulement liquidien par la plaie ombilicale chez qui notre examen note une mauvaise impression générale, vigilance normale, un syndrome poly malformatif associant une paroi abdominale flasque laissant palper les anses intestinales, une dysmorphie faciale, un micro-pénis, une cryptorchidie, une dysurie avec urines goutte à goutte, une fuite urinaire à travers la plaie ombilicale et un contact lombaire. Le bilan échographique confirme l'hypoplasie des muscles de la paroi abdominale, une cryptorchidie, une dilatation des voies excrétrices, une valve de l'urètre postérieure et une fistule de l'ouraque. Des malformations cardiaques ont été également retrouvées à l'échographie trans-thoracique type de persistance du canal artériel. L'évolution a été marquée par la persistance de la fistule ouraquienne, la normalisation de la taille des voies excrétrices, de la fonction rénale, bon

développement staturo-pondéral et psychomoteur.

**Conclusion :** L'intérêt de ce dossier réside dans la survie de l'enfant à 18 mois malgré la gravité des malformations associées et en dehors de tout geste chirurgical.

**Mots-clé :** aplasie musculaire, Prune Belly, cryptorchidie, fistule, malformation

## P-02

### Investigation autour d'un cas Ebola confirmé en Côte d'Ivoire en provenance de Guinée, Août 2021

**Introduction :** De 2013-2016, Guinée, Liberia et Sierra Leone ont connu la plus grande épidémie de Ebola avec au total 25515 cas confirmés dont 11 020 décès. Du 14 février au 18 juin 2021, Une deuxième épidémie de Ebola était notifiée en Guinée (23 cas dont 16 confirmés au laboratoire et 7 probables). Suite à l'alerte par la Côte d'Ivoire de la confirmation d'un cas de la maladie à virus Ebola le 14 août 2021, une investigation a été menée à Guinée, origine du cas.

**Méthode :** Une étude descriptive d'un cas a été réalisée sur la période du 20 juillet au 21 août 2021. A été inclus dans l'étude tout cas confirmé par laboratoire, cas confirmé par lien épidémiologique ou par clinique. Les caractéristiques cliniques, socio-démographiques ont été analysées par Epi Info® 7.2.

**Résultats :** Il ressort que le cas aurait présenté les premiers signes (vomissement, fièvre et céphalée) le 10 août 2021. Période probable d'exposition : mardi 20 juillet au lundi 02 août 2021 et date probable de début de la maladie : 06 août 2021. Un total de 64 contacts sont connus du cas confirmé dont 27 contacts à haut risque parmi lesquels 49 contacts listés et suivis. Le dernier contact sort du suivi à partir du 4 septembre 2021. Deux cas suspects ont été notifiés dont un vivant et un décès. Une vaccination de 400 personnes et le suivi des contacts listés sont initiés.

**Conclusion :** Il s'agit d'une guinéenne de 18 ans de Labé, sans antécédents morbides majeurs connus, qui a voyagé en Côte d'Ivoire. Aucune source de contamination et aucun nouveau cas n'ont été rapportés.

**Mots clés :** Ebola, Investigation, Labé, Guinée, Côte d'Ivoire

### P-03

#### Adéquation du besoin en formation du personnel de soins de Santé Maternelle et Infantile (SMI) Au Burkina Faso

**Ousmane Sylla**<sup>1,2</sup>, Ahmed Kabore<sup>1</sup>, Hervé Hien<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Université Joseph Ki Zerbo, Département de Santé Publique, Ouagadougou (Burkina Faso)

<sup>2</sup>Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, Bamako (Mali)

<sup>3</sup>Centre MURAZ, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Email : [ousmanesylla019@gmail.com](mailto:ousmanesylla019@gmail.com)

**Introduction :** La formation continue des ressources humaines de santé, socle du renforcement des capacités du secteur de la santé, doit permettre une dotation des structures sanitaires de personnels compétents afin d'offrir des prestations de qualité. **Objectif :** Analyser l'adéquation des formations reçues dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile avec le besoin en formation du personnel de services de santé de la mère et de l'enfant au Burkina Faso. **Méthodes :** L'étude est du type transversale, constituée de tous les professionnels de santé des 576 Formations Sanitaires du premier échelon et des 24 Centre Hospitalier Régional /Centre Médicale avec Antenne chirurgicale de huit régions. Les données ont été collectées par un questionnaire puis vérifiées, compilées et analysées sur le logiciel SPSS 20.0. Pour l'analyse des données, nous avons eu recours à deux types d'analyse : une descriptive simple et une bivariée. **Résultats :** L'étude a montré qu'il existe une inadéquation entre les formations reçues et les besoins en formations. Les principaux besoins en formations sont : la prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant soit 52%, le paludisme 46,6%, les soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base 46,5% et la planification familiale 45,5%. **Conclusion :** Au regard de ces résultats, Il est à retenir que parmi les principales formations offertes, seul le paludisme est en adéquation avec les besoins du personnel. Ainsi, il est recommandé aux responsables des différents programmes de santé et aux partenaires techniques et financiers d'impliquer

les professionnels dans le choix du thème de la formation afin qu'ils puissent répondre efficacement aux sollicitations des usagers des services de santé.

**Mots clés :** Adéquation, Besoins Formation, Santé Maternelle-infantile, Burkina Faso

### P-04

#### Financement de la caisse de solidarité du district sanitaire de Youwarou au Mali : une revue systématique de littérature

Seydou Kanté<sup>1</sup>, **Ousmane Sylla**<sup>2</sup>, Valeria Campos Da Silveira<sup>3</sup>, Ousmane Touré<sup>4</sup>, Zakaria Keita<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Centre de Santé de Référence de Youwarou, Direction Régionale de la Santé de Mopti, Mali

<sup>2</sup>Direction Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique Bamako, Mali

<sup>3</sup>Institut de Médecine Tropical (IMT) d'Anvers, Belgique

<sup>4</sup>Institut Nationale de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) Bamako, Mali

<sup>5</sup>Consultant Indépendant en Santé - Association la Rage en Afrique de l'Ouest, Mali

Email : [ousmanesylla019@gmail.com](mailto:ousmanesylla019@gmail.com)

**Introduction :** Dans le monde, environ 830 femmes meurent chaque jour à cause des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. La majeure partie de ces décès se sont produits dans des pays à revenu faible et la plupart auraient pu être évités. **Objectif :** Evaluer le mécanisme de financement de la caisse de solidarité dans le cadre du système de référence-évacuation du district sanitaire de Youwarou. **Méthodes :** Il s'agit d'une revue systématique de la littérature réalisée du 1er Mai au 30 Juin 2017 sur le district de Youwarou. Les données sont issues de la littérature accessible sur internet et de la littérature grise (plans d'actions, documents de politique, rapports) disponible au Mali. Les moteurs de recherche PUBMED et Google scholar ont été utilisés. Les informations ont été répertoriées dans les rubriques suivantes : i) contexte, ii) processus, iii) contenu et iv) acteurs selon le modèle proposé par Gilson et Walt. **Résultats :** Le financement de la caisse de solidarité lancé en 2006 a connu d'énormes insuffisances de financement, ainsi le taux de paiement des quotes-parts de 2006 à 2009, était de 43% pour

les mairies, 73% pour les ASACO et de 15% pour le conseil de cercle. Malgré la révision en 2013 ayant abouti au scénario de paiement par les ménages, le taux de paiement n'était que de 12%. **Conclusion** : Le déficit de financement de la caisse de solidarité du système de référence-évacuation est lié au faible engagement et de contribution des collectivités décentralisées et des associations de santé communautaire. Un plaidoyer auprès des acteurs communautaires pour plus d'engagement de mobilisation des ressources au niveau des collectivités rurales en vue d'assurer un système de référence évacuation fiable et réduire ainsi les décès maternels et néonataux.

**Mots-clés** : Référence-Évacuation, Financement, Femmes Enceintes, Mali

## P-05

### Investigation de Cas de COVID 19 au District Sanitaire Boulmiougou, Ouagadougou, Burkina Faso, Mai 2020

**Bue Clode Domingos**<sup>1,2</sup>, Barry Djibril<sup>2</sup>, Fadima Radhia Diallo<sup>2</sup>, Jean Kaboré<sup>3</sup>, Pauline Kiswendsida<sup>2,4</sup> Yanogo, Nicolas Meda<sup>2,4</sup>

#### Affiliations :

1. Programme de formation en épidémiologie de terrain et en laboratoire au Burkina Faso, Université Joseph KI ZERBO
2. Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Centre national de la recherche scientifique et technologique, Ouagadougou, Burkina Faso ;
3. Faculté de médecine, Université Joseph KI ZERBO, Burkina Faso

Auteur correspondant :

[clodedomingos@yahoo.com.br/](mailto:clodedomingos@yahoo.com.br/)

[sambistchuda@gmail.com](mailto:sambistchuda@gmail.com)

**Introduction** : L'infection à Covid19 continue ses ravages dans le monde. Le 13 mars 2020, la Burkina Faso enregistrait son premier cas de COVID-19, venu de l'étranger. Le 13 Mai 2020 le district Sanitaire de Boulmiougou a signalé un cas de COVID-19.

**Méthodes** : Une investigation épidémiologique a été conduite du 13 Mai à 14 Juin. Un cas suspect était défini comme une personne qui remplit les critères cliniques ET épidémiologiques : des 14 derniers jours avant l'apparition des symptômes. Un cas confirmé était un cas suspect avec une PCR positive. Un contact était défini comme étant toute personne qui a été en contact avec cas confirmé. Un questionnaire a été administré. A l'aide du logiciel Epi Info<sup>®</sup>, nous avons calculé les proportions et les moyennes (écart-type) ou médiane (intervalle interquartile), pour les variables qualitatives et quantitatives respectivement

**Résultats** : Cas généré 28 contacts dont 06 cas positifs (21,43%) et 22 cas négatifs (78,57%). L'âge médian des contacts est 32,5 ans (11-56). La proportion des cas contacts asymptomatiques est 71,43% et 28,57% sont symptomatiques. Le sexe ratio (Homme/Femme) parmi les cas positifs est 2.

**Conclusion** : Les contacts positifs 21,43% des contacts du cas investigué. 71,43% des contacts étaient sans symptômes et l'âge médian des contacts est 32,5 ans (11-56).

**MOTS-CLEFS** : Épidémie, Investigation, Covid-19, Ouagadougou, Burkina Faso.

## P-06

### Evaluation de l'hygiène orale chez des patients présentant un besoin de réhabilitation prothétique

**DIARRA Abdoulaziz**<sup>12\*</sup>, FALL Medina<sup>12</sup>, KONSEM Tarcissus<sup>13</sup>.

1. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo.
2. Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo, 11BP :104 Ouagadougou CMS 11, Burkina Faso.
3. Centre Hospitalo-Universitaire Yalgado Ouédraogo

E-mail: [abdoulaziz483@yahoo.fr](mailto:abdoulaziz483@yahoo.fr)

#### Introduction

Les pertes dentaires chez l'adulte ont pour conséquence l'édentement qui a un impact négatif sur l'ensemble des fonctions de l'appareil manducateur et sur la santé en général d'où la nécessité de sa prise en charge.

#### Objectif

L'objectif de cette étude était d'évaluer à partir de l'indice OHI-S (Oral Hygiene Index-Simplified) de GREENE et VERMILLON, le niveau d'hygiène orale des patients présentant un besoin de réhabilitation prothétique dans la ville de Ouagadougou.

#### Matériel et méthode

Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive portant sur l'évaluation de l'hygiène bucco-dentaire auprès de 400 patients exprimant un besoin de réhabilitation prothétique dans la ville de Ouagadougou.

#### Résultats

L'analyse descriptive a mis en évidence une population relativement jeune. La tranche d'âge [25-34] était la plus représentée avec une légère prédominance des femmes (sexe ratio 0,76). 36,75% de la population présentaient une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Le nombre moyen de dents absentes était de 3,6 par patient. Les besoins en prothèse étaient de 90% et la prothèse la plus fréquemment choisie était la prothèse adjointe partielle.

#### Conclusion

Les praticiens doivent jouer un rôle central, dans la motivation et l'instruction des patients aux soins d'hygiène bucco-dentaire, qui est un préalable à la réhabilitation prothétique. Aucune prothèse ne devrait être posée avant une mise en état de la cavité buccale et l'obtention du consentement éclairé du patient sur le suivi régulier.

**Mots clés :** Hygiène orale, édentement, réhabilitation prothétique

## P-07

### Prévalence des gingivites induites uniquement par la plaque au centre municipal de santé bucco-dentaire de la ville de Ouagadougou

**DIARRA Abdoulaziz**, TALL Idrissa, KABORE Wendpoulomdé Aimé Désiré, KONSEM Tarcissus

Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso.

E-mail: [abdoulaziz483@yahoo.fr](mailto:abdoulaziz483@yahoo.fr)

#### Résumé

#### Introduction

Les gingivites sont des formes réversibles des maladies parodontales dont l'atteinte est limitée au parodonte superficiel, la gencive. Il s'agit de pathologies inflammatoires caractérisées par des changements de couleur, de contour, de volume, de texture gingivaux et une tendance au saignement provoqué ou spontané.

#### Objectif

L'objectif de notre étude était de déterminer la fréquence des gingivites induites par la plaque bactérienne chez des patients consultant au centre municipal de santé bucco-dentaire (CMSBD) de la ville de Ouagadougou.

#### Méthodologie

Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive portant sur 352 patients reçus en consultation au CMSBD. L'étude s'est déroulée sur une période de trois mois, allant du 15 avril 2019 au 15 juillet 2019.

#### Résultats

La moyenne d'âge de l'échantillon était de 32,91ans  $\pm$  10,21 avec un sex ratio homme/femme de 0,68. 97,16% de notre population présentaient une gencive avec un aspect clinique pathologique. Plus de la moitié de l'échantillon avait un mauvais contrôle de plaque (53,6%) avec une forte prévalence dans la population adulte jeune (70%). On dénotait une corrélation positive et statistiquement significative entre le niveau d'hygiène orale et le degré d'inflammation gingivale.

#### Conclusion

La prévalence de la gingivite est élevée dans notre population d'étude et semble liée au mauvais contrôle de plaque corrélée à une inflammation gingivale. Cette étude donne un

premier aperçu sur la prévalence de la gingivite dans la ville de Ouagadougou. Cette entité pathologique peut cependant se compliquer en parodontite, atteinte irréversible du parodonte aux conséquences néfastes sur le système de santé général.

**Mots clés :** Gingivites, Plaque bactérienne, Prévalence, Indices Gingivaux

## P-08

### Rapport d'évaluation du système de surveillance de la tuberculose animale à Niamey de janvier à décembre 2019

**YOUNOUSSA ALFAZAZI Hassane**<sup>1,2</sup>, Dr Barry<sup>2</sup>, Dr ADAMOU HAROUNA Halimatou<sup>2,4</sup>, Dr ADAMOU Moustapha<sup>3</sup>, Dr YANOGO Pauline<sup>2</sup>, Pr MEDA Nicolas<sup>2</sup>

1. Résident au programme de Formation en épidémiologie de Terrain à l'université Ouaga 1 du Pr Joseph Ki-Zerbo / Direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies.
2. Programme de formation en épidémiologie de terrain à l'université Ouaga 1 du Pr Joseph Ki-Zerbo
3. Direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies.
4. Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Auteur correspondant : **YOUNOUSSA ALFAZAZI Hassane**. Résident au programme de Formation en épidémiologie de Terrain à l'université Ouaga 1 du Pr Joseph Ki-Zerbo / Direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies, Niger.

Téléphone : +227 80345837

E.mail : hassanyounoussa2@gmail.com

**Introduction :** La tuberculose est une zoonose majeure et constitue un problème de santé publique dans le monde. En Afrique en générale et particulièrement au Niger, cette maladie continue de persister malgré l'existence des textes relatifs à sa gestion et à sa surveillance. Le Niger dispose d'un réseau d'épidémiosurveillance qui comprend les services le laboratoire, le service public, les éleveurs, les transformateurs. Depuis son opérationnalisation, aucune évaluation de ce système n'a été menée. L'objectif de notre étude était d'évaluer le système de surveillance de la tuberculose animale dans la région de Niamey en 2019.

**Méthode :** nous avons mené une étude transversale descriptive dans la région de Niamey portant sur la période de Janvier à Décembre 2019 auprès des acteurs de la surveillance avec les attributs : représentativité, simplicité, flexibilité, la satibilité avec scores : faible (0% à 33%), moyen (34% à 67%), Fort (68% à 100%).

Le logiciel Epi Info et Excel ont été utilisés pour le traitement de données et le calcul des proportions.

**Résultats :** Les résultats obtenus après analyses des données collectées révèlent que la surveillance de la tuberculose animale à Niamey se limite à l'inspection des viandes avec 259 saisis enregistrés durant la période de 2014 à 2019 dont l'espèce bovine (88,03%) et la saisie répressive des abattages clandestins avec 1227,12 kg saisie en 2019. On note une absence d'analyse par le LABOCEL. Par conséquent, Cette évaluation a mis en évidence un système de surveillance simple (75%); réactif (100%) ; stable (88,23%); flexible (80%) ; représentativité (91,17%).

**Conclusion :** Ce système contribue à la lutte contre la tuberculose animale à Niamey. Mais il a besoin d'un laboratoire opérationnel.

**Mots clés :** Tuberculose animale, évaluation, Niamey 2019.

## P-09

### Contribution de la société civile à la promotion de la redevabilité dans les systèmes de santé en Afrique : le cas de l'Observatoire Communautaire sur l'Accès aux Services de Santé (OCASS) au Burkina Faso

**Joël Arthur KIENDREBEOGO**, Université Joseph KI-ZERBO, Département de Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso

**Orokia SORY**, Recherche pour la Santé et le Développement (RESADE), Ouagadougou, Burkina Faso

**Yamba KAFANDO**, Recherche pour la Santé et le Développement (RESADE), Ouagadougou, Burkina Faso

**Charlemagne TAPSOBA**, Centre de Recherche en Santé de Nouna (CRSN), Nouna, Burkina Faso

**Hamidou Ouédraogo**, Réseau accès aux médicaments essentiels (RAME), Ouagadougou, Burkina Faso

**Simon KABORE**, Réseau accès aux médicaments essentiels (RAME), Ouagadougou, Burkina Faso

**Introduction.** La faiblesse des mécanismes de redevabilité est souvent citée comme une entrave à la bonne performance des systèmes de santé. Nous présentons et appliquons un cadre d'analyse que nous avons développé à partir des expériences-terrain de l'ONG burkinabè « Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) » pour comprendre les processus d'engagement citoyen soutenant la redevabilité dans les systèmes de santé.

**Objectifs.** Appliquer ce cadre d'analyse de la redevabilité pour évaluer l'Observatoire Communautaire sur l'Accès aux Services de Santé (OCASS), un dispositif de veille citoyenne et de plaidoyer mis en place par l'ONG RAME pour renforcer l'accès de la population à des services de qualité au Burkina Faso.

**Méthodes.** Il s'est agi d'une étude qualitative à visée descriptive et analytique, qui s'est déroulée dans quatre régions sanitaires du Burkina Faso en août-septembre 2018. Les données ont été collectées par revue documentaire et entretiens individuels avec 52 informateurs clés, puis analysées de façon thématique.

**Résultats.** Les activités de l'OCASS concernaient la veille communautaire, la proposition d'alternatives, la mobilisation sociale et le plaidoyer. Même si ces activités ont parfois connu des difficultés dans leur mise en œuvre, elles ont permis d'obtenir des changements dans les services de santé en exerçant une pression permanente sur les prestataires de soins. En effet, nos résultats montrent des améliorations dans l'accueil des malades, dans l'organisation des activités de soins, dans l'approvisionnement en médicaments et en intrants, l'acquisition de matériel médico-technique, la réduction du coût des examens biologiques pour les patients souffrant du VIH/SIDA et la mutation d'agents de santé indélébiles.

**Conclusion.** Les résultats des analyses montrent que la mise en œuvre de l'OCASS au Burkina Faso est pertinente pour renforcer les mécanismes de redevabilité du système de

santé. Ces résultats pourraient être davantage améliorés si, en dehors des sanctions, des récompenses étaient également accordées aux prestataires de soins exemplaires.

**Mots clés :** veille citoyenne, observatoire communautaire, accès aux soins, redevabilité, système de santé, Burkina Faso

## P-10

### **Investigation d'un cas confirmé de Rougeole, Aire sanitaire Duokro, District Sanitaire Yamoussoukro, Région Sanitaire Béliér, Cote d'Ivoire, Aout 2021**

1 N'dri D. Cynthia Epse Kouamé, IDE participant de FETP intermédiaire, Cote d'Ivoire

2 P. Wilnique, MD, coordinateur AFENET, FETP, Cote d'Ivoire

3 J. Otshudiandjeka, MD, conseiller résident FETP, Cote d'Ivoire

4 D. Meless, Professeur Epidémiologique, Mentor FETP intermédiaire, Cote d'Ivoire

**Introduction :** La rougeole constitue un problème majeur de santé publique. En 2019, 869 770 décès ont été enregistrés dans le monde. Elle fait partie des maladies sous surveillance en côte d'Ivoire. A la semaine 29, un cas suspect notifié par le District de Yamoussoukro est revenu positif. Une investigation a été menée dans l'objectif de décrire le cas confirmé, Identifier d'éventuels nouveaux cas et proposer mesures de prévention et de contrôle.

**Méthode :** Une étude descriptive transversale a été menée le 13 Aout 2021 à Duokro village situé dans le District Sanitaire de Yamoussoukro. Les définitions de cas suspects et confirmés de rougeole du SIMR ont été utilisées. Une liste linéaire a été élaborée et utilisée pour la recherche active des cas. Les caractéristiques sociodémographiques, les informations cliniques et le statut vaccinal du cas confirmé, des contacts et les cas de rumeurs ont été considérées. Les données ont été collectées sur Excel et analysées sur Epi-Info 7, calculant les mesures de fréquences.

**Résultats :** Enfant âgé de neuf mois, de sexe masculin, non vacciné, aucun signe de la maladie au moment de l'enquête et aucune notion de voyage. Cinq personnes contacts

vivant sous le même toit dont 2(40%) hommes et 3 (60%) femmes. Quatre (4) personnes d'entr'elles soient 80% ont eu un statut vaccinal inconnu. De même, la recherche de cas des rumeurs de rougeole a permis de recenser (05) cas suspects, 1(20%) femme et 4 (80%) hommes. La tranche d'âge variait de 1 à 4 ans. Echantillons prélevés chez les cas suspects.

**Conclusion** : Cas confirmé non vacciné au moment de la maladie qui a reçu une dose après le prélèvement. Absence de nouveau cas de rougeole. Il a été recommandé de faire vacciner tous les enfants de 0 - 5 ans autour du ménage et respecter le calendrier vaccinal.

## P-11

### Investigation de Cas de COVID 19 au District Riyadh-Nouakchott, Mauritanie, Décembre 2020

**Khavnache Alioune**<sup>1,2</sup>, D.Barry<sup>2</sup>, Fadima Radhia Diallo<sup>2</sup>, Pauline Kiswendsida Yanogo<sup>2,3</sup>, Nicolas Meda<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>chef division Pollution et des Urgences Environnementales, Ministère de l'environnement de Mauritanie

<sup>2</sup> Programme de formation en épidémiologie de terrain et en laboratoire au Burkina Faso, Université Joseph KI ZERBO

<sup>3</sup>Faculté de médecine, Université Joseph KI ZERBO, Burkina Faso

Correspondance (adresse de l'auteur principal) : [aliourida59@gmail.com](mailto:aliourida59@gmail.com)

**Introduction** : En décembre 2019, des cas de pneumonie d'origine inconnue ont été détectés dans la ville de Wuhan en Chine, où un nouveau Coronavirus 2019-nCoV a été détecté le 7 janvier 2020, plus tard appelé SARS-CoV-2. Le 13 mars 2020, la Mauritanie enregistrait son premier cas de COVID-19, venu de l'étranger. Le 08 Décembre 2020 le District de Riyadh -

Nouakchott, Mauritanie a signalé un cas de COVID-19.

**Méthodes** : Une investigation a été conduite du 08 au 31 Décembre. Un cas suspect était défini comme Un patient atteint d'une maladie respiratoire aiguë avec fièvre ET n'ayant aucune autre étiologie qui explique pleinement la présentation clinique ET ayant été en contact avec le cas confirmé de COVID-19 au cours des 14 derniers jours avant l'apparition des symptômes. Un cas confirmé était un cas suspect avec une PCR positive. Un contact était défini comme étant toute personne qui a été exposée à un cas confirmé, sans protection appropriée. Un questionnaire a été administré. Avec Epi Info La fréquence des observations a été calculée et les proportions ont été comparées pour une précision lorsque l'IC est à 95%.

**Résultats** : Au total le cas investigué a généré 30 contacts dont 14 cas positifs (46,66%). L'âge médian des contacts est 45 ans (20-80). La fréquence des cas contacts asymptomatiques est 12 cas asymptomatiques (40 %). Le sexe est 1,3 hommes pour une femme.

**Conclusion** : Les contacts positifs étaient des contacts proches du cas investigué. Les contacts positifs représentaient 46,66% des contacts du cas investigué. 40% des contacts étaient sans symptômes et l'âge médian des contacts est 45 ans (20-80). Nous recommandons de bien observer les mesures de base et de prévention pour notre propre protection et bien-être car ces mesures vont conduire à un ralentissement de la propagation de l'épidémie.

**Mots clefs** : Investigation, Covid-19, Mauritanie, Épidémie

## P-12

### Connaissance, Attitudes et pratique sur la rage à Niakhène au Sénégal en 2020

Amadou Ibra Diallo<sup>1,2</sup>, Khadija Sandembou Diop Mbacké<sup>1</sup>, Mayssine Diongue<sup>1,2</sup>, Oumar Bassoum<sup>1,2</sup>, Adama Faye<sup>1,2</sup>

#### Institutions d'origine

<sup>1</sup>Institut Santé et Développement, Université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD, Sénégal

<sup>2</sup>Service de Médecine Préventive et de Santé Publique, UCAD, Sénégal

#### **Introduction**

La rage, une zoonose qui compte parmi les maladies infectieuses les plus mortelles. Tant qu'elle n'est pas déclarée, elle peut être prévenue par une prophylaxie post-exposition. Les populations des zones rurales sont les plus exposées aux morsures d'animaux. Cette étude a été menée pour évaluer les connaissances, attitudes et pratiques sur la rage en milieu rural sénégalais.

#### **Méthodologie**

Il s'agissait d'une enquête de type transversale, descriptive chez les sujets âgés d'au moins 18ans et résidant dans la commune de Niakhène. Un sondage aléatoire systématique, stratifié suivant le sexe et l'âge a été réalisé. Les données collectées portaient sur les caractéristiques personnelles, la connaissance et source d'information sur la rage, les attitudes et les pratiques face à une morsure d'animal. L'analyse a été réalisée avec le logiciel R et test de Chi2 a été utilisé pour effectuer les comparaisons de fréquences avec un seuil de 0,05.

#### **Résultats**

Un total de 300 individus a été enquêté. Ils avaient un âge moyen de 35,3 ans (+/-16,9), étaient de sexe féminin dans 52,3%, mariés dans 65,7% et étaient en prédominance sans instruction dans 67,7% des cas. La majeure partie de la connaissance sur la rage était basée sur le vécu et les échanges avec l'entourage (69,3%). Il a été noté que moins de 50% la population savait que la rage se manifestait par un trouble du comportement et devait être suspect devant toute morsure. Le chien a été

évoqué à près de 80% comme le principal vecteur de la maladie de même que la morsure (80,3%) comme principal mode de transmission. La pratique la plus partagée en cas de morsure, était de se rendre dans une structure sanitaire (83,3%) et l'une des pratiques les plus importantes qui est le nettoyage immédiat à l'eau et au savon, n'était pratiqué que chez 1% de la population d'étude. Les personnes âgées 25 à 59 ans avaient une meilleure connaissance des signes de suspicion de la rage ( $p=0,003$ ), du vecteur notamment le chien ( $p=0,045$ ). Sur les mesures de prévention, seules les personnes âgées de plus de 60 ans savaient qu'il fallait nettoyer à grande eau avec du savon la zone de morsure. Les personnes les plus instruites disaient que le principal mode de transmission était la morsure ( $p=0,049$ ).

#### **Conclusion**

Il est important et impératif que les autorités de la médecine humaine et animale puissent collaborer dans une approche One Health pour proposer des stratégies de communication pour le renforcement des connaissances mais aussi l'adoption de bonnes pratiques pour l'amélioration de la prévention contre les maladies zoonotiques les plus courantes et les plus graves.

**Mots clés :** CAP, Rage, Milieu rural, Sénégal

## P-13

### Facteurs associés au paludisme chez les cas suspects de paludisme dans les cinq districts sanitaires de Niamey, Niger, 2019

Zeinabou Alhassane<sup>1</sup>, Pauline Kiswendsida Yanogo<sup>1,2</sup>, Nicolas Méda<sup>1,2</sup>

#### **Affiliations / Institutions d'origine**

<sup>1</sup>Programme de formation en Epidémiologie du Burkina, faculté de Médecine, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

<sup>2</sup>Département de Santé Publique, faculté de Médecine, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

#### **Auteur correspondant, communicateur :**

Pauline Kiswendsida YANOGO,  
[yanogo.pauline@yahoo.fr](mailto:yanogo.pauline@yahoo.fr)

**Introduction :** Le paludisme est un problème majeur de santé publique dans le monde au Niger aussi. En 2018 l'Organisation Mondiale de la Santé a classé le Niger parmi les 6 pays enregistrant 54% des cas de paludisme au niveau mondial.

**Objectif :** Déterminer les facteurs associés au paludisme chez les cas suspects dans les cinq districts sanitaires de Niamey de novembre à décembre 2019.

**Méthodes :** Nous avons mené une étude observationnelle transversale analytique du 1<sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2019. La population cible était tous les cas suspects de paludisme consultant dans les formations sanitaires de Niamey. Les odd ratio (OR) d'association avec le paludisme ont été estimés dans une régression logistique. Les analyses ont été effectuées à l'aide des logiciels Epi-info version 7 et Stata 13. 1.

**Résultats :** 845 cas suspects de paludisme ont été enrôlés, 287 gouttes épaisses étaient positives, soit une prévalence globale de 34%. En analyse multivariée les facteurs indépendamment associés au paludisme dans les cinq districts de Niamey étaient : non instruction [OR= 4,56 ; IC<sub>95</sub> = (1,70-12,20) ; p<0,004] ; nombre de chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) inférieur à 3 doses [OR=21,47 ; IC<sub>95</sub> (10,11-45,61) ; p<0,004] ; Non utilisation des insecticides [OR=3,82 ; IC<sub>95</sub> = (1,56 – 9,35) ; p≤ 0,001] ; utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action après 21h [OR=24,05 IC<sub>95</sub> = (11,26-51,34) P≤0,001].

**Conclusion :** Le paludisme est lié à des facteurs tous modifiables. Ces résultats contribueront à améliorer la lutte contre le paludisme au Niger en général et en particulier à Niamey ciblant ces facteurs.

**Mots clés :** Cas suspects de paludisme, prévalence, facteurs associés, Niamey

## P-14

### Facteurs associés à la méningite à *Neisseria meningitidis* C dans le district de Kpendjal-Ouest au Togo en février 2019

Potobawi Essodina Alfa<sup>1</sup>, Pauline Kiswendsida Yanogo<sup>1,2</sup>, Nicolas Méda<sup>1,2</sup>

## Affiliations :

<sup>1</sup>Programme de formation en Epidémiologie du Burkina, faculté de Médecine, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

<sup>2</sup>Département de Santé Publique, faculté de Médecine, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

## Auteur correspondant, communicateur :

Pauline Kiswendsida YANOGO.  
[yanogo.pauline@yahoo.fr](mailto:yanogo.pauline@yahoo.fr)

## Résumé

**Introduction :** La méningite à méningocoque est une urgence de santé publique du fait de la létalité élevée et des séquelles graves. Le Togo a connu une épidémie de méningite à *Neisseria meningitidis* C du 17 février au 30 mars 2019 dans le district de Kpendjal-ouest dans la région des Savanes. Notre étude a eu pour objectif de rechercher les facteurs associés à cette maladie dans ce district afin d'optimiser les moyens de prévention et de lutte contre cette maladie.

**Méthodes :** Une étude cas-témoin appariée sur le sexe et la formation sanitaire a été menée du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2020 dans le district sur la période de l'épidémie. Un cas est une personne du district de Kpendjal-Ouest chez qui le *Neisseria meningitidis* C a été isolé par la PCR. Un témoin correspondait à une personne de même sexe qu'un cas, ayant consulté dans la même formation sanitaire au cours de la même période. **Résultat :** L'âge médian des cas était de 14 ans (IIQ 04 ans et 37 ans). Le sex-ratio H/F a été de 1,33. La guérison a été sans séquelles chez la majorité des cas (77,14 %) et la létalité liée à la méningite de 8,57%. Le statut vaccinal contre le méningocoque C (ORa = 7,16 ; IC 95 % = [1,02 – 49,79] ; p = 0,04), la promiscuité (ORa = 7,08 ; IC 95 % = [2,59 – 19,37] ; p = 0,0001) et l'antécédent d'infection respiratoire (ORa = 6,44 ; IC 95 % = [2,17 – 19,10] ; p = 0,001) étaient des facteurs indépendamment associés à la méningite.

**Conclusion :** Les facteurs identifiés par l'étude sont modifiables par des actions de santé publique qui pourront être entreprises pour améliorer la prévention de cette maladie dans le district.

**Mots clés :** Méningite, *Neisseria meningitidis* C, facteurs associés, Togo

## P-15

### **Rôle de la société civile et contribution des acteurs communautaires dans la lutte contre la COVID-19 au Burkina Faso.**

**Joël Arthur KIENDREBEOGO**, Université Joseph KI-ZERBO, Département de Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso

**Orokia SORY**, Recherche pour la Santé et le Développement (RESADE), Ouagadougou, Burkina Faso

**Yamba KAFANDO**, Recherche pour la Santé et le Développement (RESADE), Ouagadougou, Burkina Faso

**Charlemagne TAPSOBA**, Centre de Recherche en Santé de Nouna (CRSN), Nouna, Burkina Faso

**Issa KABORE**, Recherche pour la Santé et le Développement (RESADE), Ouagadougou, Burkina Faso

**Hamidou Ouédraogo**, Réseau accès aux médicaments essentiels (RAME), Ouagadougou, Burkina Faso

**Simon KABORE**, Réseau accès aux médicaments essentiels (RAME), Ouagadougou, Burkina Faso

**Introduction.** Les communautés devraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre les urgences de santé publique, mais assurer leur engagement effectif reste un défi dans de nombreux pays. Nous présentons l'expérience du Burkina Faso en matière d'implication des acteurs communautaires dans la lutte contre la COVID-19.

**Objectifs.** Décrire le processus de mobilisation des acteurs communautaires et leur contribution dans la lutte contre la COVID-19 au Burkina Faso.

**Méthodes.** Il s'est agi d'une étude qualitative descriptive qui s'est déroulée dans la ville de Ouagadougou, couvrant la période de mars à octobre 2020. Les données ont été collectées par revue documentaire, entretiens individuels en ligne et observation participante, puis analysées de façon thématique.

**Résultats.** L'initiative d'impliquer les acteurs communautaires pour lutter contre la COVID-19 a été prise par 23 organisations de la société civile regroupées autour d'une plateforme dénommée « Démocratie Sanitaire et

Implication Citoyenne (DES-ICI) ». Cette plateforme a lancé en avril 2020 le mouvement « Les Communautés s'engagent à Vider la COVID-19 (COMVID COVID-19) » en mobilisant plus de 300 associations à base communautaire à travers les réseaux sociaux. Ces associations, sous le leadership de la plateforme DES-ICI, ont été organisées et réparties en 54 Cellules Citoyennes de Veille Sanitaire (CCVS) à travers la ville de Ouagadougou. Ces CCVS ont travaillé de manière bénévole, menant des activités de sensibilisation, d'identification et de suivi des cas contacts. Les CCVS ont également procédé à la fabrication et à la distribution de matériel de protection aux ménages vulnérables, notamment du savon, des masques et du gel hydro alcoolique.

**Conclusion.** Le mouvement COMVID COVID-19 a été une expérience unique de mobilisation des acteurs communautaires par la société civile pour lutter contre la COVID-19. Au-delà de cette lutte, le ministère de la Santé envisage de mobiliser les CCVS pour des actions de santé communautaire, dans la dynamique de la Couverture Sanitaire Universelle.

**Mots clés :** COVID-19, participation communautaire, mobilisation communautaire, acteurs communautaires, société civile, Burkina Faso